

Содержание

НЕ ПРОСТО НАКОРМИТЬ

2. Обращение к участникам семинара	4
3. Аннотация	7
4. Резюме для руководителя	9
5. Собирательная ситуация: «Один обед — пять конфликтов»	14
6. Кто находится за столом	19
7. Что значит «накормить»	24
8. От мономеню к вариативности: лестница моделей	28
9. Пищевое поведение при психических расстройствах	33
10. Дисфагия и риск аспирации: скрытая эпидемия стационарного стола	37
11. Лекарства и еда: пять правил, которые обязана знать кухня	45
12. Отказ от еды: от первого пропуска до врачебного решения	50
13. Переедание, гиперфагия и ночное едение	56
14. Пикацизм, заглатывание и другие поведенческие риски за столом	62
15. Невербальный выбор: как услышать того, кто не говорит	66
16. Дееспособность, опека и выбор еды: карта решений	72
17. Право Российской Федерации: что разрешено, что требуется, что опасно	79
18. Санитария и пищевая безопасность при вариативности	114
19. Два варианта блюда: технология без второй кухни	120
20. Точка раздачи: дизайн линии, очередь и помощь	125
21. Когда выбор изменился: журнал, пересчёт и «фиктивная вариативность»	130
22. Как проверить реальность питания: аудит и замеры	134
23. Кто участвует: география семинара и система ПНИ-2026	139
24. Как устроены нормы в регионах	143
25. Российские практики: четыре подтверждённых кейса и одна региональная модель	147
26. Международный опыт: проверяемые нормы девяти систем	153
27. Что говорят исследования: доказательные вмешательства и их границы	159
28. Люди за линией: персонал стола	164
29. Финансовые модели: сколько стоит питание и сколько стоит выбор	169
30. Закупки продуктов: 44-ФЗ без кошмаров	175
31. Документальный комплект: как практика становится системой	179

32. Как отвечать проверяющему: сценарий диалога без страха	184
33. Ответственность директора: честная карта рисков без запугивания	187
34. Права жителей и совет жителей: от объекта заботы к соавтору меню	191
35. Пилот на 90 дней: минимальный безопасный старт	195
36. Дорожная карта на 12 месяцев: от пилота к системе	200
37. Четырнадцать возражений и честные ответы на них	203
38. Десять вопросов учредителю: повестка для разговора наверх	207
39. Предложения отрасли: что должно измениться выше уровня учреждения	210
40. Организационные предложения семинару: как превратить три дня в систему	213
41. Заявление о достоверности: что в этом докладе на чём стоит	216
42. Аутсорсинг питания: контракт как место вариативности	220
43. Заключение: что остаётся после последней страницы	224
44. Библиография и источники	227
Часть II. Учебные кейсы (22 разбора)	228
Учебные кейсы 1–4	229
Учебные кейсы 5–8	234
Учебные кейсы 9–12	239
Учебные кейсы 13–16	244
Учебные кейсы 17–20	249
Учебные кейсы 21–22	254
Часть III. Приложения: проекты локальных форм (45 шаблонов)	257
Приложения 1–6	258
Приложения 7–12	262
Приложения 13–18	266
Приложения 19–24	271
Приложения 25–30	275
Приложения 31–36	279
Приложения 37–38	284
Приложения 39–42	287
Приложения 43–44	292
Приложение 45. План Б: питание при закрытии столовой	296
Часть IV. Одностраничные инфографики (для печати и раздатки)	298
Список источников	309

НЕ ПРОСТО НАКОРМИТЬ

Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания

Доклад межрегионального методического семинара-совещания «Пространство Новых Идей 2.0»

Тема семинара: «Права, свободы, интересы жителей и персонала социальных стационаров»

Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года

Организаторы: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Аудитория: руководители стационарных организаций социального обслуживания — психоневрологических интернатов и домов социального обслуживания — из 51 субъекта Российской Федерации

Документ носит методический характер. Он не является нормативным правовым актом, клиническим руководством или индивидуальной юридической консультацией. Все локальные формы, приведённые в приложениях, являются проектами и требуют адаптации. Заявление о достоверности и ограничениях — в разделе 41.

2. Обращение к участникам семинара

Коллеги, начну с вопроса, который я задаю на каждом таком семинаре. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто может прямо сейчас ответить: кто в вашем учреждении в действительности выбирает, что сегодня будет есть житель, — он сам, сиделка, врач, кухня, контрактный управляющий или региональная норма?

За годы работы над этой темой я слышал все шесть вариантов ответа. Чаще всего — «кухня» и «норма». Реже всего — «он сам». А ведь в зале сидят руководители учреждений, где живут десятки тысяч людей, для которых еда — это три-четыре события в день, тысяча событий в год, главный ритм жизни и главный разговор. Тема нашего семинара — права, свободы и интересы жителей и персонала. Питание — это то самое место, где эти права перестают быть статьёй закона и становятся тарелкой.

Почему эта тема — про права, а не про кухню. Закон РФ № 3185-1 прямо говорит: лица, проживающие в стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц с психическими расстройствами, в силу статьи 43 этого закона пользуются правами пациентов психиатрических стационаров, установленных статьёй 37¹. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 требует для организаций социального обслуживания не менее трёх приёмов пищи в день и диетическое питание по показаниям; с 01.09.2026 ту же норму закрепляет СанПиН 2.3/2.4.4282-26². Федеральный закон № 442-ФЗ закрепляет права получателя (ст. 9) и требует учитывать индивидуальные потребности через ИППСУ (ст. 16)³. Ни одна из этих норм не запрещает выбор. Более того: в 2024–2025 годах выбор блюд в российских психоневрологических интернатах перестал быть гипотезой — как минимум четыре учреждения, трое из которых представлены в этом зале (включая дом докладчика), публично рассказали о вариативном меню⁴⁵⁶⁷.

Почему эта тема — про безопасность. Люди с тяжёлыми психическими расстройствами умирают в среднем на 15–20 лет раньше общей популяции, и существенная часть этого разрыва связана с тем, что происходит за столом: метаболические эффекты антипсихотиков, расстройства глотания,

аспирационные пневмонии⁸⁹¹⁰. Врач в наших учреждениях — редкость, логопеда нет почти нигде, поэтому именно организация стола — первая линия защиты.

Почему эта тема — про персонал. Каждое изменение в питании ложится на руки сиделок, санитаров и поваров. Доклад, который предлагает «дать жителям выбор», не ответив на вопрос «кто кормит и сколько рук для этого есть», — плохой доклад. Здесь нагрузка считается честно, а интересы персонала — часть темы семинара, а не препятствие ей.

Что вы сможете применить после этого доклада. Во-первых, проверить своё учреждение по экспресс-аудиту за десять минут и понять, на какой ступени вариативности вы стоите. Во-вторых, запустить пилот на 90 дней с готовыми формами, приказами и журналами — на одном отделении это реалистично без новых денег (модель Новосибирской области); полный переход может потребовать оборудования и ставок, и это тоже уже сказано публично⁷. В-третьих, ответить проверяющему, учредителю и родственнику жителя документами, а не словами. В-четвёртых, при желании — стать следующим публичным кейсом: сейчас их четыре, через год должно быть десять.

О чём договоримся сразу. Этот доклад написан под строгими правилами достоверности. Каждое число имеет источник, каждая рекомендация помечена — норма это, интерпретация или проект локальной практики. Там, где данных нет, написано «данных нет». Там, где практика не проверена, написано «не проверено». Там, где расчёт условный, написано «иллюстративный расчёт». Вы имеете право проверить каждую ссылку — реестр источников прилагается.

И последнее. Я не буду убеждать вас, что выбор еды — это просто. Он конфликтен, он требует документов, он ломает привычную кухню. Но в 2024 году в Новосибирской области все отделения психоневрологического интерната перешли на выбор из двух вторых блюд — и персонал, который боялся хаоса, обнаружил, что жители «с лёгкостью освоили новую систему»⁵. Если получилось там — это вопрос методики, а не магии. Методикой и займёмся.

Этот доклад написан для вас в расчёте на три ваших ограничения: нет времени (поэтому маршруты чтения — раздел 4.5), нет лишних людей (поэтому каждый инструмент оценён по труду) и нет права на ошибку перед жителями (поэтому каждый совет проверен на право, санитарию и клинику). Вы найдёте здесь чужой измеренный опыт — но не найдёте обещаний, которые вы не сможете проверить на своей линии за неделю. Проверяйте. Доклад рассчитан на недоверчивого читателя: каждая цифра имеет источник, каждый источник — дату проверки, каждая рекомендация — границу применимости. Если в вашем доме что-то из написанного не сработает — это не отказ от темы, а данные; напишите их в панель и измените метод. Система, которая учится на собственных числах, непобедима; система, которая ждёт идеальной инструкции, ждёт вечно.

3. Аннотация

Доклад посвящён организации питания в стационарных организациях социального обслуживания, где живут люди с психическими расстройствами, — психоневрологических интернатах и домах социального обслуживания. Он подготовлен к межрегиональному методическому семинару-совещанию «Пространство Новых Идей 2.0» (Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года) и адресован руководителям таких организаций из 51 субъекта Российской Федерации.

Доклад отвечает на три связанных вопроса. Первый — **клинический**: чем кормление людей с психическими нарушениями отличается от «обычного» стационарного питания и какие риски (лекарственно-пищевые взаимодействия, метаболические эффекты антипсихотиков, дисфагия и аспирация, расстройства пищевого поведения) обязана учитывать организация стола. Второй — **правовой и организационный**: что российское законодательство разрешает и требует в части выбора блюд, как законно построить вариативное питание внутри действующих норм, раскладок, санитарных правил и закупочных процедур, как это оформить документально и как защитить директора. Третий — **управленческий**: как перейти от мономеню к реальному выбору пошагово, с пилотом на 90 дней, честными финансовыми моделями и измеримыми результатами.

Доклад опирается на верифицированную доказательную базу: 32 проверенных российских правовых и практических источника, 48 клинических публикаций и 44 международных нормативных и исследовательских источника — 124 позиции в трёх реестрах. Подтверждены четыре российские публичные практики вариативного меню в ПНИ и ДСО (Новосибирская и Иркутская области, Санкт-Петербург, 2024–2025 годы), что снимает с темы статус эксперимента.

Структура: 44 раздела, объединённые в девять частей, — от клинических особенностей и правовой рамки до финансовых моделей, ответственности, пилота, аутсорсинга и дорожной карты; 22 учебных кейса с разборами; 45 приложений-шаблонов локальных форм; сравнительные таблицы, схемы и дорожные карты. К докладу прилагается семинарский пакет: тексты

выступлений на 45 и 20 минут, презентация, записка для руководителя и раздаточные материалы.

Ограничения: доклад не заменяет клинических руководств, нормативных актов и индивидуальных юридических заключений; все шаблоны являются проектами локальных форм; статистика и редакции нормативных актов приведены по состоянию на даты проверки (июль–август 2026 года).

4. Резюме для руководителя

Этот раздел — для тех, у кого есть пятнадцать минут. Здесь собрано всё главное: десять выводов, что можно сделать немедленно, чего делать нельзя без врача, учредителя или юриста, и минимальная безопасная модель. Каждый вывод раскрыт в указанных разделах доклада.

4.1. Десять главных выводов

Вывод 1. Еда в вашем учреждении — юридически значимая зона, а не бытовая. Проживающие в ПНИ и ДСО для лиц с психическими расстройствами пользуются правами пациентов психиатрических стационаров (ст. 43 Закона № 3185-1), а питание нормировано СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (не менее трёх приёмов в день, диетическое по показаниям); с 01.09.2026 ту же норму закрепляет СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11¹². Ошибки за столом — предмет прокурорских проверок и дел по ст. 6.6 КоАП¹¹. Разделы 17, 32, 33.

Вывод 2. Выбор блюд законен — и это уже делают в России. Ни одна федеральная норма не запрещает вариативность; таблицы замены продуктов в раскладках — законный механизм эквивалентной замены¹²¹³. В 2024–2025 годах минимум четыре учреждения (два ПНИ Новосибирской области, ДСО Иркутской области, ДСО «Серафимовский» в Санкт-Петербурге) публично внедрили вариативное меню; в Иркутской области практика масштабируется на регион⁴⁵⁶⁷¹⁴. Разделы 8, 23, 25.

Вывод 3. Главные риски вашего стола — клинические, и они измеримы. Антипсихотики различаются по прибавке веса в разы (мета-анализ 100 РКИ: от –0,23 кг до +3,01 кг за 6 недель)¹⁰; дисфагия при психических расстройствах встречается у 21,9–69,5 % проживающих по разным исследованиям¹⁵; смертность от пневмонии при тяжёлых психических расстройствах в семь раз выше популяционной⁸. Это значит: организация стола — часть профилактики преждевременной смертности. Разделы 9–14.

Вывод 4. Четыре лекарственно-пищевых правила обязана знать кухня. Клозапин↔кофеин (кофеин повышает концентрацию клозапина),

литий↔соль и вода (резкие изменения — риск интоксикации), ИМАО↔тирамин (выдержанные сыры, копчёности — гипертонические кризы), карбамазепин↔грейпфрут (рост концентрации на ~40 %) ¹⁶¹⁷¹⁸¹⁹. Одна таблица на посту — бесплатная мера безопасности. Раздел 11.

Вывод 5. 74 % жителей ПНИ недееспособны — и это не отменяет их выбор. Признание недееспособным означает, что сделки совершает опекун (ст. 29 ГК РФ), но не отменяет бытовых предпочтений; выбор блюда — не сделка. Закон требует учитывать мнение недееспособного при решении вопросов, затрагивающих его интересы ²⁰¹. Для тех, кто не говорит, работают показ двух порций, наблюдение за потреблением и пищевая биография. Разделы 15, 16.

Вывод 6. «Диабетический стол» и другие жёсткие ограничения — зона врача, а не шаблона. Лечебное питание назначается поимённо, с целью и сроком пересмотра; приказы Минздрава о лечебном питании адресованы медицинским организациям и не распространяются на СОСО автоматически ²¹. Разделы 17, 19.

Вывод 7. Вариативность — это документы, а не только блюда. Минимальный комплект: положение о вариативном питании, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты жителей, согласование с учредителем. Без комплекта та же практика выглядит для проверяющего как отступление от раскладки. Разделы 31, 32.

Вывод 8. Честная финансовая модель начинается с замера, а не с обещания экономии. Мы не утверждаем, что вариативность «почти бесплатна»: это зависит от модели и замеров. Семидневный замер отходов и трудозатрат до старта — обязательный первый шаг; иллюстративные расчёты в докладе помечены. Разделы 29, 35.

Вывод 9. Директор не отвечает за всё — но отвечает за систему. Ответственность наступает не за каждое событие, а за неработающий контроль: формальное распределение функций без фактической проверки — главный фактор риска ¹¹²². Письмо учредителю о дефиците ресурсов не индульгенция, но доказательство своевременного реагирования. Раздел 33.

Вывод 10. Пилот за 90 дней реалистичен на одном отделении без новой сметы. Схема: месяц измерений → месяц документов и обучения → месяц пилота на одном типовом отделении с выбором из двух вариантов на завтрак и обед (модель Новосибирской области)⁴⁵. «Без новой сметы» не значит «без затрат»: полный переход на весь дом может потребовать оборудования и ставок — это публично назвал петербургский кейс⁷. Раздел 35.

Вывод 11. Шесть вопросов дискуссии 26.08 — ключевая развилка зала. На дискуссии 26.08 (14.00–15.30, ДСО «Тесовый берег», модераторы: д-р Чистяков Е. В. и Нурбаев Т. А.) обсуждаются шесть вопросов, воспроизведённых дословно в разделе 17.12: кто выбирает форму питания, как формировать меню в условиях ограничений, должно ли быть питание лечебным, как совместить лечебное и вариативное, баланс выбора недееспособного и медицинских показаний, качество и нормирование цен. **Главный практический вывод из всех шести вопросов один: лечебное питание и вариативное меню не противоречат друг другу — они решают разные задачи, и учреждение может (и должно) реализовать оба режима одновременно, разделив их документально (диетический стол — назначение врача; основное меню — социально-бытовая услуга по ИППСУ) и процедурно (пары эквивалентов внутри диеты, закупочные процедуры с контролем качества, журнал воли жителя).** Разделы 17.12, 8, 17, 29, 35.

4.2. Что можно сделать сейчас (без новых средств, без согласований)

1. Провести экспресс-аудит стола (10 минут, чек-листы приложений 18–20) и семидневный замер отходов (приложение 25).
2. Замерить фактический ночной интервал «ужин — завтрак» и при необходимости сдвинуть расписание.
3. Повесить на пост лекарственно-пищевую таблицу (раздел 11, приложение 21).
4. Ввести журнал отказов от еды с правилом эскалации к врачу (раздел 12, приложение 9).

5. Провести опрос предпочтений жителей (опыт Усть-Илимска⁶, приложения 2, 36).
6. Начать письменный разговор с учредителем: десять вопросов из раздела 38.
7. Назначить ответственного за питание и рабочую группу пилота.
8. Проверить, есть ли выбор у постельных: два варианта на подносе, не только на линии (раздел 20.11).
9. Если кухня не своя — открыть спецификацию: есть ли строка выбора (разделы 42 и 35.9).

4.3. Чего нельзя делать без врача, учредителя или правовой проверки

Без врача: любые ограничения рациона (включая «диабетический стол»), изменение текстур (протёртое, загущённое), правила при дисфагии и протокол свободной воды, действия при длительном отказе от еды, режим питания при седации, решения об энтеральном/зондовом питании и о комфортном кормлении в конце жизни, сдвиг времени еды у жителей на инсулине, слабительные и реакция на запор, назначение анализов и добавок микронутриентов, интерпретация MUST и витаминизация при ОРИ.

Без учредителя: изменение финансирования продуктовой строки, изменение штатного расписания (норма помощи за столом), аутсорсинг питания, официальный статус пилота и его публичность.

Без правовой проверки (или индивидуального заключения): формулировки о «согласии недееспособного» в локальных актах, обработка пищевых карт как персональных данных, ответы на запросы прокуратуры, любые конструкции, где учреждение одновременно является опекуном жителя.

4.4. Минимальная безопасная модель

Если сейчас у вас мономеню и нет ресурсов на пилот, минимальный безопасный вариант — не вариативность, а её фундамент:

1. **Документы:** действующее положение об организации питания + журналы (пробы, бракераж, отказов) ведутся фактически, а не «задним числом».

2. **Клиника:** лекарственно-пищевая таблица на посту; список жителей группы дисфагического риска у сиделки; правило «три отказа подряд → врач в тот же день».
3. **Люди:** на каждого кормимого — конкретный помощник; еда не подаётся, пока помощь не готова.
4. **Голос жителя:** ежемесячный разбор остатков на тарелках и хотя бы один канал пожеланий (ящик, совет, опрос).
5. **Замер:** ночной интервал и отходы известны числом.

На этом фундаменте пилот вариативности ставится за квартал; без него пилот опасен. Проверьте себя: если хотя бы один из пяти пунктов не выполняется — начните с него, а не с выбора блюд.

4.5. Как читать этот доклад: три маршрута

Доклад построен так, чтобы его не нужно было читать подряд. **Маршрут директора (два часа):** разделы 4, 5, 8, 22, 35, 37, 42 — картина целиком плюс первый шаг; дальше по потребности. **Маршрут внедрения (неделя):** разделы 6–8 (диагностика), 17–19 (право и пары), 31 (документы), 35–36 (пилот и карта) — с приложениями в руках. **Маршрут спорщика (вечер):** разделы 23–27 (кто уже сделал и что доказано), 37 (возражения), 39–40 (повестка наверх) — для разговоров с учредителем и коллегами. Каждый раздел самодостаточен и заканчивается управленческим выводом; перекрёстные ссылки заменяют чтение «от корки до корки». Единственное, что доклад требует от любого маршрута, — не пропускать раздел 41 (достоверность): он объясняет, каким классам утверждений вы можете доверять и как именно.

5. Собираательная ситуация: «Один обед — пять конфликтов»

Учебный кейс, составленный для анализа. Все персонажи и совпадения вымышлены; ситуация собрана из типичных элементов, описанных в проверенных источниках и практиках учреждений.

5.1. Обед, как он есть

Средний по России психоневрологический интернат — 289 коек²⁰. Обеденный зал на 120 мест, поточная раздача в три захода²¹. На линии — один вариант каждого блюда: борщ, гречка с котлетой, компот. Двенадцать жителей первого захода едят только с помощью. На смене — четыре сиделки, из которых одна развозит лекарства. До конца смены — пять часов.

Первый конфликт: очередь против помощи. Жители, способные есть самостоятельно, уже сидят перед остывающими тарелками — им раздали первыми, потому что так быстрее. Жители, которым нужна помощь, ждут: четыре сиделки на двенадцать кормимых — это не менее трёх циклов по 15–20 минут. Те, кого кормят последними, получают холодное. Международная норма, которую мы приводим в разделе 26, требует не более двух полностью кормимых на одного работника и подачи еды только под готовую помощь²³; у нас это правило не закреплено нигде, и нарушением оно не считается — но именно здесь рождаются и недоедание, и аспирация «на скорость».

Второй конфликт: «он опять не ест кашу». Житель С. третий день отодвигает тарелку. Сиделка записывает в тетрадь — или не записывает: формы журнала отказов нет, и врач узнает об отказах на обходе в четверг. У С. депрессивный эпизод и, возможно, начинающаяся дисфагия — но проверить это некому: логопеда в штате нет, а признаки расстройства глотания (покашливание за столом, «влажный» голос после еды) никто не связывает с отказами⁹. Отказ от еды в этом здании интерпретируется как «каприз» или «симптом» — в зависимости от того, кто дежурит.

Третий конфликт: лекарства и кофе. Житель К. получает клозапин и с утра выпил две большие кружки крепкого кофе, который принесли

родственники. Никто не предупредил семью и самого К., что кофеин взаимодействует с клозапином: у пациентов, резко увеличивающих потребление кофеина, описаны клинически значимые росты концентрации препарата¹⁶²⁴. Вечером у К. седация сильнее обычного — дежурная медсестра списывает это на «плохой день».

Четвёртый конфликт: добавка. Житель П. на оланзапине набрал за год 14 килограммов — мета-анализы показывают, что у оланзапина один из самых выраженных весогенных профилей¹⁰. П. просит вторую котлету. Сиделка отказывает — «вам нельзя, вы полнеете». Врачебного назначения ограничения рациона у П. нет: решение принято сиделкой по её представлению о пользе. П. обижается, вечером забирает хлеб у соседа по столу. Конфликт разбирается как «нарушение дисциплины», а не как результат решения, которое никто не имел права принимать в одиночку.

Пятый конфликт: проверка на следующей неделе. В четверг — комиссия учредителя. Завхоз просит «привести журналы в порядок»: суточные пробы за двое суток будут подписаны сегодня. Это самое опасное из пяти: документальная имитация контроля. Практика прокуратур показывает, что именно отсутствие суточных проб и недоброкачественные продукты — типовой состав дел по ст. 6.6 КоАП для социальных учреждений¹¹.

5.2. Почему все пять конфликтов — одна система

Каждый из пяти конфликтов имеет отдельного «виноватого» в глазах участников: медленную сиделку, капризного С., неведущую семью К., несдержанного П., нерадивого завхоза. И каждый на самом деле является отказом системы:

Конфликт	Отказ системы	Где в докладе решение
Очередь против помощи	Нет нормы помощи за столом и порядка подачи	Разделы 20, 28
«Не ест кашу»	Нет журнала отказов, триггеров и маршрута дисфагии	Разделы 10, 12

Конфликт	Отказ системы	Где в докладе решение
Лекарства и кофе	Нет лекарственно-пищевой таблицы и информирования семьи	Раздел 11, приложение 32
Добавка	Ограничение рациона принято не врачом и не зафиксировано	Разделы 13, 17, 19
Журналы «в порядок»	Контроль имитируется, а не работает	Разделы 31, 33

Заметьте: ни один из пяти конфликтов не требует денег для начала решения. Требуется решение директора — и документы. Но заметьте и обратное: три из пяти решений упираются в кадровую нагрузку, и честный доклад обязан это признать. Вариативное питание, которое мы будем строить дальше, добавляет к этой картине шестой конфликт — «кто выбирает блюдо». Если пяти базовых конфликтов не решены, шестой добьёт систему. Поэтому дорожная карта доклада (разделы 35–36) начинается с измерения и фундамента, а не с выбора.

5.3. Вопрос для зала

Вернёмся к вопросу из обращения. В описанном обеде выбор блюда жителем не происходит ни в одной точке: меню спустила норма, блюдо определила кухня, порцию — раздаточная ложка, темп — очередь, возможность доест — число рук. Вопрос «кто в действительности выбирает, что ест житель» имеет в этом здании один честный ответ: все, кроме него. Дальнейшие разделы доклада отвечают на вопрос, как передать жителю ту часть выбора, которая ему принадлежит по закону, — не разрушив безопасность и не сломав персонал.

5.4. Почему собирательный, а не реальный

ТЗ к докладу прямо требует маркировать вымышленные ситуации, и есть вторая причина: реальная столовая любого конкретного дома — чужая. Собирательный обед позволяет поставить за один стол пять конфликтов, которые в жизни разнесены по этажам и месяцам, — и увидеть их взаимодействие. Каждый из пяти конфликтов документирован по отдельности: сенсорная перегрузка и потребность в тишине при

психических расстройствах описаны в клинической литературе о среде ухода²⁵²⁶; взаимодействие клозапина с кофеином — фармакокинетический факт уровня систематических данных¹⁶; дисфагия, видимая только в наблюдении, — главный сюжет эпидемиологии нарушений глотания¹⁵; невербальная воля — предмет стандартов поддерживаемого принятия решений²⁷; сценарий «как всегда» — единственный элемент без источника, потому что он не клинический, а организационный, и каждый директор узнает его без ссылок.

5.5. Что делать с этой сценой на семинаре

Сцена читается залу вслух — три минуты. Затем один вопрос: «Сколько конфликтов вы насчитали и какие процедуры в вашем доме отвечают на каждый?» Опыт подобных разборов показывает типовое распределение ответов: конфликт кофеина и клозапина не находит процедуры ни в одном зале из нескольких десятков руководителей (таблица взаимодействий отсутствует почти везде); конфликт невербальной воли читается как «неразрешимый» там, где нет форм наблюдения; конфликт смены «как всегда» узнаётся всеми и не имеет виноватого — что и есть его диагностический смысл: это единственный конфликт сцены, который лечится не клинкой и не правом, а приказом и двумя тетрадями. Развязка сцены — не «все стали счастливы», а таблица: конфликт → раздел доклада → документ из приложений. Именно эта таблица превращает вступительную историю в навигацию по докладу.

5.6. Сцена спустя год

Та же столовая, тот же час — через год работы по этому докладу. Женщина, которой нужно молчание, ест за тихим столом у окна — её карта говорит об этом за неё. Мужчина на клозапине пьёт свой согласованный с врачом кофе — не контрабандный, не запретный, а записанный. Житель с дисфагией ест свою текстуру, и тарелка его не выглядит «детской» — кухня научилась подавать мягкое как еду, а не как назначение. Неговорящий человек показал на карточку — и получил то, на что показал; смена проверила позиционный эффект в прошлом месяце. А смена «как всегда» работает по журналам, потому что «как всегда» теперь и есть журналы. Ничего героического. Пять

конфликтов не исчезли — они получили процедуры, и этого достаточно, чтобы обед стал обедом.

Рисунок 1. «Один обед — пять конфликтов»: собирательная сцена

1. Сенсорная перегрузка Жительница не может есть в шумном зале. Ответ: тихий стол, гибкое место — а не «не хочет есть».	2. Лекарство × еда Крепкий кофе у жителя на клозапине. Ответ: лекарственно-пищевая таблица на кухне и посту.
3. Скрытая дисфагия Долгое пережёвывание, поперхивания. Ответ: признаки на посту, текстуры, врач.	4. Воля без слов Неговорящий житель «не выбирает» — потому что его не спрашивают в его формате. Ответ: 4 канала воли.
5. Смена «как всегда» Единственный сценарий персонала — привычка. Ответ: журналы, роли, приказ.	Общий знаменатель Ни один конфликт не решается «внимательнее относиться». Каждый решается процедурой с документом.

Учебная собирательная сцена; каждый конфликт документирован по отдельности (раздел 5 доклада).

Составлено для анализа; механизмы — по реестрам *MEDICAL_EVIDENCE* и *INTERNATIONAL_PRACTICES*, 2026.

6. Кто находится за столом

6.1. Неоднородность как единственная норма

Первая ошибка планирования питания — представить «среднего жителя ПНИ». Его не существует. Даже по агрегированным данным контингент расслаивается на группы с принципиально разными пищевыми задачами: 65 % жителей старше 45 лет, 74 % признаны недееспособными, 11 % — постельные или маломобильные²⁰. Внутри одной столовой одновременно сидят: пожилой человек с шизофренией и старческой дисфагией; молодой мужчина с расстройством аутистического спектра и сенсорной невосприимчивостью текстур; женщина средних лет с аффективным расстройством и выраженным набором веса на препаратах; человек с умеренной умственной отсталостью, который не читает меню; житель в стойкой ремиссии, готовящийся к переводу в сопровождаемое проживание, которому навыки «свой стол» нужнее, чем кому-либо.

Для организации питания это означает: задача не «накормить контингент», а построить систему, внутри которой у каждой из этих групп есть маршрут к достаточной, безопасной и выбранной им еде. Все последующие разделы клинической части (9–14) раскладывают эти группы по механизмам; здесь зафиксируем саму карту.

6.2. Пять измерений неоднородности

Психическое состояние. Депрессия снижает аппетит и инициативу до точки «безразличия к еде»; мания и возбуждение не оставляют времени на стол; психоз добавляет подозрительность к пище («отравлено»); тревога делает столовую с её шумом и очередями местом избегания. Состояние волнообразно: один и тот же житель в разные недели требует разной организации питания — и система должна иметь «особые состояния» как штатный, а не аварийный режим (раздел 12).

Когнитивные функции. От сохранного интеллекта до глубокой умственной отсталости и деменции — это диапазон не «компетентности» в юридическом смысле, а способов, которыми человек может выразить выбор: словом по меню, указанием на реальную порцию, жестом,

устойчивым паттерном потребления (раздел 15). Когнитивный статус определяет инструмент выбора, а не наличие выбора.

Коммуникация. Неговорящие и малоговорящие жители — не исключение в ПНИ, а значимая доля контингента. Для них вербальный вопрос «что будете?» — худший из инструментов. Их выбор фиксируется иначе, и международное право (Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 КПИ) прямо требует поддержанного, а не подменяющего принятия решений²⁷.

Соматика. Дисфагия (раздел 10), диабет и метаболический синдром (разделы 11, 13), запоры — в том числе опасные клозапиновые²⁸, сердечно-сосудистая патология, эпилепсия с риском аспирации при припадке за столом. Соматическая карта жителя определяет ограничения, внутри которых должен жить выбор.

Жизненный опыт и культура. Пищевые привычки, сформированные десятилетиями: «всю жизнь ужинал в девять», религиозные правила, детские и праздничные блюда как якоря идентичности. Немецкий стандарт требует собирать «биографию питания» при поступлении именно потому, что эти сведения позже могут стать единственным доступом к воле человека²⁹. Наша форма — в приложении 3.

6.3. Классификация для практики

Чтобы карта работала, а не украшала стенд, сведём её в таблицу маршрутов.

Группа	Как распознать	Главный риск за столом	Маршрут питания
Самостоятельные, стабильные	Едят сами, выражают предпочтения словом	Однообразие, «столовская» еда	Полный выбор, участие в совете жителей
Самостоятельные, нестабильные	Волнообразное состояние	Пропуски приёмов при обострении	Выбор + «особые состояния» в пищевой карте

Группа	Как распознать	Главный риск за столом	Маршрут питания
Маломобильные	Едят в жилой зоне	Холодная еда, очередь «в последнюю очередь»	Подача под готовую помощь, контроль температуры
Нуждающиеся в кормлении	Не могут есть сами	Недоедание, аспирация «на скорость»	Норма помощи 1:2 (ориентир), медленный темп
Неговорящие / малоговорящие	Не отвечают на вопрос о выборе	Подмена выбора удобством персонала	Показ порций, наблюдение, пищевая биография
С дисфагией	Покашливание, «влажный» голос, долгий приём	Аспирация, пневмония	Назначенная текстура, поза, темп (раздел 10)
С выраженным набором веса	+5 % и более за 3 месяца на препаратах	Метаболический синдром	Мониторинг, пищевая среда, без самостоятельных «диет» (раздел 13)
С расстройствами пищевого поведения	Переедание, ночное едение, пика, заглатывание	Соматические и бытовые риски	Индивидуальные протоколы (разделы 13, 14)

Таблица — проект рабочей классификации для локального использования, не нормативная документация.

6.4. Управленческий вывод

Раздел отвечает на вопрос «кого мы кормим» — и этот ответ должен быть у директора в числах до любого пилота: сколько жителей едят сами, сколько с помощью, сколько неговорящих, сколько в группе дисфагического риска, сколько на весогенных препаратах. Эти пять чисел (форма — в приложении 35, дашборд) определяют и норму помощи за столом (раздел 28), и инструменты выбора (раздел 15), и клинический контур (разделы 9–14). Дом, который не знает этих чисел, планирует питание для абстракции.

6.5. Почему «средний житель» — опасная конструкция

Планирование «средней порции для среднего жителя» систематически промахивается в обе стороны, и промахи не компенсируют друг друга, а складываются. Житель с гиперфагией получает «среднее» и ищет еду ночью и в чужих тарелках (раздел 13); житель в депрессивной фазе получает «среднее» и оставляет две трети — отходы растут, вес падает, а учёт видит «норму», потому что средняя цифра съеденного по отделению остаётся прежней: одного перекормили, другого недокормили, в среднем — порядок. Единственная защита от этой арифметики — распределение вместо среднего: не «сколько в среднем оставляют», а «сколько жителей оставляют больше трети порции». Форма замера (приложение 25) построена именно так: построчно, а не одной суммой.

6.6. Контингент меняется — карта стареет

Пять чисел контингента не константа: контингент стареет, доля постельных и помощных растёт, назначения меняются. Числа, собранные год назад, планируют питание для людей, которых уже нет. Поэтому квартальное обновление — не бюрократия, а калибровка прицела; самый дорогой вид старения карты — рост группы помощи без роста ставок: он проявляется сначала в темпе кормления, потом в весе жителей, и только потом, если повезёт, в документах. ## 6.7. Как собрать пять чисел за один обход

Пять чисел раздела (едят сами / с помощью / неговорящие / группа дисфагического риска / на весогенных препаратах) не требуют ни статистика, ни недели работы. Порядок сбора — один обход с заведующими отделениями, полтора часа: по каждому отделению заведующая отвечает из головы, ответ сверяется с листом жителей. Точность «из головы» здесь — не дефект метода, а его смысл: если заведующая не может назвать число кормимых своего отделения, это самостоятельная находка, важнее самого числа. Второй проход — с врачом: список препаратов с весогенным профилем (по таблице раздела 11) и список назначенных текстур. Третий проход — со старшими сменами: кто оставляет еду, кто ест ночью, кто «не ест в зале». Три прохода дают не учётную ведомость, а живую карту контингента, которой достаточно для

решений разделов 19–20. Обновление — раз в квартал, одной строкой в панели (приложение 35).

7. Что значит «накормить»

7.1. Шесть измерений одной тарелки

Слово «накормить» в управленческой речи обычно означает одно: порция соответствует норме и съедена. Этого недостаточно, и не по гуманистическим причинам, а потому что одномерное «накормить» систематически производит недоедание, конфликты и нарушения. Разложим тарелку на шесть измерений; у каждого — свои нормы, свои провалы и свои измерители.

1. Достаточность. Порция по весу и составу покрывает норму питания: рекомендуемые нормы Минтруда (приказ № 520н) и региональные нормы, принятые на их основе³⁰¹²¹³. Измеритель — не раскладка на бумаге, а фактическое потребление: порция, выданная и не съеденная, достаточностью не является. Именно поэтому замер остатков (приложение 25) — первый инструмент доклада: он заменяет вопрос «сколько мы даём» вопросом «сколько доходит».

2. Безопасность. Три слоя. Санитарный: пробы, температуры, отдельные потоки, питьевой режим — требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 к организациям соцобслуживания². Клинический: назначенные текстуры для дисфагии (раздел 10), лекарственно-пищевые ограничения (раздел 11). Поведенческий: защита от заглатывания, пика, отбирания еды (раздел 14). Провал любого слоя — это не «недовольство качеством», а предмет ответственности (раздел 33)¹¹.

3. Удовольствие. Вкус, температура, внешний вид, разнообразие. В системе, где еда — главный ежедневный опыт жителя, удовольствие от еды — не роскошь, а фактор потребления: невкусная еда съедается хуже, и недоедание возникает при формально достаточных нормах. Международные нормы прямо связывают качество и привлекательность блюд с нутритивными исходами³¹³². Измеритель у нас дешёвый: те же остатки и жалобы жителей.

4. Социальность. Еда как совместное событие: разговор за столом, общий ритм, участие персонала. Финская национальная рекомендация закрепляет совместные трапезы персонала и проживающих как элемент качества³³;

голландское рандомизированное исследование семейной подачи показало рост качества жизни и потребления энергии именно за счёт социальной организации стола³⁴. В наших условиях социальность — ещё и бесплатный мониторинг: работник за общим столом замечает «он сегодня не жуёт» раньше любого журнала.

5. Самостоятельность. Еда как навык: самостоятельно пройти линию раздачи, выбрать, поесть приборами, убрать за собой. Для части жителей — это реабилитационная задача, прямо связанная с перспективой перевода в сопровождаемое проживание (в России такие программы действуют и расширяются²⁰). Организация стола, делающая всё за человека, закрепляет зависимость; поточная линия с самообслуживанием, как отмечает одно из российских учреждений, «развивает навыки самообслуживания»²¹.

6. Выбор. Еда как решение самого человека: что, когда, где и как есть — формула австралийского стандарта «Еда и питание»³⁵. Выбор — единственное измерение, которое нельзя делегировать: всё остальное за человека может сделать система, решение — нет. Именно здесь пересекаются право (разделы 16–17), технология (разделы 19–22) и тема семинара.

7.2. Матрица провалов

Каждое измерение имеет типовой провал, видимый без специальных обследований:

Измерение	Типовой провал	Быстрый измеритель
Достаточность	Норма на бумаге, недоедание на тарелке	Доля несъеденных порций (7-дневный замер)
Безопасность	Журналы есть, контроль имитируется	Сверка фактических проб с графиком без предупреждения
Удовольствие	«Столовая» еда, однообразие	Блюда-аутсайдеры по остаткам; жалобы
Социальность	Столовая как конвейер, тишина или команды	Наблюдение за одним обедом: есть ли разговор
Самостоятельность	Всё делают за жителя	Доля жителей, проходящих линию сами

Измерение	Типовой провал	Быстрый измеритель
Выбор	Решает кухня	Ответ жителя на вопрос «что ты сегодня выбрал?»

7.3. Управленческий вывод

«Накормить» — это шесть задач, а не одна. Директор, получающий отчёт «питание в порядке», должен спрашивать: по которому из шести измерений? Минимальная грамотность темы — различать их и знать, что деньги решают в основном первые три, а последние три — организацию и документы. Вариативное питание, о котором пойдёт речь дальше, — это не шестое измерение вместо остальных: оно работает только когда первые пять не провалены.

7.4. Проверка каждого измерения на вашей линии

Шесть измерений «накормить» превращаются в шесть проверок по десять минут — их можно пройти за один день, и проходить их стоит не директору, а тому, кто будет честен: **безопасность** — постоять у линии и сосчитать, сколько жителей из списка риска едят вне поля зрения смены; **физиология** — сверить время ужина и завтрака с шведским ориентиром ночного интервала (не более 11 часов³¹: ужин 17:30 + завтрак 8:30 = 15 часов голода, и это не экзотика, а типовой распорядок); **психология** — спросить у трёх жителей «что сегодня было на обед» вечером: не помнят или «как обычно» — еда не доходит до сознания, она фон; **социальность** — посмотреть, ест ли персонал одновременно с жителями или «потом, на кухне»: второй ответ точно описывает культуру стола; **право** — проверка реальности выбора (приложение 24); **экономика** — сырьевая строка за минуту деления (приложение 25). Шесть проверок не требуют ни рубля и дают карту, по которой видно, какое измерение в вашем доме провалено первым, — начинать надо с него, а не с самого красивого проекта.

7.5. Граница измерений: что не входит

Два соседних понятия сознательно оставлены за рамкой. **Кулинарное качество** (вкус как искусство) — важно, но не является предметом системы: система обязана гарантировать свежесть, температуру и

соответствие рецептуре, а субъективный вкус корректируется через совет жителей и дегустации (раздел 34), а не через нормативы. **Медицинская нутрициология** в полном объёме (нутриентный расчёт под заболевания) — компетенция врача и, где есть, диетолога; доклад ограничивается организацией исполнения назначений, не подменяя их содержание. Эти две границы защищают доклад от двух крайностей: кулинарного эстетства и псевдомедицины.

7.6. Минимальная планка каждого измерения

Если ресурса хватает на одно действие в измерении — вот эти шесть действий: безопасность — список риска на посту; физиология — ночной интервал ≤ 13 часов (в пределах международного диапазона 11–14 часов, подробнее — раздел 26); психология — показ меню каждому ежедневно; социальность — один «тихий стол» в зале; право — журнал замен; экономика — посчитанная сырьевая строка. Шесть действий не доводят ни одно измерение до идеала — они выводят каждое из зоны отказа. Именно так собирается минимальная безопасная модель раздела 4: не совершенство в одном и провал в пяти, а планка в шести.

8. От мономеню к вариативности: лестница моделей

8.1. Термины, чтобы не путаться

В обсуждениях смешивают четыре разных вещи. **Цикличное меню** — повторяющийся цикл блюд (14 дней по российским раскладкам, 21 день в Онтарио, 4 недели по немецкому стандарту)²¹²³³²: оно про разнообразие во времени, но не про выбор. **Вариативное меню** — наличие в одной точке приёма пищи более одного варианта блюда, из которых житель выбирает. **Замена по таблице** — технический механизм эквивалентной замены продуктов в раскладке, существующий в нормах десятилетиями¹²¹³: он делает вариативность законной, но сам по себе выбором жителя не является. **Персонализация** — индивидуальные назначения (текстуры, ограничения, усиленное питание) вне общего выбора.

Типовая ошибка: назвать «вариативным» цикличное меню («у нас 14 дней без повторов — вот и вариативность») или таблицу замен («мы заменяем гречку на рис по остаткам — вот и выбор»). Обе конструкции не содержат выбора жителя. Доклад использует слово «вариативность» строго: житель в момент приёма пищи имеет реальную возможность получить не менее двух вариантов и влияет на то, какой получит.

8.2. Лестница моделей

Между мономеню и «полным выбором» — не пропасть, а лестница. Каждая ступень — работающая модель с известной ценой и рисками; две нижние подтверждены российской практикой⁴⁵⁶.

Ступень 0. Мономеню с учётом отказов. Выбора нет, но отказ от блюда влечёт замену по таблице (житель не остаётся голодным), а остатки систематически разбираются и влияют на цикл. Это не вариативность, но её фундамент: американская федеральная норма требует альтернативу при отказе как базовый минимум³⁶.

Ступень 1. Выбор из двух вариантов в одной позиции. Один второй вариант ключевого блюда (каша А/каша Б, второе А/второе Б) на части приёмов пищи и части дней недели. Подтверждённая российская конфигурация старта: Болотнинский ПНИ — «несколько раз в неделю»,

завтрак и обед, перечень определяет диетсестра⁴. Цена: вторая гастрорёмкость, журнал заказа; новых денег при парных эквивалентах практически нет (раздел 29).

Ступень 2. Выбор по всем основным позициям ежедневно. Два варианта первых, вторых, гарниров, напитков — ежедневно. Подтверждённая конфигурация: Успенский ПНИ (все отделения)⁵ и региональная модель Иркутской области¹⁴. Требуется отлаженный журнал заказа и пересчёта объёмов по статистике выбора (раздел 21).

Ступень 3. Выбор на линии раздачи («шведский стол»). Житель комплектует тарелку на линии из выставленного ассортимента. Больше выбора — больше требований: площадь раздачи, скорость потока, санитарный контроль открытых блюд². Для ПНИ применима выборочно (буфетная зона салатов/напитков/десертов), что и делают российские учреждения⁵²¹.

Ступень 4. Семейная подача за столом. Общие блюда на столе, жители накладывают сами. Доказанный эффект у пожилых с деменцией (качество жизни, вес, потребление энергии)³⁴; для наших отделений — точно, там, где рассадка и поведение позволяют. Меняет роль персонала: от раздачи к сопровождению.

Ступень 5. «Своя кухня». Жители готовят сами при поддержке персонала: британская практика self-catering на реабилитационных отделениях³⁷ и американская модель малых домов Green House²⁶. Для нас — горизонт квартир тренинга жизненных навыков и подготовки к сопровождаемому проживанию, а не массовая модель.

8.3. Критерии реального выбора

Внедрение любой ступени проверяется пятью критериями; формальная «вариативность» отсеивается ими безошибочно (раздел 22 и приложение 24):

1. **Доступность:** вариант Б физически существует, когда подходит житель, а не «закончился к первому отделению».

2. **Равноценность:** варианты эквивалентны по питательной ценности — замена по таблице, а не «гречка или ничего»¹².
3. **Информированность:** житель знает о выборе и понимает его доступным способом (слово, показ, визуальное меню).
4. **Уважение:** выбранное реально подаётся; переубеждать «для вашей пользы» — не норма.
5. **Учёт:** выбор фиксируется и влияет на завтрашние объёмы и будущие циклы меню.

8.4. Управленческий вывод

Не существует вопроса «вводить ли вариативность» — существует вопрос «какая ступень нам по силам в этом году». Лестница позволяет начать там, где вы стоите: дом с хаотичными журналами начинается со ступени 0; дом с порядком в документах — со ступени 1 на одном отделении; дом с устоявшимся пилотом — со ступени 2. Российские подтверждённые практики занимают ступени 1–2⁴⁵⁶¹⁴: это и есть реалистичный горизонт большинства участников семинара на ближайший год.

8.5. Движение вниз по лестнице: тихий регресс

Лестница работает в обе стороны, и движение вниз — более частый сюжет, чем движение вверх. Типовая механика регресса из трёх шагов: уходит инициатор (заведующая, диетсестра) → процедура показа меню «временно» упрощается → через квартал журнал ведётся «для проверки», а выбор снова делает кухня. Внешне организация остаётся «внедрившей» — положение-то действует. Признаки регресса читаются в панели чисел раньше, чем в жалобах: падает доля выбирающих, растёт доля «стандартных», журнал срывов пустеет (не потому что срывов нет, а потому что записывать перестали). Противоядие одно: владение ступенью закрепляется не человеком, а документом и ритмом — приказ, ротация ответственных, квартальная панель (раздел 31). Практика, которая пережила смену двух заведующих, считается устоявшейся; до этого рубежа она — проект конкретного энтузиаста.

8.6. Лестница участия жителя: критерий измерения

Не путайте эту лестницу с лестницей моделей раздела 8.2: там ступени — способы организации раздачи (два варианта, шведский стол, семейная подача, своя кухня), здесь — мера контроля над едой, возвращённого жителю. Это разные оси, и их ступени не совпадают по номерам. Любая ступень измеряется в конечном счёте одним вопросом: что изменилось в тарелке конкретного жителя сегодня? Проверка ступени через жителя, а не через документ: на нулевой — его еда определена тремя ступенями чужих решений (регион — кухня — смена); на первой — его спросили, но тарелка та же; на второй — его выбор дошёл до тарелки сегодня; на третьей — до неё дошли ещё время и место; на четвёртой — он влияет на меню через совет; на пятой — еда снова часть его жизни, а не процедуры. Вопрос «на какой мы ступени» звучит абстрактно до тех пор, пока не задаётся про одного жителя по имени — дальше он звучит как план. ## 8.7. Как определить свою ступень за 15 минут

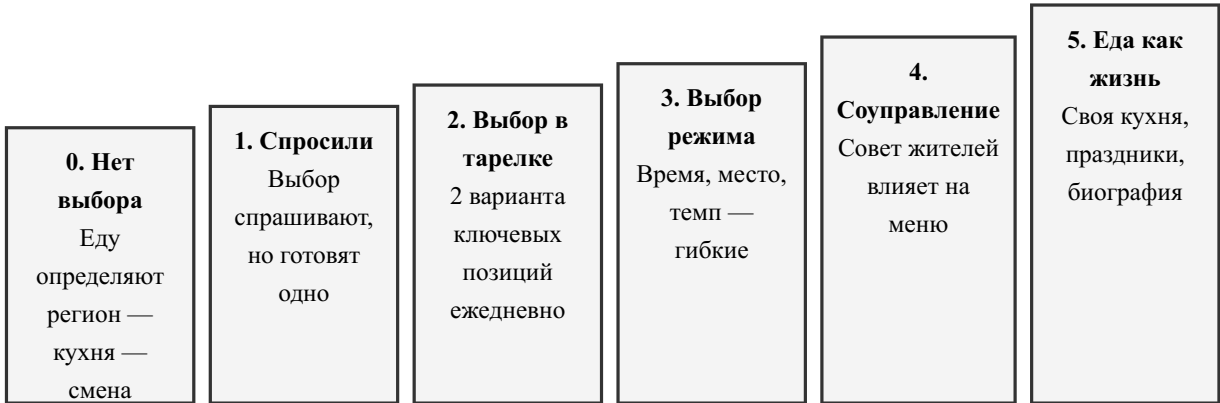
Самооценка завышает ступень почти всегда: «у нас выбор» на поверку оказывается «у нас спрашивают, но готовят одно». Объективная процедура — три вопроса к фактам, а не к ощущениям. Первый: **покажите вчерашний журнал** — если выбор не зафиксирован вчера, ступень не выше первой, что бы ни говорило положение. Второй: **был ли второй вариант физически на линии вчера** — спросить смену, сверить с журналом срывов. Третий: **кто из жителей вчера выбрал не то, что ему принесли бы по умолчанию** — если ответ «таких нет» третью неделю, выбор декоративен. Ответы ставят организацию на ступень без субъективности. Полная форма самоопределения входит в семинарский пакет (форма ступени); в докладе достаточно правила: ступень определяется вчерашним днём, а не принятым положением.

8.8. Еда как навык сопровождаемого проживания

Сопровождаемое проживание в системе уже не гипотеза: порядка семи тысяч человек вышли из ПНИ в такие программы²⁰. Человек, десятилетиями не выбиравший даже кашу, на выходе сталкивается с магазином и плитой как с чужим языком. Ступени 3–5 лестницы (время и место, совет, своя кухня) — не «ресторан для интерната», а тренировка

бытового решения: назвать, показать, отказаться, убрать за собой. Вариативное меню внутри учреждения и развитие менее институциональных форм жизни не конкурируют: первое готовит навык, без которого второе остаётся лозунгом. Для большинства домов ближайший год — ступени 1–2; ступень 5 остаётся горизонтом квартир тренинга, а не массовой моделью (раздел 8.2).

Рисунок 4. Лестница вариативности: шесть ступеней



Ступень организации определяется вчерашним днём (журнал, линия, жители), а не принятым положением. Каждая ступень проверяется пятью критериями реального выбора (раздел 8).

Модель доклада; критерии собраны из норм Онтарио, США (42 CFR §483.60), Австралии (Стандарт 6) и подтверждённых российских практик, 2024–2026.

9. Пищевое поведение при психических расстройствах

9.1. Почему обычные правила здесь работают иначе

Стационарное питание спроектировано для «среднего едока»: он приходит вовремя, сидит 20–30 минут, ест то, что дал, сообщает, если что-то не так. Психические расстройства ломают каждое из этих допущений — не изредка, а системно. Этот раздел фиксирует паттерны, которые организация стола обязана предвидеть; следующие разделы дают по каждому протокол.

Принципиальная рамка: паттерн пищевого поведения — это симптом, лекарственный эффект или их комбинация, а не характер жителя. От этого зависит реакция: на симптом отвечает врач, на лекарственный эффект — врач с кухней, на организационный сбой — администрация. Ни один паттерн не отвечает «дисциплинарным» воздействием.

9.2. Паттерны и их механизмы

Снижение интереса к еде (депрессия). Человек не «отказывается» — еда перестаёт быть значимой; тарелка отодвигается без комментария. Риск — тихое недоедание, которое обнаруживается по весу через месяцы. Реакция: журнал потребления и триггеры веса (раздел 12), а при длительном снижении — врачебный пересмотр; немецко-австрийский стандарт для таких состояний предусматривает режим «пищи по желанию» (Wunschkost) — приоритет мотивации есть над нутритивной строгостью²⁹³⁸.

Подозрительность к пище (психоз). Еда «отравлена», «не та», «с запахом». Реакция «убедить» не работает. Работают: запечатанная упаковка, блюдо из общего котла на глазах, выбор между двумя порциями, участие доверенного человека, иногда — приём пищи вне столовой. Каждый эпизод фиксируется врачу: стойкая подозрительность к еде — симптом, влияющий на план лечения.

Возбуждение и мания. Нет времени есть: два укуса на ходу — и ушёл. Реакция: питание «мало и часто», finger food (британское руководство BDA предусматривает меню, съедобное без приборов, именно для таких состояний)³⁷, приём в отдельной комнате, отложенная порция. Норма «обед

с 13:00 до 13:30» здесь просто неприменима — нужен отложенный доступ, что требуют и британские, и австралийские стандарты³⁹³⁵.

Седация. Утренние препараты с седацией делают ранний завтрак недоступным: человек спит в часы еды и «опаздывает». Реакция — гибкое окно завтрака и отложенная порция (прямая рекомендация BDA)³⁷; австралийский стандарт закрепляет доступность еды и перекусов круглосуточно³⁵. Карательная логика «опоздал — остался голодным» здесь является нарушением базовой доступности питания, а не дисциплинарной мерой.

Ригидность и сенсорные особенности (РАС, умственная отсталость). Узкий круг «безопасных» блюд, невозможность смешанных текстур, чувствительность к виду, запаху, температуре, посуде, соседям по столу. Реакция: расширение рациона постепенно, без насилия; обязательное наличие «безопасного» варианта в каждом приёме; учёт сенсорных параметров в пищевой карте. Для таких жителей вариативность «в лоб» (два незнакомых блюда) не работает — выбор строится внутри привычного ряда с постепенным расширением.

Быстрое заглатывание. Пища проглатывается почти без жевания — за считанные минуты. Риски: аспирация, удушье, рвота, отбирание еды у соседей «по инерции». Реакция: небольшие порции с добавкой, питьё между глотками, посадка рядом с работником, исключение сухих крупных кусков; наблюдение — в протоколе дисфагии (раздел 10), потому что механика риска та же.

Переедание и гиперфагия. Разобран отдельно в разделе 13 — там он связан с препаратами и метаболикой.

Прятание и «хомячение». Еда уносится и прячется: в тумбочку, под матрас. Причины разные: опыт голода, тревога, симптоматика, ночное едение (раздел 13). Реакция — не изъятие, а легализация: доступный перекус на посту снимает мотивацию прятать; санитарные правила исполняются через замену запасов, а не конфискацию.

Избирательность «всё или ничего». Съедается только любимое блюдо дня; остальное — нет. Реакция: учёт в пищевой карте, планирование цикла

так, чтобы «опорные» блюда появлялись регулярно, постепенное расширение через парные предложения.

9.3. Что это меняет в организации стола

Три следствия. Первое: **журнал потребления — не бюрократия, а диагностический инструмент**: паттерны видны только в записи (кто, что, сколько, как часто), и он должен читаться врачом еженедельно. Второе: **«особые состояния» — штатный режим**: у каждого жителя с волнообразным течением в пищевой карте прописано, что происходит с его едой при обострении и что помогало раньше (приложение 3). Третье: **гибкость по времени и месту — часть безопасности**, а не поблажка: отложенные порции, отдельные столы, приём в жилой зоне должны быть предусмотрены положением о питании, иначе они будут нарушением распорядка.

9.4. Границы раздела

Доклад не ставит диагнозов и не описывает лечения. Всё, что касается клиники здесь и далее, — уровень организации питания и наблюдения: что должны заметить сиделка и повар, что обязан зафиксировать журнал, когда срабатывает эскалация к врачу. Правило эскалации едино для всей клинической части: организация не лечит, но обязана видеть, фиксировать и передавать врачу.

9.5. Ограничение: паттерн ≠ диагноз

Обратная ошибка — психологизация всего: «он ест быстро, потому что в детстве голодал». Правило смены простое: наблюдаемое фиксируется как наблюдаемое («съедает за 3–4 минуты, не прожёвывает»), а интерпретации («почему») — территория врача и психолога. В журнале и карте живут факты; гипотезы — в беседе с врачом. Это разграничение защищает и жителя (от стигматизирующих ярлыков), и смену (от выхода за пределы компетенции, раздел 28).

9.6. Питание при обострениях: заготовленный режим

Волнообразное течение — норма психических расстройств, а значит, «особый режим питания на период обострения» должен быть заготовлен до обострения, а не изобретаться в его разгар. Заготовка — три строки в пищевой карте: что происходит с едой у этого жителя при ухудшении (отказывает / объедается / перестаёт выходить в зал / всё кажется отравленным); что помогало раньше (конкретные форматы, продукты, люди); кто принимает решение о переходе на режим и обратно (врач). Наличие трёх строк превращает обострение из импровизации смены в исполнение плана; отсутствие — гарантирует, что каждый эпизод будет прожит заново, с теми же ошибками. Проверка готовности дома простая: попросить трёх заведующих показать эти строки у трёх жителей с волнообразным течением. Если показывать нечего — вот первая задача клинического контура на месяц, важнее любого нового блюда. ## 9.7. Паттерны по сменам: что видит пост и что с этим делать

Эпидемиология паттернов даёт диапазоны, но работа поста начинается с узнавания конкретных сцен. Данные систематических обзоров: переедание при тяжёлых психических расстройствах встречается у 4,4–45 % в зависимости от диагноза и инструмента, тяга к еде — у 16,1–64 %, ночное едение — у 4–30 %⁴⁰; широта диапазонов — само по себе сообщение: «средней частоты» нет, есть частота вашего контингента, и мерить её нужно самим. Четыре рабочих сцена и их прочтение: житель съедает всё за минуты и просит ещё — не «жадность», а возможная гиперфагия терапии (раздел 13) → врач и структурированная доступность; житель прячет еду в тумбочку — часто опыт дефицита (биография, приложение 3) → не отбирать, а обеспечить легальный «запас» из допустимого; житель ест только белое/только мягкое — сенсорная селективность → пары эквивалентов внутри допустимого спектра, а не ломка; житель ест только у себя в комнате — социальная перегрузка зала → право на место, а не принуждение к залу. Каждый сцен — это не нарушение дисциплины, а информация о механизме; пост, обученный такому прочтению, перестаёт быть надзирателем и становится первым диагностом системы.

10. Дисфагия и риск аспирации: скрытая эпидемия стационарного стола

10.1. Масштаб, о котором не говорят

Расстройство глотания (дисфагия) при психических расстройствах встречается, по разным исследованиям, у 21,9–69,5 % пациентов — разброс объясняется разными популяциями и методами скрининга, но даже нижняя граница означает: каждый пятый житель¹⁵⁹. При этом в типовом ПНИ нет ни логопеда, ни скрининга, ни назначенных текстур: дисфагия остаётся невидимой до первой тяжёлой пневмонии.

Цена невидимости измерена. Смертность от пневмонии у людей с тяжёлыми психическими расстройствами в семь раз выше популяционной (RR 7,00 по национальным когортным данным), и аспирация — ключевой механизм этого разрыва⁸. Общий разрыв продолжительности жизни при тяжёлых психических расстройствах — 15–20 лет, и значимая его часть связана с причинами, на которые влияет организация стола⁸. Это главный аргумент раздела: дисфагия — не «удобство еды», а вопрос смертности.

10.2. Откуда берётся дисфагия при психических расстройствах

Механизмов шесть, и все они встречаются в наших учреждениях одновременно:

- 1. Лекарственные:** антипсихотики вызывают экстрапирамидные нарушения мускулатуры глотания и сухость рта (ксеростомия), седация замедляет глотательный рефлекс⁹.
- 2. Болезненные:** само течение расстройства нарушает координацию «жевание — глоток — дыхание».
- 3. Поведенческие:** быстрое заглатывание без жевания (раздел 9) перегружает глотание.
- 4. Возрастные:** 65 % жителей старше 45 лет²⁰; саркопения и старческая дисфагия накладываются на всё вышеперечисленное.
- 5. Сопутствующие состояния:** последствия инсультов, болезнь Паркинсона, деменция, эпилепсия.

6. Стоматологические: отсутствие зубов и плохие протезы превращают «жевательную» задачу в «глотательную».

Вывод для директора: дисфагия в ПНИ — не редкая индивидуальная особенность, а статистически ожидаемое явление, которое система обязана искать.

10.3. Признаки, которые видит сиделка без логопеда

Скрининговый уровень не требует специалиста — требуется обученный глаз и правило записи. Тревожные признаки за столом: покашливание или поперхивание во время или после еды; «влажный», булькающий голос после глотка; многократное проглатывание одного куска; еда «за щекой»; необычно долгий приём пищи; отказ от определённых текстур (твёрдого, сухого) при сохранном аппетите; повторные пневмонии в анамнезе⁹⁴¹. Любой из них — повод для врачебной оценки и простого теста с водой; несколько — для немедленной коррекции подачи до выяснения.

10.4. Текстуры: система IDDSI и её измеримый эффект

Международный стандарт описания текстур — IDDSI (восемь уровней: напитки — уровни 0–4, пища — уровни 3–7): он переводит размытое «протёртое» в проверяемые категории с простыми тестами (вилка, ложка, наклон)⁴². Доказательная база внедрения измерима: интервенционное исследование в пяти учреждениях подняло соответствие фактически поданных текстур назначенным с 44 % до 90 %, для загущённых жидкостей — с 31 % до 100 %, с сохранением эффекта через 6 месяцев; главным барьером была не техника, а осведомлённость персонала⁴³. Это значит: программа по дисфагии начинается не с блендера, а с обучения смены — и измеряется долей правильных текстур на реальных тарелках (проверка — пункт чек-листа пищеблока, приложение 19).

10.5. Организационный пакет без логопеда

Что делает учреждение, у которого нет реабилитолога (то есть почти каждое):

1. **Список риска:** по признакам раздела 10.3 врач формирует список жителей группы дисфагического риска; список живёт на посту и в кухне, а не в истории болезни.
2. **Назначенные текстуры:** врач назначает текстуру поимённо (мягкая, протёртая, загущённые жидкости) с датой пересмотра; кухня маркирует порции.
3. **Правила стола для группы риска:** вертикальная поза, медленный темп, малые глотки, отсутствие спешки и разговоров «на бегу», питьё доступно в течение всего приёма, наблюдение работника до конца еды.
4. **Достоинство текстур:** протёртая еда не должна выглядеть наказанием — австралийская практика требует подачи в формах, имитирующих обычные блюда⁴⁴.
5. **«Осознанный риск»:** если житель с дисфагией настаивает на обычной пище — это оформляется информированным решением с врачом, а не самостоятельностью сиделки и не насилием⁴⁴.

10.6. Связка с вариативностью

Дисфагия не отменяет выбор — она переносит его внутрь назначенной текстуры: два варианта протёртого второго вместо одного. Технически это просто (та же пара эквивалентов, раздел 19), а по эффекту — единственный способ сохранить право на выбор для группы, которая рискует потерять и здоровье, и голос одновременно. В пищевой карте (приложение 3) текстура и её основание фиксируются отдельным разделом с датой пересмотра.

10.7. Жидкости: забытая половина дисфагии

Разговоры о текстурах почти всегда — про еду, а между тем загущение жидкостей — самостоятельный контур с собственными уровнями IDDSI и собственными рисками: именно по жидкостям в исследовании внедрения был самый низкий старт (31 % соответствия) и самый большой эффект обучения (до 100 %)⁴³. Практический минимум: загуститель на кухне по

назначениям, тест стекания с вилки/ложки перед выдачей, кружки с клапанами — по показаниям. И запрет-правило: «просто меньше пить» — не решение, а путь к обезвоживанию, которое у пожилого жителя само по себе провоцирует и пневмонии, и делирий. Доказательная оговорка усиливает правило: загущённые напитки снижают потребление жидкости и создают нагрузку лечения, а убедительных данных о снижении респираторных осложнений при их рутинном применении нет⁴⁵⁴⁶ — поэтому «загустить и забыть» худшая из стратегий, а назначение текстуры напитка — решение врача с пересмотром, а не навсегда.

Что организация может мониторить без врача: фактический объём выпитого за сутки (маркированная посуда или простая ведомость — «стакан» как единица учёта), регулярные предложения жидкости между приёмами пищи (чайная пауза между основными приёмами — для лежачих и при жаре), у жителей на загущённых напитках — индикаторы дегидратации на посту (тёмная моча, сухость языка, сонливость вне режима). Строка в панели раздела 22 — «выпито за сутки, мл (или стаканов), среднее по группе риска». Это дешёвый способ поймать самый частый скрытый дефицит учреждения.

Там, где врач считает риск аспирации чистой воды приемлемым, международная практика знает **протокол свободной воды** (Frazier): неограниченная чистая вода между приёмами пищи после гигиены полости рта; в остальное время — назначенная текстура⁴⁵. Это не российская норма и не самодеятельность кухни: допуск, группа и исключения назначает врач; роль организации — гигиена рта до воды и журнал объёма. Без гигиены рта протокол противопоказан: вода смывает бактериальную нагрузку в лёгкие.

10.8. Пакет «без логопеда»: что организация делает своими силами

Полный контур реабилитации глотания требует специалистов, которых у большинства СОСО нет, — это честное ограничение, а не повод для бездействия. Пакет своими силами из четырёх элементов закрывает большую часть риска. **Первый — распознавание:** шесть признаков, видимых без инструментов (кашель при еде, «мокрый» голос после глотка, длительное пережёвывание без глотания, скопление пищи за щекой,

подтекание изо рта, повторные пневмонии в анамнезе) — выучиваются сменой за один инструктаж; любой признак → запись → врач. **Второй — поза и темп:** вертикальные 90°, подбородок чуть вниз, малые глотки, паузы, 30 минут после еды без укладывания — организационные меры нулевой стоимости с документированным смыслом⁴¹. **Третий — текстура по назначению:** шкала IDDSI с тестами вилкой и наклоном⁴² осваивается поваром за одно занятие; соответствие фактической текстуры назначенной — измеримый показатель, который интервенционные исследования поднимали с 44 до 90 % именно обучением, а не оборудованием⁴³. **Четвёртый — готовность к инциденту:** алгоритм приложения 12, два обученных человека на посту в часы еды. Пределы пакета называются прямо: он не лечит дисфагию, он не заменяет инструментальную оценку, он не отменяет врача. Он делает другое: переводит организацию из состояния «не знаем, кто в риске» в состояние «знаем, наблюдаем, исполняем назначения» — а это и есть тот уровень, который спрашивает проверка и который реально спасает жизни.

10.9. Структурированный скрининг: шкала вместо «опытного глаза»

Шесть признаков раздела 10.3 — инструмент первой линии, но он зависит от наблюдателя. Там, где дисфагия вероятна (тяжёлые нарушения, повторные пневмонии, кашель при еде), наблюдение стоит дополнить валидированным инструментом. Два бесплатных кандидата: **GUSS** (Gugging Swallowing Screen) — прикроватный тест из четырёх последовательных шагов (непрямая проба, затем полужидкое, жидкость, твёрдое), валидирован против эндоскопической оценки глотания, выполняется подготовленной медсестрой⁴⁷; **EAT-10** — 10 вопросов о симптомах глотания, заполняется с жителем или в форме интервью⁴⁸. Оба дают число, которое можно записать в карту и сравнить через полгода — то есть превращают «поперхивается иногда» в измеримый показатель. Ограничение честное: оба инструмента созданы не для психиатрического контингента и требуют адаптации инструкции под конкретного жителя; решение о текстуре всё равно принимает врач. Рабочая рамка: GUSS/EAT-10 — по показаниям и при сомнениях, шесть признаков — для всех, каждый день.

10.10. Гигиена полости рта: самая дешёвая профилактика аспирационной пневмонии

Аспирационная пневмония — главный смертельный риск этого контингента (раздел 10.1), и её бактериальная нагрузка формируется прежде всего в полости рта. Это делает ежедневный уход за полостью рта у зависимых жителей не «комфортной процедурой», а клинической мерой: в РКИ на 366 проживающих домов ухода уход после каждого приёма пищи (щётка; в части случаев — обработка полости рта повидон-йодом) плюс еженедельный осмотр стоматолога снизил частоту пневмоний с 19 % до 11 %⁴⁹. Обзор, который часто цитируют как Müller 2015 (Journal of Dental Research; исходная оценка — Sjögren 2008 и van der Maarel-Wierink 2013), относит к улучшению гигиены рта предотвращение примерно каждой десятой смерти от аспирационной пневмонии у немощных пожилых⁵⁰. Перенос на ПНИ — с оговоркой популяции: это дома ухода, не психиатрия.

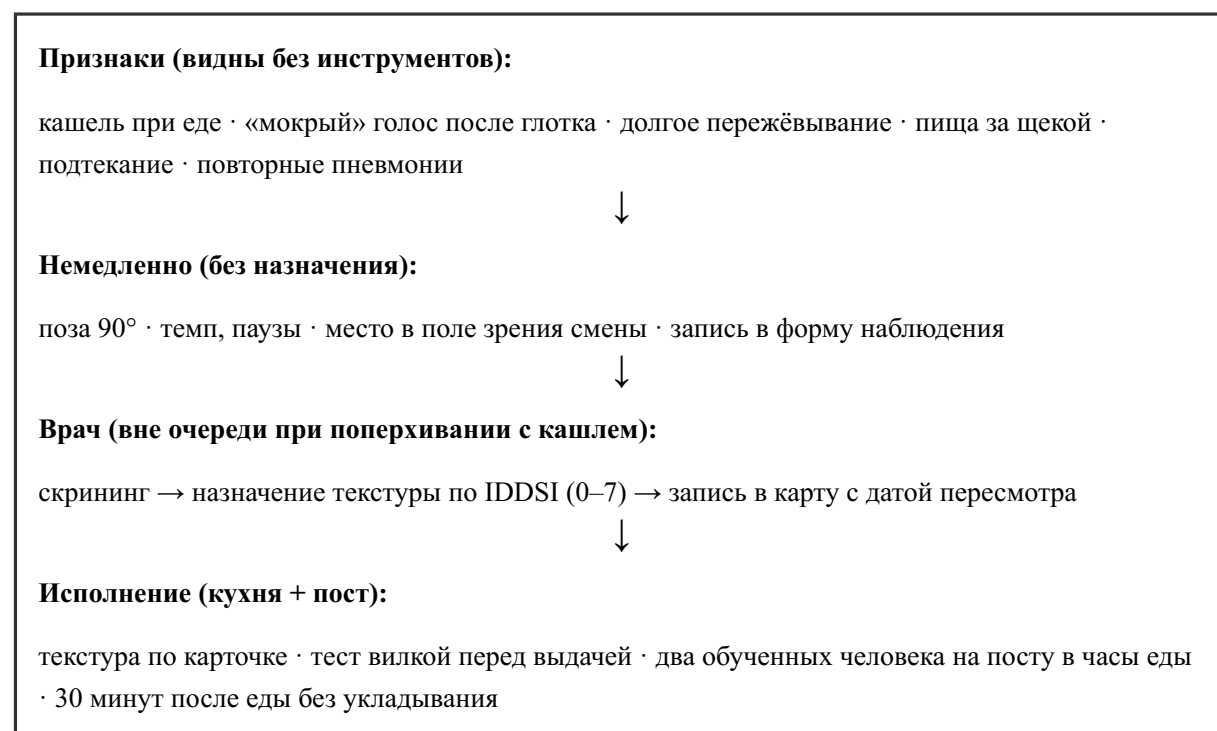
Для организации это значит не «две минуты на всех 951 место», а **группа зависимости**: уход обязателен тем, кто не чистит зубы сам (постельные, тяжёлая умственная отсталость, выраженная седация). Формула трудозатрат: число зависимых × 2–3 минуты × число приёмов пищи. На 80 зависимых и три приёма это около 8 человеко-часов в сутки — ставка, а не жест; на всех проживающих без отбора мера нереалистична и будет отвергнута залом. Практический минимум: щётка/губка и паста не «по запросу»; строка в обходе группы риска («рот осмотрен, обработан»); обучение смены. Место в панели раздела 22 — «осмотр полости рта выполнен, % группы риска». Отдельный контур — зубные протезы: плохо сидящие протезы и сухость во рту — две главные жалобы проживающих домов ухода⁵¹; протез, который мешает жевать, — частая маска «плохого аппетита» (раздел 12).

10.11. Зондовое и энтеральное питание: отдельный контур, не «без выбора»

Часть жителей получает питание через зонд или гастростому. Для них вариативность — не два вторых на линии, а **время, объём, положение, вкус разрешённых пастообразных добавок** (если врач допускает пероральные пробы) и участие в ритуале стола: сидеть со всеми, а не есть в

палате как исключённый. Прямых исследований вариативного меню при энтеральном питании в ПНИ нет — это надо сказать. Рабочая рамка: назначение смеси, скорости и положения — только врач; организация обеспечивает график, который не совпадает с пиком седации, и не использует «нельзя в столовую» как дисциплинарную меру. Любая пероральная проба при зонде — информированное решение врача, не инициатива смены.

Рисунок 9. Действия при подозрении на дисфагию



Тяжёлый эпизод (не может кашлять, синюшность) — алгоритм приложения 12: врач/скорая немедленно, приём Геймлиха обученным сотрудником.

Раздел 10; IDDSI (реестр MEDICAL_EVIDENCE: iddsi2017, iddsi_wu); распространённость дисфагии 21,9–69,5 % в группах риска.

Рисунок 28. Распространённость дисфагии: диапазоны по группам (обзоры)

Группа	Диапазон оценок	Что это значит для дома на 300 жителей
Учреждения длительного ухода (пожилые)	до ~40–70 %	десятки жителей в группе риска
Психиатрические стационары	данные фрагментарны; риск повышен терапией	список риска обязателен, независимо от точной цифры
Люди с интеллектуальными нарушениями	высокие оценки; аспирация — ведущая причина смерти	контур дисфагии = контур выживания

Диапазоны широки из-за методов выявления; доклад сознательно не даёт «одну цифру» — её нет. Практический вывод не зависит от диапазона: список риска + обученная смена + текстуры по назначению.

Источники: систематические обзоры распространённости и исходов дисфагии (реестр MEDICAL_EVIDENCE: dysph_prev, dysph_rev, dysph_dd).

11. Лекарства и еда: пять правил, которые обязана знать кухня

11.1. Принцип раздела

Взаимодействий «препарат — пища» описаны десятки, но организация стационарного питания должна держать в оперативной памяти не фармакологический справочник, а короткий перечень правил с конкретным действием для кухни, поста и меню. Каждое правило ниже снабжено классом уверенности: **(установлено)** — подтверждено исследованиями и отражено в официальных инструкциях/справочниках; **(мониторинг)** — требуется стабильность и наблюдение, а не запрет; **(рекомендация)** — разумная предосторожность профессиональных руководств.

11.2. Правило 1. Клозапин ↔ кофеин: считать чашки (установлено)

Кофеин ингибирует метаболизм клозапина: в контролируемом исследовании добавление кофеина повышало AUC клозапина в среднем на 19 %¹⁶; в клинических наблюдениях резкое увеличение потребления кофеина сопровождалось ростом концентрации до токсических значений (описан случай 1796 нг/мл)²⁴. Симметричный риск — резкая отмена привычного кофеина: падение концентрации клозапина на 37–47 % с риском потери эффекта⁵². Отдельно: курение индуцирует метаболизм клозапина и оланзапина, снижая их концентрации примерно вдвое — резкое прекращение курения без коррекции опасно¹⁶.

Действия для учреждения: в пищевой карте жителя на клозапине — привычное потребление кофе/чая/энергетиков; запрет на резкие изменения (семья предупреждается письменно, приложение 32); кофе не «награда» и не «наказание»; любое изменение привычки — информация врачу. Это же правило — часть британской лекарственно-пищевой таблицы в меню³⁷.

11.3. Правило 2. Литий ↔ соль и вода: стабильность, а не запрет (мониторинг)

Концентрация лития чувствительна к водно-солевому балансу: резкое уменьшение соли в рационе или обезвоживание повышают концентрацию до токсической (дрожь, спутанность, рвота), резкое увеличение — снижают

эффект¹⁷⁵³. Опасные сценарии в стационаре: внезапный «малосольный стол» по инициативе кухни; жара без доступа к воде; рвота/диарея; отказ от питья при обострении.

Действия: для жителей на литии — никаких изменений солевого режима без врача; доступ к воде визуально гарантирован (не «по просьбе»); при рвоте/диарее или жаре — отметка врачу в тот же день; при отказе от еды и питья — правило эскалации раздела 12 сокращается.

11.4. Правило 3. ИМАО ↔ тирамин: тираминовая разметка меню (установлено)

Неселективные ингибиторы МАО (их назначают редко, но назначают) в сочетании с тираминсодержащими продуктами вызывают гипертонический криз: выдержанные и плесневые сыры, копчёности, соления, брынза, пиво, квас домашний, соевый соус¹⁸⁵⁴. Описанные реакции — подъём давления со 160/90 до 220/115 и выше⁵⁵.

Действия: житель на ИМАО — отдельная строка в меню-потребности; кухня получает тираминовую разметку (перечень исключаемых продуктов от врача); варианты выбора для такого жителя формируются внутри безопасного множества — вариативность сохраняется полностью.

11.5. Правило 4. Грейпфрут ↔ ряд психотропных: исключить по списку (установлено)

Грейпфрут и его сок ингибируют СYP3A4 и повышают концентрации препаратов; для карбамазепина описан рост AUC порядка 40 %¹⁹. В зоне внимания также некоторые бензодиазепины и часть антипсихотиков.

Действия: простое и бесплатное — грейпфрут и грейпфрутовый сок не включаются в закупку и в меню стационара вовсе; сезонные «подарочные» фрукты от семей проверяются дежурным. Одна строка в положении о питании закрывает вопрос.

11.6. Правило 5. Алкоголь и энергетики: нулевая терпимость + серые зоны (рекомендация)

Алкоголь при приёме психотропных препаратов непредсказуемо усиливает седацию и риски; в стационаре он исключён полностью — и это должно быть прописано в правилах приёма передач. Серая зона — энергетические напитки (кофеин + стимуляторы): для клозапина они эквивалентны резкому росту кофеина (правило 1), для тревожных и биполярных состояний — провокация; доступность энергетиков в буфете стационара — организационная ошибка, которую легко устранить ассортиментным перечнем.

11.7. Лекарственно-пищевая таблица: форма

Все пять правил сводятся в одну таблицу (приложение 21): препарат — что недопустимо/что контролируется — действие кухни — действие поста — что сообщить врачу. Таблицу заполняет врач по актуальным назначениям и пересматривает при каждой смене терапии; копии — на посту, в кухне, в комнате приёма передач. Британское руководство встраивает такую таблицу непосредственно в меню и в информирование пациентов³⁷ — наша форма делает то же в рамках российского документооборота.

11.8. Чего в разделе нет

Мы не утверждаем, что перечень исчерпывающий: полный перечень взаимодействий ведёт врач. Мы не рекомендуем кухне самостоятельно трактовать инструкции: роль кухни и поста — исполнять таблицу, роль врача — её вести. И мы не превращаем правила в запрет на выбор: все пять правил определяют границы, внутри которых выбор остаётся полным.

11.9. Передачи как фармакологический канал

Комната передач — не бытовая зона, а неконтролируемая аптека, если ею не управлять: кофе, крепкий чай, энергетики, грейпфруты, копчёности, алкоголь приходят именно оттуда — с любовью и без рецепта. Порядок, согласующий права и безопасность: перечень ограничений на стенде (санитарный и лекарственный блоки отдельно), регистрация передач, хранение с маркировкой, выдача по режиму для позиций из лекарственной

таблицы. Родственникам это объясняется памяткой (приложение 32) как забота, а не подозрение: «мы проверяем передачи, потому что у вашего близкого лекарства конфликтуют с продуктами» — и большинство конфликтов гаснет на этой фразе. ## 11.10. Границы таблицы

Таблица пяти правил (приложение 21) — не справочник взаимодействий, а минимум, который обязан существовать в каждой организации. Полный справочник живёт у врача и в аптечных системах проверки; попытка повесить на пост полную фармакологию закончится тем, что не будут читать ничего. Классы уверенности в таблице — обязательный элемент: они учат смену различать «установлено» (клозапин-кофеин, литий-соль) и «осторожность по классу» (отдельные комбинации ИМАО), и не требовать от кухни одинаковой жёсткости там, где разная доказательность.

11.11. Три сценария из практики поста

Абстрактные правила взаимодействий оживают в трёх сценах, которые смена должна узнавать мгновенно. **Сцена первая — «добрый кофе».** Житель на клозапине получает в передаче термос крепкого кофе от близких — из лучших чувств. Фармакокинетика: кофеин ингибирует CYP1A2, концентрация клозапина растёт; в опубликованном случае зафиксирован уровень 1796 нг/мл с тяжёлой клиникой²⁴, а популяционные данные дают рост AUC порядка 19 % уже при обычном потреблении¹⁶. Действие смены: не конфискация со скандалом, а сообщение врачу и согласованный режим кофеина — резкая отмена тоже опасна (синдром отмены с падением концентраций на 37–47 %⁵²). **Сцена вторая — «солёные огурцы к выходным».** Житель на литии получает солёную передачу раз в неделю; натрий конкурирует с литием за выведение, колебания солевой нагрузки качают концентрацию препарата¹⁷⁵³. Действие: не запрет огурцов, а стабильность — и информация врачу. **Сцена третья — «сок вместо воды».** Грейпфрутовый сок «для витаминов» у жителя на карбамазепине: рост концентрации до 40 %¹⁹. Действие: грейпфрут исключается из меню этой группы на уровне кухни, а не на уровне памяти смены. Общий принцип трёх сцен: взаимодействия ловятся не бдительностью отдельного человека, а конструкцией — таблицей на кухне, правилом передач, маршрутом «увидел → сообщил врачу сегодня».

Рисунок 10. Выбор внутри медицинских ограничений: рамка и свобода

Назначение врача = рамка. Внутри рамки — выбор, как у всех.

└ Диета с ограничением соли → пара эквивалентов внутри диеты (2 варианта второго диетического стола)

└ Текстура IDDSI 6 → 2 варианта мягкого второго вместо одного «протёртого»

└ Лекарственное исключение (грейпфрут, кофеин-режим) → исключается на уровне меню группы, а не запрета жителю лично

└ Житель просит за рамкой → маршрут к врачу в тот же день (пересмотр назначения — его компетенция, кейс 2)

Формула для локального акта:

«Диета ограничивает множество вариантов, но не сжимает его до одного элемента».

Стык с лечебным питанием — через региональный «мост» (образец: распоряжение 19РВ-32) или локальную конструкцию раздела 17.6 до его появления.

Разделы 11, 17, 19, 24; реестр *SOURCE_REGISTRY* (S021).

Рисунок 25. Клозапин и кофеин/курение: масштаб эффектов (популяционные оценки)



Отмена кофеина: падение концентраций на 37–47 % (середина диапазона на графике). Описан случай 1796 нг/мл при тяжёлой клинике. Вывод: кофеиновый режим согласуется с врачом и не меняется резко ни в одну сторону.

Источники: Hägg et al.; case report 1796 нг/мл; обзор взаимодействий — реестр *MEDICAL_EVIDENCE*: *cloz_hagg*, *cloz_case*, *cloz_wd*. Ограничение: популяционные средние.

12. Отказ от еды: от первого пропуска до врачебного решения

12.1. Почему отказ — самая опасная бытовая ситуация

Отказ от еды в ПНИ происходит ежедневно и почти всегда обрабатывается «глазами»: кто-то заметил, кому-то сказал, кто-то решил. Между тем за отказом стоят принципиально разные состояния — от «невкусно» до депрессии, психоза, дисфагии, соматического заболевания и предсмертного периода. Цена ошибки асимметрична: пропущенный «каприз» стоит тарелки, пропущенная дисфагия или депрессия — жизни⁸⁹. Поэтому отказ должен обрабатываться алгоритмом, а не интуицией дежурного.

12.2. Классификация причин

Для практики достаточно шести корзин, каждая со своим владельцем решения:

Причина	Признаки	Владелец решения
Организационная («невкусно», «не то», «холодное»)	Избирательно, на конкретные блюда; остальное ест	Кухня + администрация
Состояние (депрессия, тревога, психоз)	Сопровождается изменением поведения, сна, контакта	Врач
Лекарственная (тошнота, седация, сухость)	Совпадает с назначением/сменой терапии	Врач
Дисфагия/соматика	Покашливание, долгий приём, боль, запор	Врач (срочно)
Осознанный отказ конкретного человека	Аргументированный, стабильный, при ясном состоянии	Житель (фиксируется)
Предсмертный период	Общее угасание, паллиативный статус	Врач + паллиативная служба

Смешение корзин — главная ошибка: «осознанный отказ» лечат как симптом, а симптом списывают на «характер».

В таблице намеренно нет отдельной строки «болит жевать» — а это одна из самых частых масок отказа: плохо сидящие протезы и сухость во рту — две

главные проблемы полости рта у проживающих домов ухода, их сообщают более половины опрошенных⁵¹. Житель, которому больно жевать, выглядит как «плохо ест твёрдое, просит мягкое» — и уходит в корзину «организационная», хотя его место в стоматологическом маршруте. Один вопрос в скрининге отказа — «болит ли жевать, мешает ли что-то во рту» — разделяет эти пути за десять секунд; состояние полости рта и протезов фиксируется в пищевом паспорте при поступлении (приложение 37).

12.3. Алгоритм эскалации

Переносимая норма существует в канадском регулировании: отказ от трёх приёмов пищи подряд и оставление значительной доли порции ($\geq 25\%$) за двумя из трёх приёмов в течение недели — формальные триггеры врачебной оценки²³⁵⁶. Мы предлагаем её как проект российского правила (это не российская норма — маркировка обязательна):

1. **Каждый отказ фиксируется** в журнале отказов (приложение 9): кто, приём, что отвергнуто, сколько съедено, поведение.
2. **Отказ → альтернатива:** в тот же приём предлагается замена по таблице (житель не остаётся голодным — норма, закреплённая в американском федеральном правиле)³⁶.
3. **Три отказа подряд → врач в тот же день.** Не «на обходе в четверг», не «завтра утром».
4. **$\geq 25\%$ порций несъедено системно за неделю → врач + пересмотр пищевой карты** (два дня).
5. **Отказ от воды или от еды и воды одновременно → немедленно.** Обезвоживание при приёме лития и ряда других препаратов — прямая угроза⁵³.
6. **Эпизод завершается записью решения:** что установлено, что назначено, когда пересмотр.

12.4. Насилие недопустимо — и что это значит юридически

«Кормить силой» в бытовом смысле недопустимо безоговорочно: это насилие, прямо противоречащее и правам пациента по ст. 37 Закона № 3185-1 (гуманное отношение, уважение человеческого достоинства), и

общим началам законодательства об охране здоровья¹. Иное — медицинское искусственное питание: решение о нём принимает врач в рамках законодательства об охране здоровья и правил оказания психиатрической помощи; это клиническая, а не административная плоскость, и доклад в неё не входит. Граница для персонала формулируется одной фразой: еду предлагают, заменяют, адаптируют, фиксируют и эскалируют — но не вводят силой.

12.5. Дееспособность и осознанный отказ

Британская модель оценивает дееспособность по конкретному решению в конкретный момент: человек с психическим расстройством может быть способен принять решение об отказе от конкретного приёма пищи — и тогда его решение фиксируется и уважается³⁹. Российская рамка различается (подробно — раздел 16): признание недееспособным не отменяет необходимости учитывать мнение, а способность выразить отношение к бытовому вопросу оценивается по существу¹. Практическая форма: осознанный отказ фиксируется словами жителя в журнале («отказался от ужина, поел в 21:00 по просьбе») — и перестаёт быть «нарушением», становясь данными.

12.6. Предсмертный период

Отдельная и трудная корзина. В паллиативной фазе нутритивные цели уступают комфорту: немецко-австрийские стандарты предусматривают режим «пищи по желанию» (Wunschkost) — приоритет того, что человек хочет и может, над нутритивной полнотой²⁹³⁸. Для ПНИ, где стареющий контингент растёт²⁰, паллиативный маршрут питания должен существовать письменно: кто определяет статус, как меняется меню, как информируется семья. Документальное оформление маршрута — в комплекте раздела 31.

12.7. Управленческий вывод

Отказ от еды — единственная ситуация стола, где промедление измеряется днями, а последствия — жизнью. Минимальный комплект: журнал отказов + правило «три подряд → врач сегодня» + альтернатива при каждом отказе + список дисфагического риска на посту. Стоимость — одна тетрадь и один

инструктаж. Отсутствие этого комплекта при тяжёлом исходе — главный документальный риск директора (раздел 33).

12.8. Что говорить жителю: фразы смены

Алгоритмы не работают без слов, а слова в момент отказа рождаются плохие: «ну что ты, давай ложечку». Рабочие формулировки, которые стоит дать смене готовыми: при отказе от блюда — «Хорошо, это уберу. Есть ещё ___, принести?» (без «почему» и без оценки); при отказе от еды — «Не будете сейчас — оставлю, скажете, когда захотите» (контроль возвращается жителю, еда сохраняется); при подозрении («отравлено») — «Я вас слышала. Скажу врачу, он придёт сегодня. Хотите, принесу в упаковке?» (без спора с содержанием). Общий принцип фраз: коротко, без уговоров, с возвратом контроля, с маршрутом. Запрещённые конструкции: «а кто будет доедать», «врач сказал надо», «в последний раз предлагаю» — каждая из них превращает приём пищи в торг, а торг проигрывается системой ежедневно.

12.9. Насилие: почему формулировка жёсткая

Запрет принудительного кормления сформулирован без оговорок сознательно. Любая схема «принуждение в исключительных случаях» в стационарной практике начинает расширяться: исключительность размывается усталостью смен и дефицитом рук. Поэтому доклад фиксирует: физическое принуждение к еде (удержание, вливание, шантаж, лишение чего-либо «пока не съешь») недопустимо всегда; истощение — клиническая ситуация, решаемая врачом (назначения, энтеральная поддержка по показаниям, госпитализация), а не силой смены. Эта позиция — прямое следствие ст. 37 закона 3185-1¹ и одновременно защита самого персонала: эпизод принудительного кормления — готовый сюжет для прокуратуры, а его отсутствие в жалобах проверяемо.

12.10. Разбор эскалации по часам

Правило «три отказа → врач сегодня» работает только с назначенными часами и фамилиями. Рабочая хронология дня: завтрак 8:30 — отказ зафиксирован в журнале к 9:00, смена предложила замену; обед 13:00 —

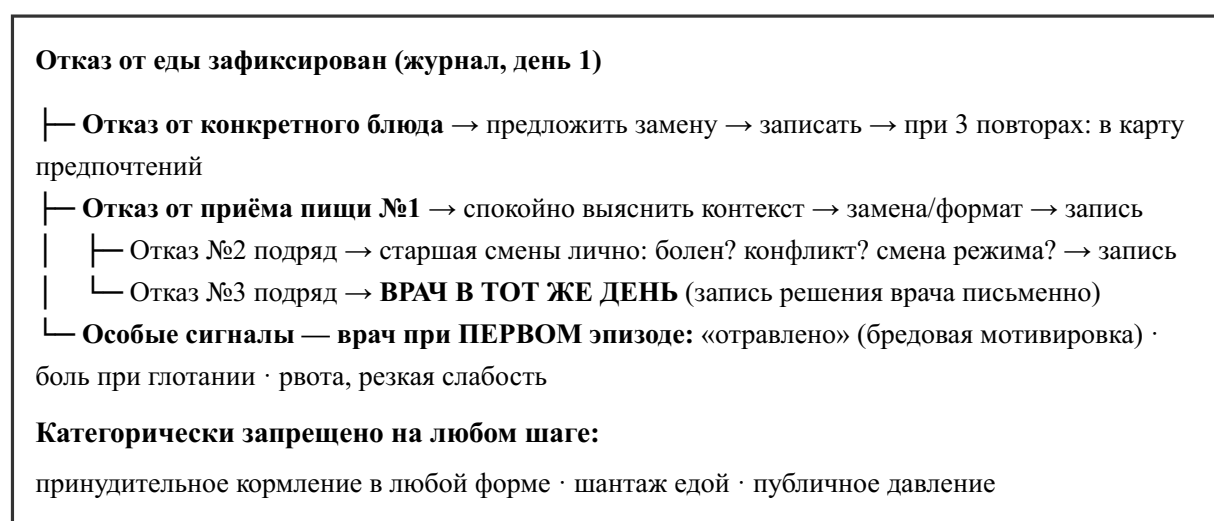
второй отказ, старшая смены лично выясняет контекст до 14:00 (болен? конфликт? «отравлено»?); ужин 17:30 — третий отказ; 18:00 — сообщение дежурному врачу или врачу по телефону; решение врача фиксируется письменно тем же вечером. Три провальных точки этой хронологии: «подождём утреннего обхода» (обход может быть через сутки — для бредовой мотивировки это поздно); «передадим устно со смены на смену» (устная передача теряет второй отказ, и счёт начинается с нуля); «врач скажет — наблюдайте» без записи (наблюдение без критериев — не решение; запись должна содержать: что наблюдать, как часто, когда пересмотр). Эскалация — не проявление паники, а штатный маршрут: врач, получающий три-четыре таких сообщения в месяц, получает их как рабочий поток; врач, не получающий их никогда, должен спросить, ведётся ли журнал.

12.11. Паллиативное питание: comfort feeding и границы искусственного питания

В предсмертном периоде (12.6) отказ от еды — не патология, а часть процесса, и главный вопрос не «как накормить», а «что еда делает для человека». Международная практика выработала рамку **comfort feeding** (комфортное кормление): еда и питьё предлагаются, пока приносят комфорт — любимые блюда, малые порции, помощь и время — без принуждения и без искусственного питания против воли⁵⁷. Данные по исходам ограничены и должны читаться точно: ретроспективное госпитальное исследование выживаемости после рекомендаций comfort feeding выполнено без группы сравнения — среди глубоко паллиативных госпитализированных пациентов с деменцией медиана выживаемости составила всего 13 дней⁵⁸; исследование описывает исходы в этой популяции, а не сравнивает режимы кормления, и вывода «comfort feeding не меняет выживаемость» оно не содержит. Систематический обзор вариантов перорального питания при деменции (в т.ч. пищевой поддержки и обучения питанию) фиксирует прибавку веса при высококалорийных добавках и отсутствие доказанных эффектов на другие исходы — и сильную роль предпочтений и культуры ухода⁵⁷. Итого: рамка comfort feeding меняет качество процесса, а не доказанно влияет на его длительность. Для российского локального акта

это переводится в три строки: (1) формат питания в конце жизни определяет врач с семьёй и, где возможно, с жителем; (2) любимые блюда и доступные текстуры — не «поблажка», а элемент паллиативного контура; (3) отказ от питания и его подтверждение документируются по процедурам 12.4–12.5, без изменения их рамок. *Маркировка: comfort feeding — международный ориентир, а не российская норма; зондовое и парентеральное питание — исключительно врачебное решение (раздел 18 семинарского пакета: «не без врача»).*

Рисунок 8. Действия при отказе от еды (схема-дерево)



Полный алгоритм — приложения 10–11; правовое основание: ст. 37, 43 закона № 3185-1 (гуманное обращение); клинический риск отказов — недоедание и его осложнения.

Раздел 12 доклада; реестры SOURCE_REGISTRY (S003) и MEDICAL_EVIDENCE.

13. Переедание, гиперфагия и ночное едение

13.1. Метаболическая цена антипсихотиков: что доказано

Прибавка веса на антипсихотиках — не слух и не «индивидуальная особенность», а измеренный классовый эффект с большим разбросом между препаратами. Мета-анализ 100 рандомизированных исследований (Pillinger и соавт., 2020) дал диапазон от $-0,23$ кг до $+3,01$ кг всего за шесть недель терапии¹⁰. Консенсусное определение клинически значимой прибавки (≥ 7 % массы тела) при длительном применении (около 38 недель, Campforts и соавт., 2023) достигается при клозапине у 76,3 % пациентов, при оланзапине — у 36,9 %, при рисперидоне — у 23,0 %⁵⁹. При первом эпизоде психоза скорость максимальна: долгосрочная прибавка достигает $+9,34$ кг (оланзапин) и $+7,19$ кг (клозапин)⁶⁰. Метаболический мониторинг предписан руководствами (вес, глюкоза, липиды по расписанию)⁶¹.

Для организации стола вывод двойной. Первый: выраженное переедание у жителя на весогенном препарате — во многом фармакологический эффект (гиперфагия), а не «прожорливость», и относиться к нему как к дисциплинарной проблеме — ошибка. Второй: кухня не может и не должна «лечить» это голоданием — самостоятельные ограничения рациона без врачебного назначения незаконны (раздел 17) и опасны.

13.2. Пищевое поведение: что показывают исследования

Обзор поведенческих проявлений при тяжёлых психических расстройствах (проект RESOLVE) фиксирует широкие диапазоны распространённости: эпизоды переедания — от 4,4 до 45 %, тяга к еде (food craving) — 16,1–64 %, ночное едение — 4–30 %⁴⁰. Диапазоны широки из-за методов и популяций — и это важно сказать честно; но даже нижние границы означают заметный контингент в каждом учреждении.

Эффективность вмешательств по весу скромная, и это тоже надо знать до того, как обещать результат: мета-анализ образа жизни при тяжёлых психических расстройствах даёт средний эффект порядка $-1,4$ кг⁶²; программа с участием диетолога (Teasdale) показывает лучшие результаты именно при специалисте⁶³. Практический смысл: метаболическая стратегия

— марафон с малыми цифрами, а не быстрая победа, и её ядро — не ограничения, а пищевая среда плюс мониторинг плюс врач.

13.3. Что может организация питания (без подмены врача)

Мониторинг веса как система. График из международных руководств: взвешивание на старте терапии, на 4-й, 8-й, 12-й неделе и далее регулярно; триггеры +5 % за 3 месяца и онтарианские пороги потери/набора (5/7,5/10 %) — сигналы врачу⁶¹²³. Весы, журнал, ответственный — стоимость нулевая, документальная ценность высокая.

Пищевая среда вместо запретов. То, что доступно между приёмами пищи, важнее того, что запрещено: буфет с фруктами и кисломолочным вместо выпечки; отсутствие энергетиков и лимит сладких напитков (раздел 11); структура приёмов без «дыр», провоцирующих набеги на кухню. Это не «диета» — это среда, и она законна без врачебных назначений, потому что не ограничивает ничьих порций.

Добавка — по правилам, а не по настроению. Конфликт «дай вторую котлету» (кейс раздела 5) решается письменным порядком добавки: кому, что, когда — по общему правилу, а медицинские ограничения порций вводятся только врачом и только поимённо (раздел 17).

13.4. Ночное едение: не наказывать, а структурировать

Ночные набеги на кухню — отдельный паттерн (4–30 % по обзору⁴⁰) с тремя разными корнями: препаратная гиперфагия, нарушение сна-аппетита, тревога. Карательные меры (замок на кухне) не работают и добавляют риски: голодный житель встревожен, конфликтует, ищет еду вне дома. Работающая альтернатива — **структурированная ночная доступность**: поздний вечерний перекус по расписанию и ночной доступ к воде, чаю и сухому перекусу на посту. Эта же мера сокращает ночной интервал «ужин — завтрак», который в международных нормах ограничен 11–14 часами³¹³⁶. То есть одна бесплатная мера закрывает сразу две задачи — поведенческую и нормативную.

13.5. Когда вопрос клинический

Эскалация к врачу обязательна при: прибавке +5 % и более за 3 месяца на препарате; выраженной гиперфагии, ломающей режим; подозрении на ночное едение как синдром; любом запросе жителя или семьи «посадить на диету». Решения, которые принимает только врач: изменение препарата, назначение ограничительного рациона, направление к эндокринологу, метформин и прочее. Роль организации — дать врачу данные (вес, журнал потребления, пищевая карта) и исполнить назначения точно.

13.6. Управленческий вывод

Гиперфагия и ночное едение — зона, где «дисциплинарная» реакция наихудшая из возможных: она не работает фармакологически, конфликтна и юридически уязвима. Работающий пакет стоит копейки: мониторинг веса с триггерами, пищевая среда, правила добавки, структурированная ночная доступность. А вариативность здесь — союзник: выбор внутри продуманной среды снижает конфликтность вокруг еды, которая и есть главный стрессоген этой темы.

13.7. Разговор с жителем о весе: без стыда

Метаболический риск порождает соблазн «воспитательных бесед» о весе — они бесполезны и жестоки: весогенность терапии не лечится стыдом¹⁰. Рабочая позиция смены и врача: проблема формулируется как «побочный эффект лечения, который мы вместе обходим», а не как «ваше переедание». Инструменты — те, что в разделе: объёмные низкокалорийные добавки, дробность, доступность по режиму, активность по возможности. И главное — честная информированность: житель, понимающий, почему его порция устроена так, а не иначе, сотрудничает; житель, получающий ограничения без объяснений, обходит их — через передачи, чужие тарелки и подполье, где калорий всегда больше.

13.8. Метаболический мониторинг как часть питания

Весогенность терапии делает вес и сахар предметом кухни не меньше, чем предметом кабинета врача: антипсихотики различаются по набору веса на килограммы за недели¹⁰, при первом эпизоде психоза долгосрочная

прибавка достигает +9,34 кг на оланзапине⁶⁰, а мониторинг метаболических параметров в реальной практике выполняется неполно⁶¹. Организационный вывод для СОСО: график взвешивания (ежемесячно, одни весы, одно время), запись в карту, порог реакции (набор более 5 % за квартал → врач и пересмотр пищевого плана). Это дешевле любого другого мониторинга в доме — и регулярно оказывается первым сигналом, что схема терапии требует пересмотра.

Отдельно — недостаточность питания, а не набор. MUST (Malnutrition Universal Screening Tool, BAPEN) — пятишаговый скрининг по ИМТ, непреднамеренной потере >5 % за 3–6 месяцев и острому заболеванию; в домах ухода его обычно заполняют ежемесячно⁶⁴. Это не тот же индикатор, что «+5 % на оланзапине»: набор и потеря — две строки панели раздела 22, иначе кухня «скринит истощение», глядя на прибавку. Кто заполняет в ПНИ: медсестра или врач по инструкции инструмента; кухня даёт вес и факт поедания, категорию риска не ставит. Для лежачих без кресла-весов строка «вес» в карте — фикция. Порог потери по рамке Онтарио (≥ 5 % за 30 дней / $\geq 7,5$ % за 90 / ≥ 10 % за 180)²³ — сигнал врачу сегодня, не «наблюдаем до обхода».

13.9. Ночная доступность: конструкция, а не «открытый холодильник»

Структурированная ночная доступность — самый недопонятый инструмент раздела. Она не означает свободного доступа к кухне (санитарно и организационно недопустимо) и не означает «ночью ничего нет» (источник конфликтов и поисков чужой еды). Рабочая конструкция из четырёх элементов: **перечень** — два-три продукта, согласованных с врачом (кефир, хлеб, фрукты по сезону; для групп с метаболическим риском — низкокалорийные объёмные варианты); **место** — точка выдачи на посту или буфетная зона отделения, не кухня; **режим** — фиксированное окно (например, 21:00–22:00 и при пробуждении ночью по запросу), запись в журнал; **границы** — жителям с гиперфагией объёмы порционные, а не «возьми сам». Смысл конструкции двойной: клинический (ночное едение перестаёт быть подпольным — а подпольное всегда чревато объединением неподходящим) и правовой (еда ночью перестаёт быть «нарушением режима» и становится предусмотренной услугой). Данные по ночному

едению при психических расстройствах (4–30 %⁴⁰) означают: в отделении на 30 человек это не гипотетика, а от одного до девяти жителей еженочно. Вопрос не «бывает ли», а «подпольно или организованно».

13.10. Запор: скрытый регулятор аппетита и поведения

Сниженный аппетит, «необъяснимые» эпизоды беспокойства и отказы от еды в ПНИ часто имеют одну незаметную причину — запор. У жителей на клозапине риск приобретает отдельный статус: запоры возникают у 30–60 % принимающих, при объективных исследованиях моторики ЖКТ признаки гипомотильности обнаруживаются до 80 %, а тяжёлый запор может завершиться илеусом, перфорацией и смертью — регулятор TGA (Австралия) ввёл для него рамочное предупреждение в инструкцию⁶⁵. Британская фармацевтическая служба прямо называет запор при клозапине потенциально фатальным и требует активного ведения: мониторинг стула и профилактические слабительные по назначению врача⁶⁶. Для организации питания это значит: деликатный учёт стула в постовом журнале (да/нет за сутки — без деталей); вода и клетчатка как часть меню, а не «по просьбе»; движение после еды как часть режима дня. Триггер эскалации — трое суток без стула у жителя из группы антихолинергической нагрузки — врач сегодня. Журнал стула содержит сведения о здоровье: доступ — пост и врач, не кухня и не «все смены»; основание обработки — оказание соцуслуг / 152-ФЗ (раздел 17.6); диагноз в журнале не пишется. *Маркировка: питание — поддержка и мониторинг; слабительные, диагностика и подбор — только врач (раздел 18 семинарского пакета: «не без врача»).*

13.11. Микронутриенты: то, что не видно на весах

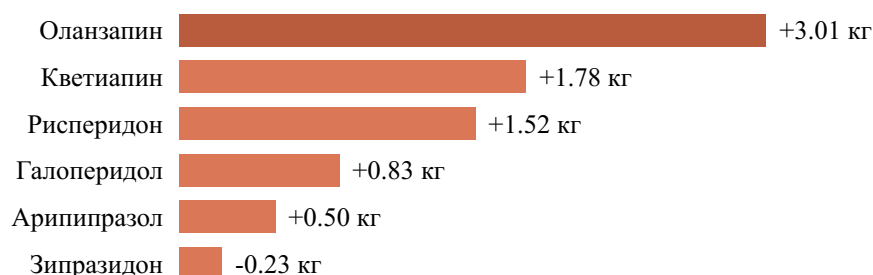
Мониторинг раздела 13.8 смотрит на вес, глюкозу и липиды — и не видит дефицитов, которые влияют на настроение, когницию и аппетит. Три точки приложения. **Витамин D:** дефицит распространён в психиатрической популяции, и рутинный скрининг рекомендован в профильной литературе⁶⁷; карбамазепин — фермент-индуктор и по данным мета-анализа ассоциирован со снижением 25(OH)D⁶⁸, а он уже есть в лекарственно-пищевой таблице раздела 11. **B12 и фолат:** дефицит

нарастает с возрастом, связан с депрессией и когнитивными нарушениями и систематически недодиагностируется у пожилых⁶⁹. **Железо:** редкое мясо плюс хронические потери дают анемию, маскирующуюся под «усталость и не ест». Практическая рамка: организация может только спросить и подсветить — пункт «профиль микронутриентов обсудить с врачом» в годовом маршруте жителей на антиконвульсантах и вегетарианцах; назначение анализов и добавок — исключительная зона врача⁶⁷.

13.12. Инсулин и время еды: гибкий стол без гипогликемии

Сахарный диабет в стационарном контингенте обычен, а вариативность ломает привычку «все едят в одно время». Если инъекция привязана к раздаче, а житель выбрал отложенный приём или другой объём — это уже клинический риск, не кухонное удобство. Прямых российских норм «инсулин × вариативное меню» нет. Рабочая рамка: список жителей на инсулине живёт у поста и кухни (без диагноза в открытом доступе — «время еды фиксировано / гибкое»); сдвиг приёма более чем на [локальный порог, согласовать с врачом] для этой группы — только с отметкой врача; отложенный обед для них либо сопровождается переносом инъекции, либо не предлагается. Гибкость стола для остальных жителей от этого не страдает. *Только врач меняет схему; организация не сдвигает инсулин «по договорённости смены».*

Рисунок 22. Набор веса за 6 недель терапии по препаратам (мета-анализ)



Средний набор веса против плацебо за ~6 недель. Вывод для кухни: весогенность — свойство терапии, а не «характера жителя»; меню и мониторинг строятся под этот факт.

Источник: Pillinger et al., мета-анализ (реестр MEDICAL_EVIDENCE: pillinger); год 2020; метод — сетевой мета-анализ РКИ; ограничение — средние значения, индивидуальная вариабельность высока.

14. Пикацизм, заглатывание и другие поведенческие риски за столом

14.1. Круг рисков

Помимо рассмотренных паттернов (разделы 9–13), столовая ПНИ встречается с группой поведенческих рисков, которые редки по отдельности, но в сумме неизбежны в большом учреждении. Их общая черта: они не лечатся организацией, но управляются ею — и цена управления измеряется безопасностью.

Пикацизм (поедание несъедобного). Бумага, земля, мел, вата, бытовая химия, лекарства чужих назначений. Встречается при умственной отсталости, психозах, деменции. Организационные меры: среда без доступных опасных объектов (хранение бытовой химии и медикаментов — вне зоны досягаемости, это отдельный контур учёта), наблюдение за жителями с зафиксированным пикацизмом во время еды и прогулок, информирование всей смены (а не только врача). Запись в пищевой карте — обязательна: пикацизм относится к пищевой безопасности не меньше, чем аллергия.

Быстрое заглатывание. Уже описано в разделе 9 как паттерн; здесь — как риск. Механика та же, что у дисфагии: большой непрожёванный кусок перекрывает дыхательные пути, и случаи удушья пищей (choking) — документированная причина смерти в психиатрических учреждениях⁴¹. Меры: малые порции с добавкой, исключение крупных сухих кусков, посадка рядом с работником, обучение смены приёму Геймлиха — да, это часть пищевой безопасности, а не только первой помощи «вообще».

Отбирание еды и «грабеж» стола. Житель забирает еду у соседей. Корни разные: гиперфагия на препаратах (раздел 13), недокорм прошлого опыта, поведенческие особенности. Меры: рассадка (не рядом с медленными едоками из группы риска), правила добавки (сытость снижает мотивацию), контроль собственного веса «грабителя» и жертвы. Важно не превращать жертву в виноватую: её порция должна быть восполнена всегда.

Опрокидывание, бросание, отказ от приборов. При возбуждении или в качестве протеста. Меры: безопасная посуда (без стекла), finger food как штатная опция меню (британское руководство включает его именно для таких ситуаций)³⁷, отдельный стол, приём пищи после снижения возбуждения — отложенная порция вместо пропущенной (раздел 12).

Ритуалы и пищевые «правила». Еда только определённого цвета, только из своей тарелки, строгий порядок блюд. Пока ритуал не опасен — он не «лечится», а учитывается: это самый дешёвый вид персонализации. Пищевая карта фиксирует ритуал как данность, и кухня с ним считается.

14.2. Общий протокол: среда, наблюдение, запись, эскалация

Все риски раздела управляются одной четвёркой действий, и её достаточно для локального акта:

1. **Среда:** опасные объекты и вещества вне досягаемости; посуда безопасная; рассадка продуманная.
2. **Наблюдение:** за столом находится работник, чья задача — видеть (а не только подавать); «обеденный дежурный» — штатная роль, а не добрая воля.
3. **Запись:** каждый эпизод (пика, заглатывание с поперхиванием, отбирание, опрокидывание) — строка в журнале, а не устный рассказ «на кухне».
4. **Эскалация:** повторяющийся эпизод — врач; эпизод с угрозой (поперхивание, несъедобное, чужое лекарство) — врач немедленно.

14.3. Граница с насилием — вторая сторона

Поведенческие риски соблазняют «силовые» решения: связать, запереть, изолировать от еды, кормить отдельно «наказанием». Каждое из этих решений — вне закона (ст. 37 Закона № 3185-1: гуманное отношение и уважение достоинства)¹ и вне доказательности: сила не изменяет ни гиперфагию, ни пикацизм, ни заглатывание. Изоляция при возбуждении — отдельная клиническая процедура со своими правилами (и питание в ней ведётся по протоколу раздела 12.4 и британского руководства³⁷) — но она не инструмент «дисциплины за столом». Локальный акт должен прямо

запрещать: лишение еды как меру воздействия, ограничение питья, «штрафные» порции. Эта строка положения о питании защищает и жителя, и директора.

14.4. Управленческий вывод

Поведенческие риски стола — зона, где дешевле всего обходится предвидение и дороже всего — импровизация. Один инструктаж смены (среда — наблюдение — запись — эскалация), безопасная посуда, правила рассадки и добавки, прямой запрет «едовых наказаний» в положении о питании — и большинство эпизодов либо не происходит, либо заканчивается записью, а не травмой.

14.5. Заглатывание предметов: граница с соматикой

Проглоченный предмет — соматическая ситуация, а не поведенческая: наблюдение за стулом, температурой, болью в животе в последующие дни — по назначению врача, с записью. Ошибка «проглотил — вышло — забыли» опасна: часть предметов травмирует не сразу. Каждый эпизод проглатывания закрывается протоколом разбора (приложение 34), и разбор спрашивает не «кто недосмотрел», а «как предмет оказался доступен» — второй вопрос чинит систему, первый только запугивает смену в молчание о следующем эпизоде.

14.6. Пикацизм и кухня: точка пересечения

У пикацизма есть прямая связь с организацией еды: часть эпизодов — это поиск еды несоциальными способами на фоне голода (реального или субъективного при гиперфагии). Отсюда два кухонных инструмента в протоколе: структурированная доступность (запланированные перекусы снижают поисковое поведение) и безопасная среда буфета (в буфетной зоне для жителя с пикацизмом нет ничего, что нельзя есть). Это тот случай, когда правильная организация питания — буквально профилактика инцидентов. ## 14.7. Протокол «среда — наблюдение — запись — эскалация» на практике

Четыре звена протокола против пикацизма распределяются по людям и часам, иначе протокол остаётся абзацем. **Среда** — еженедельный осмотр

зоны жителя старшей сменой по короткому списку (мелкие предметы, оторванные элементы одежды и мебели, доступность моющих, состояние пуговиц и шнурков на общих вещах), запись одной строкой с подписью; осмотр занимает десять минут и ловит риск до эпизода. **Наблюдение** — не «смотреть постоянно» (невозможно), а знать окна риска конкретного жителя: у большинства — скука и безструктурное время после еды; структурирование этих окон (занятие, прогулка, присутствие) снижает эпизоды сильнее, чем усиление надзора. **Запись** — каждый эпизод: что именно, когда, где, что предшествовало; серия записей за месяц показывает паттерн (время, место, тип предметов), который не виден по одному эпизоду. **Эскалация** — врач при первом эпизоде (пикацизм — не «привычка», а симптом с дифференциальной линейкой от дефицитов до компульсий), скорая — при проглатывании опасного. Отдельная строка протокола — замещение: жевательные альтернативы и структурированная доступность еды по согласованию с врачом; логика та же, что у ночной доступности (раздел 13): поведение, которому нет легального выхода, уходит в подполье и становится опаснее.

Рисунок 21. Клинические риски × контуры ответа (тепловая карта зон ответственности)

Риск	Кухня	Пост	Врач	Директор
Дисфагия/аспирация	текстуры	поза, темп, признаки	назначение, скрининг	обучение, ставки
Лекарство × еда	исключения в меню	передачи, наблюдение	таблица, режимы	регламент передач
Гиперфагия/вес	объёмные добавки	рассадка, доступность	мониторинг, схема	структура дня
Отказ от еды	замены	журнал, эскалация	решение в день 3-го отказа	правило в приказе
Пикацизм	безопасный буфет	среда, наблюдение	оценка, план	среда отделений

Красное — основная зона ответственности контура, жёлтое — участие, зелёное — поддержка. Каждая красная клетка имеет свой документ в приложениях 9–21.

Разделы 9–14, 28 доклада; реестр *MEDICAL_EVIDENCE*.

15. Невербальный выбор: как услышать того, кто не говорит

15.1. Масштаб вопроса

Три четверти жителей российских ПНИ признаны недееспособными²⁰, а значимая часть оставшихся не может выразить выбор словом по состоянию: неговорящие и малоговорящие, глубокая умственная отсталость, деменция, острые состояния. Если вариативность строится на вопросе «что будете?», она автоматически исключает большинство. Поэтому технология выбора для тех, кто не говорит, — не дополнение к системе, а её ядро.

15.2. Правовая рамка: поддержанное, а не подменяющее решение

Международный стандарт — Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 Конвенции о правах инвалидов: замещающее принятие решений («мы знаем лучше») подлежит замене поддержанным — человек получает помощь, чтобы выразить собственную волю; воля и предпочтения не заменяются «лучшими интересами»²⁷. Российское право этой логике не противоречит: Закон № 3185-1 требует учитывать мнение недееспособного при решении вопросов, затрагивающих его интересы, включая условия проживания¹. Выбор еды — бытовое решение, не юридическая сделка: неспособность к сделкам не отменяет способности предпочитать.

Маркировка: этот абзац — системное толкование норм, а не прямое правило закона; прямой нормы «выбор блюда не требует дееспособности» в российском законодательстве нет. Практические формы ниже — проект локальной практики.

15.3. Четыре канала воли

Канал 1. Показ вместо вопроса. Вербальный выбор требует удержать в памяти два слова и соотнести их с опытом — задача, непосильная многим. Показ двух реальных порций снимает её: человек указывает, тянется, смотрит, отворачивается. Практика деменс-ухода прямо рекомендует визуальный выбор вместо вербального⁷⁰³⁷. Требование к системе: вариант Б должен физически существовать на линии — показ двух порций невозможен без минимальной вариативности (ступень 1, раздел 8).

Канал 2. Наблюдение за потреблением. Тарелка — это голос: систематически несъеданное блюдо — зафиксированное «нет», доеданное до конца — «да». Журнал потребления (раздел 9) становится документом выявления предпочтений; муниципальные скандинавские стандарты прямо требуют документировать наблюдаемые предпочтения тех, кто не может сообщить их словами⁷¹.

Канал 3. Пищевая биография в «хороший день». Пока состояние позволяет, с жителем (и семьёй, прежними работниками) заполняется пищевая биография: любимое, нелюбимое, ритуалы, «детские» блюда, распорядок²⁹. Документ фиксирует волю, выраженную в период максимальной ясности, и работает, когда ясности меньше, — прямая реализация принципа приоритета зафиксированной воли²⁷. Форма — приложение 3.

Канал 4. Те, кто знает человека. Семья, опекун, давние работники — источники интерпретации воли, а не «решающие за него». Их сведения входят в пищевую карту с указанием источника²⁷.

15.4. Иерархия источников при расхождении

Порядок фиксируется в локальном акте: (1) зафиксированная воля самого жителя (пищевая биография, устойчивые предпочтения); (2) текущая демонстрируемая воля (показ, жест); (3) сведения близких; (4) медицинские ограничения по назначению врача — они ограничивают пункты 1–3 только в рамках реальной клинической необходимости; (5) удобство кухни в иерархию не входит вовсе. Медицинское ограничение не отменяет выбор, а определяет его множество: австрийский стандарт требует вовлекать самого проживающего в решение о диете³⁸.

15.5. Технология на линии: сценарий для смены

Практический сценарий показа, проверенный логикой российских внедрений⁴⁵:

1. На линии — два варианта в одинаковых гастрорёмкостях, на виду.
2. Работник показывает обе порции неговорящему жителю, называя их простыми словами: «гречка — рис».

3. Реакция фиксируется одним из четырёх значков журнала: указал / потянулся / отвернулся / без реакции.
4. При отсутствии реакции подаётся вариант по пищевой карте (зафиксированное предпочтение), а не «первый по очереди».
5. Потребление фиксируется — и корректирует карту.

Время на одного жителя — 15–20 секунд; на отделение — несколько добавочных минут на линии, которые окупаются снижением несъеденных порций.

15.6. Управленческий вывод

«Наши не могут выбирать» — самое частое возражение против вариативности (раздел 37) и самое проверяемое. Проверка стоит три дня: покажите трём неговорящим жителям две порции и запишите реакцию. Опыт показывает: «не может выбирать» обычно означает «его никогда не спрашивали доступным способом». Для аудитории, где 74 % жителей недееспособны²⁰, технология невербального выбора — это и есть вариативность, а не её доступный вариант для меньшинства.

15.7. Обучение смены чтению воли: три упражнения

Навык считывания тренируется, а не приходит с возрастом. Три упражнения для инструктажа: «молчаливый заказ» — сотрудники заказывают друг у друга без слов и проверяют, как их поняли; «перестановка» — тренировка теста позиционного эффекта на себе; «неделя наблюдения» — каждый ведёт мини-журнал одного жителя и защищает вывод перед сменой. После этих упражнений форма приложения 6 перестаёт быть бумажкой — она становится записью того, что смена уже умеет видеть.

15.8. Ошибка «профессионального чтения»

Отдельный риск — уверенность опытной смены «я его десять лет знаю». Опыт ценен, но непроверяем: знание живёт в голове и уходит с ротацией. Правило: любое «я знаю» обязано быть переведено в запись (карта, форма наблюдения) в течение недели; непереверждённое знание для системы не существует. Это звучит бюрократично ровно до первой смены кадров —

после неё это звучит как единственный способ не потерять человека вместе с ушедшей сиделкой.

15.9. Иерархия источников воли: кто на каком месте

Когда каналы противоречат друг другу — а они противоречат регулярно, — нужна заранее объявленная иерархия, иначе каждый конфликт решается авторитетом говорящего громче. Рабочая иерархия из пяти уровней: **1) текущее выраженное предпочтение жителя** (жест, показ, отказ, съеденное) — сильнейший источник, пока не противоречит назначениям врача; **2) зафиксированная биография** (приложение 3) — воля, выраженная в ясный период, имеет приоритет над текущими догадками окружающих; **3) систематическое наблюдение** (форма приложения 6, серия записей) — сильнее единичного впечатления любого сотрудника; **4) сведения близких** — ценны как данные биографии, но уступают наблюдению при расхождении («дома он любил» — но здесь два месяца не ест); **5) «усреднённое благо»** («всем полезно») — слабейший источник, приемлемый только когда первые четыре пусты. Иерархия записывается в положение о питании одним абзацем — и снимает самый токсичный класс конфликтов: споры родственников, смены и администрации о том, «что он на самом деле хочет». Спор переносится из плоскости мнений в плоскость уровней: у каждого мнения есть этаж, и этаж решает.

15.10. Культурные и религиозные рамки стола

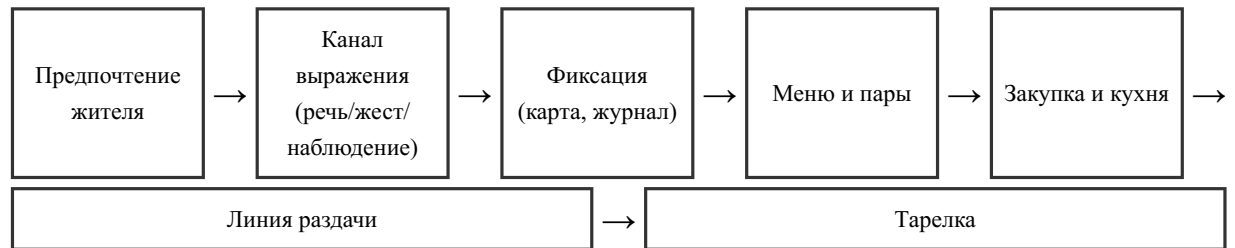
Каналы воли раздела 15.3 работают и тогда, когда предпочтение жителя задано не вкусом, а традицией: халяль или кашрут, пост (в том числе многодневный у верующих), вегетарианство, отказ от отдельных продуктов по убеждению. Для 51 региона с разным конфессиональным составом это не экзотика, а обычная часть контингента — и вопрос достоинства в смысле ст. 37 через ст. 43 закона № 3185-1¹. Международная рамка уже содержит образец: нормы Онтарио требуют при поступлении нутритивной оценки, включающей культурные, духовные и религиозные предпочтения, и планирования меню с их учётом²³; российская рамка такого пункта не содержит, но ничего не запрещает — «индивидуальные потребности» 442-ФЗ покрывают и его³. Практический минимум: два вопроса в пищевой

биографии («есть ли пища, которую вы не едите по убеждению или вере?»; «соблюдаете ли посты?») и одна строка в заказе меню — «ограничения по убеждению». Если таких жителей больше двух-трёх, имеет смысл держать в цикле пару блюд, закрывающих основные ограничения (например, постное горячее как регулярная позиция), — это дешевле индивидуальной подготовки и не требует новой строки в смете. Рамка остаётся прежней: религиозное ограничение — это волеизъявление того же достоинства, что и «не люблю рыбу», а не медицинская диета; и оно не может быть основанием для худшего рациона. Форма фиксации — пищевой паспорт (приложение 37).

15.11. Постные и религиозные меню-циклы: маркировка «пост — не диета»

Когда ограничений по убеждению много, учреждению выгоднее держать в цикле регулярные позиции, закрывающие основные рамки, чем готовить индивидуально. Практический минимум: постное горячее 2–3 раза в неделю в периоды многодневных постов (Великий пост, Рамадан, Рождественский пост), постные гарниры ежедневно (крупы, овощи — они и так в раскладке), маркировка постных позиций в визуальном меню. Три правила. **Первое: пост — волеизъявление, а не назначение.** Для жителей с медицинскими показаниями (сахарный диабет, белково-энергетическая недостаточность, анемия) постное меню согласуется с врачом; «постное» не должно становиться «неполноценным» — ограничение по убеждению не отменяет нормы питания (приказ Минтруда 520н)³⁰, и постный суп на воде без белка не заменяет обеда. **Второе: отказ от поста — право жителя в любой день.** Рамка «не люблю рыбу» из раздела 15.10 работает симметрично: давление в пользу поста так же недопустимо, как и давление против него. **Третье: пост не меняет санитарного контура.** Суточные пробы, бракераж и температурный режим для постных позиций — те же, что для обычных (раздел 18). Формы: строка «ограничения по убеждению» в заказе (раздел 15.10) и пищевой паспорт (приложение 37).

Рисунок 6. Путь от предпочтения до тарелки — и семь точек разрыва



Разрыв возможен на каждом звене: не спросили в формате жителя → не записали → меню без пары → закупка не привезла → вариант закончился → выдали «что осталось». Каждый разрыв имеет свой документ: форма наблюдения, журнал заказа, пары эквивалентов, спецификация, журнал срывов, журнал замен.

Разделы 15, 19, 21, 30 доклада; кейсы 1, 4, 14.

16. Дееспособность, опека и выбор еды: карта решений

16.1. Постановка вопроса

Тема семинара — права, свободы и интересы жителей. В питании они упираются в юридический вопрос, который редко формулируется прямо: кто вправе решать, что ест недееспособный житель, — и вправе ли вообще кто-то, кроме него? Раздел даёт карту решений: двенадцать вопросов с ответами «прямая норма / системное толкование / открытый вопрос». Маркировка соблюдается строго, потому что именно здесь директору опаснее всего опереться на красивую, но неподдержанную формулу.

16.2. Нормативная основа

Три федеральных столпа. **ГК РФ**: признание гражданина недееспособным (ст. 29) означает, что сделки от его имени совершает опекун (п. 2 ст. 29); опека оформляет отношения по ст. 31–32. Мелкие бытовые сделки без согласия попечителя допускаются **ограниченно дееспособным** (п. 1 ст. 30; при ограничении дееспособности вследствие психического расстройства — п. 2 ст. 30 со ссылкой на подп. 1 п. 2 ст. 26), а не недееспособным — эти режимы нельзя смешивать. Выбор блюда при раздаче — не сделка, а элемент ухода и реализации права на достоинство; он не требует дееспособности. **48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»**: обязанности опекуна — забота о содержании, но и учёт мнения подопечного. **Закон № 3185-1**: ст. 37 — права пациентов психиатрических стационаров (гуманное отношение, достоинство, обращения, представительство); ст. 43 прямо распространяет эти права на проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами и требует ежегодного освидетельствования комиссией врачей с участием психиатра — в том числе для решения вопроса о переводе в организацию общего типа¹. **442-ФЗ**: права получателя (ст. 9), индивидуальная программа (ИППСУ, ст. 16) и учёт индивидуальных потребностей³.

16.3. Карта решений: двенадцать вопросов

№	Вопрос	Ответ	Уровень
1	Отменяет ли недееспособность бытовые предпочтения?	Нет. Недееспособность касается сделок, не вкусов	Прямое следствие норм ГК + ст. 37/43 3185-1
2	Является ли выбор блюда «сделкой», требующей дееспособности?	Нет; бытовой акт	Системное толкование
3	Обязано ли учреждение учитывать мнение недееспособного жителя?	Да, при решении вопросов, затрагивающих его интересы	Норма (3185-1, ст. 37; 48-ФЗ)
4	Может ли опекун «запретить» жителю конкретное блюдо?	Только в рамках медицинских назначений; вкусы — не компетенция опекуна	Системное толкование
5	Что делать, если учреждение само — опекун жителя?	Конфликт интересов фиксируется; решения о питании принимаются по прозрачным правилам, а не «усмотрением опекуна»	Открытый вопрос + управленческая рекомендация
6	Нужно ли согласие недееспособного на вариативное меню?	Не требуется: вариативность не ограничивает прав, а расширяет возможность выбора	Системное толкование
7	Как быть с отказом недееспособного от еды?	Не насилие; наблюдение, альтернатива, эскалация врачу (раздел 12)	Норма (ст. 37) + алгоритм

№	Вопрос	Ответ	Уровень
8	Может ли семья диктовать меню?	Учитывается как источник сведений о воле; не заменяет её	Толкование (ГС1 как ориентир ²⁷)
9	Кто решает об ограничениях рациона (соль, сахар, порции)?	Только врач, поимённо, с целью и сроком пересмотра	Системное толкование + международная практика ³⁸
10	Куда вписываются пищевые решения юридически?	В ИППСУ (потребности) и локальные акты (порядок)	Норма (442-ФЗ)
11	Проверяет ли кто-то, учитывается ли мнение жителя?	Ежегодное освидетельствование по ст. 43; контроль учредителя; прокуратура по жалобам	Норма (3185-1)
12	Что если житель недееспособен, но его состояние улучшилось?	Вопрос о дееспособности решает суд; до решения — поддержанный выбор по максимуму	Норма + практика

16.4. Конфликт интересов «учреждение = опекун»: честный разбор

Ситуация массовая: значительная часть жителей ПНИ находится под опекой, и нередко функции опекуна выполняет само учреждение. Это создаёт структурный конфликт интересов: опекун, обязанный защищать интересы подопечного, одновременно является организацией, чьи ресурсы и удобство этими интересами ограничиваются. Прямого запрета закон не

содержит — но и прямого разрешения игнорировать конфликт тоже. Управленческие меры, снижающие риск (рекомендация, не норма):

1. Решения о питании закрепляются в **прозрачных правилах** (положение о питании, триггеры, правила добавки), применимых ко всем одинаково, — усмотрение заменяется процедурой.
2. **Совет жителей и независимый канал обращений** (раздел 34) — внешний глаз на решения «опекуна-учреждения».
3. **Ежегодное освидетельствование по ст. 43** используется по назначению: не как формальность, а как внешняя оценка условий жизни¹.
4. Спорные случаи выносятся **учредителю письменно** — молчаливое усмотрение хуже зафиксированного решения.

16.5. Практическая формула для локального акта

Предлагаемая формулировка для положения о питании (проект): «При организации питания учитываются мнение и предпочтения получателей социальных услуг, в том числе признанных недееспособными, выявленные доступным способом (словом, показом, наблюдением за потреблением, пищевой биографией, сведениями близких). Ограничения рациона вводятся только по назначению врача поимённо с указанием цели и срока пересмотра. Лишение пищи или питья как мера воздействия не допускается». Каждая фраза этой формулы имеет нормативную или документальную опору в разделах 16.2–16.4 — и ни одна не выходит за пределы действующего права.

16.6. Управленческий вывод

Дееспособность — самая «пугающая» тема вариативности, и потому самая переоценённая: юридически выбор еды не требует дееспособности, а учёт мнения недееспособного прямо предписан. Реальные риски лежат в другом месте: в непрозрачных решениях «по усмотрению», в конфликте интересов опекуна-учреждения и в отсутствии документов. Все три закрываются локальными актами, а не судебными решениями.

16.7. Разбор трёх коллизий из зала

Коллизия «родственник против опекуна-учреждения». Родственник настаивает на меню, учреждение — на своём, житель молчит. Иерархия раздела 15.9 ставит биографию и наблюдение выше обеих сторон: спор решается не статусом спорящих, а данными о жителе. **Коллизия «врач запретил, житель требует».** Назначение врача — рамка, выбор внутри рамки — право; конфликт возвращается врачу с конкретикой (что именно требует житель), а не решается сменой (кейс 2). **Коллизия «раньше выбирал, теперь нет».** Снижение способности к выбору — клинический сигнал само по себе (депрессия, прогрессирование, седация после смены схемы): сообщение врачу обязательно, «перестал — значит, не хочет» — диагностическая ошибка. Общая механика: каждая коллизия решается возвратом к источникам воли и к врачу — и никогда авторитетом должности.

16.8. Учреждение = опекун: три антидота в документах

Структурный конфликт (по вторичной аналитике, до 74 % жителей ПНИ недееспособны, а опекуном нередко выступает само учреждение²⁰ — статус данных: вторичная аналитика) не решается доброй волей, но ограничивается тремя документальными приёмами. Первый: правило приоритета зафиксированных предпочтений над административным удобством — записанное в положение (приложение 29), оно делает конфликт видимым, а не растворённым. Второй: протоколирование разногласий — если администрация отклоняет зафиксированное предпочтение, причина пишется (санитария, назначение врача, ресурс), а не замалчивается. Третий: внешний элемент там, где он доступен, — совет жителей с участием независимых представителей, близких, общественных наблюдателей (раздел 34): единственный реальный балансир конфликта «учреждение решает за жителя решения самого учреждения». Ни один приём не отменяет конфликта; все три вместе делают его управляемым и проверяемым — большего локальный уровень дать не может, и это честная граница раздела.

16.9. Карта двенадцати вопросов: как ею пользоваться

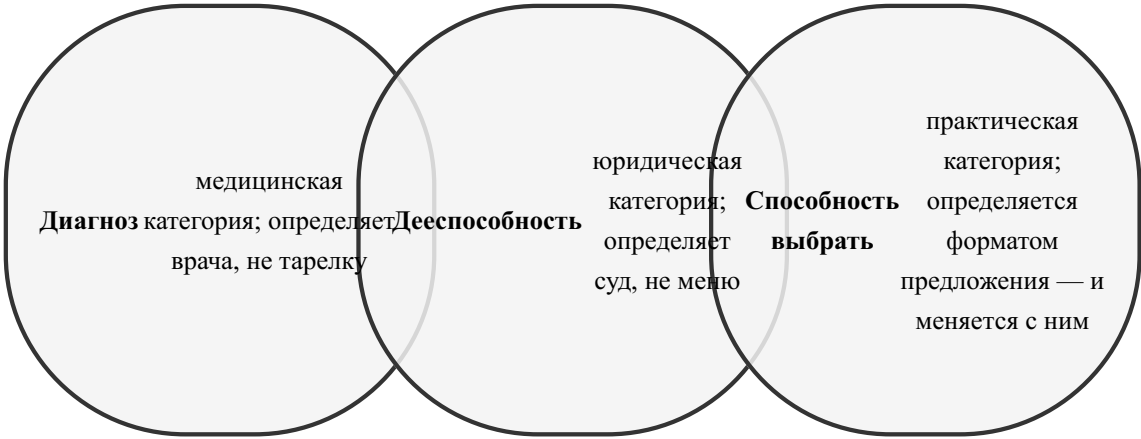
Карта раздела (способность выбрать $\neq$ дееспособность $\neq$ диагноз) применяется не к «жителю вообще», а к конкретному решению в конкретный день — это её главное отличие от ярлыков. Двенадцать вопросов сводятся к трём блокам: **информирован** ли человек о варианте (показали ли ему, в его ли формате, в его ли время); **понимает** ли последствия выбора в доступной ему мере (проверяется переспросом, а не допросом); **может ли сообщить** выбор хоть одним каналом (раздел 15). Ответы ставят жителя в одну из четырёх рабочих категорий на сегодня: выбирает сам / выбирает с поддержкой формата / выбор считается наблюдением / выбор недоступен — действует стандартный вариант с пересмотром. Категория не присваивается навсегда: пересмотр при смене состояния, терапии, а для группы «недоступен» — не реже раза в квартал. Именно динамичность категории отличает поддерживаемое принятие решений от опеки²⁷: опека фиксирует неспособность, поддержка ищет формат, при котором способность проявляется.

16.10. Ограничение дееспособности вследствие психического расстройства: недоиспользованный режим

С 02.03.2015 ГК РФ содержит отдельный режим — ограничение дееспособности гражданина, который «вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц» (п. 2 ст. 30)⁷². В отличие от полной недееспособности (ст. 29), такой гражданин самостоятельно совершает сделки, предусмотренные подпунктами 1 и 4 пункта 2 статьи 26 (мелкие бытовые и распоряжение предоставленными средствами), и совершает остальные сделки с письменного согласия попечителя (п. 2 ст. 30). Для ПНИ это прямая развилка: значительная часть жителей, признанных недееспособными, по клинической картине подпадает под критерии п. 2 ст. 30, и переход «ст. 29 → п. 2 ст. 30» (по заявлению, через суд и психиатрическую экспертизу — п. 3 ст. 29) расширяет бытовую автономию, включая выбор еды, без ущерба для защиты. Практика применения пока узкая: суды осторожно используют институт, литература отмечает его невостребованность и размытость критериев⁷². Доклад не призывает к

кампании по пересмотру решений — это компетенция суда и экспертизы; практический вывод один: в карте дееспособности жителя (приложение 37) фиксируется не только статус, но и его основание (ст. 29 или п. 2 ст. 30), потому что от него зависит объём самостоятельных бытовых решений, которые учреждение обязано уважать и обслуживать.

Рисунок 7. Три разных измерения, которые нельзя смешивать



Пересечение неполное: недееспособный может выбирать; дееспособный может сегодня не понимать последствий. Ошибка смешения — источник и излишних запретов, и опасной вседозволенности (раздел 16).

Раздел 16; ККИ, Общее замечание №1 (реестр INTERNATIONAL_PRACTICES).

Рисунок 5. Матрица способности к выбору (применяется к решению и дню, не к человеку «вообще»)

	Может сообщить выбор	Не может сообщить выбор
Понимает последствия	Выбирает сам — стандартная процедура показа меню	Выбор считается — наблюдение, тест позиции, биография (приложение 6)
Не понимает последствий (сегодня)	Выбирает с поддержкой — формат упрощается: 2 карточки, время, помощь доверенного лица	Стандартный вариант + пересмотр — гарантированное полноценное питание, пересмотр ежеквартально

Категория динамична: пересматривается при смене состояния и терапии. Основание: принцип поддерживаемого принятия решений (ККИ, Общее замечание №1).

Разделы 15–16 доклада; источники: реестр INTERNATIONAL_PRACTICES (gc1, aus6, ontario), 2026.

17. Право Российской Федерации: что разрешено, что требуется, что опасно

17.1. Логика раздела

Правовая часть доклада построена не как перечень норм, а как карта из трёх зон. Зелёная зона — то, что разрешено или требуется прямо и что директор может делать без согласований. Жёлтая зона — то, что требует документов, согласований или врача. Красная зона — то, что является нарушением независимо от благих намерений. Для каждого элемента указан уровень: норма, толкование, рекомендация.

17.2. Зелёная зона: прямые разрешения и требования

- 1. Питание ≥ 3 раз в день + диетическое по показаниям** — прямая санитарная норма для организаций соцобслуживания. На дату семинара (25–27.08.2026) действует СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7.1.11–7.1.14; с 01.09.2026 его сменяет СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18), п. 56 подп. 11–14: питание проживающих в стационарных организациях соцобслуживания организуется не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям². Ни одна из редакций не ограничивает число вариантов блюд — только безопасность и периодичность.
- 2. Права получателя и учёт индивидуальных потребностей** — ст. 9 442-ФЗ (права получателя социальных услуг) и ИППСУ (ст. 16)³.
- 3. Права проживающих по ст. 37/43 Закона № 3185-1:** гуманное отношение, достоинство, обращения¹.
- 4. Рекомендуемые нормы питания Минтруда (приказ № 520н) и региональные нормы на их основе** — базовая рамка рационов³⁰¹²¹³. Ключевое слово: рекомендуемые — региональные нормы конкретизируют их для учреждений субъекта.
- 5. Таблицы замены продуктов в раскладках** — действующий механизм эквивалентной замены, легальная основа вариативности¹²¹³.

6. **Выбор блюд жителями** — не запрещён ни одной федеральной нормой; в 2024–2025 гг. реализован публично минимум в четырёх учреждениях трёх регионов⁴⁵⁶⁷¹⁴.

7. **Плата за стационарное соцобслуживание** ограничена 75 % среднедушевого дохода (ст. 32 442-ФЗ)³⁷³ — рамка для финансовых моделей раздела 29.

17.3. Жёлтая зона: делать можно — через процедуру

Действие	Процедура	Основание
Ограничение рациона жителя (сахар, соль, порции)	Назначение врача поимённо, цель, срок пересмотра	Толкование + международная практика ³⁸
Текстурные модификации (протёртое, загущённое)	Назначение врача, маркировка порций	Клиническая необходимость (раздел 10)
Изменение цикла меню	Увязка с региональной раскладкой и таблицами замен	1213
Пищевые карты жителей (персональные данные)	Основание обработки, ограничение доступа	152-ФЗ (раздел 17.6)
Отложенные приёмы, ночная доступность	Пункт в положении о питании + санитарный контур хранения	2
Совет жителей с полномочиями по меню	Локальный акт о совете	Практика + международные нормы ²³
Вариативное меню	Пакет документов (раздел 31) + уведомление учредителя	Рекомендация на практике ⁴⁵

17.4. Красная зона: нарушения независимо от намерений

1. **Лишение еды или питья как мера воздействия** — прямое нарушение ст. 37 (гуманное отношение)¹.

2. **Насилие при кормлении** (принудительное бытовое кормление) — недопустимо; искусственное питание — только клиническая процедура по медицинским правилам (раздел 12.4).

3. **Имитация санитарного контроля** (суточные пробы «задним числом») — типовой состав дел по ст. 6.6 КоАП¹¹.
4. **Недоброкачественные продукты на столе** — ст. 6.6 КоАП для должностного лица¹¹.
5. **Картельные и согласованные закупки** — антимонопольная ответственность вплоть до уголовной (ст. 178 УК; практика ФАС)⁷⁴⁷⁵.
6. **Отказ в питании «за опоздание»** как системная практика — нарушение доступности питания (п. 7.1.11 СанПиН 3590-20; с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 СанПиН 4282-26)².

17.5. «Серая зона» лечебного питания: честная маркировка

Приказы Минздрава о лечебном питании (395н, 1008н, 330н и картотека диет) адресованы **медицинским организациям**; автоматического распространения на организации соцобслуживания они не имеют. Российская практика показывает обходную легализацию: региональные распоряжения применяют эти приказы к стационарным организациям соцобслуживания (пример — распоряжение Минсоцразвития Московской области 19РВ-32, на которое опирается ДДСОЛ с его советом по питанию)²¹. Вывод для директора: если в вашем регионе такой «мостик» есть — лечебное питание оформляется по медицинской картотеке; если нет — диетические назначения оформляются через врача и положение о питании, без прямых ссылок на неадресные приказы. *Уровень: системное толкование + практика; до проверки в конкретном регионе не использовать как готовое решение.*

17.6. Пищевые карты и 152-ФЗ

Пищевая карта/биография жителя содержит персональные данные (сведения о здоровье — специальная категория). К той же категории относятся журнал стула (раздел 13.10) и список «время еды фиксировано» для инсулина (раздел 13.12). Правовой минимум: основание обработки (исполнение договора соцобслуживания/ИППСУ), ограничение круга доступа (пост и врач; кухня видит только функциональные ограничения, не диагноз), исключение избыточных данных, сроки хранения. *Уровень:*

рекомендация по применению 152-ФЗ; форма карты в приложении 3 требует локальной правовой проверки.

17.7. КПИ: статус и практическое значение

Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов в 2008 году и ратифицировала её в 2012 году; конвенция действует как международный договор РФ. Статья 28 (достойный уровень жизни, включая достаточное питание) и Замечание общего порядка № 1 к ст. 12 (поддержанное принятие решений) — международный стандарт, который российские суды и органы используют как ориентир толкования⁷⁶²⁷. *Уровень: международный договор + толковательная практика; в локальных актах ссылаться можно и полезно — как на обоснование, а не как на прямую обязанность формата «КПИ требует два варианта каши».*

17.8. Управленческий вывод

Правовая рамка вариативности уже существует — её не нужно «пробивать». Зелёная зона шире, чем принято думать; жёлтая зона закрывается документами за недели; красная зона вся связана не с выбором, а с безопасностью и насилием. Главный правовой риск директора — не внедрение выбора, а отсутствие документов при уже существующей практике (раздел 31).

17.9. КПИ и правовая культура: дальний горизонт

Конвенция о правах инвалидов с её акцентом на поддерживаемое принятие решений²⁷ — не прямой источник обязанностей кухни, но она задаёт направление, в котором движется мировое право: от замещающих решений («за него решат») к поддерживаемым («ему помогут решить»). Для директора это означает прагматичный прогноз: нормы о выборе, предпочтениях и участии будут ужесточаться, а не смягчаться — австралийский Стандарт 6³⁵ и онтарийские требования²³ показывают вектор. Дом, построивший процедуры выбора сегодня добровольно, встретит завтрашние требования готовым; дом, ждущий обязательности, будет догонять под давлением сроков — а догоняющее внедрение всегда

дороже и фиктивнее добровольного. ## 17.10. Серая зона лечебного питания: рабочая конструкция до «моста»

Пока регионального «моста» нет, организация не должна ни игнорировать лечебное питание («мы не больница»), ни имитировать больницу («заводим диеты как в стационаре»). Рабочая конструкция из трёх элементов: назначения по питанию принимаются от лечащего врача (психиатра, терапевта) письменно — любой формат письменности лучше устного; кухня исполняет назначения через текстуры и исключения, а не через «номерные диеты», требующие больничной инфраструктуры; учредителю ежегодно уходит предложение о региональном акте по образцу существующих¹³. Конструкция честно называется временной и документируется как временная — с датой запроса учредителю. Тогда серая зона перестаёт быть безответственностью и становится зафиксированным пробелом региона с назначенным владельцем пробела.

17.11. Как читать норму: три вопроса к любому акту

Директору не нужно становиться юристом; нужна рабочая грамотность из трёх вопросов, задаваемых любому акту, который «грозит» или «разрешает». **Первый: кому адресован акт?** Приказы Минздрава о лечебном питании адресованы медицинским организациям — автоматического распространения на СОСО нет, есть стык через региональный «мост» (раздел 24)¹³. **Второй: каков статус требования?** Рекомендованные нормы Минтруда (приказ 520н³⁰) — ориентир, пока регион не сделал их императивными; СанПиН² — обязательны всегда. **Третий: что доказывает бумага?** Право, записанное без процедуры («уважать достоинство»), исполняется через документы: журнал, карта, протокол. Эти три вопроса снимают две типовые ошибки зала: первая — «нам всё запрещено» (обычно по акту, адресованному не вам); вторая — «нам всё можно» (по акту рекомендательному, который в вашем регионе давно императивен). Зелёная, жёлтая и красная зоны раздела — это и есть ответы на три вопроса, применённые к типовым ситуациям вариативного питания.

17.12. Шесть вопросов дискуссии 26.08 — глубокие ответы

(Обновлено 20.08.2026 по итогам полной верификации фактов. Вводная для дискуссии 26.08, 14.00–15.30: «Организация питания: опыт реализации проектов». Модераторы: Е. В. Чистяков, дир. ДСО «Серафимовский» (СПб); Т. А. Нурбаев, дир. ДСО «Тесовый берег» (СПб). Шесть вопросов ниже воспроизведены дословно по программе семинара. Ответы подготовлены на основании верифицированной нормативной базы и публичной практики 2024–2026 годов: все цифры, даты и реквизиты актов проверены по первоисточникам (consultant.ru, garant.ru, publication.pravo.gov.ru, mintrud.gov.ru, klerk.ru, peterburg-pravo.ru, tenmon.ru, tenderguru.ru, kcsso-barnaul.gosuslugi.ru, официальный сайт ДСО «Серафимовский» pni9.ru); корректура 19.08.2026 — исправлены дата приказа Минтруда 520н, наборы продуктов для ПНИ/ДСО СПб по Постановлению 1284, тип акта о базовых нормативах 655,53 руб, разделение правовых оснований 195-ФЗ (изменения 3185-1 ст. 27, 30; не ст. 37/43).

17.12.0. Общая логика раздела: как устроены ответы

Каждый из шести вопросов — реальный вопрос практика, а не академический. Поэтому структура ответа едина: (а) **правовая рамка** — федеральные и региональные акты, относящиеся именно к этому вопросу; (б) **практика** — конкретные учреждения, цифры, цитаты; (в) **алгоритм** — что делать директору в типовой ситуации; (г) **что нельзя делать** — типовые ошибки с правовой оценкой. Источники вынесены после каждого вопроса, чтобы дискуссия на семинаре опиралась на проверяемые цифры, а не на «общие соображения». Сквозная логика: **право выбора уже существует** (зелёная зона 17.2) — вопрос лишь в том, как его организовать, чтобы не выйти в жёлтую или красную зону (17.3–17.4).

Вопрос 1. Кто выбирает форму питания — проживающий в социальном доме или его хозяин?

Правовая рамка. Вопрос имеет три слоя: (а) «кто выбирает» как субъект воли; (б) «кто решает» как процедура; (в) «кто платит» как экономическая рамка. Снимаем каждый по очереди.

Слой 1. Кто выбирает. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», статья 37 (права пациентов, получающих психиатрическую помощь) и статья 43 (распространение этих прав на лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания): права пациента, в том числе право на гуманное отношение и уважение достоинства личности, **принадлежат самому жителю**, а не учреждению. Уточнение о редакции 22.07.2024: федеральный закон № 195-ФЗ от 22.07.2024 (вступает в силу с 01.03.2025) изменил в 3185-1 статьи **27** (диспансерное наблюдение) и **30** (участие органов внутренних дел), а также ряд статей 323-ФЗ и 3-ФЗ «О полиции»; статьи **37 и 43** действуют в ранее установленной редакции (прежняя корректная формулировка «3185-1 ред. от 22.07.2024 № 195-ФЗ (ст. 37, 43)» в первой версии доклада была неточной — статьи 37 и 43 не менялись этим законом; см. корректуру ниже).

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7.1.11 (и с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18, действует до 01.09.2032) требует «организовать питание проживающих ... не менее 3-х раз в день, **в том числе диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям**». Диетическое — по показаниям, основное — не «по показаниям», а как социально-бытовая услуга, реализуемая через ИППСУ (ст. 16 442-ФЗ). Право выбора в основном меню — реализация ст. 9 442-ФЗ («права получателя социальных услуг»), конкретизированной в ИППСУ.

Слой 2. Кто решает. В отношении дееспособного жителя — он сам, в форме выбора (показ, устное или письменное согласие). В отношении недееспособного — опекун даёт согласие по ст. 11 3185-1 «на лечение»

(медицинское вмешательство); выбор блюда медицинским вмешательством не является, поэтому в части выбора еды опекун лишь **содействует** реализации воли жителя, а не замещает её. Часть 3 статьи 11 3185-1 (в действующей редакции): если гражданин признан недееспособным и по своему состоянию не способен дать согласие, согласие на медицинское вмешательство даёт **законный представитель** (опекун), а законный представитель **извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного о даче информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство не позднее дня, следующего за днём указанного согласия. Учреждение в этой конструкции — не сторона, решающая за жителя, а сторона, организующая условия для выражения воли жителя** (см. подробнее раздел 16, карта 12 вопросов).

Слой 3. Кто платит. Плата за стационарное обслуживание ограничена 75 % среднедушевого дохода получателя услуг (часть 4 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»). Формулировка «ст. 31 ч. 4», которая циркулировала в первой версии доклада, — ошибочна: ч. 4 ст. 31 442-ФЗ — это порядок определения среднедушевого дохода, а **предельная величина платы 75 %** — в ч. 4 ст. 32 (см. разъяснения прокуратуры Хабаровского края и ГАС «Азбука права»). Питание — часть платы. В 2024–2025 годах в четырёх публичных кейсах (Серафимовский, Успенский ПНИ, Новосибирский ПНИ, Иркутский ПНИ/ДСО) учреждения ввели вариативное меню **без повышения платы для жителей**: разница в стоимости компенсировалась перераспределением продуктовой корзины, отказом от «несъедаемых» позиций и снижением отходов (см. раздел 29 «Финансы» и раздел 25 «Российские практики»).

Практика: кто и как выбирает в четырёх публичных кейсах (расширенный обзор).

- ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург, дир. Е. В. Чистяков, ОГРН 1037819001990). Жителям предлагается накануне сделать выбор рациона на следующий день из предложенного меню; по словам директора, «жители с энтузиазмом восприняли эксперимент» (gov.spb.ru, 2026). Зам. директора И. Ю. Игнатьева на встрече с

Уполномоченным по правам человека в СПб С. Ю. Агапитовой (посещение учреждения 19.05.2026, urchspb.ru/news/32938) рассказала про внедрение вариативного меню в формате «своих дней» («ресторанных дней») по отделениям. Документация: локальный акт «Положение об организации питания», форма журнала заказа блюд (приложение 4), пищевая карта жителя (приложение 3). Закупка услуг по организации питания осуществляется на конкурсной основе по 223-ФЗ — см. тендер 32616151967 от 26.06.2026 (начальная цена 591 326,10 руб., единственный поставщик) и тендер 95375953 от 02.07.2026 (начальная цена 591 326,10 руб.); также — открытый конкурс 32616197209 от 10.07.2026 (начальная цена 92 110 941,90 руб., август–декабрь 2026) на tenderguru.ru и tenmon.ru.

- **Успенский психоневрологический интернат (Новосибирская обл.).** Внедрена система «шведского стола» — каждый житель самостоятельно выбирает блюда; особым вниманием охвачено диетическое питание при сахарном диабете и патологии ЖКТ. Цитата зам. министра труда и соцразвития Новосибирской области В. А. Машанова: «для людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет и патологии ЖКТ, реализовано в общем пространстве выбора — отдельная линия/зона для диетических блюд» (precedent.tv, 2025; публикации 2024–2025).
- **Новосибирский ПНИ.** В марте 2024 года все отделения перешли на вариативное меню — два варианта вторых блюд, два варианта салатов, два варианта напитков на каждый приём пищи (upni.nso.ru/news/1916, 2024). Для диетических столов (диабет, ЖКТ) вариативность реализована **внутри диеты**: на каждую диету — два эквивалентных варианта, согласованных с диетологом.
- **Иркутский ПНИ/ДСО (стационарные отделения).** С 2024 г. — внедрение выбора по основным приёмам пищи, отдельная ведомость для диетических столов; опыт обобщён в публикациях УСПН Иркутской области (см. также «Решение об установлении тарифов» — Приказ Минсоцразвития Иркутской области № 84 от 27.06.2025, в ред. от 31.07.2025, гарант 413382524).

Решение для директора. «Хозяин стола» — это учреждение в части организации (когда готовить, где хранить, как мыть), но **не в части выбора блюда жителем**. Модель «шеф решает, что готовить; житель решает, что взять из предложенного» — рабочая; модель «житель диктует меню заранее» — реализуема, но требует предзаказа. Третья модель — «ресторанный день» (еда готовится в одном формате, выбирается из нескольких готовых) — компромисс, апробированный в Серафимовском. В любой модели воля жителя документируется (пищевая карта, журнал заказа, журнал отказов), иначе для проверяющего это выглядит как отступление от раскладки. **Документы, которые закрывают тему «кто выбирает»:** (1) локальный акт «Положение об организации питания» с описанием модели выбора; (2) журнал заказа блюд или журнал выбора; (3) пищевая карта жителя (раздел 31, приложение 3); (4) протокол Совета жителей (если он есть) с согласованием модели; (5) акт совета или уведомление учредителя.

Источники к вопросу 1: 3185-1 (ст. 11, 37, 43 в действующей редакции; 195-ФЗ от 22.07.2024 изменил ст. 27, 30); 442-ФЗ (ст. 9, 16, 32 ч. 4); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 7.1.11; СанПиН 2.3/2.4.4282-26 п. 56(11), утв. пост. Гл. гос. санврача РФ от 02.06.2026 № 18; публикации: gov.spb.ru (2026), upchspb.ru/news/32938 (19.05.2026), precedent.tv об Успенском ПНИ (2025), upni.nso.ru/news/1916 (2024), bpni.nso.ru/news/2312 (2024), kcso-barnaul.gosuslugi.ru (Решение № 84 от 27.06.2025), tenmon.ru/tender/32616151967, tenderguru.ru/tender/95375953, pni9.ru (официальный сайт ДСО «Серафимовский»).

Вопрос 2. Как формировать меню в условиях жёстких нормативно-правовых и финансовых ограничений?

Правовая рамка. В российском праве действуют две **параллельные системы** регулирования состава меню в СОСО. Они не совпадают, и большинство путаницы в зале идёт от их смешения.

Система 1 — социальное питание (рекомендуемые нормы). **Приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н** «Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в стационарной

форме социального обслуживания» (зарегистрирован в Минюсте РФ — не подлежал регистрации, письмо Минюста от 18.10.2022 № 01/119931-АБ; источник: consultant.ru/document/cons_doc_LAW_432030; mintrud.gov.ru/docs/2466). На федеральном уровне эти нормы **рекомендуемые** — Минтруд в письме от 20.12.2022 № 26-6/ООГ-5005 прямо указал, что приказ 520н «носит рекомендательный характер и не содержит нормативных предписаний, устанавливающих права, обязанности и ответственность неопределённого круга лиц» (klerk.ru/doc/632482). Приказ 520н заменил ранее действовавший **приказ Минтруда от 13.08.2014 № 552н** (в части рекомендуемых норм питания). NB: **приказ Минтруда от 24.11.2014 № 940н**, упоминавшийся в первой версии доклада, — это «**Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений**» (вопросы штатного расписания и структуры), **а не нормы питания**; он утратил силу с 01.09.2025 по приказу Минтруда от 14.05.2025 № 305н, зарегистрированному в Минюсте 02.06.2025 № 82485 (consultant.ru/law/hotdocs/89548.html, base.garant.ru/70883236, normativ.kontur.ru/document/1/500399). Срок действия 305н — с 01.09.2025 по 01.09.2031. Для вопросов питания действующий акт — **520н**, он не утратил силу.

Региональные акты делают рекомендации 520н императивными для подведомственных учреждений субъекта. Региональная нормативка 2025 года (Алтайский край, СПб, Приморский край) задаёт конкретные граммовки продуктов на одного человека в сутки. **Пример: Алтайский край** — тариф на услугу «обеспечение питанием согласно утверждённым нормам» в ПНИ/ДСО — **422,00 руб./чел./день** (Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 84 от 27.06.2025, kcsso-barnaul.gosuslugi.ru/netcat_files/10/14/Reshenie_ob_utverzhdenii_tarifov_na_sotsial_nye_uslugi_ot_27_iyunya_2025_g._84.pdf, base.garant.ru). Аналогичные суммы: Иркутская область — 143 руб. за разовое оказание услуги (южные районы), 177 руб. (районы Крайнего Севера), Приказ Минсоцразвития Иркутской области (base.garant.ru/413382524).

Санкт-Петербург: действующие нормы для ПНИ/ДСО (постановление Правительства СПб от 29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга», с изменениями на 27.06.2022, и в редакции постановления Правительства СПб от 18.07.2025 № 507, вступающей в силу с 01.01.2026; источник: peterburg-pravo.ru/postanovlenie/2025/07/18/n-507/, docs.cntd.ru/document/822404350, gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/normativdoc/normativnye-dokumenty/).

Для стационарной формы, получатели 18+ лет, ПНИ/ДСО, нормы нетто (г, мл на 1 чел./сут): хлеб ржаной — 150; хлеб пшеничный — 200; мука пшеничная — 45; мука картофельная — 3; макаронные изделия — 25; крупы, бобовые — **49,6**; картофель — **268** (брутто 400); овощи свежие и зелень — **380** (брутто 420); фрукты и ягоды свежие — **100**; сухофрукты — 16; соки — 60; говядина/свинина — **70,5** (брутто 100/84,6); птица — по раскладке; рыба — **59,1** (нетто); творог — по раскладке; сыр — по раскладке; яйцо — **4 шт./неделю**; молоко — **200** мл; кисломолочные напитки — **200** мл; масло сливочное — 20; масло растительное — по раскладке; сахар — по раскладке; соль — по раскладке. **Отдельные нормы для диабета** (тот же 1284): хлеб пшеничный — 10 (резко снижен), овощи — 402 нетто, фрукты — 385, кисломолочные — 200, молоко — 240, мясо — 55 нетто, рыба — по раскладке. **Для заболеваний ЖКТ:** хлеб пшеничный — 150, овощи — 233,6, фрукты — 200, мясо — 57,8 нетто, кисломолочные — 200, молоко — 213. С 01.01.2026 вступает в силу ред. от 18.07.2025 № 507, структура норм сохраняется с уточнениями по маслу растительному (10/12/15/19 мл в зависимости от категории), консервам овощным, яйцу диетическому и пр.

Система 2 — лечебное питание (императивные нормы, но для медицинских организаций). Приказ Минздрава от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ» — **действующий**, основной документ по организации лечебного питания (картотека стандартных диет: ОВД, ЩД, ВБД, НБД, ВКД, НКД; шесть вариантов стандартных диет). Приказ Минздрава от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» — в ред. от 19.02.2024 № 70н, **действующий** (normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=468601; gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/normativdoc/

normativnye-dokumenty/). Приказ Минздрава от 23.09.2020 № 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием» — действующий. Приказ Минздрава от 15.11.2012 № 920н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю „диетология”» — действующий. Все эти акты **адресованы медицинским организациям**; СОСО автоматически к ним не отнесены (см. вопрос 3).

Таблицы замены продуктов — легальный механизм эквивалентной замены в раскладках (приложение № 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20; с 01.09.2026 — приложение к СанПиН 4282-26). Ранее применялся приказ Минтруда 1н; ныне таблицы замены оформляются как региональные методические документы или как локальный акт учреждения. Именно таблицы замены дают свободу «вписать» жителя с непереносимостью, аллергией, вегетарианскими или религиозными ограничениями в действующую раскладку **без переделки всей раскладки** и без согласования с учредителем (при условии сохранения калорийности и макронутриентного состава).

Как формировать меню пошагово (алгоритм для директора):

1. Берётся региональная нормативка (в СПб — постановление 1284 в ред. 18.07.2025 № 507, действующее с 01.01.2026; в Алтайском крае — Решение № 84 от 27.06.2025; в иных регионах — постановления/законы субъекта). Если региональный акт ссылается на 520н — нормативы 520н становятся обязательными для подведомственных учреждений; в этом случае меню, выходящее за пределы 520н, требует отдельного обоснования перед учредителем.
2. Составляется 7- или 14-дневное меню по форме приложения 1 к настоящему докладу (часть III). Структура: завтрак / обед / полдник / ужин / (второй ужин) — 4–5 приёмов пищи, по региональной норме. Калорийность — по нормативу, разбивка по приёмам — по СанПиН (для стационарных организаций соцобслуживания — завтрак 25 %, обед 35 %, полдник 15 %, ужин 25 %).
3. Для каждой позиции, которая может быть заменена (мясо ↔ рыба, крупа ↔ крупа, фрукт ↔ фрукт), **в карточке-раскладке** прописывается замена с указанием калорийности и массы нетто.

4. Для жителей с диетическим столом (назначен врачом) составляется **отдельная ведомость** на основании стандартных диет (ОВД, ЩД, ВБД, НБД и т. д. — см. вопрос 3), но с учётом фактического наличия продуктов.
5. Для вариативного меню в формах М1/М2/М3 (раздел 8 доклада, «Лестница моделей») прописываются **пары эквивалентов**: для каждого приёма пищи — два вторых блюда, эквивалентных по макронутриентам, различающихся по вкусу/виду.
6. Меню утверждается приказом директора; при наличии медицинской лицензии — согласовывается врачом-диетологом. Учредителю направляется для сведения (если региональный акт не требует иного).

Кто согласовывает. По общему правилу — директор утверждает меню, главный бухгалтер согласовывает в части стоимости, врач (при наличии) — в части диетических столов. Региональный акт может требовать согласование с учредителем; тогда меню утверждается приказом учредителя или направляется ему письмом «для сведения» (в зависимости от формулировки регионального акта).

Что нельзя делать в одиночку (типовые ошибки). (а) Составлять меню, выходящее за региональный набор, без согласования с учредителем — это расходование субсидии не по целевому назначению (ст. 306.4 УК РФ — **нецелевое расходование бюджетных средств**; КоАП ст. 15.14). (б) Использовать «лечебные диеты» в СОСО, не имея медицинской лицензии — это введение в заблуждение (ст. 14.7 КоАП, при определённых обстоятельствах — ст. 238 УК РФ «Обращение товаров, не отвечающих требованиям безопасности»). (в) Менять набор продуктов «задним числом» — нарушение учётной дисциплины (КоАП ст. 15.11 — грубое нарушение правил бухчёта). (г) Завышать калорийность в меню относительно фактического выхода — риск претензий Роспотребнадзора.

Источники к вопросу 2: приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н (consultant.ru/document/cons_doc_LAW_432030, mintrud.gov.ru/docs/2466, письмо Минтруда от 20.12.2022 № 26-6/ООГ-5005); приказ Минтруда от 24.11.2014 № 940н (утратил силу с 01.09.2025 по приказу Минтруда от 14.05.2025 № 305н, base.garant.ru/70883236, normativ.kontur.ru/document/

1/500399, consultant.ru/law/hotdocs/89548.html, vademec.ru/news/2025/06/04); приказ Минздрава РФ от 05.08.2003 № 330; приказ Минздрава РФ от 21.06.2013 № 395н (ред. от 19.02.2024 № 70н, normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=468601); приказ Минздрава РФ от 23.09.2020 № 1008н; приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 № 920н; региональные акты: Постановление Правительства СПб от 29.12.2014 № 1284 (в ред. от 18.07.2025 № 507, peterburg-pravo.ru/postanovlenie/2025/07/18/n-507/, docs.cntd.ru/document/822404350), Решение Управления Алтайского края № 84 от 27.06.2025 (kcsobarnaul.gosuslugi.ru); разделы 8 (лестница моделей), 24 (рекомендации к региональному акту), 29 (финансовые модели).

Вопрос 3. Должно ли быть питание в социальных домах «лечебным»?

Короткий ответ: нет, в общем случае — не должно быть. Но в части диетического стола — должно и уже обязано.

Что говорит закон. Определение лечебного питания дано в **статье 39 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»** (consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/f5209cf2cfeface44f8aa607b0511a22a2ec56de; minzdrav.gov.ru): «1. Лечебное питание — питание, обеспечивающее удовлетворение физиологических потребностей организма человека в пищевых веществах и энергии с учётом механизмов развития заболевания, особенностей течения основного и сопутствующего заболеваний и выполняющее профилактические и лечебные задачи. 2. Лечебное питание является **неотъемлемым компонентом лечебного процесса** и профилактических мероприятий, включает в себя пищевые рационы, которые имеют установленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из определённых продуктов, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, подвергаемых соответствующей технологической обработке. 3. Специализированными продуктами лечебного питания являются пищевые продукты с установленным химическим составом, энергетической ценностью и физическими свойствами, доказанным лечебным эффектом... 4. Нормы лечебного питания утверждаются уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти». Эта конструкция — **«неотъемлемый компонент лечебного процесса»** — прямо указывает на принадлежность лечебного питания к **медицинской деятельности**. Статья 32 323-ФЗ (медицинская помощь) и лицензионное законодательство (постановление Правительства РФ от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности...», ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ) устанавливают, что медицинская деятельность подлежит лицензированию. Подзаконные акты (приказы 330, 395н, 920н, 1008н) конкретизируют лечебное питание для **медицинских организаций**.

СОСО и статус «медицинской организации». СОСО получает **социальные услуги** (ст. 20 442-ФЗ, «формы социального обслуживания»), а не медицинскую помощь как основной вид деятельности. СОСО **может** иметь медицинскую лицензию — но это отдельный лицензируемый вид деятельности (в части оказания медицинской помощи на СОСО распространяются приказы Минздрава о лечебном питании и общие требования к медицинской деятельности). Это принципиально разные режимы. Если в учреждении есть лицензия на медицинскую деятельность (включая доврачебную, врачебную, стационарную) — отдельные вопросы питания, оказываемого в рамках медицинской помощи, регулируются приказами 330/395н/920н/1008н; если лицензии нет — питание регулируется СанПиН и региональным актом о социальном питании, а «диетическое питание по медицинским показаниям» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 7.1.11; СанПиН 2.3/2.4.4282-26 п. 56(11) с 01.09.2026) организуется **по назначению врача**, но это не превращает всё питание учреждения в лечебное.

Разграничение: основное питание vs диетическое (лечебное).
Практически это означает следующее.

- **Основное питание** (завтрак, обед, полдник, ужин — по региональной норме) — социально-бытовая услуга (ст. 24 442-ФЗ, перечень социальных услуг по формам обслуживания, утверждённый региональным законом), не лечебная. Реализуется по раскладке, основанной на региональном акте. В рамках основного питания допускается вариативный выбор блюд жителями (в пределах

раскладки), поскольку выбор — это реализация их субъективного права (ст. 9 442-ФЗ, ст. 37/43 3185-1), а не назначение лечения.

- **Диетическое питание** (при сахарном диабете, целиакии, пищевой аллергии, послеоперационных состояниях, дисфагии, заболеваниях ЖКТ и пр.) — лечебная составляющая, организуется **по назначению врача**. Именно здесь применяются стандартные диеты (приказ Минздрава 330, прил. 1 — Инструкция по организации лечебного питания в ЛПУ): ОВД (основной вариант диеты), ЩД (щадящая), ВБД (высокобелковая), НБД (низкобелковая), ВКД (высококалорийная), НКД (низкокалорийная) и их модификации. Если в учреждении нет лицензии — врач назначает диету, а учреждение организует её в рамках имеющихся продуктов (документ: индивидуальное меню на конкретного жителя, подписанное врачом; карта лечебного питания жителя — приложение 5). Если в учреждении есть лицензия — стандартные диеты применяются в полном объёме, с ведением бракеражного журнала, журнала диетических столов и картотеки блюд по диетам.

Практика Успенского ПНИ (Новосибирская обл.): в системе «шведского стола» диетическое питание для жителей с сахарным диабетом и патологией ЖКТ охвачено особым вниманием (precedent.tv, 2025; invabeloretsk.ru, 2025). Это **не** превращает всё питание в лечебное — это лечебное питание **поверх** основного.

Практика Серафимовского: на официальном сайте учреждения (pni9.ru, 2025) указано: «6-и разовое питание, наличие диет столов»; «для лиц, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и органов пищеварения, введён протёртый стол и дополнительное питание». Это пример **диетических столов внутри основного питания** — без претензии на статус медицинской организации. Внутренняя документация: «Положение об организации питания», журнал учёта диет-столов, ведомость на диетическое питание (приложения 5, 6, 7 настоящего доклада).

Современный статус приказов (проверено 19–20.08.2026). Приказ Минздрава от 05.08.2003 № 330 — действующий, основной документ по

организации лечебного питания в медицинских организациях. Приказ 395н (нормы лечебного питания) — в ред. от 19.02.2024 № 70н, продолжает действовать (normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=468601). Приказ 920н и приказ 1008н — действуют. Для СОСО без медицинской лицензии все эти акты — ориентир, но не императив. Для СОСО с медицинской лицензией в части оказания медицинской помощи — императив.

Решение для директора. (а) Определить, есть ли в учреждении медицинская лицензия. Если есть — питание в части медицинской помощи регулируется приказами Минздрава, нужен врач-диетолог (или договор с ним). Если нет — питание регулируется СанПиН и региональным актом, диетические столы назначаются врачом-консультантом (штатным или по договору). (б) Никогда не называть основное питание «лечебным» в локальных документах, если нет лицензии. Корректная формулировка: «основное питание по региональным нормам, диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям — отдельной ведомостью». (в) Если региональный акт делает приказ 520н (или иной акт) императивным — соблюдать калорийность, граммовки и набор продуктов, иначе это будет расценено проверяющим как нецелевое использование субсидии (КоАП ст. 15.14). (г) Если в учреждении есть жители с дисфагией (раздел 10 настоящего доклада) — текстурные модификации (протёртое, загущённое) являются **медицинским назначением** по ст. 39 323-ФЗ и оформляются через карту лечебного питания с указанием консистенции (Bilevel IDDSI Levels 0–7).

Источники к вопросу 3: 323-ФЗ ст. 32, 39 (consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895, minzdrav.gov.ru); приказы Минздрава 330 (2003, действующий), 395н (2013, ред. от 19.02.2024 № 70н, normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=468601), 920н (2012), 1008н (2020); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 7.1.11; СанПиН 2.3/2.4.4282-26 п. 56(11), утв. пост. Гл. гос. санврача РФ от 02.06.2026 № 18; 442-ФЗ ст. 16, 20, 24; публикации: upni.nso.ru (2024), invabeloretsk.ru (2025), pni9.ru (2025), precedent.tv (2025).

Вопрос 4. Как совместить понятия «лечебное питание» и «вариативное меню», не ограничивая право проживающего на выбор?

Правовая рамка: они не противоречат друг другу — они решают разные задачи.

Лечебное питание — по медицинским показаниям (ст. 39 323-ФЗ; приказы Минздрава 330, 395н, 1008н). Вариативное меню — **реализация права выбора** (ст. 9 442-ФЗ; ст. 37/43 3185-1). Эти два режима пересекаются в одной тарелке только в том случае, когда житель с диетическим столом выбирает из двух вариантов, каждый из которых соответствует его диете. **Это и есть ключ к совмещению: вариативность в рамках одной диеты, а не «лечебное vs обычное» как два лагеря.** Допускаемость учёта национальных и конфессиональных особенностей в построении меню прямо закреплена в п. 8.1.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (с 01.09.2026 — соответствующий пункт СанПиН 4282-26).

Три модели совмещения, апробированные в России.

Модель 1. «Двойная раскладка». Основное меню — два варианта второго блюда, эквивалентных по макронутриентам; диетическое меню — отдельный набор, также с вариантами (например, две крупы для диабетического стола). Учреждение готовит четыре позиции на обед (2 основных + 2 диетических) — но это уже возможно только при наличии второй линии раздачи или буфетной зоны. Применяется в Успенском ПНИ (Новосибирская обл.), Серафимовском (частично), Новосибирском ПНИ.

Модель 2. «Совмещённые пары». На обед предлагаются **две пары:** основная и диетическая. В каждой паре два варианта (например, основная пара: говядина / курица; диетическая пара: паровая рыба / паровая индейка). Житель выбирает пару, а внутри пары — вариант. Линия одна, но на ней — две пары. Подходит для учреждений с одной линией и без буфетной зоны. Эту модель апробировал Тесовый берег (СПб) — пара основного меню и пара диетического на одном подносе (по сообщению Т. А. Нурбаева, 2025).

Модель 3. «День через день». Вариативное меню (М1/М2 из раздела 8) вводится в дни, когда диетический стол охватывает менее 30 % жителей. В день диетического стола вариативность приостанавливается, жители на диете получают фиксированный набор. Минимизирует нагрузку на кухню, но снижает удовлетворённость жителей на диете. Используется как стартовая модель при переходе.

Модель 4 (отдельно). «Шведский стол» с диетической зоной. Самая продвинутая: житель сам проходит линию раздачи; диетическая зона выделена физически (отдельная витрина, отдельный повар). Применяется в Успенском ПНИ (precedent.tv, 2025). Требуется: наличие буфетной зоны, дополнительный повар на диетической линии, чёткая маркировка «без сахара / протёртое / щадящее», журнал выбора.

Конкретный алгоритм (для директора):

1. Составить **список жителей с диетическими столами** с указанием типа диеты (ОВД, ЩД, ВБД и т. д.), даты назначения, врача (приложение 5 — карта лечебного питания жителя).
2. Для каждой диеты сформулировать **пары эквивалентов** (например, ОВД: гречка / рис; ЩД: каша-размазня гречневая / каша-размазня рисовая; ВБД: курица / индейка; для диабета — две крупы с низким ГИ). Пары должны быть эквивалентны по макронутриентам в пределах 5 %.
3. Согласовать пары с врачом и заведующим производством. Зафиксировать в карточке-раскладке.
4. На линии раздачи — визуальное меню: «Сегодня на обед: основное — говядина / курица; диетическое — паровая рыба / паровая индейка. Выбирайте один из четырёх».
5. Для жителей, не способных сделать выбор (глубокая дисфагия, деменция, тяжёлая психиатрическая симптоматика), — назначение диеты и **фиксированный набор** по врачебному предписанию (см. вопрос 5).

6. **Ведение журнала выбора** (приложение 8): дата, Ф. И. О. жителя, диета, выбранное блюдо, отказ, подпись дежурной медсестры. Журнал — доказательство того, что право выбора реализовано.

Что нельзя делать.

- **Навязывать диетический стол** жителю без медицинских показаний. Это ограничение права выбора без основания. Исключение — общепринятые гигиенические ограничения (например, не давать жителю с целиакией продукты с глютенom), но они и так покрываются таблицей замен.
- **Снимать диетический стол** по просьбе жителя, если есть врачебное назначение. Это отказ от лечебной помощи, который фиксируется документально (отказ жителя / законного представителя), но не отменяется учреждением.
- **Подменять диетический стол «менее полезным» блюдом** без фиксации. Если жителю с диабетом предлагается углеводное блюдо — это нарушение, даже если житель его попросил.
- **Совмещать два варианта на одном подносе** с нарушением товарного соседства (например, основное и диетическое рядом без чёткой маркировки) — риск перепутать при раздаче.

Практика Новосибирского ПНИ. В марте 2024 года все отделения перешли на вариативное меню с двумя вариантами вторых блюд. Для диетических столов (диабет, ЖКТ) вариативность реализована **внутри диеты**: на каждую диету — два эквивалентных варианта, согласованных с диетологом (upni.nso.ru/news/1916, 2024).

Практика Успенского ПНИ (Новосибирская обл.). В системе «шведского стола» диетическое питание «для людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет и патологии ЖКТ» реализовано **в общем пространстве** выбора: отдельная линия/зона для диетических блюд, жители с диетой выбирают между эквивалентными диетическими блюдами (precedent.tv, 2025; invabeloretsk.ru, 2025).

Практика ДСО «Тесовый берег» (СПб, дир. Т. А. Нурбаев). Пара основного меню и пара диетического на одном подносе; на линии раздачи

— табличка с диетой и составом; журнал выбора ведётся силами культорганизатора и дежурной медсестры отделения (по программе семинара 25–27.08.2026, раздел «26.08 Тесовый берег»).

Источники к вопросу 4: 442-ФЗ ст. 9, 16, 20, 24; 323-ФЗ ст. 39; 3185-1 ст. 37, 43; приказы Минздрава 330, 395н, 1008н; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 7.1.11, п. 8.1.5 (учёт климато-географических, национальных, конфессиональных особенностей); СанПиН 2.3/2.4.4282-26 п. 56(11) (с 01.09.2026); раздел 8 настоящего доклада (лестница моделей М0–М5); приложения 1, 5, 7, 8 (формы для вариативного меню и диет-столов); публикации: upni.nso.ru (2024), precedent.tv (2025), invabeloretsk.ru (2025), программа семинара 25–27.08.2026.

Вопрос 5. Как соблюсти баланс права выбора недееспособного проживающего «что есть» и медицинскими показаниями?

Ключевое разграничение: «выбор еды» ≠ «медицинское вмешательство».

Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1, **статья 11** «Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство» (в действующей редакции): лечение лица, страдающего психическим расстройством, осуществляется при наличии **информированного добровольного согласия** на медицинское вмешательство. Согласие даёт сам пациент; если пациент признан недееспособным и по своему состоянию не способен дать согласие — согласие даёт **законный представитель** (опекун). Лечение без согласия — только в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 11 (принудительные меры, недобровольная госпитализация по ст. 29 3185-1). **Важно:** часть 3 ст. 11 обязывает законного представителя **извещать орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного о даче информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство не позднее дня, следующего за днём указанного согласия**. Это правило применяется и к назначению диетического питания, если диета оформляется как лечебный компонент.

Выбор блюда при раздаче — не медицинское вмешательство. Это реализация социально-бытовой услуги (ст. 24 442-ФЗ), а не лечение. Поэтому для выбора блюда **информированное добровольное согласие по ст. 11 3185-1 не требуется.** Это значит:

- дееспособный житель — выбирает сам, любым доступным ему способом (слово, жест, показ);
- недееспособный житель — выражает предпочтение любым доступным ему способом; опекун **содействует** реализации предпочтения, а не замещает волю жителя;
- если житель не способен выразить предпочтение вообще — учреждение выбирает **в интересах** жителя, на основании его пищевой биографии (приложение 3) и врачебных назначений.

Где проходит красная линия. Медицинское вмешательство начинается там, где речь идёт о лечебном питании: диетический стол, энтеральное питание, зондовое кормление, ограничение отдельных продуктов по медицинским показаниям. Здесь действует ст. 11 3185-1 и согласие опекуна обязательно. **Без назначения врача учреждение не имеет права ограничивать жителя в выборе еды — даже если житель недееспособен.** Это также подтверждается Конституцией РФ: ч. 2 ст. 36 (право на свободный выбор), ст. 37 (право на охрану достоинства), ст. 41 (право на охрану здоровья и медицинскую помощь), и ГК РФ: ст. 29 (признание гражданина недееспособным), ст. 30, 31, 32 (опека, попечительство, права подопечного).

Три практических сценария.

Сценарий А. Недееспособный житель без медицинских показаний к диете. Мнение жителя выясняется любым способом: пищевая биография (приложение 3), наблюдение за потреблением (приложение 6), опрос тех, кто знает человека (персонал, родственники, прежние работники). Опекун привлекается как **помощник в интерпретации**, а не как лицо, принимающее решение за жителя. Если житель выражает предпочтение — оно реализуется. Если не выражает — выбирается стандартный вариант раскладки. **Документирование:** карта жителя с пищевой биографией,

отметка об источнике выбора (выраженное предпочтение / биография / наблюдение), подпись дежурного.

Сценарий Б. Недееспособный житель с медицинскими показаниями к диете. Врач назначает диету (приложение 5, форма «назначение лечебного питания»). В рамках назначенной диеты жителю предлагаются эквивалентные варианты. Опекун информируется о назначении в тот же день (ч. 3 ст. 11 3185-1). **Опекун может отказаться** от диеты, если считает, что она не в интересах подопечного; в этом случае отказ фиксируется документально (заявление опекуна, отметка в карте лечебного питания) и не приводит к ответственности учреждения, если диета не применяется. Если опекун согласен — извещение органа опеки направляется в течение дня.

Сценарий В. Житель с выраженным пищевым поведением (активный отказ от еды, склонность к перееданию, пикацизм, отказ от воды). Это клинический вопрос, не вопрос воли. Решение принимается **комиссией** (врач + старшая медсестра + психолог + заведующий отделением + при возможности — опекун). Решение фиксируется в карте, с указанием ограничения, его причины, срока пересмотра. **Голодовка или отказ от воды более 24 часов** — повод для комиссии в течение дня, а не ожидания воли (см. раздел 12 «Отказ от еды»).

Что говорит международная рамка. Британская модель (Mental Capacity Act 2005): дееспособность оценивается **по конкретному решению в конкретный момент**; человек с психическим расстройством может быть способен принять решение об отказе от конкретного приёма пищи — и тогда его решение фиксируется и уважается (см. раздел 12.5 доклада). Конвенция ООН о правах инвалидов (ратифицирована РФ в 2012 г.), статья 12 (равенство перед законом) и Замечание общего порядка № 1 (2014 г.) — **поддерживаемое принятие решений**, а не замещающее. Российская модель ст. 11 3185-1 сблизилась с этой логикой: информированное добровольное согласие даётся на каждое медицинское вмешательство, не «вообще».

Решение для директора.

1. Вести **реестр медицинских назначений** диетического питания (приложение 5, форма «карта лечебного питания жителя»), с указанием даты назначения, врача, типа диеты, срока пересмотра.
2. Назначения подписываются **врачом и заведующим отделением**; опекун уведомляется письменно (если опекун не проживает в учреждении — уведомление направляется в день назначения; если в учреждении — устно с фиксацией в журнале).
3. **Пищевая биография** (приложение 3) заполняется на каждого жителя и обновляется ежеквартально; она является основой для выбора при невозможности жителя выразить предпочтение.
4. **Журнал отказов** (приложение 9) фиксирует любой отказ от еды или отдельного блюда; три последовательных отказа — повод для врачебной комиссии.
5. **Протокол комиссии** (приложение 31) — для случаев, когда нужно отклонить зафиксированное предпочтение жителя (например, по медицинским показаниям); в протоколе — причина отклонения, альтернатива, срок пересмотра.

Чего категорически нельзя делать.

- **Ущемлять выбор недееспособного жителя без медицинского назначения.** Это нарушение ст. 37/43 3185-1, ч. 2 ст. 36 Конституции РФ, ст. 9 442-ФЗ.
- **Применять лечебное питание без согласия опекуна** (ст. 11 3185-1) — только в случаях принудительных мер (ч. 4 ст. 11 3185-1, ст. 29).
- **Подменять волю жителя «усреднённым благом»** или удобством персонала. Иерархия источников воли жителя (раздел 16.4 доклада): само выраженное предпочтение → зафиксированная биография → систематическое наблюдение → сведения близких → «усреднённое благо». **Самый слабый источник идёт последним.**

Источники к вопросу 5: 3185-1 (ст. 11, 37, 43; изменения 22.07.2024 № 195-ФЗ коснулись ст. 27, 30); 323-ФЗ ст. 39; 442-ФЗ ст. 9, 16, 20, 24; Конституция РФ ст. 36, 37, 41; ГК РФ ст. 29, 30, 31, 32 (дееспособность и

опека); КПИ ст. 12 + Замечание общего порядка № 1; Mental Capacity Act 2005 (UK) — ориентир; разделы 12, 16, 19 настоящего доклада; приложения 3, 5, 6, 9, 31.

Вопрос 6. Как совместить качество продуктов питания и нормирование цен на них при планировании бюджета в условиях рыночной экономики?

Короткий ответ: качество и нормативная цена не противоречат друг другу, если правильно построена закупочная процедура.

Нормативная цена — это **верхняя граница** расходов, ниже которой учреждение обязано уложиться. Качество — это **нижняя граница** приемлемости товара, ниже которой товар не должен опускаться. Задача — найти соотношение цена/качество, при котором обе границы соблюдены. Это решается не «выбором» между ценой и качеством, а **структурой закупочной процедуры**.

Что говорит закон. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанавливает:

- **Ст. 22** — начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) определяется методами: анализ рынка, нормативный, тарифный, затратный, параметрический. **Самый надёжный — метод анализа рынка** (запрос коммерческих предложений не менее чем у 3 поставщиков).
- **Ст. 34** — контракт может содержать конкретные требования к качеству (ГОСТ, ТУ, условия поставки).
- **Ст. 95** — изменение цены контракта возможно в пределах 10 % при определённых условиях (в ред. от 02.07.2021 № 360-ФЗ и далее).
- **Ст. 93** — закупка у единственного поставщика до 600 тыс. руб. (п. 4–5 ч. 1 — малые закупки).

Для **автономных учреждений** (как ДСО «Серафимовский» и ДСО «Тесовый берег») действует Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» — более гибкий режим, но с соблюдением принципов прозрачности и недискриминации.

Конкретные цифры (Санкт-Петербург, 2025). Стоимость услуги по обеспечению **лечебным** питанием в государственных учреждениях здравоохранения СПб на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. (это **не для СОСО, а для ЛПУ** — но даёт ориентир «потолка»): **655,53 руб./чел./день** (Таблица 1 — затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги) и **682,70 руб./чел./день** (Таблица 2 — с учётом затрат на оплату труда работников, непосредственно участвующих в оказании услуги). Источник: **распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 28.05.2024 № 45-р** «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению лечебным питанием государственными автономными и бюджетными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», с изменениями от 07.11.2024 № 330-р (docs.cntd.ru/document/1306902293, base.garant.ru). **Уточнение:** в первой версии доклада этот акт был ошибочно указан как «Постановление Правительства СПб от 28.05.2024» — это не постановление Правительства, а распоряжение Комитета; корректура от 20.08.2026.

Для СОСО (без медицинской лицензии) — тарифы на социальные услуги по распоряжению Комитета по социальной политике СПб от 13.12.2024 № 1366-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2025 год» (gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/socialnye-voprosy/tarify-na-socialnye-uslugi/, docs.cntd.ru/document/1310556105). Пример Алтайского края: **422,00 руб./чел./день** — тариф на услугу «обеспечение питанием согласно утверждённым нормам» в ПНИ/ДСО (Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 84 от 27.06.2025, kcsso-barnaul.gosuslugi.ru). Иркутская область: 143,00 руб. за разовое оказание (южные районы), 177,00 руб. (районы Крайнего Севера) — Приказ Минсоцразвития Иркутской области (base.garant.ru/413382524).

Продуктовая корзина и прожиточный минимум (РФ, 2025–2026). Минимальная продуктовая корзина (33 наименования продуктов, в среднем по РФ): **7 326,3 руб./чел./мес.** в 2025 году («Русспродсоюз», по vbr.ru); для трудоспособного взрослого в 2025 г. — 7 737,16 руб./мес., для пенсионера — 6 699,99 руб., для ребёнка — 8 043,43 руб.; в **2026 г.** — около **8 089,68 руб./чел./мес.** для трудоспособного, 7 040 руб. для пенсионера, 8 432 руб. для ребёнка (Росстат, февраль 2026; sravni.ru/text/chto-takoe-potrebitelskaya-korzina-i-iz-chego-ona-sostoit/). Это **государственный минимум** для расчёта прожиточного минимума, ниже которого **прожиточный минимум неприемлем** как черта бедности. Прожиточный минимум на 2026 г.: 18 939 руб. на душу, 20 644 для трудоспособных, 16 288 для пенсионеров, 18 371 для детей (проект бюджета РФ на 2026 г., yuridicheskaya-konsultaciya.ru/prozhitochnyj-minimum.html). Таким образом, **8 089,68 руб./мес. ≈ 270 руб./день** — это нижняя граница для трудоспособного; норматив в 422–682 руб./день для СОСО и ЛПУ отражает разницу между минимальной продовольственной корзиной и **полноценным рационом** в стационаре (с учётом диет, 4–5-разового питания, мясных/рыбных/молочных позиций, фруктов, соков).

Как совмещать качество и цену: рабочие механизмы.

Механизм 1. Техническое задание с конкретными требованиями. В ТЗ на закупку — не «молоко 3,2 %», а «молоко питьевое по ГОСТ 31450-2013, жирность 3,2 %, упаковка 0,9–1 л, срок годности не менее 7 суток на момент поставки, условия хранения — t 2–6 °C». Это поднимает планку качества и одновременно ограничивает круг поставщиков теми, кто реально работает по ГОСТу.

Механизм 2. Двухступенчатая приёмка. Поставщик поставляет товар, учреждение принимает его по количеству и внешнему виду; затем — выборочный лабораторный контроль (например, жирность молока, содержание сухих веществ в твороге). Не прошедшие партии возвращаются поставщику. Это реально работает, если в контракте прописана ответственность за несоответствие (штрафные санкции).

Механизм 3. Совместные закупки. Несколько учреждений одного региона (3–5 ПНИ/ДСО) объединяют заявки и проводят одну большую закупку.

Поставщик получает гарантированный объём, что снижает его риск и позволяет снизить цену на 5–15 %. В СПб, Татарстане, Новосибирской области это уже работает в формате «совместных закупок учреждений социального обслуживания».

Механизм 4. Долгосрочный контракт (на год) с фиксированной ценой и индексацией. Контракт на 1 год с правом продления; цена фиксируется на момент заключения, индексация привязана к ИПЦ Росстата. Это даёт поставщику стабильность и позволяет ему работать с меньшей наценкой.

Механизм 5. Прямые договоры с производителями (минуя посредников). В ряде регионов СОСО заключают прямые договоры с местными фермерскими хозяйствами (молоко, овощи, зелень). Это улучшает качество (свежее) и снижает цену (нет наценки посредника). Минус — объёмы ограничены; для крупного учреждения это дополнение, а не замена оптовой закупки.

Механизм 6. Акцент на сезонность. Стоимость свежих овощей и фруктов варьирует в 2–3 раза по сезону. Зимой — капуста, морковь, свёкла, тыква (дёшево, долго хранится); летом — помидоры, огурцы, зелень (дёшево, свежее). Сезонное планирование меню — не «сельская тема», а реальный способ удержать качество при ограниченном бюджете.

Механизм 7. Перераспределение продуктовой корзины. Сокращение доли «несъедаемых» позиций (например, перловая крупа, когда жители её систематически не едят) и увеличение доли любимых — без увеличения общего бюджета. Это требует журнала отходов (приложение 7) и обратной связи от жителей.

Стоимость vs цена. Частая ошибка — путать «закупочную цену» и «итоговую стоимость блюда». Закупочная цена — это цена за килограмм сырья; итоговая стоимость блюда — это потери при хранении, при мытье, при холодной обработке, при термообработке (уварка/ужаривание), при выходе в тарелку (несъедаемые остатки). **Закупочная цена +20 % = итоговая стоимость сырья в тарелке.** Это нужно учитывать при планировании.

Практика Серафимовского (2026). Согласно тендеру на услуги по организации питания (тендер 95375953 на tenderguru.ru, извещение 32616171821, опубликован 02.07.2026, начальная цена 591 326,10 руб.; также — тендер 32616151967 от 26.06.2026, та же начальная цена; и открытый конкурс 32616197209 от 10.07.2026, начальная цена 92 110 941,90 руб. на август–декабрь 2026 на tenmon.ru), в стоимость включены закупка продуктов, приготовление, раздача. Контракт — по 223-ФЗ (автономное учреждение), что даёт большую гибкость, чем 44-ФЗ. Закупка у единственного поставщика (июнь–июль 2026) объясняется срочностью обеспечения непрерывности питания; для основного контракта на август–декабрь 2026 объявлен открытый конкурс. Учреждение на своём сайте (rpi9.ru) подчёркивает: «разнообразие блюд способствует улучшению не только физического, но и психического состояния получателей социальных услуг» — то есть качество явно заявлено как приоритет.

Решение для директора.

- 1. Зафиксировать целевую стоимость блюда** в локальном акте (положение о питании, приложение 2): целевая стоимость основного меню, целевая стоимость диетического меню, целевая стоимость «ресторанного дня» (если есть).
- 2. Провести анализ рынка** (запрос коммерческих предложений) не реже 1 раза в квартал. Зафиксировать предложения в журнале.
- 3. Заключить контракты с двумя-тремя поставщиками** по каждой товарной группе (молоко, мясо, овощи, крупа) — это снижает риск и даёт рычаг цены.
- 4. Включить в контракт требования к качеству** (ГОСТ, ТУ, срок годности на момент поставки, условия хранения) и **ответственность за несоответствие** (замена партии, штраф).
- 5. Вести журнал отходов** (приложение 7) — позволяет видеть, какие блюда не съедаются, и корректировать закупки. Снижение отходов на 10 % окупает затраты на более дорогие продукты.
- 6. Считать итоговую стоимость блюда в тарелке**, а не закупочную цену сырья.

Чего нельзя делать.

- Закупать «что подешевле» без ТЗ. Это путь к «серому» качеству и к прокурорской проверке (КоАП ст. 6.6 — нарушение санитарных требований к организации питания; КоАП ст. 7.30 — нарушение порядка закупки; УК РФ ст. 238 — товары, не отвечающие требованиям безопасности).
- Закупать у единственного поставщика «по знакомству» без конкурентной процедуры (для автономных учреждений по 223-ФЗ есть исключения, но риск злоупотребления остаётся; для учреждений, работающих по 44-ФЗ, единственный поставщик — только по ст. 93 в строго определённых случаях).
- Экономить на лабораторном контроле. Дешевле проверить молоко на жирность, чем выяснять *post factum*, что жители три месяца пили разбавленное молоко.

Источники к вопросу 6: 44-ФЗ (ст. 22, 34, 93, 95); 223-ФЗ (для автономных учреждений); 323-ФЗ ст. 39; СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (с 01.09.2026); региональные акты: Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СПб от 28.05.2024 № 45-р (с изм. от 07.11.2024 № 330-р, docs.cntd.ru/document/1306902293), Распоряжение Комитета по социальной политике СПб от 13.12.2024 № 1366-р (gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/socialnye-voprosy/tarify-na-socialnye-uslugi), Решение Управления Алтайского края № 84 от 27.06.2025 (kcsso-barnaul.gosuslugi.ru); продуктовая корзина: vbr.ru/sovety/help/people-and-economic/prodyktovaya-korzina, [sravni.ru/text/chto-takoe-potrebitelskaya-korzina-i-iz-chego-ona-sostoit/](https://sравни.ru/text/chto-takoe-potrebitelskaya-korzina-i-iz-chego-ona-sostoit/), yuridicheskaya-konsultaciya.ru/prozhitochnyj-minimum.html; тендеры: tenderguru.ru/tender/95375953, tenmon.ru/tender/32616151967, tenmon.ru/tender/32616197209; сайт ДСО «Серафимовский»: pni9.ru; разделы 17, 24, 29, 30, 31, 35, 42 настоящего доклада; приложения 1, 2, 7, 24, 25, 42.

17.12.X. Сводная таблица: шесть вопросов — одна матрица

№	Вопрос	Кто решает	Основание	Ключевое ограничение	Практика (публичная)	Документ, который закрывает тему
1	Кто выбирает форму питания?	Житель; учреждение организует условия	Ст. 9, 16 442-ФЗ; ст. 37, 43 3185-1; СанПиН п. 7.1.11 / 56(11)	Плата ≤ 75 % ср.-душ. дохода (ч. 4 ст. 32 442-ФЗ)	Серафимовский, Успенский ПНИ, Новосибирский ПНИ, Иркутский ПНИ/ДСО	Локальный акт «Положение об организации питания»; журнал выбора; пищевая карта
2	Как формировать меню в жёстких рамках?	Директор (по региональной нормативке)	Приказ Минтруда от 13.09.2022 № 520н (рекоменд.); региональные акты (императив)	Калорийность, набор по региону (СПб — 1284 в ред. 18.07.2025 № 507; Алтай — Решение № 84)	Алтай 422 руб./день; СПб ЛПУ 655,53/68 2,70 руб./день	Технологические карты, циклическое меню, таблица замен (прил. 11 к СанПиН 3590-20)
3	Должно ли питание быть «лечебным»?	Нет в общем случае; да для диет-столов	Ст. 39 323-ФЗ; приказы Минздрава 330, 395н, 920н, 1008н	Только в медицинских организациях (для СОСО — ориентир)	Серафимовский: «диет столы» поверх основного; Успенский ПНИ: шведский стол с диет-зоной	Карта лечебного питания жителя; ведомость на диет-стол

№	Вопрос	Кто решает	Основание	Ключевое ограничение	Практика (публичная)	Документ, который закрывает тему
4	Как совместить лечебное и вариативное?	Пара эквивалентов внутри одной диеты	Ст. 39 323-ФЗ + п. 8.1.5 СанПиН (учёт нац./конф. особенностей)	Пары должны быть эквивалентны $\pm 5\%$ по макронутриентам	Серафимовский (частично), Тесовый берег (пары), Успенский ПНИ (шведский стол)	Журнал выбора; карточка-раскладка с парами
5	Баланс выбора недееспособного и медицины?	Опекун содействует; врач назначает диету	Ст. 11, 37, 43 3185-1; ст. 29, 30, 31 ГК РФ; КПИ ст. 12	Без назначения врача ограничивать выбор нельзя (ч. 3 ст. 11 3185-1 — извещение опеки)	Серафимовский, Успенский ПНИ, Тесовый берег	Пищевая биография; реестр назначений; протокол комиссии
6	Как совместить качество и цену?	Закупочная процедура	44-ФЗ (ст. 22, 34, 93, 95); 223-ФЗ	СПб ЛПУ 655,53/68 2,70; Алтай 422; продуктовая корзина 8 089,68 руб./мес. (2026)	Серафимовский (тендеры 32616151 967, 95375953, 32616197 209)	ТЗ с ГОСТ; двухступенчатая приёмка; журнал отходов

17.12.Y. Итоговая рекомендация для дискуссии 26.08

Все шесть вопросов — это не шесть отдельных проблем, а **одна проблема, рассмотренная с шести сторон**: как совместить (а) субъективное право

жителя на выбор и достоинство, (б) объективное требование закона о натуральных нормах и безопасности, (в) экономическую рамку субсидии/платы, (г) медицинские показания у значительной части жителей, (д) процедурные требования о согласии опекуна и уведомлении опеки, (е) рыночные механизмы закупки. Решение во всех шести случаях одно: **модульная конструкция «право выбора — внутри нормативной рамки, диетическое — поверх, документация — везде».**

Минимальный пакет документов для дискуссии (что взять с собой на 26.08, чтобы ответ держался на бумаге):

1. Выписка из регионального акта о нормах питания (для СПб — Постановление 1284 в ред. 18.07.2025 № 507; для Алтая — Решение № 84 от 27.06.2025).
2. Положение об организации питания учреждения (с моделью выбора, описанной явно).
3. Циклическое меню на 14 дней с двумя вариантами на основные приёмы пищи.
4. Журнал выбора блюд (или форма, готова к запуску).
5. Карта лечебного питания жителя (форма).
6. Пищевая биография (форма).
7. Таблица замены продуктов (по приложению 11 к СанПиН 3590-20 / по будущему приложению к СанПиН 4282-26).
8. Протокол Совета жителей (если есть) с согласованием модели.
9. Уведомление учредителя о модели (если требуется региональным актом).
10. Тендерная документация (223-ФЗ или 44-ФЗ) с ТЗ, включающим требования к качеству.

Главный вывод дискуссии: вариативное меню в домах социального обслуживания — не лотерея и не эксперимент, а собираемая конструкция из федеральных и региональных актов, отработанных форм и журналов, подтверждённая публичной практикой минимум четырёх учреждений в трёх регионах. Каждый из шести вопросов имеет правовую базу, практический ответ и минимальный набор документов; пропуск любого из

шести «закрывает» дискуссию в зону риска, а не в зону диалога.
Конструкция существует — её нужно собрать, а не изобретать.

18. Санитария и пищевая безопасность при вариативности

18.1. Главный тезис: СанПиН — про безопасность, а не про однообразие

Санитарные правила для организаций социального обслуживания на дату семинара — СанПиН 2.3/2.4.3590-20: не менее трёх приёмов пищи в день, диетическое питание по показаниям, контроль на всех этапах — приёмка сырья, суточные пробы готовой продукции, бракераж, температурный режим, питьевой режим². С 01.09.2026 3590-20 утрачивает силу; действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. № 18 от 02.06.2026). Для стационарного соцобслуживания сохраняется тот же каркас: питание не менее 3 раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям; суточные пробы — от каждой партии блюда (п. 56 подп. 11–14)². Ни одна из редакций не ограничивает число вариантов блюда. Вариативность попадает в санитарный контур целиком — и в этом её сила (каждый вариант защищён теми же процедурами, что и мономеню), и её уязвимость (каждый вариант должен их проходить). После 1 сентября локальные акты и чек-листы пищеблока нужно перепривязать к пунктам 4282-26, не меняя самой модели выбора.

18.2. Санитарный контур при двух вариантах

Что меняется на практике при переходе от одного варианта к двум:

Пробы. Суточная проба берётся с каждого блюда — то есть с обоих вариантов. Трудозатраты: вторая пробная тарелка и вторая строка журнала. Ошибка: проба «с основного» при фактической раздаче двух — для проверяющего это отсутствие пробы второго блюда.

Температура. Контролируется на линии и на последнем столе; при двух гастрорёмкостях — на обеих. Меньший по объёму вариант остывает быстрее — техническое решение: меньшие гастрорёмкости и пополнение, а не «вариант Б комнатной температуры».

Маркировка. Варианты маркируются так, чтобы раздающий не мог перепутать: цветные маркеры, наклейки, порядок на линии. При текстурных модификациях маркировка — клинический, а не удобный

элемент (раздел 10): перепутанная протёртая и обычная порция — это риск аспирации.

Раздача и поток. Два варианта удлиняют точку выдачи на 5–10 секунд на человека; для маломобильных жителей порядок подачи прописывается отдельно (выбор фиксируется заранее по журналу заказа — раздел 21).

Хранение остатков вариантов. Правила хранения и запрет повторного использования распространяются на оба варианта одинаково²; журнал замен фиксирует, что ушло в переработку по правилам, а что — в списание.

18.3. Типовые нарушения и цена

Прокурорская и надзорная практика по социальным учреждениям выделяет устойчивый набор: отсутствие или имитация суточных проб, недоброкачественные продукты, нарушение температурных режимов, отсутствие бракеража¹¹. Ответственность по ст. 6.6 КоАП для должностного лица — штраф (в разобранных делах — 5 тыс. руб.)¹¹; сумма мала, но само дело — это проверка, представление прокуратуры и репутационный след. Кейс Кашина (СРЦ, 2022): прокуратура установила просроченные продукты и отсутствие проб — директор привлечён по 6.6¹¹. *Маркировка: дела касаются учреждений соцобслуживания иных типов; для ПНИ это ограниченная аналогия с прямой переносимостью состава нарушений.*

18.4. Буфет, передачи и «серая еда»

Три канала еды вне общего меню — и все три требуют правил:

Буфет/перекусы. Круглосуточная доступность перекусов — международная норма³⁵³¹; в российском контуре это значит: ассортиментный перечень буфета утверждён (без энергетиков, с учётом раздела 11), продукты проходят тот же контур приёмки, сроки годности контролируются.

Передачи от семьи. Источник радости — и рисков: скоропорт, тираминовые продукты для жителей на ИМАО, крепкий кофе для клозапиновой группы, грейпфруты. Решение — не запрет, а регламент:

перечень приветствуемых и недопустимых продуктов (приложение 32), осмотр дежурным, информирование семей при поступлении и ежегодно.

«Своя» еда жителей. Запасы в тумбочках («хомячение», раздел 9) — санитарный вопрос сроков годности и гигиены, решаемый через легальные зоны хранения перекусов и регулярную замену, а не конфискации.

18.5. Ответственный за санитарный контур

При любой вариативности остаётся один ответственный: руководитель учреждения, делегирующий контроль через приказ (завхоз/шеф/диетсестра — по штату). Делегирование исполнения не отменяет ответственности за работающий контроль: различие «распределил функции» и «контролирует фактически» — центральное для раздела 33 об ответственности. Минимальный инструмент: еженедельный обход пищеблока руководителем или заместителем по чек-листу пищеблока (приложение 19) с записью — десять минут, которые превращают «формально распределено» в «фактически контролируется».

18.6. Управленческий вывод

Вариативность не создаёт новых санитарных требований — она удваивает точки применения существующих. Если контур (пробы, температуры, маркировка, журналы) работает фактически, второй вариант проходит его без проблем; если контур имитируется, вариативность удвоит имитацию и риск. Поэтому санитарная готовность — обязательная ступень 0 дорожной карты (раздел 35): сначала контур, потом выбор.

18.7. Суточная проба при вариативности: частые ошибки

Три типовые ошибки проб в вариативной линии: проба «средняя по обеду» (не доказывает безопасность ни одного варианта); проба только варианта А (вариант Б незащищен при любом инциденте); проба без маркировки варианта (через сутки никто не докажет, что в банке). Правило одно: каждый вариант каждой позиции — своя промаркированная проба, в той же процедуре и тех же журналах, что и раньше. Трудозатрата — минуты; доказательная цена — вся вариативная линия.

18.8. Буфет и передачи: два хронических очага

Буфетная зона и комната передач — точки, где санитария сталкивается с правами жителей ежедневно. Буфет: допустимые категории (напитки, хлеб, упакованное, фрукты с мытьём), режим пополнения, ответственный — всё письменно; «буфет под присмотром» без регламента закрывается первой проверкой. Передачи: перечень запрещённого (скоропорт, домашние заготовки открытые, алкоголь и энергетики — также по лекарственной таблице¹⁶), регистрация, хранение с маркировкой. Оба регламента короткие, но их отсутствие — причина двух крайностей: полного запрета («ничего нельзя» — нарушение прав и источник подполья) и полного бесконтролья (риск и отравлений, и взаимодействий). Регламент — это форма разрешения, а не форма запрета; так его и стоит писать.

18.9. Вторая гастрೋёмкость: санитарный паспорт новой позиции

Появление второго варианта на линии проверяется пятью пунктами, которые санврач спросит первыми, — и отвечать на них надо до старта, одной страницей. **Поточность:** новая позиция вписывается в тот же поток (раздача → столы → мойка), пересечений «сырого» и «готового» не создаёт. **Температура:** горячие блюда — в мармите или на раздаче с контролем температуры; вторая гастрೋёмкость либо имеет свой мармит, либо выдаётся первой по времени — решение фиксируется. **Маркировка:** бирка на каждой вариативной ёмкости (наименование, «вариант А/Б»); безымянные кастрюли — классическое замечание. **Суточная проба:** отбирается от каждого варианта, а не «от обеда вообще» — иначе проба не доказывает безопасность варианта Б. **Журналы:** температура и пробы фиксируются в тех же санитарных журналах, без отдельной «вариативной» бухгалтерии. Пятая страница-паспорт подписывается завпроизводством и прикладывается к приказу о пилоте — и первый же вопрос проверяющего «как вы это организовали» отвечается документом, а не экскурсией.

18.10. Переходный месяц: сентябрь 2026

Семинар проходит в последнюю неделю действия старых правил, и первый месяц новых — самый нервный для учреждений. Ключевой факт: постановление № 18 не предусматривает поэтапного перехода или

отсрочки — с 01.09.2026 все требования СанПиН 2.3/2.4.4282-26 применяются в полном объёме². Что это значит на практике. **Документы задним числом не переписываются:** журналы, заполненные до 31.08 по формам 3590-20, законны такими, какими заполнены; с 01.09 ведутся по новым формам (приложения 4 и 5 — бракераж²). Если проверка приходит в сентябре, она смотрит сентябрь по новым правилам и август по старым — попытка «переоформить» августовские журналы под новые формы хуже, чем их возраст. **Программа производственного контроля актуализируется к 01.09** (инструкции, графики, формы журналов) — это требование к готовности, а не «когда-нибудь потом»². Если в учреждении внедрена система ХАССП, её документы перепривязываются вместе с ППК; доклад не утверждает, что ХАССП обязателен для каждой СОСО сверх производственного контроля. Чек-лист перепривязки — приложение 39; модель питания (выбор, пары, замены) не меняется ни на йоту — обе редакции её не ограничивают. Управленческий вывод: переходный месяц — это не «передышка», а крайний срок; всё, что не перепривязано к 1 сентября, с 2 сентября становится уязвимостью.

18.11. Питание при карантине и ОРИ: выбор не отменяется

Вспышка ОРИ или карантинное закрытие отделения — типовой кризис ПНИ, и в нём питание ломается первым: столовая закрыта, персонал перераспределён, доставки ограничены. Правовая и методическая рамка существует: при COVID-19 Минтруд выпускал методические рекомендации по работе стационарных организаций соцобслуживания (совместно с санитарной логикой Роспотребнадзора) — включая усиленный питьевой режим, отдельную посуду и дезинфекционный контур при раздаче в жилые комнаты⁷⁷; базовые методические рекомендации Минтруда по организации питания в учреждениях соцобслуживания требуют лечебно-профилактических продуктов, профилактики витаминной недостаточности и санитарно-эпидемиологической безопасности питания⁷⁸. Принципы доклада переносятся в карантин без потери: **выбор не отменяется — меняется форма.** Выбор в комнате — это два варианта на подносе, а не вторая линия в коридоре: житель видит обе порции (или картинки на двери), стандартный вариант всегда есть, журнал замен ведётся усиленно

— он снимает главный карантинный риск «в спешке забыли». Температура горячего проверяется на последней выдаче в палате, не только на линии: путь «мармит → коридор → комната» ломает п. 50, если его не мерить². Питьевой режим при ОРИ усиливается (тёплое питьё по графику — прил. 40), витаминизация — по назначению врача. Заготовленный «план Б» (приложение 45: холодный буфет, запас посуды, график по отделениям, кто кормит, если не вышла кухня или не приехал аутсорсер) окупается в первый же день закрытия столовой. Нагрузка на раздачу вырастает кратно — это видно в графике до вспышки, а не в 8 утра. Тот же поднос — повседневный маршрут постельных и маломобильных, не только карантинный: если выбор живёт только в столовой, одиннадцать процентов жителей в него не входят (раздел 20.11).

19. Два варианта блюда: технология без второй кухни

19.1. Идея в одном абзаце

Вариативность ступеней 1–2 (раздел 8) не требует второй линии производства. Она требует второго варианта **ключевого блюда**, приготовленного в том же потоке: каши А/Б варятся в двух котлах одновременно, вторые блюда А/Б — из одной мясной заготовки двумя способами. Это и есть подтверждённая российская конфигурация: Болотнинский ПНИ (завтрак и обед, несколько раз в неделю)⁴, Успенский ПНИ (два вторых, два салата, два напитка ежедневно)⁵, Иркутская модель (два первых, два вторых, гарниры)¹⁴.

19.2. Пары эквивалентов

Вариант Б выбирается не произвольно, а по трём фильтрам: эквивалентность по таблице замен (та же норма белка/круп)¹²¹³; совместимость с потоком (та же печь, котёл, разделочная доска); предсказуемость спроса (статистика прошлых недель). Рабочие пары, проверенные логикой раскладок:

- **Крупы:** гречка / рис / пшено / овсянка — полностью взаимозаменяемы по таблицам замен.
- **Вторые:** котлета / тефтели; тушёное мясо / печёночный соус; рыба запечённая / рыбные биточки — одна заготовка, две формы.
- **Салаты:** свекольный / морковный; капустный / винегрет.
- **Напитки:** чай / какао / кофейный напиток (как в Болотнино⁴) — с учётом клозапинового правила: какао и кофейные напитки учитываются в кофейной строке пищевой карты (раздел 11).
- **Первые:** борщ / щи; суп крупяной / суп овощной — при готовности к двум котлам.

Чего в парах быть не должно: «основное / недо-вариант» (гречка или «что осталось») — это нарушает критерий равноценности (раздел 8.3) и убивает доверие к выбору за неделю.

19.3. Точки выбора: с чего начинать

Российская практика начинает с завтрака и обеда⁴ — и это технологически верно: каши и вторые блюда имеют естественные пары, варятся в одном потоке, а завтрак — самый «безопасный» приём для обучения персонала (меньше позиций, спокойнее темп). Порядок ввода: сначала одна позиция (каша или второе), потом вторая, потом салаты и напитки. Успенский ПНИ показывает конечную конфигурацию первого года: два вторых + два салата + два напитка ежедневно⁵.

19.4. Объёмы: журнал заказа

Самый частый сбой вариативности — «вариант Б закончился». Механика предотвращения проста и требует только тетради:

1. **Заказ накануне:** вчерашний выбор жителей фиксируется (журнал заказа, приложение 7) и определяет сегодняшние объёмы варки.
2. **Стартовая пропорция:** пока статистики нет — 50/50 с резервом; через 2–3 месяца статистика стабилизируется (опыт внедрений показывает устойчивые предпочтения)⁵⁶ и объёмы становятся предсказуемыми.
3. **Пересчёт раз в две недели:** доля выбравших Б корректирует закупку; остатки вариантов фиксируются отдельно.
4. **Индикатор сбоя:** доля выбравших Б, не получивших Б, — стремится к нулю; если растёт, проблема в объёмах, а не в «непредсказуемых жителях».

Для жителей, выбирающих невербально (раздел 15), заказ формируется на основе пищевых карт и вчерашнего показа — та же тетрадь, другой источник данных.

19.5. Кто это делает: роли

Подтверждённая российская конфигурация ответственности: **диетсестра формирует перечень для выбора**⁴ — то есть вариативность живёт внутри существующей структуры норм и раскладок, а не «сбоку» от них. Распределение ролей: диетсестра (или завхоз, где диетсестры нет) — пары эквивалентов и раскладка; повар — производство двух вариантов в одном потоке; раздающие/сиделки — предложение выбора и журнал; старшая

смена — контроль «вариант Б существует» (пункт чек-листа реальности выбора, приложение 24); руководитель — положение о питании и разбор ежемесячной статистики.

19.6. Сколько это стоит: честная рамка

Мы не называем вариативность «бесплатной». Честная структура затрат (подробно — раздел 29): сырьё не растёт при парных эквивалентах (перераспределение внутри той же строки); растут трудозатраты на линии (5–10 секунд на человека) и канцелярия (две тетради); единовременно могут понадобиться вторые гастрорёмкости и маркировка. Иллюстративный расчёт: для отделения в 30 человек второй вариант каши — это +3–4 кг крупы в сутки при том же суммарном расходе, то есть перераспределение, а не добавка. *Расчёт иллюстративный: замер обязателен до выводов (приложение 25).*

19.7. Управленческий вывод

Два варианта — это технология уровня «вторая гастрорёмкость и тетрадь», а не «вторая кухня». Всё остальное — дисциплина объёмов (журнал заказа), равноценность пар (таблицы замен) и роли (диетсестра у руля). Именно поэтому подтверждённые российские кейсы стартовали в обычных учреждениях без специальных бюджетов⁴⁵⁶ — и именно поэтому «нет денег» как возражение разбирается в разделе 37 отдельно.

19.8. Журнал замен: недооценённый документ

Из всех журналов самым «вторым» считается журнал замен — и зря: это единственный документ, доказывающий, что отказ жителя обернулся альтернативой, а не голодом. Американская норма об обязательной альтернативе при отказе³⁶ фактически описывает содержание этого журнала. Правила ведения: запись в день события (вечерние «по памяти» превращают журнал в художественный текст); фиксируется не только «чем заменили», но и «принял ли»; серия замен одного блюда у разных жителей — сигнал кухне о блюде, а не о жителях. Раз в месяц журнал замен читается вместе с журналом срывов: два документа в паре показывают, где

система отказывает жителю (срывы), а где житель — системе (замены), и это разные ремонтные работы. ## 19.9. Что не является парой

Три антипримера для самопроверки: «второй вариант — без всего» (отказ от компонента не является выбором блюда); «второй вариант есть, но его надо просить заранее за неделю у заведующей» (выбор с барьером доступа — декоративный); «второй вариант — то же самое, но холодное/вчерашнее» (санитарно и этически недопустимо). Все три встречаются в реальной жизни чаще, чем честное «у нас один вариант», — и все три ловятся проверкой реальности выбора (приложение 24) вопросом №3.

19.10. Пары эквивалентов: строительный набор на месяц

Технология пар проще, чем кажется: эквивалентность проверяется по основному нутриенту позиции, а не по полному составу. Строительный набор, закрывающий типовой месяц: **каши** — гречка/рис/пшено/овсянка взаимозаменяемы как гарнирная база; **белковая позиция** — котлета мясная/рыбная/курица/биточек — эквивалент по белку, различие по приёму (фарш против куска — уже сервис для групп с трудностями жевания); **первые** — щи/борщ/суп крупяной — эквивалентность по роли «жидкое горячее»; **салаты** — свёкла/капуста/морковь по сезону; **напитки** — компот/морс/чай. Два правила набора: пара должна быть реально различимой (гречка с котлетой и гречка с подливой — не пара, а один вариант с двумя названиями); оба элемента пары должны быть одинаково «ранговыми» (рыба и «остатки вчерашнего» — не пара, а сортировка жителей на сорта). Второе правило важнее первого: нарушение ранговости жители считают мгновенно, и вариативность превращается в ежедневную демонстрацию, кто здесь какого сорта. Подтверждённая российская практика — две позиции второго, два салата, два напитка¹⁴ — укладывается в этот набор без единой экзотической позиции.

Рисунок 18. Дерево решений «Можно ли выдать выбранное блюдо?»

Житель выбрал блюдо →

1. Есть ли врачебное назначение, запрещающее это блюдо? (карта: диета, текстура, взаимодействия)

└ **НЕТ** → выдать. Точка.

└ **ДА** → 2. Запрет абсолютен или по режиму?

└ Абсолютен (аллергия, ИМАО-тирамин, грейпфрут при карбамазепине) → не выдавать; предложить разрешённый эквивалент; запрос врачу — в тот же день

└ По режиму (кофеин, соль при литии, сахар) → по согласованному с врачом правилу из карты; если правила нет — врач сегодня

3. Блюдо физически доступно на линии?

└ **ДА** → выдать с записью в журнал заказа

└ **НЕТ** (закончилось) → замена по журналу срывов + запись; серия срывов → пересчёт объёмов

Дерево для поста и линии; врачебные вопросы не решаются сменой ни на одном шаге.

Разделы 11, 12, 19; кейсы 1–2; реестр MEDICAL_EVIDENCE (взаимодействия).

20. Точка раздачи: дизайн линии, очередь и помощь

20.1. Почему линия важнее меню

Вариативность живёт или умирает в трёх метрах раздаточной линии: здесь сталкиваются очередь, выбор, помощь кормимым, температура блюд и конфликты «почему ему больше». Меню может быть идеальным — если линия спроектирована под скорость, а не под человека, выбор превратится в давление, а помощь — в ожидание холодной тарелки. Раздел разбирает организацию точки раздачи на четыре элемента: поток, подача помощи, видимость порций, атмосфера.

20.2. Поток: как не создать пробку

Два варианта добавляют 5–10 секунд на человека в точке выдачи; на отделении в 30 человек это 3–5 минут на линии. Решения, проверенные практикой:

Предварительный заказ. Основной инструмент: выбор фиксируется накануне (журнал заказа), на линии — только выдача по списку с возможностью поменять решение. Время выдачи почти не растёт; российские внедрения работают именно так⁴⁵.

Визуальное меню. Фотографии или образцы двух вариантов до линии сокращают паузу «что там?» и помогают невербальному выбору (раздел 15).

Разнесение потоков. Самостоятельные жители — на линию; маломобильные получают выбор в жилой зоне по журналу заказа; кормимые — за столами, где еда приходит к ним. Смешивать три потока в одной очереди — конструктивная ошибка большинства столовых.

Две точки выдачи. Если объём большой: позиции без выбора (хлеб, первое при едином супе) выдаются отдельно от позиций с выбором — выбор не тормозит общий поток.

20.3. подача помощи: еда — под готовые руки

Международный ориентир, который мы приводим как переносимую норму (не российское требование): один работник — не более двух полностью

кормимых жителей; еда не подаётся, пока помощь недоступна²³. Логика нормы прозрачна: тарелка, стоящая перед человеком, который не может есть сам и ждёт помощника, остывает и деморализует; аспирация «на скорость» при спешке — клинический риск (раздел 10).

Российская практическая проблема: нормы помощи у нас не закреплены, а реальное соотношение на смене часто далеко от 1:2 (кейс раздела 5: четыре сиделки на двенадцать кормимых). Что можно сделать без новых штатов:

1. **Все руки на час еды:** на время основных приёмов к столу привлекается вся смена, включая тех, чьи функции в другие часы иные, — это предмет приказа, а не доброй воли.
2. **Рассадка по помощи:** кормимые садятся группами по 2 у каждого помощника; порядок подачи — по готовности рук, а не по очереди тарелок.
3. **Волонтёры и соцработники дневных отделений** в часы еды — где это возможно.
4. **Честный расчёт дефицита:** если норма 1:2 недостижима, это фиксируется числом и выносится учредителю письменно (раздел 38): молчаливый дефицит — риск директора, зафиксированный — предмет решения учредителя.

20.4. Видимость порций: «почему ему больше»

Выбор делает раздачу прозрачной — и впервые видимое неравенство порций становится источником конфликтов (типовой сбой внедрения). Три технических решения: **порционные ложки** (стандартная мерка на виду), **общие нормы граммов** у линии (табличка: «котлета — 75 г, гарнир — 200 г»), **объявленные правила добавки** («после раздачи всем — добавка из остатка»). Заметим: конфликт вызывает не выбор, а неравенство; прозрачность его лечит, а не создаёт.

20.5. Атмосфера: раздача как сервис, а не как раздача

Немецкий стандарт требует от персонала кухни выходить к жителям и проводить дегустации²⁹; финская норма — персонал за общим столом³³; австралийский стандарт формулирует ожидание жителя «я выбираю, что,

когда, где и как я ем»³⁵. Общий знаменатель: раздача — это сервисное взаимодействие, а не технологическая операция. Минимальный пакет без затрат: раздающий называет варианты вслух («гречка или рис?»), а не молча черпает; жителю дают 3–5 секунд на решение без давления очереди (предзаказ это обеспечивает); жалоба на блюдо принимается как данные, а не как претензия — и попадает в журнал.

20.6. Температура и время на еду

Два замера, которые стоит сделать один раз и повторять ежеквартально (методика — раздел 22): температура блюд на первом и последнем столе (падение >10–15 °C — предмет перестройки потока) и фактическое время на еду у самого медленного едока из группы помощи (если <15 минут — торопят, и это риск аспирации, раздел 10). Оба замера бесплатны и оба превращают «у нас всё нормально» в числа.

20.7. Управленческий вывод

Линия раздачи — место, где вариативность проверяется ежедневно. Минимальный комплект: предзаказ, визуальное меню, рассадка по помощи, порционные ложки, объявленные правила добавки, два ежеквартальных замера — и отдельный маршрут для тех, кто на линию не выходит (раздел 20.11). Ни один элемент не требует денег; все вместе превращают «конвейер» в точку сервиса — и именно здесь жители впервые почувствуют разницу между «накормить» и «обслужить».

20.8. Стол для группы помощи: микроустройство

Устройство стола, за которым едят с помощью, решает половину задачи кормления. Рассадка: помогающий между двумя жителями, а не напротив одного (постоянный зрительный контакт с обоими); жители с дисфагическим риском — не вместе (каждый требует полного внимания в момент глотка). Посуда: глубокие тарелки с бортиком, нескользящие подставки, ложки удобного захвата — адаптивная посуда возвращает частичную самостоятельность там, где она казалась потерянной, и каждый самостоятельный житель — это освобождённые минуты помощи для другого. Подача: порции среднего размера с добавкой вместо больших

(большая порция деморализует едока и провоцирует спешку помогающего). Тишина разговоров: помогающий, обсуждающий с коллегой свои дела через голову едока, — самый распространённый дефект стола помощи и самый дешёвый в устранении: одно правило инструктажа «с едоком говорят с едоком». ## 20.9. Атмосфера: бесплатные элементы, которые зал замечает первыми

Международные программы среды (Pioneer, Eden, Green House²⁵⁷⁹²⁶) единодушны в одном: обед читается жителями по атмосфере раньше, чем по меню. Элементы нулевой стоимости с наибольшим эффектом: скатерти и салфетки вместо «голового пластика»; еда на столах до рассадки, а не поиск глазами; персонал не стоит полукругом «над» едящими; шумовой фон без бряцания тележек в часы еды; освещение рабочее, а не казённо-верхнее. Ни один элемент не требует закупки сверх мелочей — но все вместе они и есть «столовая против раздаточной». Проверка простая: фотография вашего зала в часы обеда рядом с фотографией домашней кухни — разница, которую видно на снимке, и есть программа работ на квартал.

20.10. Поток: инженерия очереди за один обед

Очередь с выбором — задача потока, а не терпения. Пять проверенных решений, от дешёвого к дорогому: **предзаказ** переносит выбор с линии наканунешний вечер — линия работает со списком, скорость почти не меняется; **визуальное меню до линии** — житель подходит с готовым решением, пауза «что брать» исчезает (именно пауза, а не сам выбор, создаёт очередь); **разведение точек** — салаты и напитки выносятся с линии на отдельный столик/буфет, горячее проходит быстрее; **очерёдность отделений** — группы помощи идут первыми (сидячее ожидание для них тяжелее всего), порядок фиксируется в распорядке; **вторая точка выдачи** — при больших потоках, если позволяет помещение. Замер до и после (время от первого до последнего выданного) показывает эффект каждого решения в минутах — и даёт цифру для разговора о вариативности: «выбор добавил 4 минуты к обеду» — факт; «выбор создал хаос» — обычно диагноз отсутствия этих пяти решений, а не самого выбора.

20.11. Выбор вне линии: постельные и поднос

Одиннадцать процентов жителей — постельные или маломобильные²⁰. Если вариативность существует только на линии, она становится привилегией ходячих. Для этой группы выбор — **два варианта на подносе**, а не вторая очередь в коридоре: житель видит обе порции (или картинки на двери), показывает, стандартный вариант всегда есть, журнал заказа ведётся на посту. Температура доходит до комнаты по технологическим документам, замер — на последней выдаче, не только на линии (та же логика, что при карантине, раздел 18.11 и приложение 45). Помощь приходит с едой, а не после неё (раздел 20.3). Проверка ступени для постельного жителя та же, что для ходячего: вчера был ли у него реальный второй вариант — на подносе, не в положении.

21. Когда выбор изменился: журнал, пересчёт и «фиктивная вариативность»

21.1. Тема раздела

Выбор жителя — не константа: он меняется с состоянием, сезоном, сменой препаратов и просто со временем. Система, которая записала предпочтения при поступлении и больше не спрашивала, через год обслуживает человека, которого больше нет. Раздел — о том, как выбор отслеживается, пересчитывается и превращается в данные для кухни; и о том, как отличить работающую вариативность от её декорации.

21.2. Три регистра данных о выборе

Журнал заказа (оперативный). Вчерашний выбор = сегодняшние объёмы (раздел 19.4). Горизонт — сутки; владелец — раздача и кухня; форма — приложение 7. Без этого регистра объёмы варианта Б гадаются, и «закончился» становится нормой.

Журнал потребления (клинический). Что реально съедено: полная порция / половина / не тронута — для группы риска и при внедрении (раздел 9.3). Горизонт — неделя; владелец — сиделки и врач; функция — выявление паттернов (отказы, дисфагия, «нелюбимые блюда») раньше, чем они станут весом и пневмонией.

Статистика выбора (управленческая). Доли выбора А/Б по позициям и неделям; блюда-лидеры остатков; доля «выбрал Б — не получил Б». Горизонт — месяц; владелец — диетсестра и руководитель; функция — корректировка объёмов, цикла меню и закупок. Именно эта статистика превращает выбор жителей в управляемый процесс — и именно её опыт Усть-Илимска описывает как «группировку блюд по популярности»⁶.

21.3. Пересчёт объёмов и цикла

Правило пересчёта: каждые две недели доли выбора корректируют варку; каждый цикл меню статистика корректирует сам цикл (блюдо-аутсайдер по остаткам заменяется по таблице замен — законно и безболезненно¹²¹³). Международный ориентир для цикла: 21 день (Онтарио) и 4 недели

(Германия) против наших типовых 14²³³²; российский 14-дневный цикл — законный минимум, а не эталон, и его расширение — самая дешёвая форма разнообразия.

Отдельное правило: статистика выбора стабилизируется за 2–3 месяца, и решения по ней принимаются на горизонте месяца, а не по эпизоду. «Вчера все взяли гречку» — не основание менять пропорции; «за четыре недели рис берут вдвое чаще» — основание.

21.4. Фиктивная вариативность: пять признаков

Чек-лист для самопроверки (и для честной оценки чужих презентаций):

1. **«Вариант Б заканчивается через десять минут»** — объём занижен, выбор декоративен. Индикатор: доля нереализованного выбора Б.
2. **«Все выбирают А»** — либо Б непривлекателен (смотреть остатки), либо выбор формален (нет показа, нет времени на решение).
3. **«Выбор есть в положении, но не на линии»** — документ без процедуры; проверяется одним визитом в часы еды.
4. **«Выбирает персонал за жителя»** — журнал заказа заполняется «по привычке», без вопроса; для невербальных жителей — без показа (раздел 15).
5. **«Статистика не влияет ни на что»** — данные собираются, но объёмы и цикл не меняются; сбор ради сбора.

Каждый признак устраняется конкретным действием из разделов 19–20 — фиктивность не приговор, а диагноз.

21.5. Обратная связь жителей: от статистики к разговору

Статистика говорит «что», но не «почему». Поэтому к трём регистрам добавляется четвёртый канал — прямой разговор: ящик пожеланий (практика российских учреждений), разбор меню на совете жителей (международная норма — совет резидентов рассматривает каждый цикл меню²³⁸⁰), дегустации новых блюд с голосованием (немецкая практика²⁹). Минимальная частота: раз в цикл меню. Формат и полномочия совета — раздел 34 и приложение 30.

Важно: канал обратной связи изменит меню — иначе он умрёт за полгода. Правило ответа: каждое пожелание получает реакцию (принято / не принято с причиной) на следующем заседании; немецкий стандарт требует документированной системы жалоб со сроками ответа³² — переносимая практика, стоящая одну строку в регламенте.

21.6. Управленческий вывод

Данные о выборе — это то, что отличает систему от акции. Минимальный набор: журнал заказа (сутки), журнал потребления (неделя), статистика выбора (месяц), совет жителей (цикл). Все четыре — тетради и графы, а не программное обеспечение; их суммарная стоимость — канцелярия и дисциплина. Зато именно они дают директору доказательную базу для учредителя и проверяющего: «выбор работает — вот доли, вот пересчёт, вот решения совета» (раздел 32).

21.7. Данные для совета жителей: как показывать числа

Статистика выбора — материал совета (раздел 34), но подача решает всё. Три правила презентации чисел жителям: одна цифра — один вывод («выбирает 6 из 10 — значит, меню надо показывать ещё четверым»); никаких процентов без абсолютов (проценты пугают, «двенадцать человек» — понятно); каждая цифра заканчивается вопросом к залу («как думаете, почему рыбу выбирают чаще курицы?»). Совет, обсуждающий свои собственные данные, — это уже не консультация, а соуправление; и именно такие протоколы убеждают любого проверяющего быстрее любых положений. ## 21.8. Пять признаков фиктивной вариативности: детализация

Признаки раздела стоит уметь читать в полевых условиях, за один визит: журнал есть, но заполнен одним почерком и одной ручкой за неделю; доля «стандартных» выше 90 % без объяснения; жители на вопрос «что выбирали вчера» отвечают «не знаю»; второй вариант «есть», но к моменту вашего прихода «уже закончился» (проверьте журнал срывов — пустой журнал при ежедневных срывах и есть диагноз); выбор существует только на завтрак и только по кашам — при том что положение обещает «полную вариативность». Каждый признак по отдельности может иметь невинное

объяснение; два и более — система фиктивна, и дальнейший разговор идёт не о «развитии», а о перезапуске (кейс 12).

21.9. Пересчёт меню по статистике: рабочий цикл

Статистика выбора превращается в меню через четырёхнедельный цикл. Неделя 4 месяца: итоги журнала заказа суммируются по позициям — каждая пара получает фактическую пропорцию (например, 62/38, а не заложенные 50/50). Объёмы варки следующего цикла ставятся по фактической пропорции с резервом 10 % на вариант Б. Позиции с устойчивой долей ниже 15 % — кандидаты на замену: они не «плохие», они не выбираемы этим контингентом; замена выносится на дегустацию совета жителей (раздел 34). Позиции, заканчивающиеся до третьего отделения дважды за цикл, — кандидаты на увеличение доли (журнал срывов, приложение 8). Цикл занимает у диетсестры/завпроизводства два часа в месяц — и именно он отличает живое меню от спущенного сверху. Один честный эффект, который цикл показывает почти всегда: фактические пропорции стабилизируются через 6–8 недель и дальше меняются мало — эффект новизны кончается, и начинается настоящая карта вкусов дома, впервые измеренная.

Рисунок 15. Пять признаков фиктивного выбора (проверка за один визит)

Признак 1 Журнал заполнен одной рукой за неделю	Признак 2 «Стандартных» >90 % без объяснения
Признак 3 Жители не помнят вчерашний выбор	Признак 4 Вариант Б «уже закончился» при пустом журнале срывов
Признак 5 Выбор только на завтрак и только каши — при «полной вариативности» в положении	Правило Один признак — невинное объяснение ищется; два и более — перезапуск по кейсу 12 и разделу 21.

Полная проверка реальности выбора — приложение 24 (6 пунктов, оценка 6/6 → ≤3).

Раздел 21 доклада; механика оценки фактического опыта жителей — рейтинги CQC (реестр INTERNATIONAL_PRACTICES).

22. Как проверить реальность питания: аудит и замеры

22.1. Принцип: измеряй факт, а не документ

Всё, что написано в докладе дальше (пилот, финансы, ответственность), опирается на данные. Дом, который не измерил себя, не сможет ни доказать эффект пилота, ни защититься перед проверкой, ни понять, что чинить первым. Раздел собирает измерительный инструментарий: экспресс-аудит, семидневный замер и квартальную панель. Общее правило: измеряется факт (температура на последнем столе, остаток на тарелке, интервал в часах), а не запись о факте.

22.2. Экспресс-аудит «Стол за один день»

Чек-листы для замеряющего — приложения 18–21; здесь — логика. Один случайный будний день, замеряющий — не профильный сотрудник (заместитель, бухгалтер, сестра-хозяйка другого отделения). Четыре блока:

До еды: меню вывешено и написано языком блюд; совпадает с раскладкой; ночной интервал (вчерашний ужин → сегодняшний завтрак) в часах; журналы проб ведутся в реальном времени (почерки, время); лекарственно-пищевая таблица на посту.

Во время еды: число кормимых на одного работника; подача под готовую помощь (есть ли тарелки, ждущие рук); температура на первом и последнем столе; соответствие текстур назначенным (выборочно 3 тарелки группы риска); время на еду у самого медленного; объявлена ли добавка; ест ли персонал с жителями; остатки на тарелках (прикидка доли и блюда-лидеры); атмосфера (разговор или звон посуды и команды).

После еды: журнал отказов ведётся и читается врачом; срабатывала ли эскалация «3 отказа → врач»; куда ушли остатки; существует ли вечерний перекус и доходит ли до постельных; что может съесть житель в 2 часа ночи (спросить дежурную сиделку, а не положение).

Документы и люди: комплект из раздела 31 (положение, меню, журналы, паспорта, согласование); когда совет жителей в последний раз обсуждал меню; выходил ли повар к жителям за месяц; может ли кто-то за 5 минут назвать расход на сырьё на жителя в день.

Итог — 24 строки «да/нет/число», каждая из которых сама становится строкой плана. Опыт подобных замеров устойчив: большинство находок бесплатны (расписание, порядок подачи, журналы), меньшинство — организационны (рассада, смена), единицы требуют денег.

22.3. Семидневный замер отходов и потребления

Форма — приложение 25. Семь дней, три веса в день: выдано (кг по линии), возвращено с тарелок (кг), остатки кухни (кг). Результат — доля несъеденного по блюдам и дням, база для: финансовой модели (раздел 29), корректировки цикла (раздел 21), разговора с учредителем (раздел 38). *Методическая оговорка: семь дней — короткий ряд; сезонность и «хорошие дни» искажают. Замер повторяется ежеквартально; выводы делаются на повторяемости, а не на одном замере.*

22.4. Квартальная панель директора

Двенадцать чисел, собираемых раз в квартал на одном листе (форма — приложение 35):

1. Ночной интервал (часы).
2. Доля несъеденных порций.
3. Блюда-аутсайдеры (топ-3).
4. Кормимых на одного работника (факт).
5. Температурная дельта «линия — последний стол».
6. Соответствие текстур назначенным (выборка).
7. Число отказов и доля с эскалацией в срок.
8. Весовые триггеры — две строки, не одна: (а) набор $\geq 5\%$ за квартал (метаболический риск, раздел 13.8); (б) потеря по MUST / рамка Онтарио (недостаточность питания). Кухня не ставит категорию MUST.
9. Доля жителей с актуальной пищевой картой.
10. Доля выбравших Б, не получивших Б (при вариативности).
11. Сырьевая строка (руб./житель/день).
12. Число жалоб на питание и доля с ответом в срок.

Панель делает три вещи: показывает динамику (главный аргумент в разговоре с учредителем), рано сигнализирует о сбоях (до проверки, а не на ней) и дисциплинирует систему (что измеряется — то существует).

22.5. Экспресс-оценка «за 10 минут» для гостя семинара

Минимальная версия аудита для применения «завтра по приезду»:

1. Спросить у жителя: «Что ты сегодня выбрал?» — ответ (или его отсутствие) измеряет выбор точнее документов.
2. Посмотреть на мойку после обеда: остатки — голос всех, включая молчаливых.
3. Засечь ночной интервал по расписанию и по факту — расхождение покажет разрыв бумаги и жизни.
4. Спросить у сиделки: «Что ты делаешь, если он отказался от третьего приёма подряд?» — правильный ответ одной фразой («фиксирую и сообщаю врачу сегодня») измеряет систему безопасности.
5. Спросить у завхоза: «Сколько стоит сырьё на жителя в день?» — пауза в ответе измеряет финансовую прозрачность.

22.6. Управленческий вывод

Аудит и замеры — единственный способ перевести разговор о питании из плоскости мнений в плоскость фактов. Последовательность: экспресс-аудит (неделя 1 пилота), семидневный замер (недели 1–2), квартальная панель (постоянно). Стоимость — время одного непрофильного сотрудника в квартал и две тетради; отдача — доказательная база всей остальной работы доклада.

22.7. Аудит чужими глазами: взаимные визиты домов

Формат, недоступный внутри одной организации и почти бесплатный между двумя: взаимный аудит. Два дома (лучше — разных типов и регионов, находка через семинарский контакт) обмениваются аудиторами на один день; аудитор проходит чек-листы приложений 18–21 и пишет только факты. Три эффекта, не дающиеся самоаудитом: видны «невидимые нормы» (то, что у вас «всегда так», глаз чужого останавливает); переносятся приёмы (аудитор уносит к себе три находки хозяина — взаимность выгодна обоим); появляется внешний факт для разговора с учредителем («коллеги прошли — вот запись»). Единственное правило формата: сначала договорённость о некарательности — находки взаимного

аудита не уходят наверх без согласия принимающей стороны, иначе формат умрёт после первого визита. ## 22.8. Кто замеряет: почему не свой

Самоаудит систематически завышает баллы не из лжи, а из адаптации: своя столовая «всегда такая». Поэтому замеряющий — не владелец процесса: заместитель по другому контуру, бухгалтер, сестра-хозяйка соседнего отделения, приглашённый коллега из другой организации (взаимные аудиты двух домов — дешёвый и честный формат, легко организуемый через учредителя). Единственная компетенция, необходимая замеряющему, — умение записывать факт, а не впечатление: «вариант Б закончился на втором отделении» — факт; «кухня не справляется» — впечатление. Чек-листы приложений 18–21 построены под факты.

22.9. Оценка за 10 минут: как пользоваться шкалой

Итог аудита — не «хорошо/плохо», а позиция на шкале, определяющая первый шаг. **Зона А (18–24 балла из 24):** система работает; задача — удержание (квартальная панель, ротация ответственных, защита от регресса — раздел 8.5). **Зона Б (12–17):** практика есть, контур дыряв; задача — документы и журналы (раздел 31), не трогая линию: чаще всего линия в порядке, а падает доказуемость. **Зона В (6–11):** элементы есть, системы нет; задача — пилот по разделу 35, не «всё сразу». **Зона Г (0–5):** точка старта; задача — замеры (приложения 25–26) и один разговор с учредителем (раздел 38) до любых изменений на линии. Два правила шкалы: оценку ставит факт вчерашнего дня, а не наличие документа («положение есть» = 0 баллов, если вчера выбора не было); повторный аудит тем же человеком через квартал важнее идеальной первой оценки — динамика балла и есть главный показатель управляемости темы.

Рисунок 20. Дашборд директора: 12 чисел квартала на одном листе

1 Доля выбирающих % жителей · журнал заказа	2 Отходы на порцию г/порция · замер
3 Отказы от еды эпиз./кв. · журнал отказов	4 Замены эпиз./кв. · журнал замен
5 Срывы выбора эпиз./кв. · журнал срывов	6 Сырьевая строка руб./жит./день · бухгалтерия
7 Труд линии мин/приём · замер	8 Жалобы шт./кв. · регистрация
9 Инциденты по классам · протоколы	10 Актуальные карты % жителей · ревизия
11 Совет жителей заседаний · протоколы	12 Удовлетворённость балл 1–5 · анкета

Форма — приложение 35. Правила чтения: каждое число с трендом и одной фразой «что это значит»; панель — инструмент самопроверки и основа отчёта учредителю, не отчётность «наверх».

Разделы 22, 31; панель собрана из онтарийских триггеров и практики внутреннего аудита (F-теги как механика пунктов).

23. Кто участвует: география семинара и система ПНИ-2026

23.1. Аудитория по документам

Семинар «Пространство Новых Идей 2.0» собирает в Санкт-Петербурге руководителей стационарных организаций социального обслуживания со всей страны⁸¹. Очищенный список участников (прилагается к докладу отдельным файлом) даёт точную картину: **170 записей из 51 субъекта Российской Федерации**; с учётом четырёх явных дублей в приложении — расчётно 166 уникальных организаций. Состав неоднороден: классические ПНИ (Краснодарский край, Ростовская, Нижегородская, Новосибирская области), переименованные «дома социального обслуживания» (Красноярский край, Волгоградская, Вологодская, Тюменская области), центры реабилитации и социализации (Воронежская область), «добрые дома» (Московская, Ульяновская области), геронтологические центры с отделениями ПНО (Владимирская область), а также детские и смешанные учреждения.

Это важно для доклада: аудитория говорит на разных «организационных диалектах» — но пищевая задача у всех одна. Поэтому доклад адресован «директору стационарной организации», а не «директору ПНИ».

23.2. Система в числах (с оговорками о статусе данных)

По состоянию на апрель 2026 года, по обработке государственных данных аналитическим проектом «Если быть точным», перепроверенной нами по нескольким независимым изданиям²⁰⁸²:

- **466 психоневрологических интернатов** в России (три года назад — 536: сокращение на 13 %);
- **139 500 жителей ПНИ**; всего в стационарных организациях соцобслуживания — **более 174 000 человек** (данные Минтруда в пересказе);
- **65 % жителей старше 45 лет** — контингент стареет;
- **74 % признаны недееспособными** — три четверти;
- **11 % — постельные или маломобильные**;
- **средний размер — 289 коек**;

- **41 регион переименовал ПНИ** в «дома социального обслуживания» и подобные наименования — что и видно по списку участников;
- в сопровождаемом проживании — порядка **7 000 человек** из ПНИ (и 1 800 в программах распределённых квартир).

Статус данных: вторичная аналитика на государственных массивах, не официальная статистическая отчётность Минтруда; первичные ряды в машиночитаемом виде на дату подготовки доклада в открытом доступе не извлечены — зафиксировано в журнале верификации. Все цифры используются как порядковые ориентиры, а не как точная статистика.

23.3. Что цифры значат для темы доклада

Четыре следствия. Первое: контингент стареет (65 % старше 45 лет) — значит, растут дисфагия, соматика, потребность в помощи за столом (разделы 10, 20, 28). Второе: 74 % недееспособных — значит, технология невербального выбора (раздел 15) важнее вербальной. Третье: переименования в ДСО — это не косметика: новая вывеска задаёт ожидание «дома», и питание — первое место, где это ожидание проверяется. Четвёртое: сопровождаемое проживание растёт — и навыки «своего стола» (ступени 3–5 лестницы, раздел 8) становятся реабилитационной задачей с измеримым выходом.

23.4. Кто в зале уже внедрил вариативность

Отдельное наблюдение, важное для семинара: в списке участников присутствуют организации с **подтверждёнными публичными практиками вариативного меню**: Успенский ПНИ (№ 117 по приложению)⁵, Усть-Илимский дом социального обслуживания (№ 94)⁶, ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург, дом докладчика)⁷, а также Болотнинский ПНИ из того же региона, что и участник № 118 (Тогучинский ПНИ)⁴. Это значит: доклад говорит не о гипотезах, а о практике, которая физически присутствует в зале, — и живой обмен опытом между коллегами ценнее любого текста. Организационное предложение к семинару: вынести эти кейсы в программу разборов (раздел 40).

23.5. В зале сидят внедрившие: как использовать это обстоятельство

Сопоставление списка с подтверждёнными практиками даёт редкую конфигурацию: как минимум три организации с публично подтверждённым внедрением вариативного меню представлены на семинаре лично — Успенский ПНИ⁵, Усть-Илимская организация⁶ и ДСО «Серафимовский»⁷; четвёртый практик (Болотнинский ПНИ⁴) — из того же региона, что и Успенский. Это меняет роль доклада: он не «убеждает попробовать», а даёт залу общий язык для разговора с теми, кто уже пробовал. Практический вывод для модераторов: вопросы «сколько это стоило», «что сказала проверка», «где ломалось» должны адресоваться не только лектору, а носителям опыта в зале (формат панели — раздел 40). Для всех остальных участников их присутствие — единственная форма доказательства, сильнее любой презентации: коллега с таким же штатом, таким же учредителем и таким же СанПиНом уже сделал это.

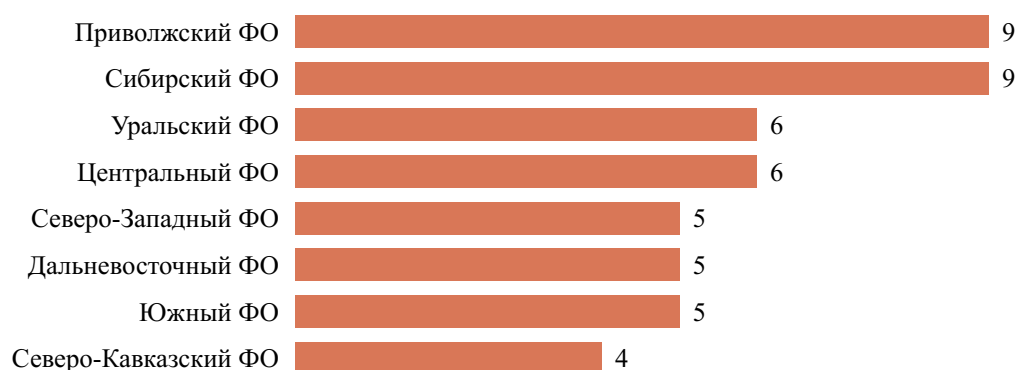
23.6. Чего в списке нет — и что это значит

В списке участников нет общественных организаций жителей и их семей, нет представителей профсоюзов смен, нет экспертов по питанию — состав сугубо управленческий. Это не упрек организаторам, а напоминание залу: решения будут приниматься о людях, которых в зале нет. Компенсация — процедурная: всё, что семинар решит, встретит первую проверку не в отчёте учредителю, а в столовой — перед жителем и перед сменой. Держать этих двух невидимых участников в поле зрения — задача модерации каждого обсуждения. ## 23.7. Что список участников говорит о системе

Очищенный список (170 записей, 51 субъект; 4 явных дубля → расчётно 166 уникальных организаций; контрольный файл PARTICIPANTS_CLEAN.xlsx) — сам по себе срез отрасли, и читать его стоит внимательно. Во-первых, типология: рядом сидят ПНИ «классические», переименованные ДСО, дома-интернаты общего типа, СРЦ и детские организации — единая тема питания собирает разные правовые режимы в одном зале, и советы, применимые к взрослому ПНИ, требуют отдельной проверки для детского учреждения (в докладе детский контур обозначен, но не раскрыт — это честная граница). Во-вторых,

география: 51 регион — это больше половины субъектов РФ, то есть решения зала потенциально затрагивают большинство региональных систем, а «семинарская повестка» способна стать отраслевой (раздел 40). В-третьих, качество исходных данных: 20 записей с пометками о неуверенном распознавании текста и 4 дубля — скромное, но показательное напоминание: даже официальный список участников федерального семинара требует чистки перед использованием. Тот же принцип действует везде в докладе: сначала чистка и верификация, потом выводы.

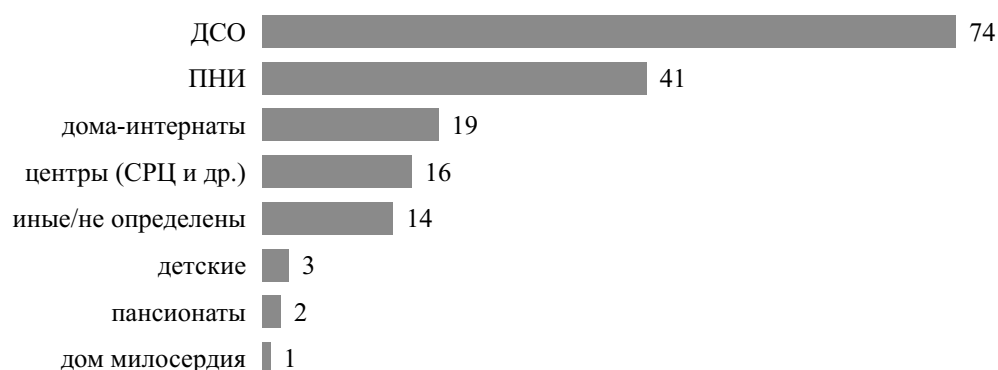
Рисунок 2. Участники семинара по федеральным округам (расчётно, по списку)



Всего 51 субъект РФ, 170 записей в списке (расчётно 166 уникальных организаций после снятия 4 дублей). Распределение по округам — расчётное, по субъектам из очищенного списка; цель — показать масштаб зала, а не точную статистику.

Исходные данные: список участников семинара (приложение к приглашению), очистка — контрольный файл PARTICIPANTS_CLEAN.xlsx, 2026. Метод: подсчёт субъектов по округам. Ограничение: возможны погрешности OCR в отдельных записях (20 помеченных).

Рисунок 3. Типы организаций в списке участников (после очистки и классификации)



Классификация по наименованиям из приложения; «ПНИ» и «ДСО» — в том числе переименованные. Вывод для темы: единая проблематика питания собирает разные правовые режимы — рекомендации требуют проверки на тип организации.

Исходные данные и метод: PARTICIPANTS_CLEAN.xlsx, классификация по наименованию, 2026. Ограничение: классификация по наименованию, без сверки уставов; 14 записей не типизированы.

24. Как устроены нормы в регионах

24.1. Двухуровневая система норм питания

Российская рамка норм питания в стационарных организациях соцобслуживания двухуровневая. Федеральный уровень — **рекомендуемые нормы Минтруда** (приказ № 520н): суточные наборы продуктов для взрослых и детей³⁰. Региональный уровень — нормативные акты субъектов, которые принимают эти нормы как обязательные для подведомственных учреждений, конкретизируют и дополняют: примеры, проверенные в наших реестрах, — постановление Правительства Москвы № 1068-ПП, постановление администрации Псковской области № 206, постановление Правительства Красноярского края № 607-п, постановление Правительства Ленинградской области № 458, постановление Правительства ХМАО № 306-п⁸³¹³¹².

Для директора действует региональный акт: именно он определяет граммы, раскладку и таблицы замен его учреждения. Первое практическое действие по теме питания — найти и перечитать свой региональный нормативный акт (а не федеральные приказы): путь к нему — через учредителя.

24.2. Что общего у региональных норм

Сопоставление проверенных актов показывает устойчивую конструкцию:

1. **Набор продуктов в граммах на человека в день** по группам (хлеб, крупы, мясо, рыба, молочные, овощи и т. д.) — прямо или со ссылкой на федеральные рекомендации.
2. **Раскладка блюд** (перспективная картотека) — перечень блюд с выходом в граммах.
3. **Таблицы замены продуктов** — эквиваленты по питательной ценности: ключевой для доклада механизм, легализующий вариативность (разделы 8, 19).
4. **Отдельные нормы для категорий** (дети, лица с соматическими заболеваниями) — с разной степенью детализации.
5. **Периодичность и режим** (число приёмов, интервалы) — в связке с СанПиН².

Различия между регионами — в деталях граммов, категориях и степени свободы таблиц замен. Систематического сопоставления всех 89 субъектов не существует (мы не нашли такого обзора — фиксируем как пробел данных); поэтому любые обобщения о «российских нормах вообще» следует делать осторожно.

24.3. Региональные модели организации: четыре архетипа

Список участников семинара показывает, что сами организации устроены по-разному — и это влияет на питание:

Архетип 1. Классический ПНИ (Краснодарский край, Ростовская, Нижегородская, Новосибирская области): специализированное учреждение для лиц с психическими расстройствами. Питание — профильная функция; диетсестра чаще в штате; именно этот архетип дал все три подтверждённые практики вариативности⁴⁵⁶.

Архетип 2. Дом социального обслуживания (ДСО) (Красноярский край, Волгоградская, Вологодская, Тюменская области и др. — 41 регион переименований²⁰): универсальное учреждение, где жители с психическими расстройствами живут вместе с другими категориями. Питание строится на общих нормах; психиатрическая специфика — на уровне назначений врача и локальных актов.

Архетип 3. Центры реабилитации и «добрые дома» (Воронежская, Московская, Ульяновская области): реабилитационная рамка, где питание — элемент восстановления навыков; ближе к ступеням 3–5 лестницы (раздел 8).

Архетип 4. Смешанные учреждения с отделениями ПНО (Владимирская область и др.): психоневрологическое отделение внутри геронтологического центра или специального дома-интерната — питание общего контура с отдельными назначениями для отделения.

Практический вывод: при заимствовании чужого опыта смотрите на архетип источника. Модель классического ПНИ переносится на ДСО с адаптацией (другие нормы, смешанный контингент), а не копируется.

24.4. Пять шагов проверки своей региональной рамки

Практический алгоритм для директора (детализация — форма в семинарском пакете):

1. Получить у учредителя действующий региональный акт о нормах питания и проверить его редакцию (дата, изменения).
2. Сверить фактическую раскладку учреждения с актом: совпадают ли граммы, категории, таблицы замен.
3. Проверить таблицы замен: какие эквиваленты разрешены — это пространство законной вариативности.
4. Найти в акте (или у учредителя) нормы для особых категорий: где «диетическое питание» вашего контура.
5. Зафиксировать письменно: какие решения в питании принимает учреждение само, какие — учредитель (матрица полномочий, приложение 17).

24.5. Управленческий вывод

Региональная рамка — не препятствие, а карта: таблицы замен в ней — готовое законное пространство выбора, которым почти никто не пользуется по назначению. Пять шагов раздела 24.4 занимают неделю и не требуют ничьих разрешений; без них любой пилот строится вслепую, а любой разговор с учредителем — без общего документа.

24.6. Разговор с регионом: как ставить вопрос

Региональный чиновник отвечает на точно поставленный вопрос в десять раз охотнее, чем на «разберитесь с нормами». Точная постановка: «Просим подтвердить статус приказа Минтруда № 520н в части норм питания для подведомственных организаций: рекомендованный или обязательный; просим указать акт, которым статус установлен». Один вопрос, одна просьба о документе — и ответ становится проверяемым. Такой же шаблон — для меню, «моста» и форм учёта. Четыре письма по этому шаблону заменяют год коридорных пересудов. ## 24.7. Проверка за пять шагов: сценарий недели

Шаги раздела укладываются в одну рабочую неделю: день 1 — письмо учредителю с вопросами 1–4 из раздела 38; день 2 — параллельный сбор документов внутри (какое меню фактически висит на кухне, кто его утвердил, когда пересматривалось); день 3 — сверка: региональное предписано $\neq$ фактическое; разница фиксируется письменно; день 4 — ответ учредителя (или фиксация его отсутствия) и решение о рамке пилота; день 5 — запись рамки в приказ о пилоте (приложение 28). Неделя без единого изменения на линии — но после неё вы знаете правовую геометрию своей кухни точнее, чем за предыдущие годы.

24.8. Четыре архетипа региональной регуляции: детализация

Архетипы раздела стоит уметь узнавать по одному документу каждого типа. **Архетип «императивное меню»** опознаётся по приложению к региональному постановлению: утверждённое двухнедельное меню с граммовками, отступления не предусмотрены — вариативность начинается только с изменения этого приложения, и первый шаг — запрос процедуры изменений (вопрос №2 учредителю, раздел 38). **Архетип «нормы без меню»:** регион закрепил нутриенты и кратность, меню — дело организации; зона свободы максимальна, но и ответственность за обоснование пар — на организации. **Архетип «типовая раскладка»:** действует наследие советской раскладки, формально рекомендованной, фактически священной; лечится письменным вопросом учредителю о статусе — ответ удивляет в обе стороны. **Архетип «мост»:** есть акт, связывающий СОСО с системой диет (распоряжение 19РВ-32 как образец¹³) — самый благоприятный для жителей с лечебным питанием и самый редкий. Один регион может комбинировать архетипы по направлениям (императивное меню + мост). Поэтому диагностика региона — не анекдот «у нас нельзя», а заполненная форма из пяти строк: статус норм, меню, мост, формы учёта, закупочная модель. Именно эту форму семинар собирает по 51 региону (раздел 40) — первый реальный срез вместо фольклора.

25. Российские практики: четыре подтверждённых кейса и одна региональная модель

25.1. Методологическая рамка: что считается подтверждением

В этом разделе действует строгое правило: практикой считается только то, о чём организация или регион рассказали публично на официальном ресурсе; новость — это подтверждение факта сообщения, а не аудит практики. Мы не утверждаем, что перечень полон: напротив, один из выводов раздела — российская практика вариативности шире её публичной документации, и поиск в рамках подготовки доклада — срез, а не перепись. Там, где деталей нет в источнике, прямо написано «данных нет».

25.2. Кейс 1. Болотнинский ПНИ (Новосибирская область), с 2024 года

Что подтверждено сообщением учреждения от 16.08.2024⁴: вариативное питание действует **несколько раз в неделю**; на завтрак — выбор чая, какао или кофейного напитка, каши или супа; на обед — выбор салатов, вторых блюд и десерта; **перечень блюд для выбора определяет медсестра диетическая**.

Разбор конфигурации: ступень 1 лестницы (раздел 8) — точечный выбор на ключевых приёмах и днях; вариативность встроена в структуру норм (ответственная — диетсестра), что снимает конфликт «выбор против раскладки». Чего в источнике нет: охват (все отделения или часть), учёт невербального выбора, статистика, влияние на отходы, судьба после 2024 года. Данных нет — и это повод для прямого контакта, а не для домыслов.

25.3. Кейс 2. Успенский ПНИ (Новосибирская область), с 2024 года

Что подтверждено сообщением учреждения от 13.08.2024⁵: вариативное меню введено **во всех отделениях**; ежедневно предлагается **выбор из двух вторых блюд, двух салатов и двух напитков**; в учреждении отмечают, что «страхи персонала не подтвердились», жители «с лёгкостью освоили новую систему»; параллельно обновлена посуда и проведены занятия по правилам этикета.

Разбор конфигурации: ступень 2 — ежедневный выбор по всем основным позициям, полный охват. Два ценнейших для семинара факта из первых рук: (1) главное сопротивление было внутренним (страхи персонала) и не материализовалось; (2) внедрение сопровождалось бытовым апгрейдом (посуда) и обучением жителей — вариативность как программа, а не как приказ. Успенский ПНИ — участник семинара (№ 117 по приложению).

25.4. Кейс 3. Усть-Илимский дом социального обслуживания (Иркутская область), с сентября 2024 года

Что подтверждено сообщением учреждения от 27.09.2024⁶: вариативное питание вводится **поэтапно**; старт — для жителей, посещающих столовую; предварительно проведён **опрос предпочтений**; блюда для выбора **сгруппированы по популярности**.

Разбор конфигурации: самая методически интересная — внедрение начато с измерения (опрос) и сегментации (сначала мобильные жители), а не с приказа. Это ровно логика дорожной карты раздела 35. Усть-Илимский ДСО — тоже участник семинара (№ 94).

25.5. Кейс 4. ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург), 2025 год

Что подтверждено сообщением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 22.07.2025⁷: директор дома Евгений Чистяков представил на заседании рабочей группы по реформированию ПНИ **первые результаты вариативного меню для части жителей**. Несколько месяцев проживающим предлагали **накануне выбрать рацион следующего дня из предложенного меню**. Для организации питания дом **закупил дополнительное оборудование и добавил сотрудников**. Жители восприняли эксперимент **с энтузиазмом**. Полный переход **крайне затруднителен**: соблюдение норм сбалансированности и учёт особенностей здоровья; жители склонны выбирать **популярные, но не самые полезные** продукты, что может отразиться на здоровье.

Разбор конфигурации: ступень 1 — заказ накануне для части жителей (модель, близкая к пилоту раздела 35). Два факта, которых нет ни в одном другом публичном российском кейсе. Первый: старт **не был «без новых денег»** — оборудование и ставки названы прямо. Второй: учреждение само

назвало пределы — нормы, здоровье, популярный нездоровый выбор. Это ценнее победной реляции: доклад не утверждает, что полный переход лёгок, и не прячет цену. *Маркировка: официальная новость учредителя — факт публичного сообщения на дату, не аудит практики и не оценка устойчивости. Докладчик семинара — директор этого дома.*

25.6. Региональная модель: Иркутская область, с 2025 года

По пресс-релизу (пересказ отраслевым изданием, 14.02.2025)¹⁴: в стационарных учреждениях области внедряется вариативное питание — **ежедневный выбор из двух первых блюд, двух вторых и гарниров**. Если конфигурация подтвердится первоисточником (сайт минсоцразвития Иркутской области), это первый в России случай **масштабирования вариативности на уровень региона** — переход от инициативы учреждений к политике учредителя. *Маркировка: источник вторичный; масштаб (сколько учреждений фактически) на дату подготовки доклада не установлен.*

25.7. Опорная практика: ДДСОЛ (Московская область)

Дом-интернат для лиц с ментальными нарушениями ДДСОЛ публикует устройство питания²¹: зимнее и летнее **14-дневное меню**, 5–6-разовое питание, поточная линия самообслуживания, буфетная зона, **совет по питанию** (на основе распоряжения Минсоцразвития Московской области 19РВ-32 от 13.04.2017, применяющего медицинскую нормативную рамку к соцучреждению), **замены по желанию жителей с согласованием с врачом**. Это не «вариативное меню» в нашем строгом смысле, но работающая модель персонализации и участия жителей внутри действующей нормативной рамки — и пример легального «мостика» к лечебному питанию (раздел 17.5).

25.8. Сравнительная таблица практик

Учреждение	Степень	Точки выбора	Частота	Охват	Ответственный	Особенности
Болотнинский ПНИ	1	Завтрак, обед	Неск. раз/нед	Данных нет	Диетсестра	Перечень от медицинской структуры
Успенский ПНИ	2	Все основные позиции	Ежедневно	Все отделения	Данных нет	Посуда, этикет, работа со страхами
Усть-Илимский ДСО	1→2	Старт — столовая	Поэтапно	Мобильные жители	Данных нет	Опрос предпочтений, группировка по популярности
Серафимовский ДСО	1	Рацион на следующий день	Накануне, неск. месяцев	Часть жителей	Данных нет	Оборудование и доп. сотрудники; энтузиазм; полный переход затруднителен (нормы, здоровье)
Иркутская область	2	2 первых, 2 вторых, гарниры	Ежедневно	Регион	Учредитель	Масштабирование на субъект

Учреждение	Степень	Точки выбора	Частота	Охват	Ответственный	Особенности
ДДСОЛ	персонализация	Замены по желанию	Постоянно	Все жители	Совет по питанию + врач	14-дневное меню, региональный «мостик» к 330н

25.9. Выводы для участников

- 1. Вариативность в России — не эксперимент:** минимум четыре учреждения и один регион — публично, с 2024 года⁴⁵⁶⁷¹⁴.
- 2. Три кейса Новосибирской и Иркутской областей начинались без новых денег** — второй вариант внутри существующих норм и потоков. **Серафимовский публично назвал оборудование и дополнительные ставки**⁷ — универсального «бесплатного старта» нет.
- 3. Три кейса сидят в зале семинара** — Успенский, Усть-Илимский и дом докладчика; обмен опытом доступен прямо на месте (раздел 40).
- 4. Документация практики отстаёт от практики:** деталей (учёт, статистика, документы) в публичных сообщениях нет; каждое учреждение, внедрившее выбор и рассказавшее о нём с цифрами, сдвинет отрасль сильнее любого методического доклада (раздел 39).

25.10. Чего мы не знаем о практиках — и почему это важно сказать

По каждой из шести практик неизвестно больше, чем известно: нет данных об экономике (изменилась ли сырьевая строка), об устойчивости (работает ли сегодня так же, как в день публикации), о жителях с тяжёлыми нарушениями (распространяется ли выбор на неговорящих), о проверках (было ли что-то спрошено). Новость подтверждает факт публичного сообщения на дату — и только; требование ТЗ искать для «устойчивости» локальные акты и повторные публикации выполнено там, где они нашлись (распоряжение ДДСОЛ²¹, региональное решение по Иркутску¹⁴), и честно не выполнено там, где их нет: повторных публикаций по Болотнинскому и Успенскому на момент проверки не обнаружено. По Серафимовскому

известны только факты, названные в новости Комитета⁷, — не штатное расписание, не меню и не панель чисел. Это не умаляет практики — это калибрует вывод: «внедрено публично» ≠ «работает годами», и зал должен слышать обе половины фразы.

25.11. Что объединяет внедривших: четыре общих признака

Сравнение подтверждённых практик (Болотнинский⁴, Успенский⁵, Усть-Илимский⁶, Серафимовский⁷, Иркутская область¹⁴, ДДСОЛ²¹) показывает общую механику, а не общие лозунги. **Первый признак — точка входа через предпочтения, а не через меню:** опрос жителей предшествует изменению линии (явно — в Усть-Илимске⁶). **Второй — скромность первой конфигурации:** два вторых, два салата, два напитка⁵ или заказ накануне для части жителей⁷; никто не начинал с «ресторанского сервиса». Третий — публичность как защита: практики рассказаны на официальных сайтах с датами; рассказанное всем труднее тихо отменить и легче защитить перед проверкой («это не самодеятельность, это практика с публикациями»). **Четвёртый — фиксация страхов и пределов постфактум:** «страхи не подтвердились»⁵ и «полный переход крайне затруднителен»⁷ — формулировки, возможные только там, где трудности сначала признали. Признак, который **не** общий: новосибирские и иркутский кейсы не сообщают о новых ставках; Серафимовский сообщает об оборудовании и сотрудниках. Это не доказывает «бесплатности» и не доказывает «дороговизны» (честная рамка стоимости — раздел 29): входной порог может быть организационным (модель НСО) или требовать ресурсов (модель СПб). Пилот на одном отделении без новых денег остаётся реалистичным; обещать бесплатный полный переход — нельзя.

26. Международный опыт: проверяемые нормы девяти систем

26.1. Правила заимствования

Международная часть доклада подчинена трём правилам. Первое: берутся только **проверяемые нормы** — числа, процедуры, документы (не «ценности» и не «подходы»). Второе: к каждой норме указан её статус дома (закон, руководство, стандарт, доплата) и **граница применимости** — в большинстве систем нормы писаны для гериатрического ухода, а не для психиатрии; перенос на ПНИ — наша адаптация, и она маркируется. Третье: превосходные степени («лучшая система») исключены — мы сравниваем механизмы, а не страны.

26.2. Великобритания: психиатрическая специфика

Единственное выявленное нами руководство, написанное **именно для психиатрических стационаров**, — Британской диетической ассоциации (BDA)³⁷⁸⁴. Заимствуемые инструменты: гибкий завтрак для седатированных; меню без приборов (finger food) для состояний с риском; протокол питания в изоляции (посуда, текстура, фиксация потребления, эскалация); лекарственно-пищевая таблица в меню (наш раздел 11); self-catering на реабилитационных отделениях. Базовый стандарт — Regulation 14 регулятора CQC: учёт предпочтений **по времени, месту и количеству еды**, а не только по составу; отложенная еда для пропустивших³⁹. Практика «защищённых приёмов пищи» приводится с честной оговоркой: систематический обзор признаёт её доказательную базу недостаточной⁸⁵⁸⁶.

26.3. Австралия: еда как самостоятельный стандарт

С 1 ноября 2025 года действует Standard 6 «Food and Nutrition» — питание как отдельный стандарт качества ухода: формула выбора **«что, когда, где и как я ем»**, перекусы 24/7, меню с участием проживающих, текстуры по IDDSI с достойной подачей и процедурой «осознанного риска»³⁵⁴⁴. Финансовая подпорка — следствие скандала: медиана расходов на сырьё \$8,00 AUD в день (исследование Hugo)⁸⁷ → надбавка \$10 AUD **в обмен на обязательную ежеквартальную отчётность о расходах на питание**⁸⁸.

Механизм «деньги в обмен на прозрачность» — самый переносимый финансовый элемент международного опыта (раздел 29).

26.4. Онтарио: решётка измеримых норм

Подзаконный акт О. Reg. 246/22 — самая детальная из найденных нормативных конструкций²³: цикл меню ≥ 21 день; выбор на всех приёмах пищи; **совет резидентов рассматривает каждый цикл меню и согласует время приёмов**; еда по диете доступна 24 часа; триггеры веса $-5\%/-7,5\%/-10\%$ за 1/3/6 месяцев с автоматической междисциплинарной оценкой; диетолог ≥ 30 минут на жителя в месяц; **кормление: один работник — не более двух кормимых, еда — только под готовую помощь**. Профессиональные формы добавляют триггеры потребления: $\geq 25\%$ порции за 2 из 3 приёмов в течение недели; отказ от трёх приёмов подряд⁵⁶. Почти вся эта решётка переносима в российский локальный акт без изменения закона — что и сделано в разделах 12, 20, 21.

26.5. США: альтернатива при отказе и ночной интервал

Федеральное правило 42 CFR §483.60³⁶: при отказе от блюда **обязательна альтернатива сходной питательной ценности**; между существенным ужином и завтраком — **не более 14 часов** (16 — при питательном перекусе на ночь). Нарушения фиксируются пронумерованными инспекционными F-тегами (F800–F807 — пищевой блок)⁸⁹: механика пронумерованных проверяемых пунктов переносима во внутренний аудит учреждения (приложения 18–24).

26.6. Скандинавия: 11 часов ночи и совместный стол

Шведское руководство Livsmedelsverket: ночной интервал ≤ 11 часов с обязательным вечерним перекусом; шесть пищевых событий в день; пищевой совет (matråd) из проживающих³¹⁸⁰. Муниципальные замеры (Талльберг) показали выполнение нормы интервала у 79 % проживающих — пример дешёвого честного индикатора, измеряемого одной строкой расписания⁸⁰. Финляндия: **персонал ест вместе с проживающими** как национальная рекомендация³³⁹⁰ — бесплатный мониторинг потребления и поведения.

26.7. Германия и Австрия: биография, желание и конец «диабетического стола»

DGE-QST (сертификация с аудитом): «биография питания» (Essbiografie) при поступлении — прототип нашей пищевой карты; «пища по желанию» (Wunschkost) при критических состояниях и в терминальной фазе; цикл меню ≥ 4 недель; вегетарианское предложение ежедневно; замещающая еда для пропустивших; повара выходят к жителям с дегустациями³²²⁹. Австрийский стандарт 2022: либерализация диет — нет общего «диабетического стола», решение о диете индивидуально и с участием проживающего³⁸; исследование SUNRISE показало, что **аппетитные названия блюд измеримо меняют выбор**⁹¹ — самая дешёвая из всех норм раздела.

26.8. Япония: как стимул стал стандартом

Жизненный цикл регуляторного инструмента за 16 лет: доплата за нутритивный менеджмент (2005) → охват 87–94 % учреждений (2020) → превращение в обязательный стандарт с **вычетом за неисполнение** и обязательной сдачей данных в национальную базу LIFE (2021)⁹²⁹³⁹⁴. Измеримые связки: доплата — с меньшим риском ухудшения уровня ухода (HR 0,90)⁹⁵; два управляющих диетолога вместо одного — госпитализация 20,3 % против 30,6 %⁹⁶. *Оговорка: не РКИ, возможны искажения отбора; используется как порядок величин, а не доказательство причинности.*

26.9. Десять переносимых норм — сводка

№	Норма	Источник	Российская посадка
1	Ночной интервал $\leq 11-14$ ч	Швеция, США	Расписание + перекус (раздел 13.4)
2	Альтернатива при отказе — обязательна	США	Таблицы замен + правило в положении
3	Выбор «что/когда/где/как»	Австралия, Онтарио	Лестница моделей (раздел 8)

№	Норма	Источник	Российская посадка
4	Замещающая еда пропустившим; гибкий завтрак	Германия, BDA	Пункт положения о питании
5	Аппетитные названия блюд	Австрия	Доска меню (0 руб.)
6	Пищевая биография при поступлении	Германия	Приложение 3
7	Совет жителей о меню и времени приёмов	Онтарио, Швеция	Раздел 34, приложение 30
8	Триггеры: вес 5/7,5/10 %; 25 % порций; 3 отказа	Онтарио	Разделы 12, 21, приложение 9
9	Кормление 1:2; еда под готовую помощь	Онтарио	Раздел 20 (ориентир)
10	Отчётность о расходах на сырьё	Австралия, Япония	Раздел 29, дашборд

26.10. Управленческий вывод

Во всех девяти системах выбор в питании закреплён законом, стандартом или условием оплаты — это нормативный мейнстрим, а не эксперимент. Российская раскладка с таблицами замен принадлежит той же логике; отставание — не в праве, а в наполнении и измерении. Правило переноса: берём проверяемые нормы, маркируем их происхождение, внедряем локальным актом, измеряем эффект своими инструментами (раздел 22).

26.11. Десятая норма, которой нет в таблице: ночной интервал

Отдельного абзаца заслуживает норма, самая дешёвая в исполнении из всех: ограничение ночного голодного интервала. Швеция — не более 11 часов³¹, США — не более 14 (16 с ночным перекусом)³⁶. Теперь типовой российский распорядок: ужин 17:30, завтрак 8:30 — пятнадцать часов. Это не экзотическое нарушение, а норма большинства зданий, и меняется она

не ремонтом, а двумя решениями: сдвигом ужина или завтрака хотя бы на час и легитимизацией вечернего перекуса (кефир, хлеб — раздел 13.9). Проверка в вашем доме занимает минуту: возьмите расписание и вычитите. Если получилось больше 13–14 часов — у вас есть первое конкретное изменение, не требующее ничего, кроме приказа о расписании, и при этом измеримо влияющее на ночное едение, утреннее самочувствие и срывы. ##

26.12. Японский сюжет: почему он важен именно для нас

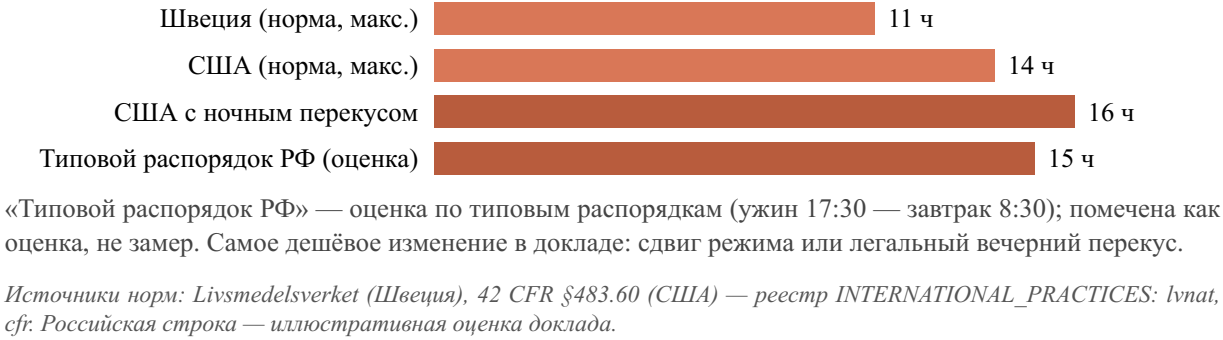
Япония — единственная из девяти систем, где норма о питании выросла из той же логики дефицита, что знакома российской отрасли: сначала надбавка за назначение специалиста по питанию (2005 год⁹²), через 16 лет — обязательность⁹⁴, параллельно — национальная база данных LIFE, делающая практики сопоставимыми⁹⁵. И именно Япония дала редкое исходное доказательство уровня системы: структурированная поддержка питания ассоциировалась со снижением госпитализаций (20,3 % против 30,6 %) и смертности (HR 0,90) в большой когорте⁹⁷. Урок двойной: изменение норм о питании — марафон в полтора десятилетия (планируйте соответственно, раздел 39), и оно начинается с денег за специалиста, а не с призывов к качеству. Для российской повестки это прямой аргумент в споре о ставках (раздел 38, вопрос 5).

26.13. Как читать зарубежные нормы без романтизации

Три фильтра для переноса. **Фильтр ресурса:** нормы Онтарио (диетолог 30 минут на жителя в месяц²³) описывают систему с другим финансированием; переносится принцип «время специалиста нормируется», а не минуты. **Фильтр правовой конструкции:** американские F-теги⁸⁹ работают, потому что за ними стоит инспекционная машина с денежными санкциями; переносится механика «пронумерованных проверяемых пунктов» во внутренний аудит, а не система штрафов. **Фильтр зрелости:** австралийский Стандарт 6 действует с 01.11.2025³⁵ — это норма на старте, и оценивать её результаты ещё рано; переносится формулировка права («что, когда, где и как я ем») как целевой ориентир, а не как «проверенная модель». Романтизация («вот там-то умеют») так же вредна, как ксенофобия («там деньги другие»): обе отменяют анализ. Правильный вопрос к каждой норме — «какой механизм

здесь работает и существует ли он у нас в принципе». Из десяти переносимых норм таблицы раздела восемь опираются на механизмы, которые в российской рамке уже существуют: совет, журнал, альтернатива при отказе, триггеры веса, ночной интервал.

Рисунок 24. Ночной голодный интервал: нормы и типовая практика



27. Что говорят исследования: доказательные вмешательства и их границы

27.1. Зачем раздел и как его читать

Доклад опирается на исследования, но не превращает их в рекламу методик. Правило раздела: каждое вмешательство приводится с популяцией, дизайном и ограничениями; вывод «работает» делается только там, где это позволяют данные. Главный методический факт, который нужно держать в уме: **почти вся доказательная база организационных вмешательств в питании получена в гериатрии и деменс-уходе, а не в психиатрии** — перенос на ПНИ требует адаптации и собственного измерения (раздел 22).

27.2. Вмешательства с измеримым эффектом

Семейная подача (family-style dining). Рандомизированное исследование Nijs и соавт. в учреждениях для людей с деменцией: общие блюда на столе дали рост качества жизни (+6,1 балла), массы тела (+1,5 кг) и потребления энергии (+991 кДж/день) против контроля³⁴. Перенос: механизм — социальность + саморегуляция порций; для отделений ПНИ с сохраненным поведением за столом применимо точно; для острых состояний — нет.

IDDSI и текстуры. Интервенционное исследование в пяти учреждениях: адресная программа подняла соответствие поданных текстур назначенным с 44 % до 90 % (жидкости: 31 % → 100 %), эффект держался 6 месяцев; барьер — осведомлённость персонала⁴³. Перенос прямой: популяция с дисфагией есть в любом ПНИ (раздел 10).

Монтессори-подход к еде. Программы обучения персонала деменс-ухода (Montessori-based activities) улучшают самостоятельность еды и снижают проблемное поведение за столом⁷⁰. Перенос: применим для отделений с когнитивными нарушениями; это подход к обучению навыку, а не к меню.

Доплаты за нутритивный менеджмент (Япония). Крупные административные массивы: доплата ассоциирована с меньшим риском ухудшения ухода (HR 0,90); диетологи — с меньшей госпитализацией (20,3

% vs 30,6 %) ⁹⁵⁹⁶. Ограничение: наблюдательные данные, возможен отбор; причинность не доказана.

27.3. Вмешательства со слабой или отрицательной доказательностью

Защищённые приёмы пищи (protected mealtimes). Популярная британская практика; систематический обзор: доказательная база **недостаточна** — исследования малочисленны и неоднородны ⁸⁵⁸⁶. Вердикт доклада: разумно и бесплатно, но не «доказано»; внедряется как организационная гигиена без обещания эффекта.

Образ жизни для снижения веса при ТПР. Мета-анализ: средний эффект порядка $-1,4$ кг ⁶² — статистически реальный, клинически скромный. Программы с диетологом сильнее ⁶³. Вердикт: метаболическая стратегия строится на среде и мониторинге (раздел 13), а не на ожидании больших цифр.

Малые дома (Green House, Eden Alternative). Оценки показывают улучшение показателей качества жизни и питания в моделях малого дома ²⁶⁷⁹; это системные реформы (штат, архитектура, финансирование), а не «приёмы» — переносятся как горизонт, а не как действие на следующей неделе.

27.4. Что доказано про вес и препараты (свод клинического ядра)

Для удобства директора клинические факты доклада собраны в одну таблицу; все они разобраны в разделах 11–13 со ссылками:

Факт	Число	Источник
Разброс прибавки веса между антипсихотиками (6 недель)	от $-0,23$ до $+3,01$ кг	Мета-анализ 100 РКИ ¹⁰
Клинически значимая прибавка (≥ 7 %) при клоzapине	76,3 % пациентов	Консенсус CRWG ⁵⁹
Прибавка при первом эпизоде психоза (оланzapин)	до $+9,34$ кг	FEPWG ⁶⁰

Факт	Число	Источник
Кофеин повышает AUC клозапина	в среднем +19 %	Контролируемое исследование ¹⁶
Грейпфрут повышает концентрацию карбамазепина	порядка +40 %	Фармакокинетика ¹⁹
Распространённость дисфагии при психических расстройствах	21,9–69,5 %	Обзоры ¹⁵⁹
Смертность от пневмонии при ТПП	RR 7,00	Нац. когорты ⁸
Разрыв продолжительности жизни при ТПП	15–20 лет	Нац. когорты ⁸

27.5. Что исследования не говорят (честные пробелы)

- 1. Нет РКИ вариативного меню в психиатрических учреждениях** — внедрение выбора опирается на нормы, практики и здравый механизм, а не на рандомизированные исходы. Это не аргумент против внедрения, но аргумент за собственное измерение (раздел 22).
- 2. Нет надёжной доказательности «вариативность снижает отходы»** — связь правдоподобна механистически, но документированных сравнений мало; наша позиция — замерить до и после (приложение 25), а не цитировать.
- 3. Нет данных по российским ПНИ** — отечественной исследовательской базы по питанию в ПНИ мы не нашли; это само по себе находка для семинара (раздел 39: отраслевые данные — вклад учреждений).

27.6. Управленческий вывод

Доказательная карта даёт три опоры: измеримые вмешательства (семейная подача, IDDSI, Монтессори, диетологи) — внедрять по показаниям; слабые (защищённые приёмы, lifestyle) — внедрять как гигиену без обещаний; пробелы (вариативность, отходы, Россия) — измерять самим. Директор,

внедривший выбор и замеривший отходы, вес и жалобы, через год будет владеть доказательством, которого сейчас нет ни у кого в стране.

27.7. Что доклад сделал бы с грантом на исследование

Если у отрасли появится возможность одного исследования — вот его постановка, собранная из пробелов раздела: многоцентровое (5–7 ПНИ разных регионов) прагматичное исследование внедрения выбора из двух вариантов с измерением отходов, веса, отказов, трудозатрат и качества жизни за 6 месяцев, с замером до/после по единой методике. Такое исследование закрыло бы главный пробел («нет РКИ вариативности в психиатрии») дешевле одного федерального форума — и общий замер семинара (раздел 40) является его заделом. ## 27.8. Как пользоваться базой, не становясь исследователем

Правило трёх вопросов к любой «научной» цифре, которую вам принесут: какая популяция (психиатрия? пожилые? дети?), какой дизайн (РКИ? наблюдение? новость?) и что измерено (вес и госпитализации — или «удовлетворённость» по самодельной анкете). Цифра, не выдержавшая трёх вопросов, в приказ не попадает — в лучшем случае в презентацию с оговоркой. Реестры доклада (MEDICAL_EVIDENCE.xlsx) размечены именно по этим трём осям — ими можно пользоваться как готовой проверкой.

27.9. Три исследования, которые стоит знать в лицо

Из всей доказательной базы три работы дают директору максимум на единицу чтения. **Первое — RCT Нийса** (Нидерланды, учреждения для людей с деменцией и интеллектуальными нарушениями): семейный стиль подачи — общие блюда, выбор за столом, персонал за тем же столом — дал +6,1 балла качества жизни, +1,5 кг массы и +991 кДж суточного потребления против контроля³⁴. Это ближайшее к «вариативности» рандомизированное доказательство: не меню меняли, а социальную конструкцию стола — и эффект оказался клинически значимым. **Второе — внедрение IDDSI в пяти учреждениях:** обучение персонала подняло соответствие текстур назначенным с 44 до 90 %⁴³; доказательство того, что главный резерв безопасности — не оборудование, а обучение. **Третье —**

японская когорта поддержанного жилья: организация питания как сервиса ассоциировалась со снижением госпитализаций и смертности⁹⁷; единственное «исходное» доказательство на уровне системы. Заметьте, чего нет в этой тройке: ни одного российского исследования и ни одного исследования вариативного меню как такового. Это не случайность, а точная карта пробела раздела 27.4 — и точный ответ на вопрос «а где доказательства, что это надо делать у нас»: доказательства есть о механизмах (среда стола, текстуры, организация сервиса), доказательств «два варианта каши против одного» не существует ни в одной стране — и честный доклад обязан это произнести вслух.

Рисунок 26. Эффект «семейного стола» (РКИ, прирост против контроля)



Энергия +991 кДж/день показана в условных единицах для единого масштаба графика. Менялась социальная конструкция стола (общие блюда, выбор за столом, персонал за столом), а не состав меню.

Источник: *Nijs et al., рандомизированное исследование в учреждениях для лиц с деменцией/ИН (реестр MEDICAL_EVIDENCE: nijs); ограничение — популяция не психиатрическая, перенос как гипотеза механизма.*

Рисунок 27. Триггеры пересмотра плана питания (модель Онтарио)

Изменение веса	Срок	Действие
5 %	за 1 месяц	оценка, пересмотр плана питания
7,5 %	за 3 месяца	оценка, пересмотр, привлечение специалиста
10 %	за 6 месяцев	полный пересмотр, врач, документированный план

Переносится как модель порогов для локального акта (взвешивание ежемесячно, одни веса, порог реакции записан заранее). Сами проценты — ориентир, не российская норма.

Источник: *O. Reg. 246/22 (Онтарио) — реестр INTERNATIONAL_PRACTICES: ontario; год 2022.*

28. Люди за линией: персонал стола

28.1. Почему тема персонала — половина темы семинара

Формула темы семинара — «права, свободы, интересы жителей **и персонала**» — не случайна. Каждое изменение в питании исполняют руки: сиделка предлагает выбор, повар варит второй вариант, раздающий держит темп, диетсестра ведёт раскладку, завхоз отвечает за пробы. Доклад, игнорирующий их нагрузку, интересы и страхи, не будет исполнен — об этом прямо говорит опыт Успенского ПНИ, где главным препятствием оказались не деньги и не нормы, а «страхи персонала»⁵. Раздел разбирает людей за линией: роли, нагрузку, обучение, мотивацию и ошибки управления.

28.2. Роли и их реальная нагрузка

Сиделка/санитар. Ключевая фигура стола: кормит, наблюдает, фиксирует, предлагает выбор. Добавочная нагрузка вариативности — 5–10 секунд на жителя на линии и несколько строк в журналах; добавочная нагрузка клинического контура — замечать признаки (дисфагия, отказы) и знать одну фразу эскалации. Это реальные минуты, и честный план закладывает их в смену, а не в «энтузиазм».

Повар. При парных эквивалентах второй вариант — та же заготовка в другой форме (раздел 19): нагрузка растёт на гастрорёмкости и маркировку, а не на «второе производство». Зато впервые появляется обратная связь: повар видит, что его блюдо выбирают. Немецкая практика делает это инструментом мотивации — повар выходит к жителям с дегустациями²⁹; российская адаптация: дегустация новых блюд цикла с голосованием совета жителей.

Диетсестра (или завхоз при её отсутствии). Владелец раскладки, таблиц замен и пар эквивалентов; подтверждённая российская конфигурация — именно диетсестра формирует перечень для выбора⁴. Это единственная роль, где вариативность добавляет интеллектуальную, а не механическую работу: подбор пар, пересчёт объёмов по статистике (раздел 21).

Врач. В стационарной организации врач — скорее всего приходящий, и его пищевые функции должны быть зафиксированы письменно, иначе они «висят в воздухе»: назначения текстур и ограничений, ведение лекарственно-пищевой таблицы, еженедельное чтение журналов отказов и потребления, реакция на триггеры веса, освидетельствование по ст. 43¹.

Руководитель. Владелец системы: положение о питании, приказы, еженедельный обход по чек-листу (раздел 18.5), квартальная панель (раздел 22.4), разговор с учредителем (раздел 38).

28.3. Норма помощи: самая болезненная цифра

Ориентир 1:2 (один работник — не более двух полностью кормимых)²³ для большинства российских учреждений недостижим текущими штатами — и доклад не делает вид, что это решается приказом. Честная конструкция из трёх шагов:

1. **Замер:** сколько кормимых приходится на одного работника фактически на каждом приёме (форма учёта трудозатрат, приложение 26).
2. **Реорганизация:** все руки на час еды, рассадка по помощи, порядок подачи под готовые руки (раздел 20) — это улучшает ситуацию без новых штатов.
3. **Фиксация дефицита:** разрыв между фактом и ориентиром оформляется числом и выносится учредителю письменно (раздел 38). Молчаливый дефицит — зона риска директора (раздел 33); зафиксированный — предмет компетенции учредителя.

28.4. Обучение: три уровня за три инструктажа

Программа обучения стола не требует учебного центра — требует трёх сорокаминутных инструктажей с проверкой усвоения «на линии»:

1. **Клинический минимум:** признаки дисфагии (раздел 10.3), правило «3 отказа → врач сегодня», лекарственно-пищевая таблица (раздел 11). Проверка: вопрос на обходе — ответ одной фразой.
2. **Технология выбора:** как предлагать два варианта, как показывать порции неговорящему (раздел 15.5), как фиксировать в журналах. Проверка: наблюдение за одним обедом.

3. Санитарный контур при вариативности: пробы двух вариантов, температуры, маркировка (раздел 18). Проверка: сверка журналов без предупреждения.

Международные данные подтверждают: главный барьер качества — осведомлённость персонала (в исследовании IDDSI — от 5 до 79 % в разных домах)⁴³. Обучение — самая дешёвая точка рычага во всём докладе.

28.5. Мотивация и выгорание

Питание — эмоционально тяжёлая зона работы: кормление, отказы, конфликты, запахи, темп. Три рабочих механизма удержания людей, проверенные логикой практик:

Видимый смысл. Персонал, видящий разницу в остатках и в лицах жителей после внедрения выбора, становится союзником программы — поэтому статистика пилота (раздел 35) доводится до смены, а не только до учредителя.

Участие. Повар на дегустации, сиделка в совете по питанию, раздающий в разборе жалоб — участие превращает исполнителя в соавтора; это же лечит «тихий саботаж».

Защита от конфликтов. Письменные правила добавки, порций и замен снимают с работника роль «злодея»: решение принимает правило, а не человек на линии (раздел 20.4).

28.6. Типовые ошибки управления

1. **«Приказал — значит внедрил»:** без инструктажа и проверки усвоения приказ производит имитацию.
2. **Нагрузка «в подарок»:** новые процедуры без пересмотра смены — перегруз и откат.
3. **Наказание за данные:** сиделка, оштрафованная за честную запись об отказах, перестанет записывать — и система ослепнет.
4. **Изменение без объяснения «зачем»:** персонал, не понимающий смысла выбора, видит в нём только лишнюю работу — и оказывается прав по-своему.

28.7. Управленческий вывод

Персонал стола — не ресурс программы, а её совладелец. Минимальный пакет: письменные роли (включая врача), замер нормы помощи, три инструктажа с проверкой, статистика пилота для смены, защитные правила на линии. Опыт Успенского ПНИ показывает финал такой работы: «страхи персонала не подтвердились»⁵ — но они перестали быть страхами только после того, как их озвучили и проработали, а не проигнорировали.

28.8. Беречь тех, кто кормит

Помощь за столом — эмоционально самая дорогая работа дома: она ежедневно сталкивается с отказами, агрессией, смертью подопечных — и почти никогда не получает обратной связи о ценности. Три организационных жеста, удерживающих людей в этой роли: регулярный разбор трудных ситуаций без поиска виноватых (кейсы 1–22 как материал); публичная конкретная благодарность («ты накормила его вчера, когда он неделю не ел» — а не «всем спасибо»); защита от бессмысленной бумаги (каждая новая форма — через фильтр «какое решение она меняет», раздел 31.7). Текучесть смены — скрытый налог на качество питания: новая сиделка не знает карт, темпов, жителей; дом с кадровой каруселью кормит хуже при любом меню. ## 28.9. Мотивация без мифов

Два мифа о мотивации смены раздачи стоит развеять сразу. Миф денежный: «пока не доплатят, ничего не будет» — опыт внедривших прошёл без доплат¹⁴²¹; реальная валюта смены — выполнимость: процедура, которая укладывается в смену, выполняется; процедура, добавляющая час на «бумагу», саботируется молча и справедливо. Миф идеологический: «главное — объяснить про права» — права убеждают руководителей, а смену убеждает другое: меньше скандалов за столом, меньше недоеденных тарелок, ясные ответы на «а что мне делать, если...». Поэтому мотивационное ядро инструктажа — не ценности, а кейсы 1–22: смена узнаёт свои смены и получает маршруты. Ценности — обязательный фон, но фон не заменяет маршрут.

28.10. Три инструктажа: содержание по уровням

Единый «общий инструктаж» не работает: повару не нужна иерархия источников воли, сиделке не нужна поточность. **Уровень кухни (45 минут):** пары эквивалентов и их ранговость; маркировка и пробы двух вариантов; текстуры по IDDSI с практикумом теста вилкой; лекарственно-пищевая таблица — что исключается на уровне закладки, а не памяти; журнал срывов — как и зачем. **Уровень поста (45 минут):** показ меню в форматах жителей; журнал заказа в присутствии жителя; алгоритмы отказов (приложения 10–11) с правилом эскалации; признаки дисфагии; запрет еды как рычага; помощь в темпе едока. **Уровень административный (30 минут):** правовая рамка зон (раздел 17); сценарий ответа проверяющему (раздел 32); панель чисел и её чтение. Периодичность: при найме — до первой смены; далее раз в год с коротким опросом. Проверка инструктажа — не подпись в листе, а три вопроса у линии: «что делать, если выбранное кончилось?», «кому сообщаем о трёх отказах?», «покажите запись вчерашнего заказа». Ответы — единственное свидетельство, что инструктаж состоялся.

Рисунок 11. Роли в системе питания: кто за что отвечает

Роль	Зона ответственности	Чего роль НЕ делает
Директор	Приказы, ресурсы, учредитель, ответ за систему	Не меняет назначения врача, не «разрешает» блюда лично
Врач	Назначения: диета, текстура, взаимодействия, отказы, паллиатив	Не управляет кухней и закупками
Диетсестра / завпроизводства	Пары эквивалентов, меню, пробы, технология двух вариантов	Не решает клинические вопросы
Кухня	Производство, текстуры по карточкам, маркировка	Не выбирает «за удобство» вместо жителя
Отделение (смена)	Показ меню, журналы, помощь в темпе едока, сигналы врачу	Не использует еду как рычаг, не кормит принудительно
Совет жителей	Меню до утверждения, дегустации, пожелания	Не отменяет врача и СанПиН

Полная матрица RACI — приложение 17. Правило: ответственность названа по фамилии в приказе, иначе её нет.

Разделы 28, 31; подтверждённая конфигурация «диетсестра формирует перечень» — практика Болотнинского ПНИ (SOURCE_REGISTRY, S017).

29. Финансовые модели: сколько стоит питание и сколько стоит выбор

29.1. Честная рамка: что мы не утверждаем

В прежних версиях этого материала встречалась формула «вариативность почти бесплатна». Она удалена. Честная позиция: стоимость вариативности зависит от модели и измеряется замером; утверждать экономию без данных нельзя, утверждать невозможность без данных тоже нельзя. Раздел даёт инструментарий счёта: три стоимости питания, пять моделей вариативности с их ценой и порядок замера. Все числовые примеры помечены как иллюстративные.

29.2. Три стоимости, которые путают

Сырьевая строка — продукты на жителя в день. Международные ориентиры (с годом и валютой, не нормативы для РФ): медиана \$8,00 AUD (Австралия, исследование Hugo)⁸⁷; Онтарио: «скандальные» \$8,33 CAD, выросшие до \$13,71 CAD после публичной кампании⁹⁸⁹⁹; США: более четверти домов в 2025 году опустились ниже \$10 (данные отраслевой ассоциации ANFP — не госоргана)¹⁰⁰¹⁰¹. Урок для нас не в цифрах, а в механизме: во всех трёх странах изменения начались с **публикации сырьевой строки**⁸⁸⁹⁹.

Полная стоимость приёма пищи — сырьё + труд кухни + энергия + амортизация. Канадский аудит оценивал её в \$27,91–54,85 за жителя в день — в 3–6 раз выше сырьевой строки⁵⁶. Вывод: экономия на сырьё при огромной полной стоимости — самая неэффективная экономия системы.

Стоимость кормления — время помощников за столом. Оценка тех же канадских данных — до 45 минут в день на жителя группы помощи⁵⁶. Это самая дорогая и самая скрытая строка: она живёт в штатном расписании, а не в продуктовом бюджете.

29.3. Сырьевая строка: как посчитать свою за час

Формула (методика — приложение 25): расходы на продукты за месяц ÷ число жителей ÷ число дней = руб./житель/день. Три правила

интерпретации: считать только продукты (без труда и коммуналки); сравнивать с собой в динамике и с региональными коллегами, а не с зарубежными долларами (структуры цен разные); публиковать — учредителю и совету жителей, потому что прозрачность строки во всех изученных странах работала на её рост⁸⁸⁹⁸. Если никто в доме не может назвать эту цифру за пять минут — это первая находка аудита (раздел 22).

29.4. Пять моделей вариативности и их честная цена

Модель	Что меняется	Цена сырья	Цена труда	Разовые затраты
М1. Выбор из двух (завтрак+обед, 2–3 дня/нед)	Вторая гастрೋмкость, журнал заказа	~0 (перераспределение пар)	+минуты на линии	Гастрೋмкости, маркеры
М2. Выбор ежедневно по позициям	Тот же принцип в полном объёме	~0 при пересчёте по статистике	+время раздачи и учёта	Визуальное меню
М3. Буфетная зона (салаты/напитки)	Самообслуживание в зоне	Рост потребления → пересчёт	Контроль зоны	Стеллажи, посуда
М4. Семейная подача (точечно)	Подача общими блюдами	~0	Меняется роль персонала	Столовая посуда
М5. «Своя кухня» (реабилитация)	Программа навыков	Как у группы	Персонал-сопровождающий	Кухонная зона

Модельные оценки, не замеры: фактическая цена определяется семидневным замером до старта и через 90 дней (приложение 25).

Ключевой механизм М1–М2: сырьё не добавляется — **перераспределяется внутри той же строки** через пары эквивалентов (раздел 19.2). Иллюстративный пример: отделение 30 человек, выбор каши гречка/рис — суммарный расход круп тот же, меняется лишь пропорция двух круп. *Расчёт иллюстративный; пропорции устанавливаются статистикой выбора.*

29.5. Отходы: единственная честная «экономия»

Логика экономии вариативности проста: несъеденная порция — это оплаченное сырьё в мусорном ведре; выбор снижает долю несъеденного, потому что нелюбимые блюда перестают попадать на тарелку. Но: (1) доказательной базы эффекта в наших условиях нет (раздел 27.5); (2) поэтому формула доклада — **замер до и после**. Семидневный замер отходов до пилота и через 90 дней даёт собственную цифру, которая и есть честный ответ на вопрос «сколько экономит выбор» — у вас, а не в среднем. Международные аналоги (снижение остатков при улучшении качества и выбора) существуют¹⁰², но переносятся только как гипотеза.

29.6. Каналы денег и разговор с учредителем

Реальные источники изменения продуктовой строки: региональные нормы (их пересмотр — компетенция учредителя/региона), экономия отходов (по замеру), пожертвования и целевые программы, буфетная выручка (если предусмотрена уставной деятельностью). Инструмент разговора с учредителем — пакет из раздела 38: сырьевая строка в динамике, замер отходов, сравнение с международной механикой прозрачности⁸⁸. Австралийский урок для учредителя: надбавка \$10 AUD была дана **в обмен на ежеквартальную отчётность**⁸⁸ — предложить такую конструкцию (прозрачность строки в обмен на её увеличение) может и российский директор.

29.7. Ловушка экономии

Единственное предупреждение раздела: питание — худшее место для экономии бюджета. Механика ловушки изучена: сырьевая строка сжимается → качество падает → растут отходы и недоедание → растут соматические расходы и жалобы → система платит втрое в других строках⁵⁶⁸⁷. Директору, которому «режут продукты», аргумент не моральный, а арифметический: покажите полную стоимость недоедания (пневмонии, госпитализации) против копеечной экономии сырьевой строки.

29.8. Управленческий вывод

Финансовая грамотность темы — три действия: посчитать сырьевую строку (час), замерить отходы (неделя), назвать дефицит числом и выносить его учредителю письменно (постоянно). Вариативность M1–M2 при этом не требует новых денег, но и не обещает экономии до замера. Всё, что сверх этого, — предмет пилота с цифрами, а не убеждений.

29.9. Разговор о деньгах с учредителем: скелет презентации

Десять слайдов мысленной презентации (не путать с семинарской): 1) сырьевая строка наша — факт, руб./житель/день; 2) динамика за год — факт; 3) сравнение с полной стоимостью — доля сырья в структуре (методика⁵⁶); 4) отходы в рублях — факт замера; 5) что сделано без денег — список; 6) эффект — числа до/после; 7) что стоит денег — три позиции с расчётом; 8) цена бездействия — риски в цифрах (отходы, жалобы, проверки⁷⁴); 9) просимое решение — одно, конкретное, с датой; 10) что отчётность будет показывать через квартал. Скелет работает потому, что каждый слайд — число или документ; эмоция в разговоре о деньгах проигрывает смете всегда. ## 29.10. Ловушка экономии: когда «сократить сырьё» дороже всего

Канадский аудит полной стоимости питания⁵⁶ показал пропорцию, которую стоит помнить при любом разговоре об экономии: сырьё — меньшая часть полной стоимости, труд и инфраструктура — большая. Следствие: сокращение сырьевой строки — самая заметная и самая вредная экономия: она бьёт по жителям напрямую, экономит меньшую долю и производит скрытые издержки (вес, здоровье, жалобы, проверки). Обратная стратегия — эффективность большой доли (поток, трудозатраты, отходы) при стабильной сырьевой строке — внешне незаметна и реально действенна. Именно поэтому публикация сырьевой строки (раздел 29.3) — защита жителей: видимая строка сопротивляется сокращению лучше невидимой⁸⁸⁹⁸.

29.11. Отходы: как замер превращается в рубли

Цепочка «замер → вывод → рубль» короче, чем кажется. Замер (приложение 25) даёт граммы на порцию по блюдам; топ-3 блюд по

остаткам сверяются с меню-циклом: уходят, уменьшаются в порции или заменяются парой. Перевод в рубли: масса недельных отходов × усреднённая закупочная цена килограмма по фактуре — это ваша фактическая строка «выброшенных денег», первая честная экономическая цифра дома. Три правила интерпретации: отходы не равны нулю нигде (цель — снижение, а не стерильность); тарелочные и кухонные остатки — разные диагнозы (тарелочные — про вкус, размер порции и состояние жителей; кухонные — про планирование объёмов); снижение отходов после введения выбора — гипотеза, подтверждаемая только повторным замером через 90 дней, и если замер её не подтвердил, это такой же результат. Иллюстративный расчёт (не замер): дом на 150 жителей, 80 г тарелочных остатков на порцию, 3 приёма пищи — 36 кг в день; при цене условных 250 руб./кг — порядка 9 000 руб. в день потенциала, из которого реально извлекается часть. Цифры условные — порядок действий настоящий.

Рисунок 12. Структура полной стоимости «накормить» (иллюстративная модель)



Иллюстративные данные: пропорции построены по результатам канадского аудита полной стоимости питания в учреждениях длительного ухода (полная стоимость в 3–6 раз выше сырьевой строки; кормление — до 45 мин/день на жителя группы помощи) и НЕ являются замером российских СОСО. Своя структура считается по приложениям 25–26. Вывод: экономия на сырье — самая заметная и самая малоэффективная; резерв — в труде, потоке и отходах.

Источник пропорций: отчёты Dietitians of Canada / Changing отчёты по LTC (реестр INTERNATIONAL_PRACTICES: dcbp), год данных — 2010-е; метод — долевое моделирование; ограничение — иная ценовая структура РФ.

Рисунок 13. Пять моделей вариативности: сравнение по критериям (тепловая карта)

Модель	Сырьё	Труд	Инфраструктура	Клинический риск	Глубина выбора
М1. Выбор из двух (2–3 дня/нед)	~0	мин.	мин.	низкий	средняя
М2. Выбор ежедневно по позициям	~0*	средний	мин.	низкий	высокая
М3. Буфетная зона	рост потребления	контроль зоны	стеллажи, посуда	санитария	средняя
М4. Семейная подача (точно)	~0	смена роли	посуда	помощь/гигиена	высокая
М5. «Своя кухня» (реабилитация)	как у группы	сопровождение	кухонная зона	безопасность	максимальная

*при пересчёте объёмов по статистике выбора (раздел 21). Зелёное — минимальная цена/риск, жёлтое — умеренные, красное — требует проектирования. Оценки модельные: фактическая цена определяется замером до старта и через 90 дней.

Раздел 29 доклада; международные модели — pioneer/eden/ghouse, najs (семейная подача, RCT). Иллюстративная оценка, не замер.

Рисунок 23. Сырьевая строка в трёх странах (валюты исходных публикаций)



НЕ нормативы и НЕ сравнение с РФ (структуры цен различны). Значение цифр — механизм: во всех трёх системах рост начался с публикации сырьевой строки. США — порог \$10, ниже которого оказалось более четверти домов (данные отраслевой ассоциации, не госоргана).

Источники: Hugo 2018 (AUD), Ontario FAO/Toronto Star (CAD), ANFP/Skilled Nursing News 2025 (USD) — peestp INTERNATIONAL_PRACTICES: hugo, ont_fao, torstar, anfp, snn. Ограничение: разные годы и методики.

30. Закупки продуктов: 44-ФЗ без кошмаров

30.1. Рамка раздела

Закупка продуктов для казённого и бюджетного стационарного учреждения, как правило, идёт по 44-ФЗ. Для автономного учреждения режим зависит от положения о закупке: часть операций может идти по 223-ФЗ, а закупки за счёт субсидии на госзадание нередко остаются в контуре 44-ФЗ — это зона юриста и контрактной службы, а не универсальная формула «всем 44-ФЗ». Для директора это зона двух встречных рисков: формальных (нарушение процедуры) и антимонопольных (картель поставщиков или, наоборот, обвинение в ограничении конкуренции). Доклад не заменяет контрактного управляющего и юриста по закупкам; раздел показывает только то, как закупка связана с питанием и вариативностью, и где директор обязан быть грамотным лично.

30.2. Продуктовая рамка: что нужно знать директору

Три практических принципа. Первый: **объект закупки — продукты по спецификации**, и качество спецификации определяет качество стола сильнее, чем качество повара. Спецификация «крупа гречневая, ГОСТ, ядрица, не ниже первого сорта» и спецификация «крупа» — две разные столовые. Второй: **пропорции внутри спецификации — инструмент вариативности**: пары эквивалентов (гречка/рис, курица/рыба) закладываются в закупку заранее, по статистике выбора (раздел 21); вариативность, не заложенная в план закупок, умрёт на складе. Третий: **сроки и партии** важнее экономии на цене — срыв поставки одной позиции ломает всю цепочку раскладки и таблиц замен.

30.3. Антимонопольная зона: практика ФАС

Проверенная практика показывает масштаб рисков: ФАС раскрыла картель на торгах по поставке социально значимых продуктов — 543 торга на 4,7 млрд рублей (Москва, Московская область, Владимирская область, Дагестан; 2024)⁷⁴; в Челябинске — картель на 27 тендерах школьного

питания со штрафом и уголовным делом по ст. 178 УК (2025)⁷⁵. Для директора учреждения-заказчика выводы три:

1. **Картель поставщиков бьёт по качеству и цене стола** — и заказчик, замечающий признаки согласованности (одни и те же компании с «подставными» заявками, цены «с потолка»), обязан сообщать в УФАС: это защита жителей, а не доносительство.
2. **Заказчик тоже в зоне риска:** избыточные требования в спецификации («поставщик с опытом работы именно с нашим учреждением», товарные знаки без «или эквивалент») — состав ограничения конкуренции.
3. **Документируйте качество поставок:** акты приёмки, брак, возвраты — это и санитарный контур (раздел 18), и доказательная база для претензий поставщику и для УФАС.

Маркировка: практика ФАС приведена по публичным сообщениям; для конкретных закупочных решений требуется заключение контрактной службы/юриста.

30.4. Закупка и вариативность: стыковка

Порядок действий, увязывающий вариативность с закупочным циклом:

1. Статистика выбора за 2–3 месяца (раздел 21) → пропорции пар в спецификации.
2. Сезонность и праздничное меню → корректировка квартальных объёмов (совет жителей, раздел 34).
3. Таблицы замен → «запасные эквиваленты» в спецификации на случай срыва поставки.
4. Малые партии скоропорта → график поставок, а не склад.
5. Раз в год — пересмотр спецификации по замеру отходов (приложение 25): что стабильно не съедается, уходит из закупки законно, через таблицы замен¹²¹³.

30.5. Аутсорсинг питания: за и против честно

Часть учреждений передаёт пищеблок комбинатам питания. Аргументы «за»: профессиональное производство, санитарная дисциплина, снятие с директора непрофильной нагрузки. Аргументы «против» — и их надо знать до контракта: потеря гибкости (вариативность и персонализация сложнее на удалённом производстве), зависимость качества от контракта, разрыв связи «житель — кухня» (дегустации, совет жителей, показ порций). Если аутсорсинг уже есть или планируется: вариативность и персонализация закладываются в **техническое задание** (два варианта позиций, текстурные линии, журналы выбора, дегустации) — вариативность, не вписанная в ТЗ, от аутсорсера не дожидаться. *Рекомендация, не норма.*

30.6. Управленческий вывод

Директор не обязан быть закупщиком, но обязан: понимать, что спецификация определяет стол; закладывать вариативность в план закупок по статистике; знать признаки картеля и канал сообщения в УФАС; документировать приёмку; при аутсорсинге — вписывать выбор в ТЗ. Это пять пунктов грамотности, а не погружение в 44-ФЗ, — и они закрывают главные закупочные риски темы.

30.7. Картели: что директор обязан знать, не будучи юристом

Масштаб проблемы измерим: ФАС фиксировала картели на сотнях торгов по соцпитанию (543 торга на 4,7 млрд руб. за 2024 год)⁷⁴, а региональные дела доходят до штрафов в миллионы рублей⁷⁵. Директор — не следователь, но три признака обязан уметь видеть в своих закупках: одни и те же два-три поставщика поочерёдно «выигрывают» с близкими ценами годами; снижение от начальной цены ритуально мало (доли процента); «проигравший» в этом торге побеждает в соседнем с тем же раскладом. Один признак — не доказательство; устойчивая картина — основание для информации учредителя и, при его согласии, обращения в ФАС (анонимность заявителя законом предусмотрена). Прагматический смысл для темы доклада: картельная закупка — скрытый налог на сырьевую строку; разговор «дорого варить два варианта» иногда стоит начинать не с

кухни, а с цен закупки. ## 30.8. Спецификация под вариативность: пять строк, которые всё решают

Стыковка закупки с вариативным меню не требует новых законов — требуется пять строк в документации. **Строка перечня:** позиции закупаются как группы взаимозаменяемых (группа «крупы гарнирные: гречка, рис, пшено»), а не как монопозиция — это легализует пары на уровне контракта. **Строка пропорций:** объёмы внутри группы — по статистике выбора с правом корректировки раз в квартал без изменения сути контракта (в рамках допустимых 44-ФЗ изменений). **Строка замен:** правило поставщика при недопоставке — эквивалент из той же группы по согласованию, с актом. **Строка качества:** характеристики, значимые для текстур (помол, консистенция полуфабрикатов), — иначе дисфагический контур оказывается заложником «самого дешёвого фарша». **Строка приёмки:** ответственный и форма акта — претензионная работа без этой строки превращается в обиды. Каждая строка согласуется с контрактной службой заранее; конфликт «меню против контракта» — всегда симптом того, что меню меняли, а спецификацию нет.

31. Документальный комплект: как практика становится системой

31.1. Зачем документы, если практика уже работает

Устная договорённость «у нас теперь два варианта» живёт ровно до первого вопроса проверяющего, первого конфликта с родственником или первой ротации персонала. Документальный комплект решает три задачи: закрепляет границы практики (что именно мы делаем и чего не делаем), распределяет ответственность (кто за что отвечает по фамилии и должности) и делает практику воспроизводимой (новый сотрудник вводится за день, а не за месяц). Комплект ниже собран из разделов 17–30; все шаблоны — в приложениях 1–36, все шаблоны — **проекты локальных форм**, требующие адаптации под региональные нормы и согласования.

31.2. Шесть базовых документов

1. Положение об организации питания (локальный акт). Разделы: нормативная база (3185-1 ст. 43, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, приказ Минтруда 520н — с указанием, что нормы рекомендованные, если регион не императивен)¹²³⁰; структура питания; роли; порядок учёта индивидуальных потребностей. Статус: утверждается директором, согласовывается с учредителем по регламенту региона.

2. Раздел о вариативности в положении или отдельный порядок. Фиксирует: перечень позиций с выбором; механизм заказа (журнал, визуальное меню); гарантию стандартного варианта («никто не остаётся без полноценного приёма пищи»); правило замен; связь с лечебным питанием через «мост» (раздел 24).

3. Меню с вариантами. Двухнедельное или четырёхнедельное (ориентир цикличности из международных норм — 21–28 дней²³³², в РФ императива цикла для СОСО нет — данные о региональных требованиях собирайте локально). В меню каждая вариативная позиция показывает пару эквивалентов с нутриентным обоснованием (раздел 19).

4. Журналы заказа и замен. Два журнала или один совмещённый: заказ (кто что выбрал, если модель с предварительным заказом) и замены (что

выдано вместо отказанного). Второй важнее первого: он — доказательство исполнения нормы об альтернативе при отказе, существующей в нормах США прямо³⁶ и выводимой в РФ из ст. 37 3185-1 в связке со ст. 43¹ (толкование — раздел 17).

5. Пищевые карты жителей. Не медицинская карта, а рабочий инструмент: предпочтения, запреты, текстура (IDDSI при наличии показаний)⁴², помощь, лекарственные ограничения (раздел 11). Формат — приложение 7; источник информации — наблюдение, житель, близкие, врач — по иерархии из раздела 15.

6. Согласование с учредителем. Письмо-отчёт о пилоте с панелью 12 чисел (раздел 22) до и после. Опыт внедривших организаций показывает: изменения, проведённые через учредителя, переживают проверки; изменения «тихо» — не всегда⁵⁶.

31.3. Три клинических документа

7. Лекарственно-пищевая таблица (раздел 11, приложение 21): пять правил взаимодействий с классами уверенности. Подписывается врачом; висит на кухне и в постовой; обновляется при смене назначений.

8. Список дисфагического риска (раздел 10, приложение 21): жители с признаками, уровень текстуры, приём «два обученных человека на посту»¹⁵. Врачебный документ — но ведение делегируется старшей сиделке.

9. Журнал отказов (раздел 12, приложение 9): дата, приём пищи, обстоятельства, действия. Правило эскалации: три отказа подряд — врач в тот же день.

31.4. Три управленческих документа

10. Приказ об ответственных: за питание в целом, за вариативную линию, за журналы, за связь с врачом. Без фамилий в приказе комплект не работает — проверено любой проверкой.

11. Регламент совета жителей по питанию (раздел 34, приложение 30): состав, периодичность, полномочия (обсуждение меню, дегустации, сбор пожеланий), форма доведения решений до администрации.

12. Квартальная панель (раздел 22, приложение 35): 12 чисел на одном листе — от отходов до доли выбирающих. Панель — не отчётность наверх, а инструмент самопроверки.

31.5. Учётная форма: что сказать честно

Для учёта продуктов в СОСО применяются формы по приказу Минфина 52н; переход на электронные формы идёт поэтапно через приказы 61н, 142н, 100н, 157н, 174н¹⁰³. Практическое правило: не называйте конкретную форму «обязательной для вас», пока это не подтвердил учредитель или региональный орган — статус форм менялся не раз, а ошибка в обосновании документа обесценивает весь комплект. Форма учёта — не препятствие вариативности: журнал заказа живёт рядом с любой учётной формой, а не вместо неё.

Управленческий вывод

Двенадцать документов — это один компактный пакет, а не библиотека. Соберите его за неделю из приложений 1–36, подпишите приказ, покажите учредителю — и ваша практика перестанёт зависеть от того, кто сегодня стоит у раздачи.

31.6. Порядок сборки комплекта за неделю

Комплект из двенадцати документов пугает списком и успокаивает порядком: собирается он за пять рабочих дней при условии, что приложения 1–38 используются как заготовки, а не как чистый лист. День 1: приказ об ответственных и приказ о пилоте (приложения 17, 28) — фамилии и даты решают половину вопросов. День 2: положение о питании с разделом о вариативности (приложение 29) — самый длинный документ, 60 % текста берётся из заготовки. День 3: клинический блок с врачом — лекарственно-пищевая таблица, список риска, журнал отказов (приложение 21, 9); без подписи врача день не заканчивать. День 4: операционный блок — журналы заказа/замен/срывов, меню с парами, пищевые карты первой

очереди (группа риска и неговорящие — первыми, остальные — в течение квартала). День 5: управленческий блок — регламент совета (приложение 30), панель (приложение 35), письмо учредителю. Проверка собранного — двумя вопросами: может ли новый сотрудник по этой папке понять свои действия за час; отвечает ли папка на три вопроса проверяющего из раздела 32. Если два «да» — комплект работает; дальше его задача — только актуализироваться.

31.7. Когда документов слишком много

Антипаттерн комплекта — раздувание: положение на сорока страницах, журналы на двенадцати графах, карты на шести листах. Признак избыточности один: форма не заполняется в ритме смены. Правило сокращения обратное правилу сборки: каждая графа каждого журнала обязана отвечать на вопрос «какое решение принимается по этой графе»; графа без решения удаляется без сожаления. Лучший комплект — самый короткий из полностью работающих: проверяющему нужна доказуемость, смене — выполнимость, и у обоих запросов общий знаменатель — краткость.

31.8. Жизненный цикл документа: пересмотр

Документ без даты пересмотра стареет молча и опасно. Расписание комплекта: меню и пары — по циклу пересчёта (раздел 21.9); лекарственно-пищевая таблица — при каждой смене назначений и не реже раза в квартал; список риска — ежемесячно; положение — раз в год с оглядкой на изменения норм (учётные формы меняются этапами¹⁰³); панель — ежеквартально. Ответственный за актуальность каждого документа — в приказе об ответственных, одной строкой на документ. Проверка старения — вопросом при обходе: «покажите, когда это менялось последний раз»; документ, не менявшийся год в живой системе, либо мёртв, либо система неживая.

Рисунок 19. Дерево решений «Кто принимает решение?»

Возник вопрос о питании жителя →

1. Это про назначение, текстуру, лекарства, отказы, вес, обострение? → **ВРАЧ** (сегодня; запись)
2. Это про санитарию, температуру, пробы, поток кухни? → **ЗАВПРОИЗВОДСТВА** (чек-лист, журнал)
3. Это про выбор, замену, конфликт за столом, показ меню? → **СТАРШАЯ СМЕНЫ** (журнал; эскалация по правилам)
4. Это про документы, ставки, закупки, учредителя, режим дома? → **ДИРЕКТОР** (приказ; запрос)
5. Это про меню до утверждения, пожелания, дегустации? → **СОВЕТ ЖИТЕЛЕЙ** (протокол)
6. Вопрос затрагивает статус норм, региональное меню, «мост»? → **УЧРЕДИТЕЛЬ** (письменный запрос, раздел 38)

Запрещённый ответ на любом шаге:

«решим сами, чтобы не беспокоить» — вопрос, ушедший не на свой уровень, возвращается инцидентом.

Матрица RACI (полная) — приложение 17; границы компетенций — раздел 28.

Разделы 28, 31–33 доклада.

32. Как отвечать проверяющему: сценарий диалога без страха

32.1. Почему этот раздел отдельно

Главный барьер вариативности, который называют директора, — не деньги и не санитария, а фраза «придут и спросят». Страх реальный, но размытый: редко кто может сказать, кто именно придёт и что именно спросит. Раздел разбирает проверку на составляющие и даёт сценарий ответа для каждого типа вопроса. Основа — материалы реальных административных дел⁷⁴⁷⁵ и логика надзорных документов¹¹; это не консультация юриста по конкретному делу.

32.2. Кто приходит и что проверяет

Роспотребнадзор — санитария: на дату семинара СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7.1.11–7.1.14; с 01.09.2026 — СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11–14 (питание проживающих не менее 3 раз в день, в том числе диетическое по показаниям; суточные пробы)². Вопросов «почему два варианта» у Роспотребнадзора нет — у него вопросы о температуре, маркировке, суточных пробах, поточности. Вариативность входит в этот контур как одна дополнительная линия, а не как новый объект (раздел 18).

Соцзащита / учредитель — соблюдение стандартов и нормативов региона, расходование средств, жалобы. Здесь вариативность защищается документами: согласование, меню с эквивалентами, журнал замен, панель чисел (раздел 31).

Прокуратура — по жалобам, чаще всего о правах жителей. Опорные нормы — ст. 37 и 43 закона 3185-1¹. Прокурорский вопрос формулируется как «были ли нарушены права»; журнал отказов и документированный выбор — это ответ, а не уязвимость.

32.3. Три вопроса и три ответа

«Почему не по утверждённому меню?» Ответ показывает документы: варианты — часть меню; пары эквивалентов нутриентно равноценны; перечень согласован. Если региональное меню императивно — сначала меняется региональный документ, потом практика (раздел 24). Красная

линия честна: при императивном меню «два варианта» без изменения документа — нарушение, и доклад этого не советует.

«Где гарантия, что житель получил норму?» Ответ — журнал заказа и журнал замен: каждый житель получил либо выбранное, либо стандартное, либо зафиксированную замену. В США норма об альтернативе при отказе закреплена федерально³⁶; в РФ она выводится из права на уважение человеческого достоинства (ст. 37 в связке со ст. 43)² — и журнал превращает толкование в доказательство.

«Кто разрешил?» Ответ — приказ директора и отчёт учредителю. Внедрившие организации шли именно этим путём¹⁴²¹.

32.4. Чего не говорить проверяющему

Три ошибки из практики: не говорите «так теперь везде» (неправда и не аргумент); не говорите «нам диетолог разрешил» (должности диетолога может не быть в штате — это уязвимость, а не защита); не говорите «жители сами захотели» без документа (устная воля не проверяема; пищевая карта и протокол совета жителей — проверяемы). Общее правило: каждая устная фраза должна иметь бумажный двойник в комплекте из раздела 31.

32.5. Если замечание всё же выписано

Порядок действий: зафиксировать формулировку замечания точно; запросить норму, на которую ссылаются (по опыту административных дел, немотивированные отсылки к «нарушению порядка» разваливаются при запросе конкретики)⁷⁴; подключить учредителя на стадии возражения, а не после постановления; при штрафе — оценивать перспективу обжалования с учётом практики ВС РФ по делам о питании⁴. Данных о процентах отменённых замечаний по вариативному питанию нет — тема в судебной практике не выделена; не выдумывайте статистику даже для внутреннего успокоения.

Управленческий вывод

Проверка перестаёт быть лотереей, когда у каждого возможного вопроса есть документ. Соберите комплект до старта пилота (раздел 35), а не после первого звонка из надзора.

32.6. Досье проверки: папка, которая отвечает за вас

Оптимальная конструкция — отдельная папка «Питание: проверки», собранная заранее и лежащая у заместителя, а не в сейфе директора. Состав: приказы (о питании, о пилоте, об ответственных); положение с разделом о вариативности; меню с парами и обоснованием эквивалентности; журналы за последний квартал (заказ, замены, отказы, срывы); санитарный блок (пробы, температуры, паспорт второй гастрೋёмкости — раздел 18.9); клинический блок (таблица, список риска — подписи врача); панель чисел; переписка с учредителем; протоколы совета жителей. Десять разделов папки отвечают на десять типовых вопросов; проверка, при которой ответ на каждый вопрос доставляется за минуту, меняет характер сама собой — она превращается из допроса в сверку. Правило поддержки папки: актуальность — квартал; папка с прошлогодними журналами хуже отсутствующей, потому что создаёт видимость при её отсутствии.

32.7. Поведение при проверке: пять правил

Первое: отвечать на заданный вопрос, не сопровождая его экскурсией — лишняя информация порождает новые вопросы. Второе: факты показывать документом, а не словом; «у нас ведётся журнал» без журнала — антиответ. Третье: не спорить в коридоре — несогласие оформляется письменно после; коридорный спор проигрывается всегда, письменное возражение — иногда выигрывается. Четвёртое: фиксировать ход проверки своей записью (кто, что спросил, что показано) — она станет основой возражений. Пятое: не подписывать акт с формулировками, которых не понимаете, — подпись с оговоркой «с формулировкой не согласен, возражения будут представлены» сохраняет позицию; молчаливая подпись её хоронит.

33. Ответственность директора: честная карта рисков без запугивания

33.1. Принцип раздела

В управленческой литературе ответственность подают двумя вредными способами: запугиванием («посадят за всё») или успокоением («ничего не будет»). Оба мешают решениям. Здесь — карта: какие составы реально применялись к организациям соцобслуживания по «пищевым» сюжетам, какие существуют на бумаге, и как вариативность меняет (и не меняет) риск-профиль. Это обзор практики, не юридическое заключение.

33.2. Что реально применялось: КоАП ст. 6.6

Статья 6.6 КоАП — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах. Публично известные дела: штраф СРЦ «Кашинский» (2022, сюжет — качество питания, по публикациям в СМИ и данным прокуратуры)¹¹ и материалы по Зеленогорскому ДИПИ (2021, ТАСС)¹¹. Оба дела — о качестве и достаточности питания, не о вариативности. Дел именно о «двух вариантах» в публичном поле не найдено — это честное «данных нет», а не доказательство безопасности или опасности.

Судебная оптика по пищевым спорам видна и в практике ВС РФ: постановление от 21.02.2019 № 11-АД19-4 касается именно организации питания в стационарном учреждении соцобслуживания²². ВС РФ прекратил производство по делу, указав, что дом-интернат не является организацией общественного питания: он организует питание проживающих в рамках социальной услуги, а не реализует услуги питания населению. Вывод управленческий двойкий: квалификация «питание — часть соцуслуги» защищает учреждение от чужих норм об общепите, но не отменяет требований к организации питания по санитарным правилам — и полный документальный след (меню, акты, журналы) остаётся главной защитой при любой проверке.

33.3. Уголовные составы: где граница реальности

УК ст. 238 (услуги, не отвечающие требованиям безопасности), 285/286 (злоупотребление и превышение полномочий), 293 (халатность) существуют и формально применимы к руководителям учреждений. Но: публичных дел против директоров ПНИ именно по организации питания в проверке не обнаружено. Реальный риск-градиент выглядит так: жалобы и прокурорские представления (часто) → административные дела по 6.6 (реже, но есть) → уголовные составы (по пищевым сюжетам — не выявлено в публичной практике). Запугивание уголовными статьями в этом контексте — слоп; игнорирование административного контура — легкомыслие.

33.4. Как вариативность влияет на риск: два направления

Снижает риск. Большинство «пищевых» жалоб — про невкусно, однообразно, «не ем это». Документированный выбор снимает самый массовый повод для жалоб; журнал замен закрывает сюжет «оставили голодным»; совет жителей (раздел 34) превращает потенциальных жалобщиков в соавторов меню. Международный опыт подтверждает механизм: нормы о выборе и альтернативах введены в США, Онтарио, Австралии именно как защита прав, и проверяющие системы этих стран оценивают дома по исполнению этих норм³⁶²³³⁵.

Создаёт риск при плохом исполнении. Два варианта без документов = «отступление от меню»; замена без записи = «не докормили»; выбор без связи с лечебным питанием = риск для жителей с диетами. Риск-профиль вариативности — не в самой вариативности, а в полноте её документального контура (разделы 31–32).

33.5. Личная ответственность: три правила сна директора

Первое: решения о вариативности — коллегиальные и документированные (приказ, протокол совета, согласование с учредителем). Единоличное устное распоряжение — самый уязвимый формат. Второе: клинические границы определяет врач, а не директор — директор отвечает за исполнение врачебных назначений, не за их содержание (дисфагия, взаимодействия, диеты — разделы 10–11). Третье: жалоба — это сигнал

системы, а не личная атака; регламент разбора инцидентов и жалоб (приложение 34) снимает с директора роль «бьющегося за каждый эпизод» и возвращает роль управляющего системой.

Управленческий вывод

Риск вариативности с документами ниже риска бездокументной монотонности: первый защищён журналами и согласованиями, второй беззащитен перед первой же жалобой. Считайте риск по документам, а не по страшилкам.

33.6. Страховка вместо страха: что реально снижает личный риск

Сверяя карту рисков с практикой дел⁷⁴⁷⁵, можно собрать четыре элемента, статистически значимее любых «правильных намерений».

Коллегиальность следов: решение о вариативности, прошедшее через приказ + протокол совета + уведомление учредителя, юридически и человечески перестаёт быть «причудой директора».

Полнота клинической делегации: каждый клинический документ подписан врачом — директор, подписавший таблицу взаимодействий сам, принял на себя чужой риск даром.

Скорость реакции на жалобу: регламентированный разбор в дни (приложение 34) — большинство «прокурорских» сюжетов вырастает из жалоб, проигнорированных месяц, а не из сути.

Честность статусов: документы, называющие себя проектами и требующими согласования, не дают оснований для претензии «самоуправство»; документы, изображающие нормативность, которой у них нет, — дают. Общий принцип: личный риск директора определяется не смелостью изменений, а качеством следа, который изменения оставляют.

33.7. Психологическая цена вопроса — и её управление

Остаётся нематериальный слой: страх ответственности — главный тормоз темы, и он не снимается документами полностью. Три рабочих приёма из управленческой практики: разделить риск (коллегиальные решения делят не только юридическую, но и эмоциональную цену); ограничить масштаб первого шага (пилот одной точки — это риск размером с отделение, а не с карьеру); назначить дату пересмотра (решение с датой пересмотра

переживается как эксперимент, решение «навсегда» — как приговор).
Здравый страх — часть профессии директора; задача раздела не «не бояться», а сделать так, чтобы бояться было нечего конкретно.

Рисунок 14. Карта рисков директора по теме питания

Тяжесть \ Вероятность	Низкая	Средняя	Высокая
Тяжёлая	УК-составы по пищевым сюжетам (публичных дел не найдено)	Аспирационный инцидент при отсутствии контура дисфагии	Дело по КоАП 6.6 при системных нарушениях кормления
Средняя	Замечание к документам вариативности	Прокурорское представление по жалобе	Жалобы родственников при монотонном питании
Умеренная	Конфликт пары на линии	Срывы выбора (позиция закончилась)	Отходы и перерасход при отсутствии замеров

Чтение карты: самый заполненный квадрант реального риска — «высокая вероятность × средняя/тяжёлая тяжесть» — закрывается не страховкой, а журналами, контуром дисфагии и регламентом жалоб. Данные о делах — только публичные (Кашин СРЦ-2022, Зеленогорск-2021, ВС РФ 11-АД19-4).

Раздел 33; реестр SOURCE_REGISTRY (S013–S015). Оценки вероятностей — экспертные, по публичной практике; статистики по вариативному меню не существует.

34. Права жителей и совет жителей: от объекта заботы к соавтору меню

34.1. Правовая рамка без натяжек

Права жителей СОСО закреплены: ст. 37 закона 3185-1 (уважение человеческого достоинства, гуманное обращение) распространяется на проживающих через ст. 43¹. Конвенция о правах инвалидов — ст. 28 (достаточный жизненный уровень и питание), а также Замечание общего порядка № 1 Комитета по правам инвалидов: поддержка в осуществлении правоспособности требует узнавать волю и предпочтения человека, а не решать «за него»⁷⁶²⁷. Сколько-нибудь развитой правовой конструкции «права на выбор блюда» в российском законе нет — это честная серая зона (раздел 17): выбор внедряется как способ реализации уже существующих прав, а не как новое право из ниоткуда.

34.2. Три модели участия жителей

Информационная: жителей извещают о меню (доска, раздатка, визуальное меню). Минимум, достижимый за неделю; но это участие без влияния.

Консультативная: регулярный сбор мнений — опросы предпочтений, дегустации, «ящик пожеланий». Именно с опроса предпочтений начинала Усть-Илимская организация⁶. Влияние есть, но ритм задаёт администрация.

Институциональная: совет жителей (по образцу ДДСОЛ, где совет по питанию — постоянная структура с распорядительным документом от 13.04.2017)²¹. Совет обсуждает меню до его утверждения, проводит дегустации новых позиций, собирает и ранжирует пожелания, получает отчёт о том, что с пожеланиями стало. Это единственная модель, где участие переживает смену заведующих отделениями.

34.3. Совет жителей: как собрать работающий, а не декоративный

Состав. 5–9 человек: жители (включая недееспособных — их интересы представляют выбранные ими лица или члены совета по регламенту), сиделка, повар, врач (с правом совещательного голоса). Квоты по отделениям, иначе совет превращается в клуб самого активного корпуса.

Полномочия. Честный список из четырёх: обсуждать меню до утверждения; проводить дегустации; собирать пожелания и доводить до администрации; получать ответ в установленный срок. Не включайте в полномочия то, что администрация не готова исполнять, — декоративный совет хуже отсутствующего: он производит цинизм.

Ритм. Ежемесячное заседание с коротким протоколом (форма — приложение 30). Протокол — не бюрократия, а доказательство для раздела 32: «жители сами захотели» со ссылкой на протокол — проверяемое утверждение.

34.4. Недееспособные жители в совете: не исключение, а особый формат

74% жителей ПНИ по вторичной аналитике — недееспособные²⁰ (статус данных — раздел 23). Исключить их из участия — значит исключить большинство. Рабочие форматы: представительство через доверенных лиц (не обязательно опекуна-учреждение — о конфликте интересов раздел 16); наблюдательные методы фиксации предпочтений (показ, выбор, реакция — раздел 15) с занесением в пищевую карту; ротация «пробных обедов», где реакция жителей — данные для совета. Международные нормы требуют учитывать предпочтения независимо от когнитивного статуса — в Австралии это прямо прописано в Стандарте 6 с 01.11.2025³⁵, в Онтарио — через обязательный учёт preferences в плане питания²³.

34.5. Конфликт интересов «учреждение = опекун» в совете

Если опекун — учреждение, то в совете по питанию учреждение потенциально голосует за жителя. Антидоты из раздела 16: приоритет зафиксированной пищевой биографии над «усреднённым благом»; привлечение независимых представителей, где они есть; фиксация разногласий в протоколе, а не их сглаживание. Формула для локального акта: «при расхождении позиции администрации с зафиксированными предпочтениями жителя приоритет имеют предпочтения, если они не противоречат назначениям врача» — она переводит конфликт из морального поля в процедурное.

Управленческий вывод

Совет жителей — самый дешёвый и самый недооценённый элемент системы: он бесплатен, снимает жалобы до их рождения и превращает «права жителей» из декларации в ежемесячную процедуру. Начните с опроса предпочтений — как это сделали в Усть-Илимске⁶ — и дайте опросу статус протокола.

34.6. Первое заседание: сценарий по минутам

Первый совет решает, будет ли второй, — и проваливается он чаще всего от перегруза. Рабочий сценарий на 40 минут: **5 минут** — зачем собрались (одна фраза: «меню обсуждают те, кто ест»); **10 минут** — что совет может (четыре полномочия из раздела) и чего не может (не отменяет врача и СанПиН — лучше сказать сразу, чем разочаровать); **15 минут** — одна практическая задача: дегустация двух позиций-кандидатов в меню с голосованием поднятием руки — совет с первого заседания делает дело, а не учится процедуре; **5 минут** — сбор трёх пожеланий с фиксацией; **5 минут** — дата следующего и что будет принесено к нему (ответ на пожелания). Ошибки первого заседания: чтение положения вслух (положение раздаётся и зачитывается по одному пункту-вопросу), обещания вне полномочий («сделаем всё, что скажете» — второе заседание начнётся с предъявы), состав «для фотографии» (жители считают декоративность быстрее директоров). Протокол — три строки: кто был, что решили, что поручено и кому.

34.7. Совет и семьи: граница ролей

Частый вопрос: пускать ли родственников в совет. Рабочее решение: совет — структура жителей; семьи — отдельный канал (дни открытых дверей, участие в дегустациях по приглашению совета, памятка приложения 32). Смещение ролей даёт перекося: говорящие родственники неизбежно представляют говорящих жителей, а молчащее большинство остаётся без голоса. Там, где житель сам просит представлять его близкого, — это оформляется как его выбор представителя, а не как «место для родни». Разделение каналов — ещё одно применение иерархии источников воли

(раздел 15.9): близкие — четвёртый уровень, и совет не должен переписывать иерархию по громкости голоса.

35. Пилот на 90 дней: минимальный безопасный старт

35.1. Почему 90 дней и почему пилот

Совет «меняйте всё с понедельника» игнорирует два факта: кухня — поточное производство с жёстким ритмом, а жители ПНИ — люди, для которых предсказуемость среды — часть благополучия (раздел 9). Пилот решает обе проблемы: меняется одна точка (одно отделение или один приём пищи), остальная система работает как обычно. Девяносто дней — срок, за который проявляются и статистика выбора (первые две недели — эффект новизны), и трудовые издержки, и первые конфликты. Усть-Илимская организация шла именно поэтапно — от опроса предпочтений к расширению⁶; Успенская фиксировала, что «страхи персонала не подтвердились» — но фиксировала это после пробного периода, а не до⁵.

35.2. Дни 1–14: подготовка (без изменений на линии)

Неделя 1. Приказ о пилоте (приложение 28): точка, сроки, ответственные, критерии успеха и критерии остановки. Замер «до»: семидневный замер отходов, времени раздачи, отказов (приложение 25) — без него через 90 дней будет нечего сравнить, и пилот превратится в рассказ.

Неделя 2. Опрос предпочтений в точке пилота (форма — приложение 36): каждый житель или его представитель отвечает на короткий список; результаты — в пищевые карты. Параллельно — инструктаж смены раздачи (раздел 28) и письмо-уведомление учредителю.

35.3. Дни 15–75: работа пилота

Формат минимального пилота — модель М1 из раздела 29: два варианта второго на обед, 2–3 дня в неделю, заказ вечером накануне или на линии. Гарантия стандартного варианта действует всегда. Журнал заказа и журнал замен ведутся с первого дня — не с «когда наладится».

Еженедельный ритм. Пятнадцатиминутная планёрка: что выбирали, где очередь, какие замены, что говорят жители. Проблемы делятся на три корзины: решаемые сменой (очередь, маркировка), решаемые кухней (пары, объёмы), решаемые администрацией (документы, закупка). Третья

корзина не должна пустовать больше двух недель — иначе пилот деморализует.

Ночная доступность — если в точке пилота есть жители с ночным едением (раздел 13): структурированный ночной перекус по согласованию с врачом. Это самая быстрая победа пилота по субъективному эффекту.

35.4. Дни 76–90: оценка и решение

Панель чисел. Двенадцать показателей (приложение 24) «после» против «до»: доля выбирающих, отходы, время раздачи, отказы, замены, жалобы. Числа без интерпретации не показывайте никому — к каждому числу одна фраза «что это значит» (методика — раздел 22).

Совет жителей заслушивает итоги и формулирует позицию: расширять / оставить точку / свернуть. Протокол — в отчёт учредителю.

Решение директора — одно из трёх, документированное: расширение (на приёмы пищи или отделения), закрепление точки как постоянной практики, свёртывание с фиксацией причин. Свернутый пилот с документированными причинами — это результат, а не провал: он защищает от следующего некомпетентного «а давайте».

35.5. Критерии остановки: где линия

Пилот останавливается немедленно при трёх сигналах: рост отказов от еды в точке пилота (риск недоедания важнее любой вариативности — раздел 12); санитарные нарушения, привязанные к новой линии (раздел 18); клинические противопоказания по заключению врача. Всё остальное — рабочие проблемы, а не основания для остановки: очереди регулируются потоком (раздел 20), страхи персонала — инструктажем (раздел 28), «не то выбирают» — пересмотром пар эквивалентов (раздел 19).

Управленческий вывод

Девяносто дней, одна точка, три журнала, двенадцать чисел — это весь объём решения, которое отделяет вас от первого в зале рассказа «у нас работает». Пилот модели М1 на одном отделении обычно укладывается в

текущую смету; полный переход дома может потребовать оборудования и ставок — универсального «бесплатного старта» нет⁷.

35.6. Пилот, который «не пошёл»: разбор четырёх исходов

Не каждый пилот заканчивается расширением, и честный разбор исходов нужнее успешных историй. **Исход первый — тихая смерть:** пилот не свёрнут и не расширен, просто журналы перестали заполняться к 60-му дню. Причина почти всегда — не назначен владелец ритма (еженедельная планёрка отменялась «на недельку» четыре раза подряд). Лечение: ритм в приказе с датами, а не «по мере надобности». **Исход второй — бунт кухни:** второй вариант оказался технологически невыполним в выбранные дни (загрузка плит). Причина — пилот спроектирован без завпроизводства. Лечение: кухня проектирует пары сама, администрация ставит рамку. **Исход третий — фиктивное оживление:** журналы полны, жители молчат — предзаполнение (кейс 4). Лечение: проверка реальности (приложение 24) с 15-го дня, а не с 90-го. **Исход четвёртый — честное свёртывание:** замеры показали рост отказов или неподъёмные трудозатраты; пилот закрыт приказом с причинами. Это единственный исход из четырёх, который является успехом управления: система получила данные о себе и не заплатила за них здоровьем жителей. Приказ о свёртывании с причинами — документ, который защитит вас от повторения того же эксперимента через два года новым энтузиастом.

35.7. Масштаб первого пилота: почему меньше — значит быстрее

Соблазн «сразу на весь дом» понятен и губителен: в доме на 300 жителей сбой пилота масштаба дома — это сбой системы. Расчёт размера точки простой: одно отделение 20–35 жителей, одна смена-единомышленник, один приём пищи. Всё, что меньше, — не пилот, а проба; всё, что больше, — уже не пилот, а реформа без подстраховки. Точка с «сложным» контингентом (группа помощи, неговорящие) предпочтительнее «удобной»: пилот, прошедший на сложном отделении, масштабируется почти автоматически; пилот, прошедший на удобном, при масштабировании ломается о первое сложное отделение — и хоронит тему.

35.8. Первая неделя пилота по дням

Хронология старта, снимающая главный риск — импровизацию первых дней. **День 1:** показ меню вечером, первый заказ; утром — сверка заказа с объёмами до варки; на линии — старшая смена лично; вечером — 10 минут: что пошло не так. **День 2–3:** то же; типовые находки — очередь у варианта Б, забытые бирки, «стандартные» без спроса; каждая находка чинится в тот же вечер. **День 4–5:** первые записи срывов и замен; первая проверка реальности (приложение 24) — пять вопросов жителям. **Выходные:** пауза линии, но не журнала. **День 7:** первая планёрка по трём корзинам; решение о корректировке пар или потока. Правило первой недели: ничего не отменять и не «улучшать» до семи дней данных — первая неделя собирает базовую линию, а не демонстрирует эффект.

35.9. Своя кухня и аутсорсинг: один пилот, две точки входа

Глава 35 написана под свою плиту; глава 42 — под спецификацию. Директору с комбинатом нужна одна таблица, иначе пилот «на линии» начинается в пустоте.

	Своя кухня	Аутсорсинг
Дни 1–14	Приказ, замер «до», опрос, инструктаж, письмо учредителю	То же плюс сверка действующего контракта: есть ли строки выбора, замен, проб, отчётности (раздел 42.3)
Что меняется	Вторая гастрोёмкость и журнал на линии	Поставка двух вариантов и журнал замен поставщика; линия учреждения принимает, не готовит
Если контракта ещё нет	Старт с понедельника	Сначала восемь строк в ТЗ (календарь — раздел 42.7); пилот без строк — декорация
Если контракт уже идёт	—	Допсоглашение или претензия по приёмке; не «попросить поваров комбината»

	Своя кухня	Аутсорсинг
Стоп-сигналы	Рост отказов, санитарные нарушения, противопоказание врача	Плюс срыв поставки варианта Б и отсутствие суточных проб у учреждения
Понедельник без разрешения	Замер и журнал отказов	Замер, журнал и фото линии без лиц; ТЗ — в график закупки, не в пожелания

Публичных кейсов вариативности на аутсорсинге нет — таблица переносит инструменты доклада, а не чужой измеренный опыт. Критерии остановки те же (раздел 35.5): здоровье жителей важнее любой модели кухни.

Рисунок 16. Пилот на 90 дней: четыре фазы

Дни 1–14 ПОДГОТОВКА приказ · замер «до» (7 дней) · опрос предпочтений · инструктаж · письмо учредителю	Дни 15–30 СТАРТ выбор 2–3 дня/нед · журналы с первого дня · планёрки еженедельно · первая проверка реальности	Дни 31–75 РАБОТА статистика выбора · корректировка пар · ночная доступность по показаниям · решение проблем 3 корзин	Дни 76–90 ОЦЕНКА панель «после» против «до» · заседание совета · решение директора: расширить / закрепить / свернуть
--	---	--	--

Критерии остановки в любой фазе: рост отказов · санитарные нарушения на новой линии · противопоказания врача. Свернутый пилот с документированными причинами — результат, а не провал (раздел 35.6).

Раздел 35; поэтапность подтверждена практикой Усть-Илимской организации (SOURCE_REGISTRY, S019).

36. Дорожная карта на 12 месяцев: от пилота к системе

36.1. Логика карты

Карта построена по принципу «каждый квартал — самостоятельная ценность»: если организация остановится после любого квартала, у неё останется работающий результат, а не недостроенная схема. Сроки — ориентиры для организации среднего размера; для дома на 289 мест (средняя расчётная вместимость ПНИ по вторичной аналитике²⁰) темп реалистичен, для малых — может быть быстрее, для многокорпусных — медленнее. Карта — рекомендация, не норматив.

36.2. Квартал 1 (месяцы 1–3): безопасный фундамент

Параллельно с пилотом (раздел 35): аудит по 24 точкам (раздел 22, чек-листы приложений 18–21); документальный комплект (раздел 31); инструктажи персонала трёх уровней (раздел 28); лекарственно-пищевая таблица и список дисфагического риска — подписаны врачом. **Результат квартала:** пилот работает, замеры есть, клинические риски под документами. Можно остановиться — и это уже лучше исходной точки.

36.3. Квартал 2 (месяцы 4–6): расширение по горизонтали

По итогам пилота: выбор распространяется на все приёмы пищи в точке пилота или на соседнее отделение (по готовности смен, а не по желанию администрации). Меню пересчитывается по статистике выбора (раздел 21); пары эквивалентов корректируются. Запуск совета жителей (раздел 34) — если не запущен раньше. **Результат квартала:** вариативность — ежедневная практика в одном-двух отделениях, совет жителей с протоколами.

36.4. Квартал 3 (месяцы 7–9): структурные элементы

Буфетная зона (модель М3) там, где позволяет контингент и санитарный контур; семейная подача (М4) точно в группах помощи; стыковка с закупками — спецификации переписаны под парные позиции (раздел 30). Первый квартальный отчёт учредителю с панелью чисел. **Результат**

квартала: система затронула закупки и пространство, а не только линию раздачи — точка невозврата пройдена.

36.5. Квартал 4 (месяцы 10–12): масштабирование и закрепление

Решение о масштабировании на организацию в целом по данным трёх кварталов. Обновление положения о питании в полном объёме; годовой отчёт учредителю; обмен опытом — региональная площадка, семинар, публикация практики по образцу тех, кто уже рассказал о своём опыте публично⁵⁶¹⁴. **Результат года:** вариативность — норма организации, документированная, измеренная, защищённая перед проверкой.

36.6. Три типовых сбоя и их профилактика

«**Пилот застрял**» — точка работает год, расширения нет. Причина почти всегда управленческая: нет решения по итогам 90 дней. Профилактика — дата решения в приказе о пилоте, назначенная в день его подписания.

«**Ключевой человек ушёл**» — практика держалась на одном заведующем. Профилактика — документальный комплект и ротация ответственных: практика должна переживать людей (раздел 31).

«**Учредитель молчит**» — отчёты уходят, реакции нет. Профилактика — просить не благословения, а конкретики: согласование перечня позиций, форму отчёта, дату заслушивания. Молчание учредителя — риск раздела 32, и снимать его надо до масштабирования, а не после проверки.

Управленческий вывод

Двенадцать месяцев — это не срок «до красоты», а срок до точки, где откат дороже движения вперёд. Каждый квартал заканчивайте документом и числом: бумага и статистика — единственное, что переживает энтузиазм.

36.7. Карта при нехватке: три ветки обеднённого сценария

Базовая карта предполагает дефолтные ресурсы; честность требует веток для их отсутствия. **Ветка «нет второй гастрೋмкости и не будет»** (кейс 22): весь год строится вокруг предзаказа и буфета; ступень лестницы фиксируется как «максимум для данной инфраструктуры» и не маскируется под полную вариативность; реконструкция — отдельной повесткой с

учредителем ежегодно. **Ветка «нет ставок на помощь»** (кейс 21): год строится вокруг форматов самостоятельности и приоритета риска; замеры трудозатрат идут в запросы ежеквартально; вариативность ограничивается позициями, не требующими дополнительной помощи. **Ветка «учредитель против»**: год строится на замерах и документах без изменения линии (замеры не требуют согласования); собранная доказательная база — предмет повторного разговора на следующий цикл; параллельно — региональная группа семинара как внешний аргумент (раздел 40). Общий принцип веток: обеднённый сценарий — не «урезанный базовый», а другой маршрут к той же ступени; его отличие — темп, а не направление.

36.8. Как карта умирает: предупреждение по датам

Смерть карты имеет расписание: квартал 1 проваливается молча (пилот «не дошёл» — никто не заметил), квартал 2 — громко (первый конфликт с учредителем — и тема заморожена «до лучших времён»), кварталы 3–4 — тихо (усталость, «и так сойдёт»). Против каждой даты — свой предохранитель: для первого — публичный старт (приказ с датами читает весь коллектив, молчать становится неудобно); для второго — заготовленные ответы раздела 38 и поддержка региональной группы; для третьего — промежуточная победа в конце каждого квартала, празднуемая вслух (совету жителей докладывается число, коллективу — результат). Карта без предохранителей — не план, а пожелание.

Рисунок 17. Дорожная карта на 12 месяцев (каждый квартал — самостоятельная ценность)

Квартал 1 ФУНДАМЕНТ	Квартал 2 ГОРИЗОНТАЛЬ	Квартал 3 СТРУКТУРА	Квартал 4 МАСШТАБ
пилот · аудит 24 точки · документальный комплект · клинические блоки подписаны	выбор ежедневно в точке / второе отделение · пересчёт меню по статистике · совет жителей	буфетная зона · семейная подача точно · спецификации закупок · первый отчёт учредителю	решение по данным 3 кварталов · положение полностью · годовой отчёт · обмен практикой

Точка невозврата — квартал 3: система затронула закупки и пространство. Три типовых сбоя и их предохранители — разделы 36.6–36.8.

Раздел 36 доклада.

37. Четырнадцать возражений и честные ответы на них

37.1. Как устроен раздел

Каждое возражение дано в редакции, близкой к тому, как его произносят, — и разобрано без издёвки: большинство возражений содержат рациональное ядро. Ответы опираются на материалы доклада; где данных нет, сказано, что данных нет.

1. «Наши жители не способны выбирать». Ядро правды: часть жителей действительно не выбирает вербально. Ответ: выбор — это каналы, а не анкета: показ, наблюдение, биография, близкие (раздел 15). Австралийский Стандарт 6 с 01.11.2025 требует учитывать предпочтения независимо от когнитивного статуса³⁵. А там, где выбор недоступен и наблюдению, — действует гарантированный стандартный вариант: никто не обязан выбирать, чтобы поесть.

2. «Будут очереди и хаос на раздаче». Ядро: время выбора реально. Ответ: поток решается конструктивно — заказ накануне, визуальное меню до линии, маркировка (раздел 20). Успенский опыт зафиксировал обратное: «страхи не подтвердились»⁵. Замер времени «до/после» в пилоте покажет вашу правду — данные вашей организации важнее чужих гарантий.

3. «Это дорого». Ответ честный: неизвестно, пока не замерено. Сырьевая строка при парных эквивалентах близка к нулю (раздел 29), труд растёт на минуты, отходы могут падать. Но «вариативность бесплатна» — недоказанное утверждение, и доклад его не повторяет. Семь дней замера отвечают на вопрос точнее любой дискуссии.

4. «Санэпид не разрешит». Проверьте, о чём возражение: СанПиН 3590-20 (с 01.09.2026 — 4282-26) регулирует поточность, температуру, пробы — а не число вариантов блюда². Вторая гастрорёмкость на линии — тот же контур, одна дополнительная точка маркировки (раздел 18). Если у санврача конкретное замечание — разбирать конкретику, а не фольклор о нём.

5. «У нас нет диетолога». Правда для большинства организаций — и не препятствие: пары эквивалентов строятся по нутриентной логике меню-

раскладки (раздел 19), клинические вопросы решает врач. Диетолог ускоряет, но его отсутствие не отменяет ни нормы, ни практику внедривших⁵⁶.

6. «Жители будут выбирать нездоровое». Ядро: выбор из пары эквивалентов — это выбор внутри нормы, а не между нормой и вредом (раздел 19). Свобода выбирать «гречку или рис» не создаёт свободы выбирать «гречку или конфеты». Пределы выбора задаёт меню — они и есть инструмент.

7. «А если выбрал, а потом отказался?» Процедура замены: журнал, альтернатива, фиксация (разделы 12, 19). Норма об альтернативе при отказе — федеральная в США³⁶; у нас — выводимая из ст. 37/43 с документированием¹. Эпизоды неизбежны; неизбежность и есть предмет журнала.

8. «Лечебное питание несовместимо с выбором». Совместимо через «мост»: региональные акты связывают СОСО с системой диет (пример — распоряжение 19РВ-32 в ДДСОЛ)²¹, а внутри диеты тоже существуют пары. Диета — это ограничение множества, а не его сжатие до одного элемента.

9. «Персонал против». Обычно против не выбор, а непонятная надбавка к работе. Инструктаж по трём уровням, роли в приказе, ритм планёрок — и главное: персонал участвует в проектировании линии, а не узнаёт о ней из приказа (раздел 28).

10. «Проверка спросит — что ответим?» Документом. Раздел 32 разбирает три типовых вопроса и три документальных ответа. Страх проверки лечится комплектом, а не отказом от практики.

11. «Это всё для маленьких прогрессивных домов, у нас 400 мест». Контрпример: практики внедрены в ПНИ стандартной вместимости⁵⁶, а Иркутская область масштабировала модель регионально¹⁴. Масштаб меняет логику (поточность, заказ накануне), а не принцип.

12. «Зачем, если и так нормально?» «Нормально» чьими мерками? Семидневный замер отходов и журнал отказов за неделю покажут, нормально ли на самом деле. Если после замера всё подтвердится —

доклад отработал: он дал вам инструмент проверки, а не только инструмент изменений.

13. «Кухня не своя — нам не из чего выбирать». Ядро правды: без своей плиты директор не «добавляет вторую кастрюлю» — он меняет спецификацию. Ответ: вариативность на аутсорсинге живёт в восьми строках контракта, а не в желании директора (раздел 42). Если контракт уже идёт и строк выбора нет — пилот начинается с допсоглашения и приёмки, не с линии. Если контракт впереди — осенний календарь закупки (раздел 42.7) важнее любого слайда. Публичных кейсов вариативности именно на аутсорсинге в открытых источниках нет — это пробел доклада, а не доказательство невозможности.

14. «Через четыре дня новый СанПиН — не время экспериментировать». Ядро: 01.09.2026 4282-26 вступает целиком, переходного периода нет². Ответ: новый СанПиН не запрещает число вариантов блюда — он меняет формы бракеража и привязку ППК. Журналы августа не переписываются; с утра 1 сентября открываются новые формы (раздел 18.10, приложение 39). Останавливать выбор «пока привыкнем» — лишняя работа: обе редакции выбор допускают. Если проверка придёт в сентябре, она смотрит сентябрь по новым правилам и август по старым.

Управленческий вывод

Из четырнадцати возражений двенадцать снимаются документами, замерах или конструкцией линии. Тринадцатое снимается спецификацией, не энтузиазмом. Четырнадцатое снимается чек-листом 1 сентября, не паузой. «Зачем» снимается только собственными данными. Начните с замера: он либо развяжет руки, либо закроет вопрос честно.

37.2. Риторика спора: как не проиграть правое дело

Три приёма, которые губят хорошие аргументы в зале директоров. **Первый — моральное превосходство:** «вопрос достоинства» в ответ на вопрос о деньгах. Зал слышит: «денег у меня нет, поэтому я про достоинство». Правильный порядок — сначала механика (замер, пары, поток), потом смысл; никогда наоборот. **Второй — зарубежный аргумент без фильтра:**

«в Онтарио диетолог 30 минут на жителя». Зал слышит про чужие деньги. Правильная подача: «принцип — время специалиста нормируется; наши минуты считаем сами». **Третий — обещание результата:** «отходы упадут на треть». Не упадут у конкретного слушателя — и вся тема дискредитирована. Замена: «замер покажет вашу цифру; вот дома, где после выбора замеряли»⁵. Общая механика этих замен: каждый аргумент доклада построен как «принцип + метод проверки + чужой измеренный факт», и ни один не требует веры.

37.3. Возражение-лакмус: «а сами бы вы так ели?»

Самое короткое и самое точное из всех возражений — оно же тест на честность системы. Отвечать на него оправданиями («для жителей нормально») нельзя — это и есть признание двух сортов. Рабочий ответ — процедурный: еда с линии периодически пробуется руководством (обход с тарелкой, а не с папкой), совет жителей дегустирует, дегустации протоколируются. Дом, где директор не ел свою еду в этом месяце, не имеет права спорить о её качестве — имеет обязанность пойти и поесть. Возражение-лакмус хорошо ещё и тем, что стоит ноль рублей и ставится в чек-лист директора (приложение 18) одной строкой.

38. Десять вопросов учредителю: повестка для разговора наверх

38.1. Зачем этот список

Большинство управленческих решений в СОСО упираются не в закон, а в региональный контур: статус норм, меню, формы учёта, финансирование (раздел 24). Директор часто не знает, что именно спросить, — и спрашивает «можно ли нам», получая в ответ осторожное «не надо». Десять конкретных вопросов превращают разговор с учредителем из просьбы в совместную инженерную задачу. Каждый вопрос сформулирован так, чтобы на него можно было ответить документом.

38.2. Вопросы о нормах и документах

1. Каков статус рекомендованных норм Минтруда (приказ 520н) в нашем регионе — рекомендация или основа императивного регионального норматива?³⁰ От ответа зависит свобода манёвра по парам эквивалентов (раздел 19).

2. Утверждено ли в регионе собственное перспективное меню для СОСО — и если да, какова процедура внесения изменений в него? При императивном меню вариативность начинается с изменения документа, а не линии раздачи (раздел 24).

3. Есть ли в регионе акт, связывающий СОСО с системой лечебного питания (по образцу распоряжения 19РВ-32)²¹ — и если нет, готов ли учредитель его инициировать или санкционировать локальный «мост»?

4. Какая форма учёта продуктов признаётся в регионе актуальной — с учётом поэтапного перехода на электронные формы по приказам Минфина¹⁰³ — и допускает ли она журналы заказа и замен как приложения?

38.3. Вопросы о финансах и закупках

5. Как устроена сырьевая строка нашего финансирования — и можем ли мы публиковать её внутри системы (учредителю и совету жителей) по

итогах квартала? Международный опыт показывает: прозрачность строки работает на её адекватность⁸⁸⁹⁸.

6. Допускает ли действующий контракт (или типовая документация закупок) парные позиции и закупку по фактической статистике выбора — или потребуются изменение спецификаций при следующей закупке (разделы 30 и 42.7)?

7. Как в регионе относятся к аутсорсингу питания — и если он у нас, включает ли контракт требования к вариативности, текстуре и документированию замен? Аутсорсинг без этих строк передаёт подрядчику не только кухню, но и права жителей (разделы 30 и 42).

38.4. Вопросы о полномочиях и развитии

8. Согласен ли учредитель на пилот по модели раздела 35 — одна точка, 90 дней, панель чисел — с заранее оговорённой датой заслушивания итогов? Просьба о пилоте с датой заслушивания — это просьба о решении, а не о благословении; на неё легче ответить «да».

9. Готов ли регион к обмену практиками — и поддержит ли учредитель публичный рассказ о нашем опыте по образцу организаций, уже сделавших это⁵⁶¹⁴? Публичность — защита практики: рассказанное труднее тихо отменить.

10. Что учредитель считает показателями качества питания для нашей организации — и готов ли он включить в них долю выбирающих жителей и уровень отходов? Этот вопрос переводит вариативность из статуса «инициативы директора» в статус «показателя системы» — финальная форма её защиты.

38.5. Как вести сам разговор

Три правила. Первое: каждый вопрос сопровождайте одностраничной справкой (образец структуры — приложение 33) — у чиновника нет времени читать доклад, есть время подписать справку. Второе: не просите всё сразу; оптимальная первая повестка — вопросы 1, 2 и 8 (статус норм, меню, пилот). Третье: фиксируйте ответы письменно, хотя бы служебной

запиской, — не для давления, а для раздела 32: документированная позиция учредителя — половина защиты перед любой проверкой.

Управленческий вывод

Учредитель — не препятствие, а незадействованный ресурс: у него есть то, чего нет у директора, — право менять региональные документы. Десять вопросов — это способ дать учредителю работу, которую он способен выполнить.

38.6. Если ответ «нет»: три уровня отказа и работа с каждым

Отказ учредителя — не точка, а диагностика. **Отказ-ресурс** («нет денег»): самый работоспособный — отвечается списком нулевой стоимости и повторными замера; деньги просятся уже под цифры, а не под идею. **Отказ-риск** («придут — накажут»): отвечается документами раздела 32 и предложением начать с того, что не меняет линию (замеры, карты, совет). **Отказ-статус** («не положено»): самый информативный — просите ссылку на норму; в половине случаев нормы не находится, и «не положено» превращается в «не принято», а это уже разговор о решении, а не о запрете. Во всех трёх случаях отказ фиксируется письменно (вежливо: «по итогам встречи поняли так-то») — зафиксированный отказ работает на вас через год, когда рамка сменится, а устный растворяется. И главное: отказ по одному вопросу не распространяется на остальные девять — повестка раздела построена так, чтобы её нельзя было закрыть одним «нет».

38.7. Когда учредитель — союзник: как не потерять его

Благоприятный учредитель — ресурс со сроком годности (ротации, смена приоритетов). Три правила удержания: отчитываться результатом, а не активностью (панель чисел против красочного рассказа); давать ему его роль публично (упоминание поддержки учредителя в материалах практики — по образцу публикаций внедривших⁵⁶); не подставлять (всё, что несёт риск, приходит к нему с проработанной защитой, а не голым). Союзник, получающий числа, роль и безопасность, остаётся союзником дольше срока ротации.

39. Предложения отрасли: что должно измениться выше уровня учреждения

39.1. Граница раздела

Всё предыдущее — о том, что организация может сделать сама, в действующем правовом поле. Этот раздел — о том, что ей мешает и что решается только на региональном и федеральном уровнях. Предложения сформулированы как повестка для отраслевого обсуждения (в том числе на семинаре), а не как готовые законопроекты: за пределами компетенции доклада — детальное нормотворческое конструирование.

39.2. Пять федеральных предложений

1. Закрепить минимальный стандарт выбора в рекомендованных нормах. Приказ 520н³⁰ задаёт нутриентные рамки; международные системы дополнительно закрепляют структуру выбора (два и более вариантов основных блюд — Онтарио²³, альтернатива при отказе — США³⁶, «что, когда, где и как я ем» — Австралия³⁵). Формула для обсуждения: в рекомендованные нормы — не меню, а принцип «не менее двух вариантов основной позиции там, где это технологически возможно».

2. Урегулировать стык СОСО и лечебного питания. Сегодня приказы Минздрава о лечебном питании адресованы медицинским организациям, а СОСО живут в серой зоне (раздел 17). Варианты решения — совместный акт Минтруда и Минздрава или типовой региональный «мост» по образцу уже существующих²¹. Пока стык не урегулирован, каждая организация решает клинические вопросы на свой страх и риск.

3. Ввести в отраслевую отчётность два показателя: доля жителей, участвующих в выборе питания, и уровень пищевых отходов. Оба — измеримы дёшево (приложения 24–25), оба меняют поведение системы сильнее любых призывов: что измеряется наверху, то организуется внизу.

4. Снять неопределённость с формами учёта. Поэтапный переход на электронные формы (приказы 61н, 142н, 100н, 157н, 174н)¹⁰³ порождает на местах уверенность, что «всё меняется, лучше не начинать». Нужна единая

актуальная справка: какие формы применяются СОСО сейчас и какие — после каждого этапа.

5. Поддержать публикацию практик. Организации, внедрившие вариативность, существуют⁵⁶¹⁴, но их опыт распространяется через новостные ленты, а не через методические каналы. Федеральный (и региональные) сборники практик с документальными приложениями сократили бы цикл внедрения с лет до месяцев.

39.3. Пять региональных предложений

6. Установить статус рекомендованных норм — одним абзацем в региональном акте: рекомендация или императив. Неопределённость статуса — главный тормоз (раздел 24).

7. При императивном меню — предусмотреть процедуру его изменения с участием организаций: кто инициирует, какие обоснования, какие сроки.

8. Ввести региональный «мост» к лечебному питанию там, где его нет, — по готовому образцу²¹.

9. Включить требования к вариативности и документированию в типовые документы закупок и аутсорсинговых контрактов (разделы 30 и 42): контракт без этих строк делает права жителей предметом доброй воли подрядчика.

10. Создать региональную площадку обмена — ежегодный семинар или рабочую группу с публикацией материалов. Иркутский опыт показывает: региональное решение масштабирует практику быстрее, чем усилия отдельных организаций¹⁴.

39.4. Чего доклад не предлагает

Три сознательных умолчания. Не предлагается новый федеральный закон о питании в СОСО: действующая рамка (3185-1, СанПиН, 520н)¹²³⁰ позволяет внедрять главное уже сейчас; проблема — в статусах и стыках, а не в отсутствии закона. Не предлагается обязательная вариативность для всех без переходного периода: у части организаций нет ни кухни, ни смены для второго варианта — принуждение без ресурсов производит фиктивную

вариативность (раздел 21). Не предлагаются числовые нормативы стоимости: честных данных о сырьевой строке российских СОСО в публичном поле нет, и норматив, построенный на отсутствии данных, был бы слопом.

Управленческий вывод

Десять предложений — это повестка, которую директора способны сформулировать сообща лучше, чем поодиночке. Семинар — подходящее место для её согласования; раздел 40 — о том, как это организовать.

39.5. Как предложения становятся нормами: японский таймлайн как учебный

Механика изменения норм видна на японском примере⁹²⁹⁴ в трёх фазах. Фаза 1 — «деньги за добровольность»: надбавка стимулирует авангард, накапливается практика и доказательства. Фаза 2 — «данные»: национальная база делает практику видимой и сравнимой; появляется язык цифр. Фаза 3 — «обязательность»: норма распространяется на всех, когда отрасль уже умеет. Российская повестка раздела стоит сейчас между фазами 1 и 2: авангард есть⁴⁵⁶, данных — нет. Практический вывод для зала: самый продуктивный запрос вверх сегодня — не «разрешите» и не «обяжите», а «считайте»: два показателя в отчётности (предложение 3) запускают фазу 2 без единого рубля и без единого риска. Тот, кто понял таймлайн, не тратит годы на требование фазы 3 из фазы 1.

39.6. Роль профессионального сообщества

Предложения 6–10 реализуются регионами, но иницируются сообществом: именно директора, а не чиновники, знают, где стык болит. Минимальная инфраструктура сообщества по теме: рабочая группа (желательно при существующей ассоциации), ежегодный сбор практик с документами, общий банк локальных форм (приложения доклада — первый взнос). Стоимость — организационная, эффект — соразмерный федеральной программе: методический дефицит, о котором все говорят, ликвидируется именно так и никак иначе.

40. Организационные предложения семинару: как превратить три дня в систему

40.1. Уникальность состава

В зале семинара — руководители стационарных организаций из 51 субъекта РФ (по очищенному списку участников — см. контрольный файл PARTICIPANTS_CLEAN.xlsx). Среди них — как минимум **трое носителей публичной практики**, которые могут ответить не докладом, а вчерашним днём: Успенский ПНИ (Новосибирская область, публикация от 13.08.2024⁵), Усть-Илимская организация (Иркутская область, публикация от 27.09.2024⁶) и ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург, дом докладчика; новость Комитета от 22.07.2025⁷). Рядом — представители региона, где модель масштабирована решением области¹⁴. Новость и публикация — факт сообщения на дату, не аудит устойчивости; в панели это оговаривается в первую минуту. Вопрос «работает ли» задаётся коллеге за соседним столом, а не эксперту с трибуны.

40.2. Пять предложений по формату

1. Живая панель внедривших. Тридцать минут, трое голосов: Успенский, Усть-Илимск и Серафимовский. Не доклады — ответы на заранее собранные вопросы зала: стоимость, страхи, проверки, где ломалось, что не получилось. Дом докладчика говорит первым и коротко: что именно выбрал житель вчера и где полный переход затруднителен⁷ — чтобы панель не выглядела чужой витриной. Ценность формата в статусе говорящих: они не продвигают методику, они отчитываются о своей практике.

2. Работа в региональных группах по карте норм. Каждая группа заполняет шаблон «статус норм моего региона» (форма — в семинарском пакете): статус 520н, наличие регионального меню, «мост» к лечебному питанию, формы учёта. Результат — собранная карта 51 региона: первый срез реальной нормативной географии вместо предположений (раздел 24).

3. Общий замер. Договорённость зала: каждая организация проводит семидневный замер отходов и отказов по единой методике (приложение 25) в один и тот же месяц и сдаёт анонимизированные данные в общий массив.

Через квартал у отрасли появится первая честная статистика — вместо обмена впечатлениями.

4. Резолюция из десяти предложений. Раздел 39 выносится на обсуждение и голосование: какие предложения зал поддерживает, какие — с поправками. Подписанная повестка от 51 региона весит больше, чем любой одиночный запрос учредителю.

5. Дежурная методическая точка. Назначение (волонтёрски) двух-трёх организаций, чей документальный комплект открыт для запросов коллег. Опыт показывает: главный дефицит внедряющих — не знания, а готовые формы, которые «у кого-то уже работают»⁵.

40.3. Чего не делать на семинаре

Три антипаттерна. Не принимать деклараций «о важности питания» — важность консенсусна, дефицит в механизмах. Не собирать «пожелания в федеральный центр» без адресата и срока — такие сборы дискредитируют сам формат. Не соревноваться регионами в красоте презентаций — полезный семинар заканчивается таблицей обязательств (кто, что, к какой дате), а не фотографиями.

40.4. После семинара: минимальная инфраструктура

Через 30 дней — рассылка итоговых материалов (включая заполненную карту норм регионов). Через 90 дней — сбор статусов: кто начал пилот, кто провёл замер, кто получил ответ учредителя. Через 12 месяцев — к следующему циклу встреч: сравнение «до/после» по организациям, участвовавшим в общем замере. Эта инфраструктура стоит часов, а не денег; её отсутствие превращает любой семинар в приятное воспоминание.

Управленческий вывод

Семинар с таким составом — сам по себе ресурс, сопоставимый с годом переписки. Решение, которое стоит принять в первый час: чем именно зал обменяется к последнему дню — контактами или обязательствами.

40.5. Работа зала по часам: конструкция трёх дней

Предложения раздела складываются в тайминг. **День 1** — карта фактов: доклад (45 минут), живая панель трёх внедривших (30 минут), региональные группы заполняют карту норм (60 минут); итог дня — зал знает правовую географию лучше любого федерального органа. **День 2** — методика: разборы кейсов в группах (два блока по 45 минут), экспресс-аудит своей организации каждым участником (10 минут, форма из пакета), общий замер — инструктаж по методике и подписка об участии (45 минут). **День 3** — решения: обсуждение и голосование резолюции (90 минут), таблица обязательств (кто, что, к какой дате — 60 минут), закрытие: назначение дежурной методической точки. Каждый блок заканчивается артефактом (карта, форма, подписка, резолюция, таблица) — семинар, у которого пять артефактов, не нуждается в «итоговом коммюнике о важности».

40.6. Подписка об общем замере: текст

Формулировка, которую зал может принять за минуту и выполнить за неделю: «В период с ____ по ____ наша организация проводит семидневный замер пищевых отходов и отказов по единой методике (приложения 25 и 9 доклада) и передаёт анонимизированные итоги (организация, число жителей, остаток на порцию, эпизоды отказов) в общий массив до ____». Четыре реквизита честности: единая методика обязательна (своя методика у каждого = несравнимые числа); анонимизация на входе (снимает страх «показать плохое»); фиксированный месяц (сезонность); ответная рассылка массива всем участникам (данные принадлежат залу, а не собирателю). Пятьдесят одна организация по этой подписке — первая репрезентативная цифра отрасли по питанию, и получена она будет силами самого зала за семь дней.

41. Заявление о достоверности: что в этом докладе на чём стоит

41.1. Зачем этот раздел

Предыдущие версии материалов на эту тему содержали утверждения без источников, заимствованные цифры и оценки, выдававшиеся за факты (подробный разбор — в контрольном файле AUDIT_OLD_REPORTS.md). Этот раздел — публичная отчётность настоящей версии: какие классы утверждений в ней есть, как каждый подтверждён и где читатель может проверить авторов.

41.2. Классы утверждений и их подтверждение

Нормы права. Каждая ссылка на нормативный акт сопровождается реквизитами и привязкой к реестру источников (SOURCE_REGISTRY.xlsx, 29 записей S001–S030 без S026, даты проверки — июль–август 2026 года). Для каждого акта указано, что именно он подтверждает. Известные ограничения зафиксированы в реестре: по одному акту (упоминавшийся в ранних материалах приказ 940н) подтверждение не найдено — он исключён из аппарата доклада, а не оставлен «на всякий случай».

Клинические данные. Все числовые утверждения о лекарственных взаимодействиях, дисфагии, метаболических эффектах и реабилитации привязаны к реестру клинических источников (MEDICAL_EVIDENCE.xlsx, 48 записей: систематические обзоры, мета-анализы, руководства IDDSI и профессиональных обществ, клинические случаи). Для каждого класса утверждений указан класс уверенности: где доказательства сильны (клозапин — кофеин¹⁶, литий — соль¹⁷), где — ограничены (частота отдельных паттернов пищевого поведения), где отсутствуют (рандомизированные исследования вариативного меню в психиатрии не найдены — раздел 27).

Международные нормы. Все нормы девяти зарубежных систем привязаны к реестру (INTERNATIONAL_PRACTICES.xlsx, 44 записи) с указанием акта, пункта и даты вступления в силу там, где она значима (например, австралийский Стандарт 6 — с 01.11.2025³⁵). Перенос норм на российскую

почву везде обозначен как рекомендация или ориентир, а не как обязанность.

Российская статистика. Числа о системе ПНИ (количество организаций, жителей, доля недееспособных) взяты из вторичной аналитики («Если быть точным» / ТАСС, апрель 2026)²⁰ и везде в тексте помечены как вторичные данные, а не официальная статотчётность. Где данные не удалось подтвердить независимо, это сказано прямо.

Российские практики. Каждая упомянутая практика имеет публичный первоисточник с датой публикации⁴⁵⁶¹⁴²¹⁷. Оценка распространённости практик («мало», «растёт») помечена как интерпретация, основанная на открытом поиске, а не на репрезентативном обследовании — такого обследования не существует.

Числовые примеры и расчёты. Все модельные вычисления (стоимость, время, объёмы) помечены как иллюстративные расчёты с явными допущениями. Формула «вариативность почти бесплатна» из ранних версий удалена как недоказанная; вместо неё — порядок замера.

41.3. Что доклад не знает (честный список пробелов)

Репрезентативной статистики вариативного питания в российских СОСО нет. Рандомизированных исследований эффекта вариативности именно в психиатрических стационарах не найдено. Судебной практики именно о вариативном меню не обнаружено. Данных о сырьевой строке российских СОСО в публичном поле нет. Статус норм в каждом из 51 региона не проверен индивидуально — методика проверки дана (раздел 24), сама проверка — работа региональных групп (раздел 40). Эти пробелы — не извинение, а карта того, где читатель обязан включать собственную проверку.

41.4. Как проверить авторов

Три способа. Первый: реестры источников (три контрольных файла) — каждое утверждение в тексте имеет маркер, каждый маркер — строку реестра с URL и датой проверки. Второй: матрица «утверждение — источник» (CLAIM_SOURCE_MATRIX.xlsx) — полный перечень

фактических утверждений доклада с привязкой. Третий: отчёт о соответствии антислоп-правилам (ANTI_SLOP_REPORT.md) — перечень правил и того, как каждое исполнено. Если читатель нашёл утверждение без маркера или маркер без строки реестра — это ошибка авторов, а не недоразумение читателя.

Управленческий вывод

Достоверность — это не обещание «мы не ошибались», а конструкция «вы можете нас поймать». Все четыре контрольных файла приложены к докладу именно для этого.

41.5. Известные уязвимости этой версии

К заявлению о достоверности честность обязывает приложить список уязвимостей самого доклада. **Первая — датировка:** реестры проверены в июле 2026 года; нормы (особенно региональные и учётные формы¹⁰³) меняются, и перед приказом каждый пункт проверяется заново — доклад обучает этой проверке, но не заменяет её. Пример: СанПиН 2.3/2.4.4282-26 утверждён 02.06.2026 и вступает в силу 01.09.2026, через несколько дней после семинара; в этой версии доклада переход от 3590-20 к 4282-26 зафиксирован, но локальные акты учреждения нужно перепривязать самостоятельно. **Вторая — языковая асимметрия:** международные источники читались в оригиналах на английском; нюансы норм на других языках (немецкие, шведские документы) могли быть сглажены переводом — это отмечено в реестре там, где релевантно. **Третья — отбор практик:** шесть российских практик найдены открытым поиском (одна из них — учреждение докладчика: кейс 25.5, конфликт интересов раскрыт в самом кейсе); организации, внедрившие без публикаций, в доклад не попали физически — выборка практик систематически смещена к публичным. **Четвёртая — собирательные кейсы:** кейсы 1–22 сконструированы из типовых механизмов; они правдивы по механизму и условны по фактуре — и промаркированы соответственно. **Пятая — авторская позиция:** там, где доказательств нет, доклад занимает позицию (например, приоритет зафиксированной воли в конфликте «учреждение = опекун»); позиция аргументирована, но остаётся позицией — и раздел 16 показывает её

границы. Ни одна из пяти уязвимостей не исправляется редактурой; все исправляются только новыми данными — прежде всего теми, которые соберёт сам зал (раздел 40).

42. Аутсорсинг питания: контракт как место вариативности

42.1. Почему это раздел доклада

Питание учреждения всё чаще обеспечивает не собственный пищеблок, а сторонняя организация: регионы централизуют производство в комбинатах питания и фабриках-кухнях, поставщики приходят с готовыми блюдами и своими поварами¹⁰⁴. Для директора это не «передача кухни», а смена модели управления: контракт становится местом, где решается, что и как едят жители. Санитарная рамка такой модели описана в отраслевой литературе и не зависит от того, кто стоит у плиты¹⁰⁴. Честная оговорка: публично подтверждённых кейсов внедрения вариативного меню именно на аутсорсинге в открытых источниках не найдено — это пробел доклада; раздел построен на переносе инструментов глав 19–22 и 30 в контрактную плоскость, а не на подтверждённых примерах. Задача раздела — показать, как вписать выбор в контракт и как проверять аутсорсера, не превращая учреждение в «приёмный пункт тарелок».

42.2. Правовая рамка: кто за что отвечает

Закупка услуг питания для казённых и бюджетных учреждений, как правило, идёт по контрактной системе (ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ)¹⁰⁵. Для автономных учреждений режим может быть 223-ФЗ при наличии положения о закупке — это та же оговорка, что в разделе 30.1, а не формула «всем 44-ФЗ». Санитарная рамка при этом не «уезжает» вместе с кухней: СанПиН 2.3/2.4.4282-26 прямо регулирует привлечённые предприятия. П. 56 подп. 12: при использовании готовых блюд из предприятий общественного питания в организации стационарного социального обслуживания выделяется помещение для приёма готовой продукции и отбора суточных проб — пробы отбирает ответственный работник пищеблока учреждения по процедуре подп. 4 п. 56 (каждое блюдо отдельно, холодные закуски/первые/гарниры/напитки — не менее 100 г, хранение не менее 48 часов при +2...+6 °С)². П. 56 подп. 14: требования пункта распространяются на предприятия, привлекаемые для обеспечения питания организации стационарного социального обслуживания². Раздел VI (кейтеринг): предприятие обязано разработать и соблюдать внутренний

порядок, обеспечивающий прослеживаемость этапов изготовления, перевозки, хранения и реализации и разграничение ответственности; вскрытие упаковок и порционирование — в выделенном помещении (зоне), расположенном в месте оказания услуги². До 01.09.2026 действует аналогичная рамка СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 7.1.11–7.1.14, раздел VI)². Вывод для директора: суточные пробы, бракераж и температура могут быть делегированы контрактом по исполнению, но не по ответственности — перед жителями и проверяющими отвечает учреждение.

42.3. Восемь строк контракта, которые делают вариативность реальной

Развитие раздела 30 применительно к аутсорсингу: **1. Перечень как группы взаимозаменяемых** (группа «крупы гарнирные: гречка, рис, пшено»), а не монопозиция — легализует пары на уровне контракта. **2. Пропорции по статистике выбора** с правом корректировки раз в квартал без изменения сути контракта. **3. Строка выбора:** на приёмах пищи, где заявлена вариативность, предоставляется не менее двух вариантов основных позиций; срыв выбора фиксируется поставщиком в журнале замен и не считается исполнением. **4. Строка замен:** при недопоставке — эквивалент из той же группы по согласованию с учреждением, с актом. **5. Строка качества:** характеристики, значимые для текстур (помол, консистенция полуфабрикатов) — иначе дисфагический контур становится заложником «самого дешёвого фарша» (раздел 10). **6. Строка приёмки:** ответственный от учреждения, форма акта, место и процедура суточных проб по п. 56 подп. 12². **7. Строка состава:** меню-цикл с раскладкой и массой порций — приложение к контракту; сверка с нормами приказа Минтруда 520н³⁰. **8. Строка отчётности:** доля выбора по позициям и остатки по блюдам — ежемесячно; это данные для панели чисел раздела 22. Каждая строка согласуется с контрактной службой заранее; конфликт «меню против контракта» — всегда симптом того, что меню меняли, а спецификацию нет.

Чего нельзя отдать поставщику даже строкой ТЗ. Исполнение можно делегировать, ответственность — нет. В спецификации это формулируется негативным списком: суточные пробы отбирает работник учреждения (п. 56

подп. 12 и подп. 4)²; бракераж приёмки готовой продукции остаётся актом учреждения; список дисфагического риска и текстурные назначения — у врача и поста, не у комбината; эскалация отказа от еды (раздел 12) — маршрут учреждения. Поставщик готовит и привозит; учреждение решает, что безопасно этому жителю сегодня.

42.4. Как проверять аутсорсера без «кухонной войны»

Инструменты доклада работают и по договору. **Замер остатков** (приложение 25) — чужой кухне тоже видно, что не съедается; сверка с закупкой поставщика. **Внезапный контроль линии** в часы раздачи: температура блюд — по технологическим документам (п. 50 СанПиН 4282-26)², соответствие заказанных позиций выданным, наличие стандартного варианта для тех, кто не выбрал (гарантия раздела 21). **Сверка суточных проб:** наличие, маркировка, объём, срок хранения. **Фотофиксация** раздачи и линии — дешёвый и доказательный инструмент: гастрорёмкости, маркировка, температура на термометре. Лица жителей на кадр не попадают — пищевая линия не повод расширять обработку биометрии; персональные данные здоровья остаются в контуре 152-ФЗ (раздел 17.6). **Раз в квартал — совместный разбор панели чисел** с поставщиком: отходы, жалобы, доля выбора. Кейсы 14 (недопоставка) и 22 (одна плита) переносятся на аутсорсинг один в один: перезаказ, форматы без второй линии, претензионная работа по документам. Прокурорский и антимонопольный контуры никуда не исчезают: качество питания — ст. 6.6 КоАП¹¹, сговоры поставщиков — практика ФАС⁷⁴.

42.5. Экономика: почему «дешевле отдать на сторону» — не всегда правда

Полная стоимость приёма пищи в 3–6 раз выше сырьевой строки (раздел 29, канадский аудит)⁵⁶: аутсорсер оптимизирует прежде всего сырьё — самую видимую и самую малую часть стоимости. Поэтому контракт фиксирует не только цену порции, но и её состав: меню-цикл с раскладкой, массу порций, соответствие нормам 520н³⁰. Международный ориентир: британские стандарты питания в стационарах обязательны и для контрактных поставщиков¹⁰⁶; нормы Онтарио применяются независимо от

способа обеспечения питания²³. Экономия, которую обещает аутсорсер, должна быть показана построками (сырьё, труд, энергия, логистика), а не «общей цифрой».

42.6. Управленческий вывод

Аутсорсинг — не конец вариативности, а её новое место: в спецификации, приёмке и отчётности. Инструменты доклада (пары, замер, журналы, суточные пробы) переносятся в контракт дословно — раздел 42.3. Красная линия: учреждение не передаёт по договору контроль качества — его можно делегировать исполнением, но не ответственностью. Если контракт не содержит строк выбора и проб, вариативность в учреждении на аутсорсинге невозможна независимо от желания директора.

42.7. Осенний календарь: когда править ТЗ

Выбор, не попавший в ближайшую закупку, откладывается на весь срок контракта. Календарь — управленческий, не нормативный: конкретные даты закупки у каждого учреждения свои, логика одна.

Сентябрь. Новый СанПиН не повод останавливать выбор (раздел 18.10). Параллельно: семидневный замер и журнал заказа дают числа для спецификации, а не впечатления. **Октябрь.** Восемь строк раздела 42.3 формулируются с контрактной службой; негативный список (пробы, бракераж, дисфагия, эскалация отказа) остаётся у учреждения. **Ноябрь–декабрь.** Если контракт истекает в первом полугодии — строки должны быть в документации сейчас; если контракт длинный и строк нет — готовится допсоглашение, а не «подождём переторжки». **Январь.** Пилот по таблице раздела 35.9: либо линия своей кухни, либо приёмка двух вариантов от поставщика. Пропуск осеннего окна не запрещает замер и журнал отказов — запрещает обещать выбор, которого нет в договоре.

43. Заключение: что остаётся после последней страницы

43.1. Суть доклада в пяти предложениях

Питание в стационарной организации — это не услуга рядом с заботой, а ежедневный тест на уважение, который система сдаёт или проваливает три-четыре раза в день. Правовое поле позволяет организовать выбор уже сегодня: нормы существуют, серые зоны обозначимы, процедуры — описаны в этом докладе. Практика существует и работает — в организациях, представители которых сидят в этом зале⁵⁶⁷, и в регионе, масштабировавшем её решением области¹⁴. Если кухня не своя, то же самое начинается со спецификации, а не с пожелания директору (раздел 42). Доказательная база разной плотности: по клинике и международным нормам она сильна, по эффекту вариативности в психиатрии — почти пуста, и честность обязывает это признавать. Поэтому последнее слово доклада — не «внедряйте», а «измеряйте»: семь дней замера отделяют убеждение от знания.

43.2. Три образа, с которых начинался разговор

В разделе 5 обед собрал пять конфликтов за одним столом: женщина, которой нужно молчание вместо зала; мужчина, чей кофеин и клозапин конфликтуют без ведома кухни¹⁶; житель, чья дисфагия пока видна только внимательной сиделке¹⁵; человек без слов, чьё «не хочу» система пока не умеет услышать; и смена, которая делает всё «как всегда», потому что «как всегда» — единственный доступный ей сценарий. Теперь у каждого из этих конфликтов есть процедура: тихая зона и гибкий формат (раздел 20), лекарственно-пищевая таблица (раздел 11), список риска и текстуры (раздел 10), четыре канала воли (раздел 15), комплект документов и роли (разделы 28, 31). Доклад не обещает, что конфликты исчезнут; он показывает, что они перестают быть безымянными.

43.3. Что изменится для четырёх людей

Для жителя — еда перестаёт быть тем, что происходит с ним, и становится тем, в чём он участвует: называет, показывает, выбирает, отказывается — и отказ не превращается в голод, потому что есть задокументированная

альтернатива. Для сиделки — «покормить» заменяется понятной работой с понятными опорными точками: карта жителя, таблица текстур, правило трёх отказов. Для директора — тема питания выходит из зоны тревожного тумана («придут — спросят») в зону управляемой системы: приказ, журналы, панель чисел, дата заслушивания у учредителя. Для учредителя — появляется работа, которую только он может сделать: статусы норм, «мост» к лечебному питанию, показатели отрасли (раздел 39).

43.4. Первый шаг

Доклад написан так, чтобы его можно было закрыть на любой странице и начать действовать. Если вы закрыли его здесь, первый шаг занимает одну неделю и не требует ничьих разрешений: семидневный замер — отходы, отказы, время раздачи (приложение 25). Для тех, кто уезжает с семинара 27 августа: 1 сентября журналы не переписываются, новые формы бракеража открываются с утра — чек-лист в приложении 39. Что бы замер ни показал, дальше у вас будет не мнение о питании в вашем доме, а знание о нём. Из этого знания — и только из него — растёт всё остальное: пилот, совет жителей, разговор с учредителем, а через год, возможно, ваш рассказ на таком же семинаре — третий рассказ внедривших, которому зал поверит, потому что за ним будут стоять ваши числа.

Человек за столом ждёт не доклада. Он ждёт обеда, в котором есть место его выбору. Теперь вы знаете, как такой обед организовать.

43.5. Письмо директору через год

Представьте: прошёл год после семинара. Один из двух сценариев реализовался. **Сценарий А.** Вы вернулись, положили доклад на полку — тема «сложная, но когда-нибудь». Ничего не изменилось, кроме одного: теперь вы знаете, что у коллег работает, — и каждая жалоба на еду читается иначе. **Сценарий Б.** Вы сделали неделю замера, совет, пилот в одном отделении; панель чисел лежит у учредителя; два варианта второго — обычный день, который уже никто не замечает, как не замечают водопровод. Разница между сценариями — не деньги (пилот М1 дешевле одного ремонтного дня), не разрешения (замеры не требуют согласований), не люди (смена та же). Разница — первая неделя. Всё, что доклад может

сделать, — убедить вас в одном: первая неделя дешевле года сомнений. Далее работают ваши числа, ваш совет, ваши жители, которые впервые скажут, какая каша — их. Этот разговор уже начался в зале. Продолжение — за вашей линией раздачи, в ближайший понедельник, 8:30.

44. Библиография и источники

Полный перечень источников доклада формируется автоматически из трёх контрольных реестров при сборке и приводится далее единым списком со сквозной нумерацией:

- **Нормативные акты, судебная и правоприменительная практика, российские публичные практики** — реестр SOURCE_REGISTRY.xlsx (29 записей, маркеры S001–S030 без S026, даты проверки — июль–август 2026 года);
- **Клинические источники** — реестр MEDICAL_EVIDENCE.xlsx (48 записей: систематические обзоры, мета-анализы, руководства IDDSI и профессиональных обществ, клинические случаи);
- **Международные нормы и практики** — реестр INTERNATIONAL_PRACTICES.xlsx (44 записи: законы, подзаконные акты, стандарты, отчёты аудиторов девяти систем).

В тексте доклада каждый источник приводится в сноске в месте первого упоминания; повторные ссылки указывают на номер сноски. Список ниже сгруппирован по реестрам и дублирует сноски для удобства печатного чтения.

Часть II. Учебные кейсы (22 разбора)

Двадцать два ситуационных разбора переводят материал разделов в плоскость ежедневных решений: что нельзя делать, что сделать немедленно, кто принимает решение, какие документы нужны, каково долгосрочное решение и где граница вывода. Все кейсы — учебные, составленные для анализа; они не описывают конкретные организации и людей. Формат разбора на семинаре: 15 минут на кейс по восьми пунктам структуры.

Учебные кейсы 1–4

Все кейсы в этом блоке — учебные ситуации, составленные для анализа. Они не описывают конкретные организации и конкретных людей. Правовые и медицинские основания приводятся как ориентиры для разбора, а не как заключение по реальному делу.

Кейс 1. Один вариант закончился до подхода последнего отделения

Ситуация. На обед два варианта второго: гречка с котлетой и рис с рыбой. Рыба закончилась на третьем из пяти отделений. Последние два отделения получают только гречку; часть жителей выбирала рыбу утром по визуальному меню.

Проблема. Выбор оказался реальным для первых отделений и фиктивным для последних — это срыв выбора, который система обязана фиксировать, а не «неудачный день».

Что нельзя делать. Выдавать гречку молча, без объяснения; переписывать лист заказа задним числом; делать вывод «вариативность не работает» по одному эпизоду.

Немедленно. Предложить замену из остатков линии (гарнир альтернативный, если есть) и зафиксировать эпизод в журнале срывов выбора: дата, позиция, сколько порций не хватило, кому предложена замена.

Кто принимает решение. Старшая смены раздачи — о замене на месте; заведующий производством — о причине (неверный расчёт заказа или неверная статистика выбора).

Документы. Журнал срывов выбора (приложение 8), журнал заказа (приложение 7).

Долгосрочное решение. Пересчёт объёмов по статистике выбора за 2–4 недели (раздел 21): обычно реальное распределение отличается от «пятьдесят на пятьдесят», которое кухня заложила по умолчанию. Запасной норматив: стандартный вариант готовится с резервом, вариативный — по статистике.

Основания. Логика альтернативы при недоступности выбранного соответствует норме о замене при отказе (42 CFR §483.60 — как международный ориентир)³⁶; в российской рамке — исполнение обязанности обеспечить питание по СанПиН 2.3/2.4.3590-20² и уважение достоинства (ст. 37, 43 закона 3185-1)¹.

Ограничение вывода. Один эпизод — не статистика; решения по объёмам принимаются только по серии записей журнала.

Кейс 2. Человек выбирает блюдо, противопоказанное по назначению врача

Ситуация. Житель с назначенной диетой с ограничением соли настойчиво просит солёную рыбу, которую ест его сосед по столу. Житель дееспособен, настроение решительное.

Проблема. Столкновение двух легитимных норм: права на выбор и врачебного назначения. Серая зона, в которой персонал чаще всего ошибается в обе стороны — либо запрещает «вообще всё», либо пускает на самотёк.

Что нельзя делать. Решать вопрос на линии раздачи силой авторитета смены; давать запрещённое «чтобы не скандалил»; устраивать публичное выяснение диагноза при других жителях.

Немедленно. Предложить разрешённый эквивалент из меню; спокойно сообщить, что вопрос солёного — к врачу сегодня же; зафиксировать запрос.

Кто принимает решение. Врач — единолично: он может скорректировать назначение, подтвердить ограничение и разъяснить его жителю, или назначить исключение с фиксацией риска. Персонал и директор назначения не меняют.

Документы. Пищевая карта с назначением, запись врача, при изменении назначения — обновлённая карта.

Долгосрочное решение. Правило в положении о питании: конфликт «выбор против назначения» всегда уходит врачу в день возникновения;

меню проектируется так, чтобы у диетических столов тоже были пары эквивалентов (раздел 19).

Основания. Врачебное назначение — акт профессиональной компетенции, которую персонал СОСО не имеет права пересматривать; стык соцобслуживания и лечебного питания решается через региональный «мост» (раздел 24, пример — распоряжение 19РВ-32)²¹. Право на выбор сохраняется внутри назначенных рамок (ст. 37, 43 закона 3185-1)¹.

Ограничение вывода. Кейс не решает вопрос «кто прав» — он задаёт маршрут решения. Содержательный ответ в каждом случае даёт врач.

Кейс 3. Недееспособный житель показывает на фотографию блюда

Ситуация. На визуальном меню из фотографий житель с выраженным когнитивным снижением уверенно тычет пальцем в борщ. Сиделка говорит: «Он всегда на первую картинку показывает, это не выбор».

Проблема. Как отличить выбор от рефлекса — и кто имеет право объявить жест жителя «не выбором».

Что нельзя делать. Игнорировать жест, потому что «всё равно не выбор»; исполнять жест без проверки, если тот же человек показывает на любую первую картинку в любой ситуации; исключать жителя из процедуры выбора навсегда по одному наблюдению.

Немедленно. Проверка простым тестом: поменять порядок фотографий. Если житель показывает на борщ независимо от его позиции — это выбор; если всегда на первую картинку — это позиция, а не содержание. Зафиксировать результат в форме наблюдения.

Кто принимает решение. Смена фиксирует наблюдение; вывод о характере предпочтений заносится в пищевую карту по итогам нескольких наблюдений — решением, в котором участвует знающий жителя персонал, а при возможности — близкие (раздел 15).

Документы. Форма наблюдения за невербальным выбором (приложение 6), пищевая карта.

Долгосрочное решение. Индивидуальный протокол выбора для жителя: формат показа (две карточки, а не пять), время, проверка позиционного эффекта раз в месяц — предпочтения и способности меняются.

Основания. Обязанность учитывать предпочтения независимо от когнитивного статуса прямо закреплена в международных нормах (австралийский Стандарт 6 с 01.11.2025³⁵; Онтарио — учёт preferences в плане питания²³). В российской рамке — реализация ст. 37 через процедуру¹.

Ограничение вывода. Тест с перестановкой — скрининг, а не психологическая диагностика; он упорядочивает наблюдение, но не подменяет знание человека.

Кейс 4. Персонал заполняет лист выбора заранее

Ситуация. Заведующая отделением обнаруживает: лист заказа на завтра заполнен сегодня днём — до того, как жителям показывали меню. Сиделка объясняет: «Так быстрее, я и так знаю, кто что ест».

Проблема. Фиктивная вариативность в чистом виде: процедура существует, выбора нет. Дополнительный риск — документы, которые при проверке «докажут» то, чего не было (раздел 21).

Что нельзя делать. Устраивать показательный разбор при смене; списывать на «лень» — причина почти всегда в дефиците времени на процедуру; отменять журнал как «бесполезный» (проблема не в журнале, а в его наполнении).

Немедленно. Аннулировать предзаполненный лист, провести процедуру выбора с жителями заново в тот же вечер, поговорить с сиделкой о том, сколько времени реально занимает показ меню.

Кто принимает решение. Заведующая отделением — о процедуре; директор — если причина в объективном дефиците времени смены (тогда вопрос о нормах нагрузки, раздел 28).

Документы. Журнал заказа, служебная записка о нарушении процедуры, при повторении — материалы внутренней проверки.

Долгосрочное решение. Сделать процедуру выполнимой: визуальное меню висит заранее, показ занимает минуты на человека, выбор фиксируется в присутствии жителя. Проверка реальности выбора (приложение 24): случайный опрос пяти жителей «что вы вчера заказывали» раз в неделю.

Основания. Документ, не соответствующий фактам, — худшая из позиций перед любой проверкой (раздел 32); смысл норм о выборе — реальная, а не бумажная альтернатива³⁶²³.

Ограничение вывода. Эпизод не доказывает злого умысла: «я знаю, кто что ест» часто правда по содержанию — проблема в подмене процедуры знанием.

Учебные кейсы 5–8

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.

Кейс 5. Житель отказывается от еды из-за подозрения в отравлении

Ситуация. Житель с психотическим расстройством второй день не ест: «Здесь отравлено». Убеждать бесполезно — убеждение бредовое. Вес пока стабилен.

Проблема. Отказ от еды, встроенный в клиническую картину: стандартные приёмы убеждения не работают, а бездействие опасно.

Что нельзя делать. Доказывать, что еда не отравлена (логика против бреда не работает и усиливает недоверие); кормить принудительно — насилие недопустимо ни в какой форме (раздел 12); ждать «пока проголодается» без мониторинга.

Немедленно. Врач — в тот же день (правило трёх отказов здесь срабатывает раньше: бредовая мотивировка — клинический сигнал сама по себе). Рабочие приёмы смены, не нарушающие доверия: запечатанная упаковка, еда из общего котла при жителе, выбор жителем конкретной тарелки из нескольких, участие знакомого человека, которому он доверяет.

Кто принимает решение. Врач — о клинической тактике (включая коррекцию терапии); смена — о формате подачи; директор — об организационных условиях (возможность выбора тарелки, упакованные продукты).

Документы. Журнал отказов (приложение 9), запись врача, динамика веса.

Долгосрочное решение. Индивидуальный план питания на период обострения: форматы еды, которые минуют бредовый фильтр (упаковка, «магазинные» продукты, приготовление на глазах там, где возможно). Это ситуация, где структурированная доступность еды (раздел 13) буквально спасает нутритивный статус.

Основания. Недопустимость принудительного кормления — из ст. 37 закона 3185-1 (гуманное обращение)¹; риск недоедания при отказах —

клиническая проблема с документированной летальной значимостью (пневмония, истощение)¹⁵⁸.

Ограничение вывода. Приёмы «обхода» бреда — тактика на обострение, а не постоянная модель; по выходе из обострения формат пересматривается врачом.

Кейс 6. Житель спит во время завтрака из-за седативного эффекта

Ситуация. Вечерний приём препаратов перенесён на 22:00 по новой схеме. Утром пятеро жителей спят через завтрак; к 11:00 они голодны и раздражительны, кухня завтрак уже убрала.

Проблема. Конфликт фармакологии и распорядка: режим питания не подстроен под реальный ритм жителей.

Что нельзя делать. Будить насильно «потому что завтрак»; оставлять без завтрака «виноваты сами»; менять время приёма препаратов самостоятельно — это компетенция врача.

Немедленно. Организовать сохранение завтрака для спящих (отложенные порции — с соблюдением температурного режима и сроков, это решаемая санитарная задача, раздел 18) и сообщить врачу о картине утра.

Кто принимает решение. Врач — о времени приёма препаратов (перенос на более ранний вечер часто решает проблему); заведующий производством — о формате отложенного завтрака; директор — о распорядке.

Документы. Распорядок, запись врача о времени приёма, журнал выдачи отложенных порций.

Долгосрочное решение. Гибкое окно завтрака (например, 8:00–9:30) вместо точки 8:30; согласование распорядка с врачебным назначением как постоянная процедура при каждой смене схем терапии.

Основания. Режим питания СОСО по СанПиН — не реже трёхразового с учётом заключения врача для нуждающихся (п. 7.1.11–7.1.14 3590-20; с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 4282-26)²; седация как побочный эффект и её влияние на режим — клиническая реальность антипсихотической

терапии⁶¹. Международный ориентир гибкости: «что, когда, где и как я ем» (Стандарт 6)³⁵.

Ограничение вывода. Гибкое окно — не отмена режима, а его диапазон; санитарные требования к температуре и срокам выдачи сохраняются в полном объеме.

Кейс 7. Два жителя отбирают еду друг у друга

Ситуация. За столом на шестерых один житель систематически забирает котлету у соседа, тот не сопротивляется, но потом доедает хлеб с чаем. Смена «не замечает»: вмешательство провоцирует агрессию.

Проблема. Скрытое недоедание одного жителя плюс пищевая агрессия другого — ситуация, где молчание смены подписывает обоих в риск.

Что нельзя делать. Наказывать отбирающего лишением еды (еда — не инструмент вознаграждения и наказания, раздел 20); садить «обидчика» в одиночку навсегда без наблюдения; считать «они сами разберутся».

Немедленно. Рассадка: развести по разным столам сегодня же; потерпевшему — гарантированная полная порция под наблюдением; фиксация эпизода.

Кто принимает решение. Старшая смены — о рассадке; врач — об оценке пищевого поведения отбирающего (гиперфагия, импульсивность, когнитивное снижение — разные механизмы, раздел 13); заведующая отделением — о постоянной схеме столов.

Документы. Запись об инциденте, пищевые карты обоих, при повторении — протокол разбора (приложение 34).

Долгосрочное решение. Схема рассадки как документ отделения (кто с кем сидит и почему); для жителя с гиперфагией — структурированный режим доступности еды, снижающий «охоту» за чужими порциями (раздел 13); для потерпевшего — контроль веса.

Основания. Пищевая агрессия и гиперфагия — описанные паттерны поведения при психических расстройствах⁴⁰¹⁰⁷; обязанность защищать

жителя от вредного воздействия других жителей — из общей логики ст. 37¹.

Ограничение вывода. Рассадка — рабочий инструмент, а не наказание; схема пересматривается, а не закрепляется пожизненно.

Кейс 8. Человек быстро заглатывает куски

Ситуация. Житель ест очень быстро, не прожёвывая, большими кусками. Дважды за месяц — эпизоды поперхивания с кашлем. Врач в отпуске, замещающий придёт через неделю.

Проблема. Быстрое заглатывание — фактор риска аспирации; ожидание врача неделю без промежуточных мер — неоправданный риск.

Что нельзя делать. Ждать врача без каких-либо изменений; переводить на полностью протёртое «на всякий случай» без назначения (излишняя модификация текстуры ухудшает качество жизни и питательность); отбирать еду темпом («есть медленно!» — команда не работает).

Немедленно. Организационные меры, не требующие назначения: меньшие порции с добавкой, а не большая порция сразу; куски меньшего размера по просьбе повара (это сервировка, не диета); напиток под рукой; место за столом в поле зрения смены; никакой спешки — его стол обслуживается первым, чтобы убрать мотив «надо успеть».

Кто принимает решение. Смена — о сервировке и наблюдении; замещающий врач — о скрининге дисфагии по прибытии; при повторном поперхивании — врач вне очереди (поперхивание с кашлем — признак из списка дисфагического риска, раздел 10).

Документы. Форма наблюдения, запись о поперхиваниях, после врача — при подтверждении риска, назначение текстуры по IDDSI⁴².

Долгосрочное решение. Скрининг дисфагии и при подтверждении — текстура, темповые техники, позиция за столом; обучение смены приёмам безопасного кормления (раздел 10).

Основания. Поперхивание при еде — маркер риска аспирационной пневмонии, самого летального осложнения дисфагии⁹⁴¹; связь текстуры с исходами показана в исследованиях внедрения IDDSI⁴³.

Ограничение вывода. Организационные меры — мост до врача, а не замена скрининга; «ест дважды поперхнулся» — достаточное основание для внеочередной оценки.

Учебные кейсы 9–12

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.

Кейс 9. Кухня приготовила протёртое блюдо, не соответствующее назначенной текстуре

Ситуация. Жителю назначена текстура IDDSI 6 (мягкая, кусочками). Кухня приготовила «как обычно протёртое» — однородное пюре (это IDDSI 4). Разница видна невооружённым глазом, но не тому, кто не обучен.

Проблема. Ошибка в обе стороны опасна: слишком грубая текстура — риск аспирации; слишком гладкая (как здесь) — избыточная модификация: меньше питательной плотности, хуже сытость, унижающий «детский» вид тарелки.

Что нельзя делать. Выдать как есть («протёртое же»); разбавлять пюре водой или бульоном «до нужной консистенции» — это меняет и текстуру, и питательность непредсказуемо; считать, что «пюре безопаснее, пусть будет пюре» — избыточная модификация тоже вред.

Немедленно. Не выдавать; приготовить/выдать порцию назначенной текстуры из доступных компонентов (мягкие кусочки — котлета, тушёные овощи — есть в стандартном меню); зафиксировать несоответствие.

Кто принимает решение. Заведующий производством — о порции сегодня; врач — если несоответствие повторяется (возможно, назначение не доведено до кухни корректно); директор — если причина в отсутствии обучения кухни шкале IDDSI.

Документы. Назначение текстуры в пищевой карте и на кухонной карточке, запись о несоответствии.

Долгосрочное решение. Кухонная карточка текстур: на стене кухни — вилка IDDSI с фотографиями из собственного меню; обучение поваров тесту вилок и тесту наклона (занимает минуту на блюдо, раздел 10); контрольная проверка текстур старшей сменой при выходе линии.

Основания. IDDSI — международный стандарт описания текстур⁴²; внедрение стандарта улучшает соответствие назначенной текстуры

фактической⁴³; исполнение врачебного назначения — обязанность, вытекающая из п. 7.1.12 СанПиН 3590-20 (с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 4282-26: питание по медицинским показаниям)².

Ограничение вывода. Самопроверка текстур кухней — организационная мера; ответственность за назначение и его пересмотр остаётся на враче.

Кейс 10. Родственник требует запретить продукт без врачебного назначения

Ситуация. Дочь жителя требует: «Уберите отцу сахар совсем — у него преддиабет, я читала». Врачебного назначения по сахару нет. Отец сахар любит, споров не хочет, на вопросы отмалчивается.

Проблема. Третья сторона (родственник) требует ограничить права жителя без клинического основания — конфликт заботы, контроля и автономии.

Что нельзя делать. Исполнить требование молча («родственникам виднее») — это ограничение жителя без основания; отмахнуться («вы нам не указ») — родственник важен и может знать реальные факты; втягивать жителя в спор «кто главнее».

Немедленно. Зафиксировать запрос письменно (форма — заявление родственника); маршрутизировать врачу: если есть клинические основания — врач назначит; если нет — врач разъяснит родственнице. Позицию самого жителя выяснить отдельно и спокойно.

Кто принимает решение. Врач — о клинической стороне; житель (дееспособный) — о собственном питании в пределах назначений; директор — о регламенте приёма таких заявлений.

Документы. Заявление родственника, запись врача, пищевая карта (позиция жителя).

Долгосрочное решение. Регламент «третьих сторон»: любой запрос на ограничение — только через врача и только с учётом позиции жителя; памятка родственникам (приложение 32) с этим регламентом — большинство конфликтов снимается заранее объявленным правилом.

Основания. Права жителя не ограничиваются по требованию третьих лиц без оснований (ст. 37, 43 закона 3185-1)¹; участие близких в пищевой биографии приветствуется как источник информации, но не как источник запретов (раздел 15).

Ограничение вывода. Если житель недееспособен и опекун — учреждение, конфликт интересов разбирается по процедуре раздела 16: зафиксированные предпочтения жителя имеют приоритет над «усреднённым благом».

Кейс 11. Житель требует добавку при медицинском ограничении

Ситуация. Житель с ожирением на фоне терапии (набор веса — известный эффект его препаратов) требует вторую порцию каждый обед. Врач рекомендовал контроль калорийности. Житель кричит: «Вы меня морите голодом».

Проблема. Гиперфагия лекарственного генеза против назначенного ограничения; публичный конфликт за столом дестабилизирует всё отделение.

Что нельзя делать. Давать добавку «чтобы замолчал» — назначение обесценивается ежедневным исключением; читать нотации о весе при всех; оставлять конфликт на уровне «сиделка решает каждый день по настроению».

Немедленно. Дать запланированную порцию спокойно и без лекции; эскалация врачу — не «жалоба на жителя», а запрос на пересмотр тактики: возможно, нужны низкокалорийные объёмные добавки (овощи), дробность, пересмотр препарата.

Кто принимает решение. Врач — о назначении и его коррекции; смена — исполняет назначение одинаково каждый день; директор — обеспечивает кухне возможность низкокалорийных объёмных добавок.

Документы. Назначение врача, пищевая карта, динамика веса, записи о конфликтах.

Долгосрочное решение. Структурированный ответ на гиперфагию (раздел 13): объёмные низкокалорийные компоненты, дробный режим, ночная

доступность там, где ночное едение — часть картины. Метаболический мониторинг веса, глюкозы, липидов — по стандартам для его терапии⁶¹⁵⁹.

Основания. Набор веса на антипсихотиках — документированный дозозависимый эффект¹⁰⁶⁰; гиперфагия и ночное едение описаны как специфические синдромы⁴⁰; обязанность исполнять назначение — из п. 7.1.12 СанПиН 3590-20 (с 01.09.2026 — п. 56 подп. 11 4282-26)².

Ограничение вывода. «Добавка или нет» — не вопрос дисциплины, а вопрос назначения; любое смягчение — только через врача, любое ужесточение — тоже.

Кейс 12. Выбор есть только на бумаге

Ситуация. Положение о вариативном питании утверждено полгода назад. Проверка показывает: меню с двумя колонками висит, но кухня готовит один вариант — «второй никто никогда не заказывал». Журнал заказов пуст.

Проблема. Фиктивная вариативность организационного (а не операционного, как в кейсе 4) масштаба: система самообмана, которая при проверке превращается в обман документальный.

Что нельзя делать. Считать «положение есть — практика есть»; наказывать кухню (она рационально адаптировалась к нулевому спросу); тихо снять колонку меню и забыть.

Немедленно. Диагностика по пяти признакам фиктивной вариативности (раздел 21): знают ли жители о выборе; показывает ли кто-то меню; реально ли второй вариант приготовить; что с журналом; спросить пятерых жителей «вы знали, что можно выбрать?».

Кто принимает решение. Директор — это провал внедрения, а не исполнителей: процедура выбора не была встроена в ритм отделений.

Документы. Положение, меню, журнал, результаты диагностики, служебная записка.

Долгосрочное решение. Перезапуск как пилот (раздел 35): одна точка, показ меню как обязанность смены, журнал, замер через 90 дней. Положение без процедуры — предмет для переписывания, а не для полки.

Основания. Различие «документ — практика» — ядро проверок реальности выбора в международных системах (рейтинги CQC оценивают фактический опыт жителей, а не положения)³⁹; ответственность за соответствие документов практике — управленческая (раздел 33).

Ограничение вывода. Нулевой спрос в первые недели — норма (эффект новизны работает в обе стороны); вывод о фиктивности делается по данным месяцев, а не дней.

Учебные кейсы 13–16

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.

Кейс 13. Бухгалтерия не может связать выбор со списанием

Ситуация. Вариативная линия работает месяц. Бухгалтерия: «Журнал заказа живёт в отделении, списание продуктов идёт по укрупнённым нормам — как нам свести, сколько гречки и сколько риса списать?»

Проблема. Учётный разрыв: вариативность породила два потока данных (заказы и склад), которые не соединены. Риск — необоснованное списание при первой же финансовой проверке.

Что нельзя делать. Списывать «как раньше, пополам» — фиктивная точность хуже честного метода; требовать от бухгалтерии «разобраться самим» — им не хватает данных отделений; сворачивать вариативность из-за учётной трудности (это решаемая задача, раздел 29).

Немедленно. Назначить ответственного за сведение: ежедневные итоги журнала заказа (сколько порций какого варианта выдано) передаются в бухгалтерию по простой форме — одна строка на позицию.

Кто принимает решение. Главный бухгалтер совместно с заведующим производством — о методике списания по фактической выдаче; директор — приказом закрепляет форму и ответственных.

Документы. Форма сведения (приложение 7 + учётная форма), приказ о порядке учёта вариативных позиций, действующие учётные формы по 52н с учётом переходного статуса¹⁰³.

Долгосрочное решение. Списание по факту выдачи: статистика выбора за месяц автоматически даёт пропорцию списания парных продуктов. Уточнить у учредителя признаваемую форму — статусы форм меняются поэтапно¹⁰³.

Основания. Принцип достоверности учёта; методика «выдано по заказам = списано по пропорции» — стандартное решение поточных кухонь, а не изобретение.

Ограничение вывода. Методика — предмет согласования с учредителем и учётной политикой организации; приложение — проект локальной формы, не норматив.

Кейс 14. Поставщик не привёз один из вариантов

Ситуация. По контракту на завтра — рыба для вариативной позиции. Поставщик звонит вечером: рыбы нет, будет курица. Заказы жителей собраны, треть выбрала рыбу.

Проблема. Разрыв цепочки «закупка — меню — заказ»: выбор сделан под продукт, которого не будет.

Что нельзя делать. Молча заменить рыбу курицей во всех порциях; объявить «завтра без выбора» как новую норму; устроить скандал поставщику без документирования факта нарушения (претензионная работа живёт на бумаге, раздел 30).

Немедленно. Повторный показ меню вечером: «рыбы завтра не будет, есть курица и второй вариант — перезаказ». Опыт показывает: при честном перезаказе почти весь спрос перераспределяется без конфликтов.

Кто принимает решение. Заведующий производством — о замене позиции; старшая смены отделений — о перезаказе; ответственный за контракт — о претензии поставщику.

Документы. Акт о недопоставке, претензия по контракту, запись о перезаказе в журнале заказа.

Долгосрочное решение. В спецификации закупки — правило взаимозаменяемости с нутриентными эквивалентами (раздел 30); резервная пара позиций из долгохранящихся продуктов на случай срыва поставки; статистика срывов — аргумент при следующей закупке.

Основания. Исполнение контракта и претензионная работа — 44-ФЗ и условия контракта; гарантия полноценного приёма пищи при срыве — из обязанности обеспечить питание².

Ограничение вывода. Единичный срыв — рабочая ситуация; систематические срывы — повод для пересмотра отношений с поставщиком по документам, а не по накопленному раздражению.

Кейс 15. Персонал использует десерт как поощрение

Ситуация. В отделении укоренилось: «Кто убрал за собой — получает компот с булочкой, кто нет — просто компот». Сиделки считают это педагогикой.

Проблема. Еда превращена в инструмент управления поведением — прямое нарушение принципа «питание — право, а не награда» (раздел 20) и нормы о гуманном обращении.

Что нельзя делать. Закрывать глаза «мелочь же» — из таких мелочей собирается культура столовой; наказывать сиделок без объяснения (практика укоренилась, значит, её никто не останавливал — вина системная); запрещать булочки «чтобы не было соблазна».

Немедленно. Прекратить дифференциальную выдачу сегодня же: десерт получают все по норме. Разговор со сменой — не о «плохих людях», а о правиле и его основаниях.

Кто принимает решение. Заведующая отделением — о прекращении практики; директор — о фиксации правила в документах; врач — если у кого-то ограничения по сладкому (тогда альтернатива, а не лишение).

Документы. Правило в положении о питании («пища не используется как поощрение или наказание»), памятка персоналу (приложение 31), запись об инструктаже.

Долгосрочное решение. Инструктаж первого уровня (раздел 28) с этим правилом в явном виде; включение правила в контрольные вопросы обходов; для сиделок — легальные инструменты поощрения (словесные, режимные, привилегии, не связанные с едой).

Основания. Гуманное обращение и недопустимость лишения питания — ст. 37 закона 3185-1¹; использование еды как рычага — маркер институциональной культуры, который международные системы оценки (CQC) трактуют как дефект ухода³⁹.

Ограничение вывода. Правило касается еды как рычага; оно не запрещает ни праздничные столы, ни совместную готовку как деятельность — граница в условности («получишь, если»).

Кейс 16. Житель не говорит, но систематически оставляет одну кашу

Ситуация. Немой житель два месяца подряд не трогает манную кашу — ест всё остальное. Смена выводит: «не ест манную». Диетолога нет, врач говорит: «раз ест остальное — порядок».

Проблема. Классический случай невербального сообщения, которое система уже расшифровала — но не закрепила: предпочтение живёт в голове смены и умрёт с её ротацией.

Что нельзя делать. Продолжать выдавать манную «по меню» и выбрасывать — это и отходы, и ежедневное игнорирование сказанного; делать из одного наблюдения теорию («у него аверсия к текстуре» — возможно, но это уже гипотеза для наблюдения, раздел 15); оставлять знание неформальным.

Немедленно. Занести в пищевую карту: «манную не ест (наблюдение, 2 мес.) — замена: любая другая каша». Проверить замену: при выдаче другой каши — ест.

Кто принимает решение. Смена фиксирует; заведующая отделением утверждает запись в карте; врач — если появятся признаки, что дело не во вкусе, а в текстуре или глотании (раздел 10).

Документы. Пищевая карта, форма наблюдения (приложение 6).

Долгосрочное решение. Регулярный пересмотр пищевых карт (раз в квартал): предпочтения меняются, и карта должна быть живым документом; замены из карты — в статистику планирования закупок (раздел 21).

Основания. Наблюдение — легитимный канал воли невербального жителя (раздел 15); учёт предпочтений независимо от способности их высказать — международная норма³⁵²³.

Ограничение вывода. Запись «не ест манную» — фиксация наблюдаемого, а не диагноз; при появлении признаков дисфагии маршрут меняется на клинический.

Учебные кейсы 17–20

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.

Кейс 17. Житель хочет есть позже установленного времени

Ситуация. Ужин в 17:30. Житель годами привык ужинать дома в 20:00 — в 17:30 он не голоден, к 20:00 голоден и зол. Просит «просто оставить мне тарелку».

Проблема. Режим против биографии: одна из самых частых и самых решаемых точек трения (раздел 9).

Что нельзя делать. Отвечать «режим для всех один» — режим инструмент, а не ценность; оставлять тарелку на столе на 2,5 часа — санитарно недопустимо (температура, сроки); делать вид, что просьбы не было.

Немедленно. Отложенная порция с соблюдением правил: порция снимается с линии, хранится по температурному режиму, выдаётся в 20:00 (или организуется поздний перекус — чай, выпечка, кефир — из буфетной зоны, если она есть).

Кто принимает решение. Старшая смены — о ежедневной отложенной порции; заведующий производством — о её санитарно корректной схеме; директор — если вопрос системный и таких жителей много (тогда — сдвиг режима или второе окно ужина).

Документы. Пищевая карта (привычное время), распорядок с правилом отложенных порций, журнал выдачи.

Долгосрочное решение. Гибкие окна приёмов пищи (раздел 20) и ночная доступность там, где она показана (раздел 13); при массовом запросе — пересмотр самого распорядка: международный опыт идёт к «когда я ем» как элементу прав³⁵, а шведская норма ночного интервала (не более 11 часов) показывает: режимы проектируются от физиологии, а не от удобства кухни³¹.

Основания. СанПиН задаёт кратность (не реже трёхразового) и учёт заключения врача, а не астрономическое время ужина²; право на привычный ритм — элемент уважения биографии (ст. 37)¹.

Ограничение вывода. Отложенная порция — сервис для отдельных жителей; при превращении исключения в массовую практику менять надо режим, а не плодить исключения.

Кейс 18. В отделении не хватает работников для помощи за столом

Ситуация. В отделении 12 жителей нуждаются в помощи при еде. В смену — две сиделки. Норма помощи под «готовые руки» (1:2)²³ выполняется формально: кормят всех одновременно, темп конвейерный, двое жителей регулярно не доедают.

Проблема. Дефицит рук — самая дорогая и самая честная проблема питания (раздел 28): она не решается ни журналами, ни меню.

Что нельзя делать. Ускорять кормление («по ложке в минуту») — это прямой риск аспирации и ежедневное унижение; переводить всех на пюре «чтобы быстрее елось» без назначения; писать в документах, что помощь оказывается «в полном объёме».

Немедленно. Распределить помощь по приоритету риска: сначала жители с дисфагическим риском (список из раздела 10); для остальных — форматы, снижающие потребность в руках: порционная сервировка, адаптивная посуда, рассадка «помогающий между двумя нуждающимися». Зафиксировать дефицит служебной запиской директору — это документ для раздела 38.

Кто принимает решение. Директор — о перераспределении смен между отделениями и о запросе учредителю (форма сообщения о дефиците — приложение 33); старшая смены — о приоритете внутри смены.

Документы. Список дисфагического риска, служебная записка о дефиците, форма учёта трудозатрат (приложение 26) — замер реальных минут помощи.

Долгосрочное решение. Замер трудозатрат кормления (минуты на жителя × число нуждающихся × приёмы пищи) — единственный честный аргумент в разговоре о ставках (раздел 29: стоимость кормления — самая скрытая строка)⁵⁶. Параллельно — форматы самостоятельности там, где они возможны (адаптивная посуда, «семейная» подача части блюд).

Основания. Норма 1:2 при кормлении под «готовые руки» — онтарийский стандарт, используемый здесь как ориентир, а не как российский норматив²³; обязанность обеспечить потребление назначенного питания — из ст. 37/43 и СанПиН¹².

Ограничение вывода. Перераспределение и форматы — купирование, а не решение; решение — штатное, и путь к нему лежит через документированный замер дефицита.

Кейс 19. Директор получает жалобу от родственника

Ситуация. Письмо: «Моего брата кормят одной перловкой, на фото из отделения — серая масса. Требую разобраться, копия — в прокуратуру». Проверка фактов: перловка была вчера, фото сделано месяц назад при неудачном свете, брат ест нормально, но меню действительно монотонно.

Проблема. Жалоба частично не точна по фактам, но точна по существу (монотонность) — классическая ситуация, где формальная отписка проигрывает существу.

Что нельзя делать. Отвечать только опровержением («перловка была один раз») — родственник читает это как «нам всё равно»; искать виноватого до выяснения; обещать «разобраться и наказать» — жалоба не о наказании.

Немедленно. Запросить факты (меню за месяц, журнал замен, вес жителя); пригласить родственника на обед в отделение — личный визит снимает 80% конфликта; дать письменный ответ по существу: что проверено, что подтвердилось, что меняется.

Кто принимает решение. Директор лично — жалоба с копией в прокуратуру не делегируется.

Документы. Жалоба, материалы проверки, ответ заявителю, при системном выводе — решение о пилоте вариативности (раздел 35) или о совете жителей с участием родственников (раздел 34).

Долгосрочное решение. Регламент разбора жалоб и инцидентов (приложение 34): сроки, обязательный личный контакт, фиксация системных выводов. Родственники — неоплаченные аудиторы качества:

организованный канал их наблюдений (дни открытых дверей, участие в дегустациях совета) дешевле любой PR-службы.

Основания. Прокурорский контур по жалобам — реальный риск-градиент (раздел 33)⁷⁴⁷⁵; ответ по существу — и правовая, и управленческая норма.

Ограничение вывода. Не каждая жалоба справедлива; регламент защищает обе стороны: и жителя от плохой еды, и организацию от капризных конфликтов.

Кейс 20. Прокуратура просит показать, как учитывается мнение недееспособных жителей

Ситуация. Запрос по итогам плановой проверки: «Представить документы, подтверждающие учёт мнения и предпочтений жителей, признанных недееспособными, при организации питания». В организации 70% жителей недееспособны.

Проблема. Запрос бьёт в самое уязвимое место: если процедуры учёта невербальной воли не документированы, ответить нечем.

Что нельзя делать. Отвечать «их интересы представляет опекун» — опекун здесь само учреждение, конфликт интересов очевиден даже без юридического образования (раздел 16); срочно изготавливать документы задним числом — это выясняется и усугубляет; отрываться общими фразами о «заботе».

Немедленно. Собрать то, что есть честно: пищевые карты с записями наблюдений, протоколы совета жителей (если есть представители интересов), журнал замен. Если документов мало — честный ответ о текущем состоянии плюс план с датами: внедрение форм наблюдения (приложение 6), опроса, совета.

Кто принимает решение. Директор — об ответе; заведующие отделениями — о сборе существующих записей; юрист/учредитель — о форме ответа.

Документы. Ответ на запрос, план мероприятий с датами и ответственными, приказ о внедрении процедур.

Долгосрочное решение. Полный контур раздела 15: четыре канала воли, формы наблюдения, пищевые карты, протоколы совета. После внедрения любой такой запрос отвечается папкой за час.

Основания. Ст. 37/43 закона 3185-1 — права не ставятся в зависимость от дееспособности¹; КПИ и общие замечания ККИ — о поддерживаемом принятии решений⁷⁶²⁷; международные нормы прямо требуют учёта предпочтений при когнитивных ограничениях³⁵²³.

Ограничение вывода. Запрос прокуратуры — не обвинение; честный ответ с планом почти всегда завершает сюжет, вымученная «идеальная папка» — начинает его.

Учебные кейсы 21–22

Все кейсы — учебные ситуации, составленные для анализа.

Кейс 21. Учредитель не выделяет средства на дополнительный персонал

Ситуация. Замер трудозатрат показал: для нормальной помощи за столом не хватает трёх ставок сиделок. Ответ учредителя: «Денег нет, решайте в рамках имеющихся ресурсов». Директор в отчаянии: без рук всё остальное декорация.

Проблема. Предел компетенции директора — и одновременно проверка, не превратился ли отказ в удобное объяснение бездействия.

Что нельзя делать. Ссылаться на отказ как на индульгенцию («денег нет — ничего не можем») — значительная часть изменений стоит минуты, а не ставки; требовать «или дайте людей, или не мешайте» — конфронтация без данных проигрывает; скрывать дефицит от учредителя дальше (молчание фиксирует статус-кво как норму).

Немедленно. Разделить план на два списка: «нулевая стоимость» (рассадка, приоритет риска, отложенные порции, адаптивная посуда из имеющейся, форматы самостоятельности) — внедряется немедленно; «требует ресурсов» (ставки, обучение, оборудование) — уходит в повторный запрос с данными замера.

Кто принимает решение. Директор — о списке нулевой стоимости; учредитель — о ставках; директор обязан сделать повторный запрос документированным: числа, сценарии, последствия бездействия.

Документы. Форма учёта трудозатрат (приложение 26), форма сообщения учредителю о дефиците (приложение 33), план нулевой стоимости с датами.

Долгосрочное решение. Повторные запросы раз в квартал с обновлёнными данными — в управленческой реальности решения о ставках принимаются на третий-четвёртый документированный запрос, а не на первый;

параллельно — включение показателя помощи в отчётность (раздел 39, предложение 3).

Основания. Стоимость кормления как скрытая строка — раздел 29⁵⁶; обязанность организации — обеспечить потребление питания имеющимися ресурсами с максимальным качеством и одновременно документировать дефицит (ст. 37/43)¹.

Ограничение вывода. «Нулевая стоимость» — честная категория организационных мер, а не обещание, что системная проблема рук решается без рук: пределы списка называются учредителю прямо.

Кейс 22. Пищеблок физически не позволяет готовить две горячие линии

Ситуация. Здание 1970-х: одна плита на четыре конфорки, узкая раздача, две гастроремки на вторых блюдо физически не встают на линию. Проектная документация реконструкции — «в планах региона».

Проблема. Инфраструктурное ограничение — последнее возражение, которое остаётся после снятия всех остальных; оно реально, но не абсолютно.

Что нельзя делать. Объявлять «вариативность нам не светит» — выбор не сводится к двум горячим линиям; уродовать технологию (готовить второй вариант заранее и держать его часами на водяной бане — санитарно хуже, чем один свежий вариант); ждать реконструкции как единственного решения.

Немедленно. Перейти к форматам выбора без второй горячей линии: заказ накануне (кухня готовит два варианта последовательно по статистике заказа, а не держит параллельно); вариативность холодных позиций (салаты, напитки, десерты — буфетная зона); вариативность по дням недели («вторник — рыбный с двумя гарнирами»); отложенные порции и ночная доступность.

Кто принимает решение. Заведующий производством — о технологически возможном формате; директор — о выборе модели (M1 в

режиме предзаказа, МЗ буфет — раздел 29); учредитель — о реконструкции как отдельной повестке.

Документы. Обоснование выбранного формата (одна страница: ограничение → формат → гарантии санитарии), журнал заказа, план реконструкции в переписке с учредителем.

Долгосрочное решение. Капитальная повестка — отдельным документом с расчётом: стоимость второй линии против эффекта; при невозможности реконструкции — максимум выбора в имеющемся контуре как постоянная модель, а не «временная ущербность».

Основания. СанПиН регулирует безопасность и кратность, а не число линий²; мировая практика заказного питания (room service модели в госпиталях) показывает: выбор строится на предзаказе и организации, а не только на площадях¹⁰⁶.

Ограничение вывода. Предзаказ переносит выбор с линии наканунешний вечер — это другой ритм для смен, и он требует своего инструктажа (раздел 28), а не только решения кухни.

Как пользоваться кейсами на семинаре и в обучении

Каждый кейс разбирается за 15 минут по фиксированной схеме: ситуация зачитывается без раздела «решение»; группа формулирует ответы по восьми пунктам; сверка с текстом. Ценность разбора — в расхождениях: если группа предлагает нечто отсутствующее в кейсе, это повод для дополнения локального комплекта, а не для «исправления ошибки». Кейсы допускается адаптировать под специфику организации (детское/взрослое учреждение, размер, регион) с сохранением структуры из восьми пунктов.

Часть III. Приложения: проекты локальных форм (45 шаблонов)

Сорок пять шаблонов — рабочий инструментарий доклада: чек-листы, формы, журналы, алгоритмы, проекты приказов и положений. Каждый шаблон снабжён дисклеймером: это проект локальной формы, не нормативно установленный документ; он требует адаптации под региональное законодательство, учётную политику, структуру учреждения, медицинскую лицензию и требования учредителя. Порядок внедрения комплекта — раздел 36 и конец части III.

Приложения 1–6

Единый дисклеймер для всех приложений 1–36 (приводится на каждом шаблоне): «Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации под региональное законодательство, учётную политику, структуру учреждения, медицинскую лицензию и требования учредителя».

Приложение 1. Чек-лист готовности учреждения

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Заполняется директором с заведующим производством и врачом до старта пилота. Любой ответ «нет» — не запрет, а пункт плана.

Право и документы 1. Статус норм питания в регионе выяснен (рекомендация / императив) — ☐ да ☐ нет 2. Региональное меню изучено; процедура его изменения известна — ☐ да ☐ нет 3. Согласование учредителя на пилот получено письменно — ☐ да ☐ нет 4. Приказ о пилоте подписан, ответственные названы по фамилиям — ☐ да ☐ нет

Клиника 5. Лекарственно-пищевая таблица подписана врачом и висит на кухне и посту — ☐ да ☐ нет 6. Список жителей с риском дисфагии актуален; смена знает признаки — ☐ да ☐ нет 7. Правило «три отказа — врач в тот же день» доведено до всех смен — ☐ да ☐ нет

Кухня и линия 8. Пары эквивалентов на первую неделю рассчитаны и согласованы — ☐ да ☐ нет 9. Санитарный контур второй позиции проверен (маркировка, температура, пробы) — ☐ да ☐ нет 10. Журналы заказа, замен, срывов выбора заведены — ☐ да ☐ нет

Люди 11. Инструктаж смены раздачи проведён (показ меню, роли, замены) — ☐ да ☐ нет 12. Жители и близкие информированы; сбор предпочтений начат — ☐ да ☐ нет

Дата: _____ Подписи: директор _____ зав. производством _____
врач _____

Приложение 2. Карта пищевых предпочтений жителя

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Заполняется на каждого жителя; пересматривается ежеквартально. Источник каждой записи указывается: сам житель / наблюдение / близкие / врач.

Поле	Содержание	Источник
Любимые блюда		
Не ест (наблюдаемое)		
Не ест (заявляет сам)		
Текстура (по IDDSI, если назначена)		врач
Назначенная диета / ограничения		врач
Лекарственные ограничения (из таблицы)		врач
Помощь за столом (нет / частичная / полная)		наблюдение
Привычное время еды, ритуалы		
Напитки: что пьёт, что нет		
Аллергии, непереносимости		врач
Канал выбора (речь / показ / наблюдение)		

Дата заполнения: _____ Заполнил: _____ Дата пересмотра: _____

Приложение 3. Пищевая биография

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Заполняется при поступлении (или при создании карты на действующего жителя) со слов жителя и близких. Не анкета-опросник, а разговор по наводящим темам.

1. Где и как ел всю жизнь: дома, в семье, один, в учреждениях?
2. Что готовил сам? Что готовили для него?
3. Еда праздника и еда будня — что это было?
4. Что никогда не ел и почему (если помнит/говорит)?

5. Кто в его жизни «знает, как он ест» — имя, контакт?
6. Что из еды связано с тяжёлыми периодами (голод, стационары, ограничения)?
7. Три блюда, без которых «всё не то».

Запись ведётся в свободной форме, 5–15 предложений. Выдержки переносятся в карту предпочтений (приложение 2). Документ хранится в отделении, доступен смене.

Приложение 4. Простая форма выбора

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Одна строка на жителя, заполняется при показе меню (вечером накануне или утром). Формат — бумажный лист отделения.

Дата: _____ Приём пищи: обед / ужин

№	Житель (фамилия или код)	Вариант А	Вариант Б	Стандартный	Подпись/ отметка смены
1		☐	☐	☐	
2		☐	☐	☐	

Правила заполнения: выбор фиксируется в присутствии жителя; «стандартный» отмечается, если житель не выбрал (это нормальный итог, а не сбой); лист передаётся на кухню до ____ часов.

Приложение 5. Визуальное меню

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Требования к изготовлению (не бланк, а спецификация):

- формат: лист А4 или А3 на день, вешается в столовой и на посту;
- каждая позиция — фотография реальной порции из собственной кухни (не стоковые картинки: жители должны узнавать свою еду);

- подписи крупным шрифтом, от 24 пт; без кулинарных терминов («биточек», а не «биточек паровой по-дунайски»);
- варианты выбора расположены рядом, визуально сопоставимы;
- фотографии обновляются при смене меню-цикла; ламинация — для санитарной обработки;
- для жителей со слабым зрением — устное дублирование при показе обязательно.

Ответственный за изготовление и обновление: _____ (фамилия в приказе).

Приложение 6. Форма наблюдения за невербальным выбором

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требует адаптации.

Для жителей, которые не сообщают выбор речью. Заполняется сменой, 2–3 минуты на запись.

Дата: _____ Житель (код): _____ Приём пищи: _____

1. Что было предъявлено (карточки / блюда / меню): _____
2. Реакция: показал рукой ☐ взгляд задержался ☐ потянулся ☐ отвернулся ☐ без реакции ☐
3. Проверка позиции (предметы поменяны местами): реакция повторилась на тот же предмет ☐ на ту же позицию ☐
4. Ел предъявленное: полностью ☐ частично ☐ не ел ☐
5. Вывод для карты предпочтений: _____

Подпись: _____ Подтверждающее наблюдение (через 1–2 недели): дата _____ вывод совпал ☐ уточнён ☐

Приложения 7–12

Приложение 7. Форма предварительного заказа (журнал заказа)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Журнал отделения. Заполняется при вечернем показе меню; итог уходит на кухню до установленного часа.

Дата подачи: _____ Меню на (дата): _____

Позиция	Вариант А (заказов)	Вариант Б (заказов)	Стандартный (заказов)	Итого порций
Первое				
Второе				
Салат				
Напиток				

Особые порции по картам (текстура, диета): _____

Итоги передал: _____ Принял на кухне: _____ Время: _____

Ежемесячно итоги суммируются → статистика выбора для пересчёта меню и списаний (разделы 21, 29).

Приложение 8. Журнал срывов выбора

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Фиксирует эпизоды, когда заявленный выбор оказался недоступен. Ведётся на кухне/линии.

Дата	Приём пищи	Позиция	Что случило сь (закончи лось / не привезли / не приготов или)	Скольки м не хватило	Чем заменили	Подпись

Разбор — на еженедельной планёрке: серия из трёх срывов одной позиции → пересчёт объёмов или замена пары (раздел 21).

Приложение 9. Журнал отказов от еды

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Ведётся в отделении. Заполняется на каждый отказ от приёма пищи (не от блюда — от еды в целом или большей её части).

Дата	Житель (код)	Приём пищи	Сколь ко съеден о	Обсто ятельс тва (настр оение, слова жителя, конте кст)	Что предло жено взамен	Приня л замену ?	Кому сообщ ено	Подпи сь

Правило эскалации (выделяется в журнале рамкой): три отказа подряд у одного жителя — сообщение врачу в тот же день. Отказ с бредовой мотивировкой («отравлено») — сообщение врачу при первом эпизоде.

Приложение 10. Алгоритм при отказе от блюда

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Отказ от конкретного блюда (не от еды вообще):

1. **Спокойно принять.** Никаких «а кто теперь будет доедать» — реплика при отказе запрещена.
2. **Предложить замену** из доступного: второй вариант линии, стандартная замена (хлеб, кисломолочное, фрукты по сезону — перечень замен утверждён заранее).
3. **Записать** в журнал заказа/замен: житель, блюдо, замена.
4. **При повторении** (тот же житель + то же блюдо, 3 раза) — занести в карту предпочтений: «не ест ____ (наблюдение)».
5. **Если отказ распространяется** на большую часть приёма пищи — переход к приложению 11.

Запрещено: уговаривать давлением, ставить условия («съешь — получишь»), заменять отказ наказанием любой формы.

Приложение 11. Алгоритм при отказе от еды

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. **Первый отказ.** Спокойно уточнить причину, если житель говорит; предложить замену и формат (другое время, другое место, помощь). Запись в журнал отказов.
2. **Второй отказ подряд.** Старшая смены лично выясняет контекст; проверяет: не болен ли (жалобы, температура по показаниям), не конфликт ли за столом, не сменилось ли что-то в режиме. Запись.
3. **Третий отказ подряд → врач в тот же день.** Не завтра, не «на обходе послезавтра» — в день третьего отказа.
4. **Особые сигналы — врач при первом эпизоде:** бредовая мотивировка («отравлено»), признаки боли при глотании, сочетание с рвотой или резкой слабостью.
5. **До решения врача:** предлагать питьё и лёгкие форматы (кисломолочное, суп), наблюдать, не давить. Взвешивание по назначению.

6. Категорически запрещено: принудительное кормление в любой форме, шантаж едой, публичное давление.

Все шаги документируются в журнале отказов (приложение 9).

Приложение 12. Алгоритм при риске аспирации

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Профилактика (ежедневно): - жители из списка дисфагического риска едят в поле зрения обученной смены; минимум два обученных человека на посту в часы приёма пищи; - текстура строго по назначению (IDDSI); проверка вилкой перед выдачей; - поза: вертикально, 90°, после еды 30 минут без укладывания; - темп: паузы, без спешки; напиток между глотками по назначению.

При поперхивании (лёгкий эпизод, житель справился сам): 1. Остановить приём пищи, дать откашляться, не похлопывать по спине стоящего (эффективен кашель). 2. Записать эпизод; сообщить старшей смены. 3. Повторный эпизод в течение недели → врач вне очереди: пересмотр текстуры.

При тяжёлом эпизоде (не может кашлять, синюшность, потеря сознания): 1. Вызов медперсонала и врача — немедленно; при отсутствии эффекта — скорая (103/112). 2. Приём Геймлиха — только обученным сотрудником. 3. После эпизода — врачебный осмотр в тот же день даже при благополучном исходе (риск отсроченной пневмонии). 4. Протокол разбора инцидента (приложение 34) в течение 3 дней.

Связь с документами: список риска и текстуры — приложение 21 (медицинский контур); основания — раздел 10 доклада.

Приложения 13–18

Приложение 13. Алгоритм при быстром заглатывании

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. **Распознать:** ест значительно быстрее остальных, не прожёвывает, набирает полный рот, были эпизоды поперхивания.
2. **Сервировка без назначения врача:** порция меньше + добавка; куски уменьшенного размера (сервировка, не изменение текстуры); напиток под рукой; стол обслуживается в числе первых (снимает мотив «успеть»).
3. **Наблюдение:** место в поле зрения смены; записи о поперхиваниях — в форму наблюдения.
4. **Эскалация:** любое поперхивание с кашлем — врач вне очереди (скрининг дисфагии; назначение текстуры по IDDSI при подтверждении).
5. **Запрещено:** команды «ешь медленнее» как единственная мера; отбор еды темпом; самовольный перевод на пюре.
6. **Документы:** форма наблюдения, запись врача, при назначении — обновление карты.

Приложение 14. Алгоритм при пикацизме

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Пикацизм — поедание несъедобного (бумага, ткань, земля, предметы).

1. **Среда (первично):** осмотр зоны жителя и столовой — убрать доступные несъедобные предметы риска (мелкие, острые, токсичные; моющие средства — только под замком).
2. **Наблюдение:** усиленный визуальный контроль в часы приёма пищи и после; записи — что, когда, где.
3. **Замещение:** доступные безопасные жевательные альтернативы по согласованию с врачом; структурированная доступность еды

(регулярные перекусы снижают «поисковое» поведение у части жителей).

4. **Врач:** сообщение при первом выявленном эпизоде — пикацизм требует клинической оценки (дефицитные состояния, терапия, поведенческий план).
5. **Инцидент** (проглочен опасный предмет): наблюдение за состоянием, врач немедленно; симптомы (боль, рвота, задержка стула) — скорая. Протокол разбора (приложение 34).
6. **Документы:** записи наблюдения, назначения врача, протокол осмотра среды (раз в неделю, подпись старшей смены).

Приложение 15. Алгоритм при конфликте за столом

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. **Прервать эскалацию, не наказывая едой:** спокойный голос, развести участников за разные столы; еда обоих сохраняется полностью.
2. **Пострадавшему** (у кого отобрали, кого толкнули) — порция восстанавливается, приём пищи завершается спокойно.
3. **Запись об инциденте** в день события: участники, что произошло, меры.
4. **Разбор причины на планёрке:** рассадка, конкретная пара жителей, дефицит любимых позиций, гиперфагия одного из участников — у каждой причины своё решение (кейс 7).
5. **Повторные конфликты одной пары** — постоянная рассадка (документ отделения), врач — о пищевом поведении инициатора.
6. **Запрещено:** лишение еды или десерта как наказание; вынос из столовой без еды; публичное отчитывание.

Приложение 16. Алгоритм при пищевом инциденте

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Пищевой инцидент: массовое недомогание, подозрение на отравление, посторонний предмет в блюде, нарушение температурного режима с выдачей.

1. **Остановить выдачу** подозрительной позиции немедленно; сохранить остатки и суточную пробу — не выбрасывать.
2. **Медицина:** осмотр пострадавших; при массовом характере — врач, при тяжёлых симптомах — скорая.
3. **Изоляция фактов:** что готовилось, когда, из чего; записи по горячим следам, без согласования версий.
4. **Уведомления** по действующим правилам организации и требованиям законодательства (руководитель, учредитель; при признаках инфекции — по установленному порядку).
5. **Протокол разбора** (приложение 34) в течение 3 дней: причина, виновное звено, корректирующее действие, срок, ответственный.
6. **Запрещено:** уничтожение остатков и проб, «тихое» снятие позиции без записей, поиск виноватого до установления фактов.

Приложение 17. Матрица ролей RACI по питанию

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

R — исполняет, A — отвечает за результат, C — консультируется, I — информируется. Заполняется под структуру организации; ниже — базовая конфигурация.

Процес с	Директ ор	Зав. произво дством	Врач	Старша я смены	Сиделк а	Бухгалт ерия	Совет жителе й
Положе ние о питании	A	C	C	I	I	I	C
Меню с вариант ами	A	R	C	I	I	I	C

Процес с	Директ ор	Зав. произво дством	Врач	Старша я смены	Сиделк а	Бухгалт ерия	Совет жителе й
Показ меню, сбор выбора	I	I	I	A	R	—	I
Лекарст венно- пищевая таблица	I	I	A/R	C	I	—	—
Список дисфаги ческого риска	I	I	A	R	R	—	—
Журнал ы (заказ, замены, отказы)	I	C	I	A	R	I	—
Списан ие продукт ов	A	C	—	I	—	R	—
Закупки , претенз ии	A	C	—	—	—	R	—
Совет жителей	I	C	C	C	—	—	A/R
Панель чисел, отчёт учредит елю	A/R	C	C	C	—	C	I

Утверждено приказом № ____ от _____

Приложение 18. Чек-лист директора (ежемесячный)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Обошёл столовую в часы основного приёма пищи лично — ☐
2. Просмотрел журналы: заказ, замены, отказы, срывы — записи ведутся, не «копеечные» — ☐
3. Панель чисел месяца собрана; отклонения объяснены письменно — ☐
4. Совет жителей заседал; протокол есть; по решениям есть движение — ☐
5. Жалобы по питанию разобраны в срок; системные выводы сделаны — ☐
6. Переписка с учредителем актуальна (запросы без ответа повторены) — ☐
7. Инструктажи новых сотрудников по питанию проведены — ☐
8. Один случайный разговор с жителем о еде состоялся; запись в дневник обхода — ☐

Подпись: _____ Дата: _____

Приложения 19–24

Приложение 19. Чек-лист пищеблока (ежедневный)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Санитарный журнал дня ведётся; температурный режим линии зафиксирован — ☐
2. Суточные пробы отобраны по каждому приёму пищи, включая вариативные позиции — ☐
3. Вариативные позиции промаркированы (бирки: название, вариант) — ☐
4. Текстуры по назначениям проверены (тест вилкой) перед выдачей — ☐
5. Итоги заказа получены от отделений в срок; объёмы соответствуют — ☐
6. Особые порции (диеты, текстуры) приготовлены и промаркированы отдельно — ☐
7. Отходы взвешены/зафиксированы (в период замера) — ☐
8. Лекарственно-пищевая таблица на видном месте; новые назначения доведены — ☐

Зав. производством: _____

Приложение 20. Чек-лист отделения (ежедневный, часы приёмов пищи)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Визуальное меню дня показано жителям; выбор зафиксирован в присутствии жителей — ☐
2. На посту в часы еды — не менее двух человек, обученных приёмам безопасного кормления — ☐
3. Жители из списка дисфагического риска — в поле зрения; поза 90° соблюдена — ☐

4. Отложенные порции для спящих/отсутствующих оформлены по правилам — ☐
5. Отказы и замены записаны в день события — ☐
6. Конфликтов без записи не осталось — ☐
7. Помощь распределена по приоритету риска; никто из нуждающихся не остался без помощи — ☐

Старшая смены: _____

Приложение 21. Чек-лист медицинского контура

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Документы контура подписывает врач.

А. Лекарственно-пищевая таблица (вкладыш, обновляется при смене назначений)

Правило	Действие для кухни и смены	Класс уверенности
Клозапин + кофеин	Кофе/чай для получающих клозапин — по согласованию с врачом; кофеин не отменять резко	высокий (усиление концентраций клозапина; синдром отмены)
Литий + соль	Не менять солёность резко; солёные «загрузки» и бессолевые недели исключены	высокий
ИМАО + тирамин	Перечень ограничений у врача; выдержанные сыры, копчёности — по списку	высокий
Грейпфрут + ряд препаратов	Грейпфрут и сок из меню получающих карбамазепин и др. — исключены	высокий для карбамазепина
Алкоголь/энергетики	Исключены полностью; передачи проверяются	высокий

Б. Список дисфагического риска: житель (код) — признак — текстура по IDDSI — дата назначения — подпись врача.

В. Ежемесячно: список риска пересмотрен ☐; таблица актуальна ☐; журнал отказов просмотрен, меры приняты ☐; метаболический мониторинг (вес, глюкоза, липиды по назначениям) в графике ☐.

Врач: _____

Приложение 22. Чек-лист закупок

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Спецификация допускает парные позиции и закупку по статистике выбора — ☐
2. Правило взаимозаменяемости при срыве поставки прописано (нутриентные эквиваленты) — ☐
3. Ответственный за приёмку и претензии назначен; акты недопоставки оформляются — ☐
4. Статистика срывов поставок ведётся и учитывается при следующей закупке — ☐
5. При аутсорсинге в контракт включены: вариативность, текстуры, документирование замен, доступ к журналам — ☐
6. Закупка сверена с меню-циклом и картами (диеты, текстуры) — ☐
7. Признаки картельного поведения (одинаковые цены, поочерёдные победы) — основание для обращения в ФАС; ответственный знает порядок — ☐

Приложение 23. Чек-лист бухгалтерского учёта

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Применяемая учётная форма подтверждена учредителем (с учётом поэтапного перехода на электронные формы) — ☐
2. Ежедневные итоги журнала заказа поступают в бухгалтерию по установленной форме — ☐

3. Списание парных продуктов идёт по фактической пропорции выдачи (методика согласована) — ☐
4. Разница «склад — выдача — списание» объяснима за любой день месяца — ☐
5. Отложенные порции и замены отражены в выдаче — ☐
6. Сырьевая строка (руб./житель/день) посчитана за месяц и передана директору — ☐

Главный бухгалтер: _____

Приложение 24. Чек-лист проверки реальности выбора

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Проводится еженедельно в пилотной точке, далее ежемесячно.

1. Спросить пятерых случайных жителей: «Что вы вчера выбирали?» — ответили соответственно журналу: ____ из 5
2. Журнал заказа заполнен тем же днём, что и показ меню (проверка по почерку/времени — без парадоксов «заполнено заранее»): ☐
3. Оба варианта физически были на линии (опрос смены + журнал срывов): ☐
4. Доля «стандартных» (невыбравших) не растёт необъяснимо третью неделю подряд: ☐
5. Замены выдавались реально (спросить двоих, кому меняли блюдо): ☐
6. Жители знают, что выбирать можно (опрос): ____ из 5

Оценка: 6/6 — выбор реален; 4–5 — точечные сбои, разбор на планёрке; ≤ 3 — вариативность фиктивна, диагностика по разделу 21 и кейсу 12.

Провёл: _____ Дата: _____

Приложения 25–30

Приложение 25. Форма семидневного замера отходов

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Замер проводится до пилота и на 80–90-й день, в обычную (не праздничную) неделю. Взвешивание — на кухонных весах, в конце каждого приёма пищи, отдельно тарелочные остатки и кухонные остатки.

День	Приём пищи	Тарелочные остатки, кг	Кухонные остатки, кг	Число порций	Остаток на порцию, г	Примечание
1	завтрак					
1	обед					
1	ужин					

Итоги недели: средний остаток на порцию ____ г; топ-3 блюда по остаткам _____; сравнение с замером «до» (при повторном замере): ____ %.

Правила честности: не менять меню на неделю замера «получше»; не анонсировать замер сменам как проверку (искажение поведения); фиксировать аномальные дни (праздник, похороны, обострение) в примечании, а не исключать молча.

Приложение 26. Форма учёта трудозатрат на кормление

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Замер — 3 типичных дня, по каждому приёму пищи, секундомером, без изменения поведения смены.

День/приём	Число жителей, нуждающихся в помощи	Число помогающих	Время приёма пищи, мин	Суммарные минуты помощи	Минут помощи на жителя	Кто не получил помощь вовремя

Расчёт дефицита: потребность (жители × нормативные минуты) – имеющиеся минуты = дефицит в минутах → пересчёт в ставки (делением на продолжительность рабочего времени). Результат — основание для формы сообщения учредителю (приложение 33).

Приложение 27. Форма отчёта о 90-дневном пилоте

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. Паспорт пилота: точка, даты, модель (M1–M5), ответственные. **2. Панель чисел «до/после»** (12 показателей):

Показатель	До	После	Что это значит (одна фраза)
Доля выбирающих, %			
Отходы на порцию, г			
Время раздачи, мин			
Отказы от еды, эпизодов/нед			
Замены, эпизодов/нед			
Срывы выбора, эпизодов/мес			
Жалобы жителей/родственников			
Трудозатраты линии, мин/приём			
Сырьевая строка, руб./житель/день			
Доля знающих о выборе, %			
Эпизоды дисфагического риска			
Удовлетворённость (анкета, б. 1–5)			

3. Позиция совета жителей (протокол прилагается): расширить / сохранить / свернуть. **4. Решение директора:** одно из трёх, с обоснованием. **5. Приложения:** журналы, замеры, инциденты и их разбор.

Приложение 28. Проект приказа о пилоте вариативного питания

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

ПРИКАЗ № ____ от «»_20__ г. «О проведении пилотного проекта по организации вариативного питания»

1. Провести с «» по «» (90 дней) пилотный проект в отделении № : **выбор из двух вариантов вторых блюд на обед**, дней в неделю, с гарантией стандартного варианта.
2. Ответственные: руководитель пилота — ; **кухня** — ; отделение — ; **медицинский контур** — ; сведение данных — ____.
3. До старта: провести замеры по приложениям 25–26; опрос предпочтений; инструктаж смен; уведомить учредителя.
4. Вести журналы по приложениям 7–9 с первого дня.
5. Критерии успеха: ____ (доля выбирающих, отходы, отсутствие роста отказов). Критерии остановки: рост отказов; санитарные нарушения; противопоказания врача.
6. «» (дата) — заслушать итоги; решение о расширении/закреплении/свёртывании оформить приказом.

Директор _____ /подпись/

Приложение 29. Проект положения о вариативном питании

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Структура положения (разделы и ключевые формулировки):

1. **Общие положения.** Цель: реализация прав жителей (ст. 37, 43 закона № 3185-1) через организованный выбор в питании. Положение действует в рамках действующих норм (СанПиН 2.3/2.4.3590-20; рекомендованные нормы — приказ Минтруда № 520н, статус в регионе — ____).
2. **Перечень вариативных позиций** и режим (дни, приёмы пищи).
3. **Гарантия стандартного варианта:** «житель, не сделавший выбор, получает полноценный стандартный вариант; выбор — право, а не обязанность».
4. **Порядок показа меню и фиксации выбора** (визуальное меню, формы, сроки передачи заказа).

5. **Замены и отказы:** порядок, журналы, запрет использования еды как поощрения/наказания, запрет принудительного кормления.
6. **Связь с назначениями врача:** конфликт «выбор против назначения» решает врач в день обращения; диетические столы имеют собственные пары эквивалентов.
7. **Роли и ответственность** (по матрице, приложение 17).
8. **Контроль:** проверки реальности выбора (приложение 24), панель чисел, отчётность учредителю.
9. **Совет жителей** — со ссылкой на положение (приложение 30).

Приложение 30. Положение о пищевом совете жителей

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

1. **Состав:** 5–9 человек — жители (с квотой по отделениям; интересы недееспособных представляют выбранные ими лица или члены совета), сиделка, повар; врач — с правом совещательного голоса. Срок полномочий — 1 год, ротация — половина состава.
2. **Полномочия:** обсуждение меню до утверждения; дегустации новых позиций; сбор и ранжирование пожеланий; получение ответа администрации на пожелания в срок до 14 дней.
3. **Ритм:** заседание ежемесячно; кворум — половина состава; протокол ведётся и хранится ____ лет.
4. **Права совета:** запрашивать меню, журналы срывов, панель чисел; выносить предложения директору; инициировать дегустации.
5. **Границы:** совет не заменяет врачебные назначения и не отменяет санитарные требования; при расхождении позиции администрации с зафиксированными предпочтениями жителя приоритет имеют предпочтения, если они не противоречат назначениям врача.
6. **Форма протокола:** дата, состав, вопросы, решения, сроки, ответственные.

Приложения 31–36

Приложение 31. Памятка персоналу «Питание и выбор: десять правил»

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Формат — один лист А4, вывешивается на посту.

1. Еда — право, а не награда. Никогда не используйте еду как поощрение или наказание.
2. Показывайте меню каждому, каждый день, в его формате (речь, карточки, жест).
3. «Стандартный вариант» — нормальный итог, а не отказ от выбора.
4. Отказ от блюда — предложите замену и запишите. Без комментариев вслух.
5. Три отказа от еды подряд — врач сегодня. «Отравлено» — врач при первом.
6. Текстура — как в карте. Проверка вилкой — минута, риск аспирации — жизнь.
7. Кто ест с помощью — ест в своём темпе. Конвейер недопустим.
8. Записывайте в день события: замены, отказы, конфликты, срывы.
9. Не знаете — спросите старшую смену. Не решайте врачебные вопросы сами.
10. Житель за столом — хозяин своей тарелки. Ваша работа — чтобы выбор был реальным.

Приложение 32. Памятка родственникам

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Что мы делаем. В нашем доме жители выбирают блюда из предложенных вариантов. Выбор фиксируется, замены гарантированы, стандартный вариант есть всегда.

Как вы можете помочь. Расскажите нам, что ваш близкий любит и не ест — это войдёт в его пищевую карту. Сообщите о привычном времени еды, любимой посуде, ритуалах. Участвуйте в днях открытых дверей и дегустациях совета жителей.

Что важно знать. Ограничения в питании вводит только врач. Если вы считаете, что близкому нужно ограничение, — напишите заявление, врач рассмотрит его. Мы не вводим запретов по устной просьбе, потому что право на еду, которую человек любит, — это его право.

Куда обращаться. Вопросы о еде — старшая смена отделения; предложения — совет жителей; жалобы — директор (срок ответа ____ дней). Передачи: принимаются ____ (перечень ограничений по санитарным правилам — см. на стенде).

Приложение 33. Форма сообщения учредителю о дефиците ресурсов

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации.

Генеральному директору/начальнику _____ от директора _____

1. Дефицит: (ставки / оборудование / площади — конкретно, количественно: «3,0 ставки сиделок по расчёту из замера, приложение 26»). **2. Методика расчёта:** замер от ____ (даты), форма прилагается. **3. Последствия бездействия:** (фактическое: «12 жителей группы помощи получают менее ____ минут помощи за приём пищи; двое систематически не доедают»). **4. Что сделано без ресурсов:** (перечень мер нулевой стоимости и их эффект). **5. Сценарии:** минимальный (____ ставки → эффект), *полный* (→), *стоимость каждого*. **6. Просьба:** *рассмотреть до* (дата); при отказе — просим письменного подтверждения для учёта в плане работы.

Приложения: формы замеров, расчёты. Директор _____ /подпись/

Приложение 34. Протокол разбора пищевого инцидента

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Срок составления — 3 дня с инцидента.

1. Что произошло: дата, время, место, участники, хронология (по записям, без согласования версий). **2. Класс инцидента:** аспирация / конфликт / массовое недомогание / посторонний предмет / проглатывание несъедобного / иное. **3. Немедленные меры:** что сделано, кем, когда; врач (время вызова, осмотра). **4. Причина:** звено цепочки (продукт / технология / текстура / рассадка / наблюдение / среда) — с обоснованием. **5. Факторы среды:** что в организации позволило инциденту (не «человеческий фактор» как стоп-слово, а условия: смена в одиночку, карта не обновлена и т.п.). **6. Корректирующие действия:** действие — ответственный — срок — проверка исполнения. **7. Уведомления:** кто и когда проинформирован по установленному порядку. **8. Вывод для системы:** одна строка — что меняется в регламентах.

Составил: _____ Утвердил: директор _____

Приложение 35. Форма управленческого дашборда (квартальная панель)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Один лист на квартал.

№	Показатель	Квартал	Предыдущий	Тренд	Комментарий
1	Доля выбирающих жителей, %				
2	Отходы на порцию, г				
3	Отказы от еды, эпизодов				
4	Замены по отказам, эпизодов				
5	Срывы выбора, эпизодов				
6	Сырьевая строка, руб./житель/день				
7	Трудозатраты линии, мин/приём				
8	Жалобы по питанию				
9	Инциденты (по классам)				
10	Жителей с актуальными картами, %				

№	Показатель	Квартал	Предыдущий	Тренд	Комментарий
11	Заседания совета жителей состоялись				
12	Анкета удовлетворённости, б. 1–5				

Три вывода квартала (по одному предложению): _____

Приложение 36. Анкета жителей в доступном формате

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Требуется адаптации. Проводится раз в квартал; заполняется со слов жителя или самостоятельно; для невербальных жителей — не проводится (их канал — наблюдение, приложение б).

1. Еда вам в целом нравится? (улыбающийся / нейтральный / грустный смайл — обвести)
2. Что из еды вам нравится больше всего? _____
3. Что бы вы убрали из меню? _____
4. Удаётся ли выбрать то, что хочется? всегда / иногда / никогда
5. Достаточно ли еды? да / хотелось бы больше / слишком много
6. Удобно ли есть в столовой (шум, место, время)? да / что мешает: _____
7. Одно пожелание повару: _____

Обработка: итоги сводятся в панель (показатель 12) и докладываются совету жителей; по пунктам 3 и 7 администрация отвечает совету в 14 дней.

Правила применения приложений

Все 38 форм — единый комплект: формы наблюдения питают карты, карты — меню и закупки, журналы — панель, панель — отчёты учредителю. Внедрять комплект рекомендуется в последовательности дорожной карты (раздел 36): сначала замеры (25–26) и карты (2–3, 6, 37), затем журналы (7–9) и алгоритмы (10–16), затем управленческий слой (17–24, 27–35) и памятка жителю (38). Дисклеймер о локальном статусе сохраняется на

каждой форме после адаптации — до тех пор, пока форма не утверждена локальным актом организации.

Приложения 37–38

Приложение 37. Пищевой паспорт при поступлении (проект формы)

Проект локальной формы. Не является нормативно установленным документом. Заполняется при поступлении совместно с жителем, а при невозможности — с опекуном/семьей; обновляется при изменении состояния и не реже раза в год. Владелец — старшая медсестра; копия полей — на кухне и посту.

Блок	Что фиксируется	Кто заполняет
Предпочтения	Любимые и нелюбимые блюда; привычный ритм дня; как предпочитает есть (ложка/вилка, помощь, тарелка-разделитель)	Житель + семья; каналы воли — раздел 15
Ограничения по убеждению	Религиозные/культурные (халяль, пост, вегетарианство); аллергии и непереносимости (в т.ч. целиакия, лактоза) — со слов и по документам	Житель/семья + врач
Глотание	Шесть признаков дисфагии (да/нет); при сомнении — GUSS/EAT-10 с записью балла	Медсестра
Полость рта	Свои зубы/протезы; «болит ли жевать»; сухость во рту; дата последнего осмотра стоматологом	Медсестра
Лекарства × еда	Препараты из таблицы раздела 11 (клозапин, литий, ИМАО, карбамазепин и др.); согласовано с врачом	Врач
Вес и статус питания	Вес при поступлении; рост; динамика (триггеры 5/7,5/10 % — раздел 26); аппетит по шкале 1–5	Медсестра

Блок	Что фиксируется	Кто заполняет
Питьевой режим	Обычный объём; при загущённых напитках — уровень IDDSI и фактический объём за сутки	Медсестра + кухня
Стул	Регулярность (для группы антихолинергической нагрузки — контроль трёх суток)	Пост

Правило формы: каждая строка либо заполнена, либо помечена «данных нет» — пустых строк нет. Паспорт не заменяет медицинскую документацию; он собирает на одном листе то, что иначе размазано по пяти журналам.

Приложение 38. Памятка для жителей «Моя еда — мой выбор» (доступный формат, easy read)

Проект локальной формы в технике easy read: короткие фразы, одна мысль на строку, картинка к каждой мысли. Формат — лист А4 (двусторонняя печать), вывешивается в столовой и вручается при поступлении. Соответствует подходу Accessible Information Standard (Англия): информация предоставляется в формате, который человек может понять¹⁰⁸. Пиктограммы подбираются под контингент дома (фотографии реальных блюд и столовой работают лучше абстрактных значков).

Лист 1. Моя еда — мой выбор (вывешивается в столовой, вручается при поступлении)

1. Каждый день вам показывают меню. Меню — это список еды.
2. Вы можете сказать: «Хочу это». Вы можете сказать: «Не хочу это».
3. Если вы не говорите — вам покажут две тарелки. Вы покажете пальцем.
4. Вы не останетесь голодным. Всегда будет другой вариант.
5. Если вы едите в комнате — вам тоже принесут два варианта. Покажите, какой хотите.
6. Если еда мешает глотать — скажите персоналу. Вам помогут.

7. Если болит жевать — скажите персоналу. Вас посмотрит врач.
8. Вы можете пить воду, когда хотите. Просите пить.
9. Есть еда, которую вы не едите по вере? Скажите — мы учтём.
10. Ваше мнение важно. Совет жителей обсуждает еду.
11. Если что-то не так с едой — вы можете пожаловаться. Это ваше право.

Лист 2. Сегодня обед — рабочий лист выбора (лежит на раздаче и на посту постельных; заполняется на приём, не «навсегда»)

Сегодня: _____ (завтрак / обед / ужин). Дата: _____

Покажите пальцем или положите метку.

	Вариант А	Вариант Б	Не хочу ни то ни другое
Картинка / название	_____	_____	Принесут третий вариант по таблице замен
Мой выбор	☐	☐	☐

Если вы ничего не отметили — вам принесут обычный вариант. Это нормально. Выбирать не обязательно.

Кто спросил: _____ Кто принял заказ: _____

Обратная сторона листа 1: «Куда пожаловаться» — имя и кабинет ответственного, ящик для записок совета жителей, телефон доверия учредителя. Лист 2 не хранит диагноз и не вывешивается в коридоре с фамилиями — это заказ на приём (раздел 17.6).

Приложения 39–42

Приложение 39. Чек-лист перехода на СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (с 01.09.2026)

Проект локального чек-листа. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утверждён постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 18 (зарег. в Минюсте 02.06.2026 № 86854), действует с 01.09.2026 до 01.09.2032; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с этой даты утрачивает силу². Дата семинара (25–27.08.2026) попадает в переходный период: документы учреждения готовятся к перепривязке. Пункты ниже сверены с текстом 4282-26 по официальной публикации.

Требование	Где в СанПиН 4282-26	Действие в учреждении
Питание в стационарном соцобслуживании: не менее 3 раз в день, в т.ч. диетическое (лечебное) по медицинским показаниям	п. 56 подп. 11	Перепривязать положение о питании; проверить формулировки меню
Суточные пробы при использовании готовых блюд из предприятий общественного питания (аутсорсинг)	п. 56 подп. 12; отбор по подп. 4 (каждое блюдо отдельно; холодные закуски/первые/гарниры/напитки — не менее 100 г; хранение не менее 48 ч при +2...+6 °С)	Помещение приёма готовой продукции; назначенный ответственный; инструкция по пробам
Бракераж готовой продукции, журнал бракеража	п. 56 подп. 13; образцы журналов — приложения 4 и 5	Новые формы журналов; обучение заводпроизводством
Кейтеринг: внутренний порядок, прослеживаемость, разграничение ответственности; вскрытие упаковок и порционирование — в выделенном помещении/зоне	раздел VI (п. 51–55)	Строка в договоре с поставщиком; проверка выполнения при приёмке

Требование	Где в СанПиН 4282-26	Действие в учреждении
Питьевой режим: вода по обязательным требованиям; фонтанчики (чаша — ежедневная обработка), кулеры (мойка ≥ 1 раза в 7 дней, дезинфекция ≥ 1 раза в 3 месяца), кипячёная вода (кипячение ≥ 5 минут, смена ≥ 1 раза в 3 часа, график смены); посуда из расчёта списочного состава	п. 62	Проверить кулеры и графики; ведомость питьевого режима (приложение 40)
Температура горячих жидких и иных блюд, холодных супов, напитков при выдаче — по технологическим документам	п. 50	Термометры на линии; сверка с технологическими картами
Требования распространяются на привлекаемые предприятия питания	п. 56 подп. 14	Пункт в договоре аутсорсинга (раздел 42)

Порядок действий: до 25.08.2026 — сверить положение о питании и чек-листы пищеблока с текстами обоих СанПиН (3590-20 действует до 01.09.2026); с 01.09.2026 — перепривязка журналов и форм на пункты 4282-26, обновление памятки персоналу пищеблока, уведомление учредителя одной страницей (что меняется, что остаётся). Модель выбора блюд при переходе не меняется: ни одна из редакций не ограничивает число вариантов (раздел 18).

Приложение 40. Питьевой режим: форма учёта и санитарные требования

Проект локальной формы. Правовая рамка — п. 62 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (с 01.09.2026; до этого — аналогичные требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20): питьевой режим обязателен в организациях социального обслуживания; вода — по обязательным требованиям (глава III СанПиН

1.2.3685-21; глава IV СанПиН 2.1.3684-21; ТР ЕАЭС 044/2017)². Клинический смысл: низкое потребление жидкости — распространённый и недооценённый дефицит у пожилых¹⁰⁹; рекомендации по гидратации в гериатрии суммированы в руководстве ESPEN и в клинических рекомендациях для учреждений длительного ухода¹¹⁰¹¹.

Ведомость «Выпито за сутки» (по отделению, группа риска — лежачие, жители на загущённых напитках, жаркий период):

Житель	Утро (стакан/ мл)	День	Вечер	Ночь	Итого	Примечание*

*Примечание — индикаторы дегидратации: тёмная моча, сухость языка, сонливость вне режима, снижение тургора кожи; любой из них — запись и сообщение врачу. Важно: по данным обзора, клинические признаки малоинформативны для диагностики обезвоживания — надёжен только объективный метод (осмоляльность сыворотки)¹⁰⁹; постовые признаки — повод к эскалации, а не диагноз.

Правила: единица учёта — «стакан» (200 мл) или маркированная посуда; норма-ориентир для взрослых без ограничений — не менее 1,6 л/сутки для женщин и 2,0 л/сутки для мужчин (рекомендация ESPEN по гидратации в гериатрии; индивидуально, при сердечной, почечной патологии и иных ограничениях — только по назначению врача)¹¹⁰; чайная пауза между приёмами пищи как «шестое пищевое событие» (раздел 10.7); у жителей на загущённых напитках — фактический объём выпитого (загущение снижает потребление — раздел 10.7). *Маркировка: объёмные ориентиры — не норматив; ограничение питьевого режима — только врачебное назначение.*

Приложение 41. Детские учреждения (ДДИ): что переносится, что нет

Маркер для руководителей детских домов-интернатов и смешанных организаций. Семинар и рекомендации доклада — про взрослых, пока учредитель отдельно не поручил детский контур. Ниже — границы переноса модели выбора, а не педиатрическое руководство.

Блок	Переносится	Не переносится / требует адаптации
Вариативность и выбор	Принцип «не менее двух вариантов», визуальное меню, наблюдение за невербальным выбором (раздел 15), IDDSI и текстуры (раздел 10)	Согласие родителей/законных представителей; возрастные форматы меню и порций; педиатрический контур вместо терапевтического
Нормы питания	—	Детские наборы приказа Минтруда 520н (граммы на ребёнка) ³⁰ ; среднесуточные наборы и массы порций для детей — приложения к СанПиН 4282-26 ²
Санитарные требования	Суточные пробы, бракераж, температурный контроль	Раздел VIII СанПиН 4282-26 (детские коллективы): свои перечни недопустимой продукции, режимы, порции, диетическое питание детей — п. 60 ² ; общие требования к детским организациям — СП 2.4.3648-20 (пост. ГГСВ РФ от 28.09.2020 № 28) ¹¹²
Правовая рамка	Учёт мнения и предпочтений (раздел 15–16)	Дети — особая рамка: законные представители, органы опеки, возраст согласия; режимы дееспособности раздела 16 не применяются

Приложение 42. Калькулятор стоимости вариативности (инструкция)

Сопровождает файл Калькулятор_стоимости_вариативности.xlsx (папка проекта и 04_приложения_и_реестры/). Четыре листа. **Лист 1 «Пары блюд»:** норма закладки (г/порцию) × закупочная цена (руб./кг) = стоимость порции для каждого из вариантов пары; разница — на порцию и в месяц. **Лист 2 «Отходы»:** масса тарелочных остатков × число порций × цена сырья = строка «выброшенных денег» (методика — приложение 25). **Лист**

3 «Сценарии отходов»: снижение отходов на 10/20/30 % — гипотеза, подтверждается только повторным замером через 90 дней (раздел 29). **Лист 4 «Два сценария»:** (1) собственный пищеблок, пара эквивалентов внутри нормы; (2) аутсорсинг, две позиции в ТЗ вместо монопозиции. Цифры на листах 1–2 — учебные заглушки, не себестоимость конкретного дома и не экономика Серафимовского. Жёлтые ячейки — ввод. *Маркировка: калькулятор считает гипотезу, а не доказывает её; формула доклада «замер до и после» остаётся обязательной.*

Приложения 43–44

Приложение 43. Спецификация вариативности для контракта аутсорсинга (форма восьми строк)

Проект локальной формы к разделу 42. Согласуется с контрактной службой до публикации закупки; является приложением к контракту вместе с меню-циклом и раскладкой. Форма переносит «восемь строк» раздела 42.3 в заполняемый шаблон. Распечатка на одну страницу А4 — на стол директора, не только в PDF доклада.

№	Строка контракта	Формулировка для спецификации (адаптировать)	Основание
1	Перечень позиций	Группы взаимозаменяемых позиций (например, «крупы гарнирные: гречневая, рисовая, пшённая»), а не монопозиции	Разделы 19, 42.3
2	Пропорции	Пропорции вариантов внутри группы — по статистике выбора учреждения; корректировка раз в квартал без изменения предмета контракта	Раздел 21

№	Строка контракта	Формулировка для спецификации (адаптировать)	Основание
3	Гарантия выбора	На приёмах пищи с заявленной вариативностью — не менее двух вариантов основных позиций; срыв выбора фиксируется поставщиком в журнале замен и не считается исполнением	Раздел 42.3
4	Замены при недопоставке	Эквивалент из той же группы по согласованию с учреждением, двусторонний акт в сутки замены	Раздел 19
5	Качество текстур	Характеристики полуфабрикатов, значимые для текстур (помол, консистенция), — в спецификации качества; дисфагические позиции — отдельным пунктом	Раздел 10
6	Приёмка и пробы	Ответственный от учреждения, место и процедура суточных проб	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 12 (с 01.09.2026); до этой даты — п. 7.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ²

№	Строка контракта	Формулировка для спецификации (адаптировать)	Основание
7	Состав и нормы	Меню-цикл с раскладкой и массой порций — приложение к контракту; соответствие нормам питания	Приказ Минтруда № 520н ³⁰
8	Отчётность	Ежемесячно: доля выбора по позициям, остатки по блюдам, журнал замен — данные для панели чисел учреждения	Раздел 22

Негативный список — в ТЗ отдельной строкой. Нельзя передать поставщику: отбор суточных проб; бракераж приёмки готовой продукции как акт учреждения; список дисфагического риска и текстурные назначения; маршрут эскалации отказа от еды. Фотофиксация приёмки — линия, маркировка, термометр; лица жителей на кадр не попадают (раздел 17.6).

Дисклеймер: проект формы, не нормативный документ; требует адаптации под 44-ФЗ/223-ФЗ и позицию контрактной службы учредителя¹⁰⁵.

Приложение 44. Письмо учредителю о пилоте вариативности при аутсорсинге (шаблон)

Проект письма на одну страницу. Цель — санкция учредителя на включение строк выбора в спецификацию закупки у действующего поставщика (при изменении) или в новую закупку. Отправляется за 30+ дней до срока планирования закупки.

Уважаемый _____ !

Государственное учреждение «_____» (стационарная форма социального обслуживания, _____ мест) просит согласовать включение в спецификацию закупки услуг питания следующих позиций: (1) группы взаимозаменяемых позиций вместо монопозиций; (2) гарантия не менее двух вариантов основных блюд на приёмах пищи с заявленной вариативностью с фиксацией срыва выбора поставщиком; (3) процедура замен при недопоставке из той же группы; (4) ежемесячная отчётность поставщика о доле выбора и остатках.

Обоснование. Правовая рамка не ограничивает число вариантов блюд (СанПиН²; нормы питания — рекомендуемые³⁰). Механизмы обеспечения выбора при собственном пищеблоке и при аутсорсинге совпадают по содержанию (журналы, замеры, гарантия стандартного варианта) и различаются только местом фиксации — контрактом.

По сырьевой строке пары эквивалентов, как правило, сопоставимы; изменение — в спецификации и отчётности. Это не обещание «пилот без затрат»: обучение смены, маркировка, весы, иногда посуда и ставки остаются отдельными строками. Если они понадобятся — укажем в следующем письме с расчётом, а не прячем в формулировку «финансирование не запрашиваем».

Просим согласовать до «_____» _____ 20__ г. (срок планирования закупки на 20__ год).

Приложения: форма восьми строк (приложение 43); панель чисел учреждения за последний квартал; проект графика перехода.

С уважением, _____

Приложение 45. План Б: питание при закрытии столовой

Проект одностраничной формы к разделу 18.11. Подписывается до вспышки, не утром закрытия. Не заменяет санитарные предписания по конкретному карантину.

Когда включается. Закрытие столовой, карантин отделения, ОРИ, невыход кухни / срыв аутсорсера.

Блок	Что заранее	Кто владелец	Отметка
Выбор в комнате	Два варианта основных позиций на подносе (не вторая линия в коридоре); стандартный вариант всегда есть	Старшая смены + кухня	☐
Заказ	Лист у поста или визуальное меню на двери; журнал замен ведётся усиленно	Пост	☐
Температура	Горячее доходит до комнаты по технологическим документам (п. 50 СанПиН 4282-26) ² : мармит → коридор → палата — замер на последней выдаче, не только на линии	Завпроизводством	☐
Питьё	График тёплого питья; ведомость приложения 40	Пост	☐
Посуда	Запас одноразовой / раздельной по карантинному контуру	Завхоз	☐

Блок	Что заранее	Кто владелец	Отметка
Холодный буфет	Перечень (хлеб, кисломолочное, фрукты по правилам буфета раздела 18.4), не «что осталось в холодильнике»	Кухня	☐
Если не вышла кухня / не приехал аутсорсер	Кто готовит или кто принимает аварийную поставку; чей телефон в 7:00; что выдаём в первый приём без горячего цеха	Директор / зам	☐
Смена	График раздачи по отделениям с запасными руками; нагрузка не «обнаруживается в 8 утра»	Зам. по АХЧ	☐

Витаминизация и любые ограничения рациона при ОРИ — только по назначению врача (раздел 4.3). Выбор не отменяется: меняется форма подачи.

Подпись руководителя: _____ дата: _____ следующий пересмотр: не реже раза в год или после каждой вспышки.

Часть IV. Одностраничные инфографики (для печати и раздатки)

Десять одностраничных материалов для печати: плакаты для поста и столовой, памятки для инструктажей, раздатка для совета жителей и семинара. Каждая страница самодостаточна и может копироваться отдельно от доклада; источники данных указаны на самих страницах либо в разделах, на которые инфографика ссылается.

Инфографика 10. Десять запретов смены — коротко и навсегда

1. Еда — не награда и не наказание	2. Не кормить принудительно. Никогда. Ни в какой форме
3. Не решать врачебные вопросы (текстура, диета, лекарства)	4. Не заполнять выбор за жителя
5. Не комментировать отказ вслух	6. Не торопить едока
7. Не оставлять группу риска без наблюдения	8. Не менять кофеин/соль резко
9. Не «забывать» записать замену	10. Не передавать «устно со смены» то, что должно быть в журнале

Позитивная версия тех же правил — памятка персоналу (приложение 31).

Инфографика 1. Шесть измерений «накормить» — плакат для столовой

1. БЕЗОПАСНО Список риска на посту · текстуры по карте · никто из группы риска не ест вне поля зрения	2. ФИЗИОЛОГИЧНО Ночной интервал ≤ 13 ч · кратность ≥ 3 · режим под лекарства, а не наоборот
3. ПОНЯТНО Меню показано каждому в его формате · житель помнит, что ел	4. ЧЕЛОВЕЧНО Еда — не рычаг · темп едока · тихий стол существует
5. ЗАКОННО Журнал замен · отказ = альтернатива, а не голод	6. ПОСЧИТАНО Сырьевая строка известна за 5 минут · отходы меряются

Минимальная планка — по одному действию в каждом измерении (раздел 7.8). Не совершенство в одном и провал в пяти, а планка в шести.

Инфографика 2. Пять правил «лекарство × еда» — для кухни и поста

Правило	Что делаем	Уверенность
Клозапин + кофеин	Режим кофе/чая — согласован с врачом; резко не отменять и не добавлять	высокая
Литий + соль	Солёность стабильна; никаких «солёных загрузок» и бессолевых недель	высокая
ИМАО + тирамин	Выдержанные сыры, копчёности — по списку врача	высокая
Грейпфрут + карбамазепин и др.	Грейпфрут и сок исключены из меню группы	высокая
Алкоголь, энергетики	Исключены полностью; передачи проверяются	высокая

Полная таблица подписывается врачом и висит на кухне и посту (приложение 21). Передачи — фармакологический канал (раздел 11.8).

Инфографика 3. Шесть признаков риска дисфагии — плакат для поста

1 Кашель во время или после еды	2 «Мокрый», булькающий голос после глотка
3 Долгое пережёвывание без глотания	4 Пища скапливается за щекой
5 Подтекание изо рта при еде	6 Повторные пневмонии в анамнезе

Любой признак → запись → врач. Поперхивание с кашлем — врач вне очереди. До назначения: поза 90°, темп, место в поле зрения. После назначения: текстура по IDDSI, тест вилкой.

Инфографика 4. Четыре канала воли невербального жителя

1. ПОКАЗ

Карточки, фотографии, два предмета.
Проверка: перестановка мест (тест позиции).

2. НАБЛЮДЕНИЕ

Что ест, что оставляет, куда тянется. Серия записей > одно впечатление.

3. БИОГРАФИЯ

Записанная в «хороший день» воля имеет приоритет над сегодняшними догадками.

4. БЛИЗКИЕ

Источник биографии — не источник запретов. Их сведения — в карту, их запреты — к врачу.

Иерархия при конфликте каналов: текущее предпочтение > биография > наблюдение > близкие > «усреднённое благо» (раздел 15.5).

Инфографика 5. Что директор может сделать уже в понедельник (без денег и согласований)

Час 1 Вычесть из времени завтрака время ужина. Больше 13 ч — план сдвига или перекуса.	Час 2 Прогнать замер: взять весы, назначить неделю взвешивания отходов (приложение 25).
День 1 Повесить на пост шесть признаков дисфагии (инфографика 3).	День 2 Завести журнал отказов с правилом «3 отказа — врач сегодня».
День 3 Спросить пятерых жителей: «Что вы вчера выбирали?» — и записать ответ.	День 4 Письмо учредителю: статус норм 520н в регионе — один вопрос, одна просьба о документе.
День 5 Обход с тарелкой: съесть обед с линии вместе с жителями. Записать три находки.	Итог недели У вас есть факты. Дальше решения принимаются по ним, а не по настроению.

Инфографика 6. Ночная доступность: конструкция из четырёх элементов

ПЕРЕЧЕНЬ 2–3 продукта, согласованных с врачом: кефир, хлеб, фрукты; для метаболического риска — низкокалорийные.	МЕСТО Точка на посту или буфетная зона отделения. Не кухня.
РЕЖИМ Фиксированное окно + по запросу ночью. Запись в журнал.	ГРАНИЦЫ При гиперфагии — порционно, не «возьми сам». Санитария — в полном объёме.

Ночное едение при психических расстройствах: 4–30 % (обзор RESOLVE). Вопрос не «бывает ли», а «подпольно или организовано» (раздел 13.5).

Инфографика 7. Пары эквивалентов: строительный набор месяца

Позиция	Эквивалентная пара	Что проверяем
Гарнир	гречка ↔ рис ↔ пшено ↔ овсянка	одинаковая «ранговость»
Белковое	котлета мясная ↔ рыбная ↔ курица	эквивалент по белку
Первое	щи ↔ борщ ↔ суп крупяной	роль «жидкое горячее»
Салат	свёкла ↔ капуста ↔ морковь	сезонность
Напиток	компот ↔ морс ↔ чай	лекарственная таблица

Не пара: «второе без всего» · «то же, но вчерашнее» · «по запросу за неделю». Пара различима и рангоранговая — иначе это сортировка жителей на сорта (раздел 19).

Инфографика 8. Стол для группы помощи: микроустройство

РАССАДКА Помогающий между двумя жителями. Дисфагический риск — не парами.	ПОСУДА Глубокие тарелки с бортиком, нескользящие подставки, удобные ложки.
ПОРЦИЯ Средняя + добавка. Большая порция деморализует и торопит.	ТЕМП Едок задаёт темп. Конвейер недопустим — это риск аспирации.
РАЗГОВОР С едоком говорят с едоком, а не через голову о своём.	НОРМА РУК Ориентир 1:2 для помощи под «готовые руки» (Онтарио) — и честный замер дефицита (приложение 26).

Инфографика 9. Что доказано, что нет: честная карта доказательств

Утверждение	Статус
Среда стола (семейная подача) улучшает вес и качество жизни	РКИ (Nijis): +6,1 QoL, +1,5 кг
Обучение персонала текстурам снижает ошибки вдвое	интервенционное: 44→90 %
Взаимодействия клозапин-кофеин, литий-соль — реальны	систематические данные
Структурированное питание связано с меньшей смертностью	когорта (Япония): HR 0,90
Вариативное меню в психиатрии улучшает исходы	РКИ НЕ НАЙДЕНЫ — пробел
Вариативность снижает отходы	гипотеза — только ваш замер
«Вариативность почти бесплатна»	недоказано — формула удалена

Зелёное — можно ссылаться смело; жёлтое — с оговоркой; красное — не утверждать. Полная матрица — CLAIM_SOURCE_MATRIX.xlsx.

Список источников

Источники приведены в порядке первого упоминания в тексте. Полные машиночитаемые реестры — контрольные файлы SOURCE_REGISTRY.xlsx, MEDICAL_EVIDENCE.xlsx, INTERNATIONAL_PRACTICES.xlsx.

1. Закон РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи...», ст. 37, 39, 43, 44. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/ (проверено: 23.07.2026)
2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (пост. ГГСВ РФ от 27.10.2020 № 32), п. 7.1.11–7.1.14 — до 01.09.2026; СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (пост. ГГСВ РФ от 02.06.2026 № 18, зарег. в Минюсте 02.06.2026 № 86854), п. 56 подп. 11–14, п. 62, раздел VI. https://rovenkiadm.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/SanPiN_2.4.4282-26.pdf (проверено: 17.08.2026)
3. ФЗ № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», ст. 9, 16, 17, 31, 32. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (проверено: 23.07.2026)
4. ГАУССО НСО «Болотнинский ПНИ»: «Вариативное питание» (16.08.2024). <https://bpni.nso.ru/news/2312> (проверено: 23.07.2026)
5. ГАУССО НСО «Успенский ПНИ»: вариативное меню во всех отделениях (13.08.2024). <https://upni.nso.ru/news/1916> (проверено: 23.07.2026)
6. ОГБУСО «Усть-Илимский дом социального обслуживания»: «Что за зверь такой? Вариативное питание» (27.09.2024). <https://ui-ogbuso.ru/novosti/> (проверено: 23.07.2026)
7. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга: «Работа по развитию психоневрологических интернатов продолжается» (22.07.2025) — первые результаты вариативного меню в ДСО «Серафимовский». <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/302216/> (проверено: 17.08.2026)
8. Correll C. et al. Мета-анализ смертности при шизофрении: смерть на 15–20 лет раньше; пневмония RR 7,00 — высшая из естественных причин (World Psychiatry, 2022) (2022). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9077617/>
9. Дисфагия при шизофрении: механизмы (паркинсонизм, сухость, гиперсаливация, седация, нарушения еды) — обзор (обзор). <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2024.1448623/full>
10. Pillinger T. et al. Мета-анализ 100 РКИ (25 952 пациента): прибавка веса на антипсихотиках от –0,23 кг (галоперидол) до +3,01 кг (клозапин) за медиану 6 нед (Lancet Psychiatry, 2020) (2020). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31860457/>
11. Прокуратура: проверки питания в соцучреждениях, дела по ст. 6.6 КоАП (Кашин СРЦ 2022; Зеленогорск 2021; представление 19.03.2024 soc13.ru). <https://www.kashin.info/prokuratura-informiruet/novosti-prokuratury/9121> (проверено: 23.07.2026)
12. Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п (нормы питания), актуальная ред.. https://ctonus.ru/f/normy_pitaniya.docx (проверено: 23.07.2026)
13. Постановление адм. Псковской обл. № 206; постановление Правительства Красноярского края № 607-п; пост. Правительства Ленобласти № 458; пост. Правительства ХМАО № 306-п. — (проверено: 23.07.2026)
14. Иркутская область: вариативное питание в стационарных учреждениях — выбор из двух первых, вторых и гарниров (14.02.2025). <https://irkutsk.bezformata.com/listnews/variativnoe/142531226/> (проверено: 23.07.2026)

15. Font L. et al. Дисфагия на фоне антипсихотиков: распространённость 21,9–69,5% (систематический обзор) (систематический обзор). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10455044/>
16. Hägg S. et al. Кофеин 400–1000 мг/день: +19% AUC клозапина, –14% клиренс (2000). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2014893/>
17. Литий и диета: почки обрабатывают литий и натрий сходно; дефицит натрия/обезвоживание → рост уровня лития (Cleveland Clinic). <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/25207-lithium-toxicity>
18. NHS. MAOI — диетические ограничения (тирамин): пациентский листок (NHS). <https://www.torbayandsouthdevon.nhs.uk/uploads/25672.pdf?last-updated=20201119>
19. Garg S.K. et al. Грейпфрутовый сок: пик карбамазепина 6,55→9,20 мкг/мл (+40%), AUC +41% (1998). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9757152/>
20. Исследование «Если быть точным»: «Как устроены ПНИ в России» (09.04.2026). <https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tochnym> (проверено: 23.07.2026)
21. ДДСОЛ (Московская обл.): 14-дневное вариативное меню, совет по питанию, замены по желанию жителей с врачом. <https://ddsol.ru/about/pitanie/> (проверено: 23.07.2026)
22. Постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4 (переквалификация 6.6→6.7 КоАП). <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72095418/> (проверено: 23.07.2026)
23. О. Reg. 246/22 (General) под Fixing Long-Term Care Act 2021, ст. 75–80 — Онтарио, Канада, 2022. <https://www.ontario.ca/laws/regulation/220246>
24. Yartsev P. et al. Тяжёлая токсичность клозапина при приёме энергетиков (600 мг кофеина/день; уровень 1796 нг/мл) — клинический случай (2021). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8043221/>
25. Pioneer Network. Home-Style Dining Interventions — США. <http://www.pioneenetwork.org/wp-content/uploads/2016/10/Home-Style-Dining-Interventions.pdf>
26. Green House Project: модель и независимая оценка (качество жизни, нейтральная стоимость) — США. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5338211/>
27. Замечание общего порядка № 1 (2014) Комитета ООН по правам инвалидов о ст. 12 КПИ (CRPD/C/GC/1) — Комитет ООН по правам инвалидов, 2014. <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-1-article-12-equal-reco>
28. Шведский регистр: ССЗ — ведущая причина избыточной смертности при шизофрении (MRR 2,80; смерть от ССЗ на 10 лет моложе) (регистровое исследование). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6137375/>
29. DGE-QST Betriebe/Kliniken: цикл ≥4 недель, вегетарианское ежедневно, перекусы в любое время — Германия. https://www.jobundfit.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE-QST/DGE-Qualitaetsstandard_Betriebe_Behoerden_Hochschulen.pdf
30. Приказ Минтруда России от 13.09.2022 № 520н «Об утверждении рекомендуемых норм питания...». <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405607433/> (проверено: 23.07.2026)
31. Livsmedelsverket. Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen (ночной интервал ≤11 ч; 6 приёмов) — Швеция, 2021. https://www.livsmedelsverket.se/49bd7f/globalassets/publikationsdatabas/broschyrrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf
32. DGE-QST для стационарных учреждений (Essbiografie, Wunschkost, Fingerfood, аудит) — Германия. https://www.bmlh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ernaehrung/GesundeErnaehrung/DGE-Standard_Seniorenverpflegung.pdf?__blob=publicationFile&v=4

33. Suominen M. et al. Nutritional guidelines for older people (семейные трапезы, персонал ест вместе) — Финляндия, 2020. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12877505/>
34. Nijs K. et al. Family-style mealtimes: cluster RCT (BMJ, 2006) (2006). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1463975/>
35. Strengthened Aged Care Quality Standards, Standard 6 — Food and Nutrition — ACQSC, Австралия, 2025. <https://www.agedcarequality.gov.au/providers/quality-standards/strengthened-aged-care-quality-standards>
36. 42 CFR § 483.60 Food and Nutrition Services (CMS) — США, 2016. <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/483.60>
37. BDA. Nutrition and Hydration Digest / руководство по питанию в психиатрических стационарах — British Dietetic Association. <https://www.bda.uk.com/asset/A18E6711-0DCF-4191-851AB06AC59B4C90/>
38. Qualitätsstandard Ernährung в домах престарелых (Австрия, актуализация 2022) — Sozialministerium, Австрия. https://www.sozialministerium.gv.at/dam/jcr:4f9ff5dc-a44c-4dee-b8d9-a22e6cd3c300/AKTUALISIERTE_QS_f%C3%BCr_die_Ern%C3%A4hrung_in_Wohn-_und_Pflegeeinrichtungen_f%C3%BCr_Seniorinnen_und_Senioren.pdf
39. CQC. Regulation 14: Meeting nutritional and hydration needs — руководство для поставщиков — CQC, Великобритания. <https://www.cqc.org.uk/guidance-regulation/providers/regulations-service-providers-and-managers/health-social-care-act/regulation-14>
40. RESOLVE: реалистский синтез антипсихотической прибавки веса (2025) (2025). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12531729/>
41. Дисфагия, аспирационная пневмония и кишечная непроходимость на антипсихотиках у лиц с нарушениями развития; предупреждение FDA о запорах на клозапине (2020) (обзор). <https://www.jscimedcentral.com/public/assets/articles/psychiatry-11-1183.pdf>
42. Cichero J.A.Y. et al. The IDDSI Framework (Dysphagia, 2017;32(2):293–314) (IDDSI, 2017). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27913916/>
43. Wu X.S. et al. IDDSI implementation: соответствие текстур 44%→90% (2022). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8994209/>
44. ACQSC. Texture-modified food and fluids (IDDSI, EDAR) — provider fact sheet — ACQSC, Австралия. https://www.agedcarequality.gov.au/sites/default/files/media/fnd_providers_texturemodified.pdf
45. Steele C.M. Нагрузка лечения загущёнными жидкостями: нет убедительных данных о снижении осложнений при доказанном снижении потребления жидкости (Breathe (ERS), 2021). <https://publications.ersnet.org/content/breathe/17/1/210003>
46. Li W.Q. et al. Систематический обзор и мета-анализ применения загущённых жидкостей при дисфагии (2025). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12516007/>
47. Trapl M. et al. GUSS (Gugging Swallowing Screen): прикроватный скрининг дисфагии, валидирован против FEES, выполняется подготовленной медсестрой (Stroke, 2007). <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.483933>
48. Belafsky P.C. et al. EAT-10: 10-пунктный опросник симптомов дисфагии (само- и интервью-версии) (Ann Otol Rhinol Laryngol, 2008). <https://doi.org/10.1177/000348940811701210>
49. Yoneyama T. et al. Ежедневный уход за полостью рта в домах ухода: частота пневмоний 11 % против 19 % в контроле (РКИ, 366 проживающих) (J Am Geriatr Soc, 2002). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11874491/>

50. Müller F. Обзор 4 РКИ: улучшение гигиены полости рта может предотвращать ~1 из 10 смертей от аспирационной пневмонии у немощных пожилых (Gerodontology, 2015). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4541086/>
51. Porter J. et al. Более половины проживающих домов ухода сообщают о проблемах полости рта — преимущественно сухость во рту и плохо сидящие протезы (Int J Dent Hyg / PMC, 2015). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4501060/>
52. Отмена кофеина: снижение уровня клозапина на 37–47% (Carrillo 1998; обзор) (клинический обзор). <https://www.pharmacytimes.com/view/caffeine-and-clozapine>
53. StatPearls. Lithium Toxicity: риски — дегидратация, диуретики, лихорадка, потери ЖКТ (StatPearls). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499992/>
54. MAOI diet and tyramine: руководство для назначающих (обновление 2022) (prescriber's guide). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9172554/>
55. «Сырная реакция» на ИМАО: история открытия (Blackwell; АД 160/90→220/115) (исторический обзор). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2738414/>
56. Dietitians of Canada. Best Practices for Nutrition, Food Service and Dining in LTC Homes — Онтарио, 2019. <https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/2019-Best-Practices-for-Nutrition,-Food-Service-and-Dining-in-Long-Term-Care-LTC-Homes.pdf>
57. Oral feeding options for people with dementia: a systematic review (систематический обзор (2011); PMID 21391936). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21391936/>
58. Comfort feeding in hospitalised people with dementia: a retrospective study of survival following comfort feeding recommendations (J Nutr Health Aging, 2024; DOI 10.1016/j.jnha.2024.100362). <https://doi.org/10.1016/j.jnha.2024.100362>
59. Мета-анализ CRWG (прибавка $\geq 7\%$ за 38 нед): клозапин 76,3%, оланзапин 36,9%, рисперидон 23,0% (BJPsych Open, 2026) (2026). <https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/association-between-antipsychotic-medication-and-clinically-relevant-weight-change-metaanalysis/C2DC78D062978D7C805E0E9B99B7911F>
60. Мета-анализ при первом эпизоде психоза: долгосрочно оланзапин +9,34 кг, клозапин +7,19 кг (мета-анализ). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5589463/>
61. Мониторинг метаболического риска на антипсихотиках: график (вес/ИМТ: исходно, 4/8/12 нед, 6 мес, ежегодно; глюкоза/липиды/АД: исходно, 12 нед, ежегодно) (клинические рекомендации). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8582768/>
62. Lifestyle interventions in mental health conditions: systematic review (57 исследований; –1,42 кг) (2022). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9462072/>
63. Teasdale S. et al. Nutrition/dietary interventions for SMI (MJA, 2023) (2023). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9828433/>
64. BAPEN. MUST — Malnutrition Universal Screening Tool: 5-шаговый скрининг (ИМТ, непреднамеренная потеря $>5\%$ за 3–6 мес, острое заболевание); для домов ухода — регулярное (обычно ежемесячное) взвешивание (BAPEN, Великобритания, 2003/2018). https://www.bapen.org.uk/pdfs/must/must_explan.pdf
65. Every-Palmer S. et al. Клозапин-индуцированная гипомотильность ЖКТ: запоры у 30–60 % пациентов, при объективных методах — до 80 %; тяжёлый запор может быть фатальным (иблиус, перфорация) (Aust N Z J Psychiatry / PMC, 2017). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5533872/>

66. NHS Specialist Pharmacy Service. Ведение запоров у принимающих клозапин: может быть фатальным; мониторинг стула, профилактические слабительные (NHS, Великобритания). <https://sps.nhs.uk/articles/managing-constipation-in-people-taking-clozapine/>
67. Cuomo A. et al. Дефицит витамина D распространён в психиатрической популяции; рекомендован рутинный скрининг (Frontiers in Psychiatry, 2019). <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2019.00167/full>
68. LoPinto-Khoury C. et al. Мета-анализ: карбамазепин ассоциирован со снижением 25(OH)D (Epilepsy Research, 2021). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34847425/>
69. Hanna S. Дефицит B12 и фолата у пожилых: связь с депрессией и когнитивными нарушениями, недодиагностика (Primary Care Companion / PMC, 2009). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2781043/>
70. Montessori-based interventions for dementia: systematic review (15 исследований) (2023). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10336713/>
71. Örebro kommun. Riktlinjer för mat, måltid och nutrition (IDDSI, процесс нутритивной помощи) — Швеция, 2023. <https://www.orebro.se/download/18.5779588418bcc1d3d2313d8/1700215055156/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20mat,%20m%C3%A5ltider%20och%20nutrition%20version%206,%2023-11-16.pdf>
72. Лозовская С.О. «Правосубъектность лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными вследствие психического расстройства». <https://vestnik.msal.ru/jour/article/view/2058> (проверено: 23.07.2026)
73. Ст. 31 442-ФЗ + ПП РФ № 1075 (расчёт среднедушевого дохода). https://www.consultant.ru/law/podborki/plata_za_stacionarnoe_socialnoe_obslyuzhivanie/ (проверено: 23.07.2026)
74. ФАС: картель на торгах поставки соц. значимых продуктов, 543 торга, 4,7 млрд руб. (25.07.2024, РГ). <https://rg.ru/2024/07/25/fas-raskryla-kartel-na-torgah-na-postavku-socialno-znachimyh-produktov.html> (проверено: 23.07.2026)
75. ФАС/ФСБ: картель на школьном питании Челябинск, 27 тендеров 2022–2024, штраф 5,1 млн (01.08.2025). <https://www.pro-goszakaz.ru/news/116068> (проверено: 23.07.2026)
76. КПИ, ст. 28 «Адекватный жизненный уровень и социальная защита» — ООН. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>
77. Письмо Минтруда России от 21.04.2020 № 26-4/10/В-3076: методические рекомендации по организации работы стационарных организаций социального обслуживания в условиях COVID-19 (усиленный питьевой режим, раздача в жилые комнаты, дезинфекционный контур). <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=361442> (проверено: проверено 18.08.2026 по тексту письма)
78. Методические рекомендации по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (пост. Минтруда России от 15.02.2002 № 12, ред. приказа от 04.06.2007 № 397): лечебно-профилактические продукты, профилактика витаминной недостаточности, санитарная безопасность. <https://docs.cntd.ru/document/901816611> (проверено: проверено 18.08.2026 по тексту)
79. Eden Alternative: философия и десять принципов — США. <https://edenalt.org/>
80. Region Jämtland: кейс Tallgläntan — замеры ночного голодания 2×/год — Швеция, 2016. <https://www.regionjh.se/download/18.7b79416a31d3449611c4/1557149809111/2016-2-Skoglind-%C3%96hman.pdf>
81. Письмо Минтруда о семинаре + список участников (приложения пользователя). — (проверено: 23.07.2026)

82. Ведомости: «Психоневрологических интернатов за три года стало на 13% меньше» (10.04.2026). <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2026/04/10/1189295-psihonevrologicheskikh-internatov-stalo-menshe> (проверено: 23.07.2026)
83. Постановление Правительства Москвы № 1068-ПП (нормы питания в стационарных организациях). — (проверено: 23.07.2026)
84. BDA. Практические ресурсы по питанию в психиатрии (лекарственно-пищевые взаимодействия) — BDA. <https://www.bda.uk.com/practice-and-education/resources-for-practice/mental-health-learning-disability-inpatients.html>
85. Porter J. et al. Protected mealtimes: systematic review & meta-analysis (Int J Nurs Stud, 2017) (2017). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27866011/>
86. Porter J. et al. Protected Mealtimes: stepped-wedge cluster trial (2019) (2019). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5295189/>
87. Hugo C. et al. What does it cost to feed aged care residents in Australia? (Nutrition & Dietetics, 2018) — Австралия, 2018. https://pure.bond.edu.au/ws/files/25958488/What_does_it_cost_to_feed_aged_care_residents_in_Australia.pdf
88. Milte R. et al. Foodservice Costing Tool study (2022): полная стоимость пищевой службы; надбавка \$10 — Ун-т Квинсленда, 2022. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9321358/>
89. The Consumer Voice. Food Appendix (F-теги пищевого блока) — США. <https://theconsumervoice.org/wp-content/uploads/2026/06/Food-Appendix.pdf>
90. Ruokavirasto. New food recommendation for elderly care (2020) — Финляндия, 2020. <https://www.ruokavirasto.fi/en/foodstuffs/healthy-diet/uutiset/new-food-recommendation-for-elderly/>
91. MedUni Graz (SUNRISE): аппетитные описания блюд меняют выбор — Австрия, 2021. https://www.medunigraz.at/frontend/user_upload/OEs/institute/pflegewissenschaft/pdf/Leitfaden_Interessierte.pdf
92. NIPH Journal: реформа LTCI 2005 и пищевые доплаты — Япония, 2006. <https://www.niph.go.jp/journal/data/55-1/200655010006.pdf>
93. Доплата за нутритивный менеджмент: охват 87–94% учреждений (2020) — Япония, 2021. <https://comimi.jp/archives/column/kasan3>
94. Ревизия тарифов 2021: усиленная доплата, обязательный стандарт, вычет, LIFE — MHLW, Япония. <https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyos/2021housyuukaitei/documents/eiyoucaremanezimentonozyuuzitu.pdf>
95. ERIA. Outcomes of Long-term Care in Japan (доплаты и исходы, HR 0,90) — Япония, 2020. <https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-Report/2020-13-Outcomes-of-Long-term-Care-Japan/Outcome-of-Long-term-Care-Insurance-Service-in-Japan-new.pdf>
96. Число диетологов и госпитализации: 2 vs 1 — 20,3% vs 30,6% — Япония. <https://rehab.cloud/mag/2862/>
97. Supported housing for people with SMI: systematic review & meta-analysis (2022) (Frontiers in Psychiatry). <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2022.966029/full>
98. FAO Ontario: финансирование LTC, конверт raw food — Онтарио, 2019. <https://fao-on.org/wp-content/uploads/2024/08/Long-term-care-homes-program.pdf>
99. Toronto Star: конверт сырья \$8,33 CAD (2017) — Онтарио, 2017. https://www.thestar.com/news/canada/ontario-nursing-homes-feed-seniors-on-8-33-a-day/article_6b7fab43-437c-5ba6-bbfb-0f1d6426062b.html

- 100.** ANFP Benchmarking Program: расходы на сырьё в nursing homes — США. <https://www.anfponline.org/docs/default-source/legacy-docs/docs/benchmarking-program/anfpbenchmarkingprogramarticle-marchapriledge2018.pdf>
- 101.** Skilled Nursing News: >25% домов снизили расходы на питание ниже \$10 (2025) — США, 2025. <https://skillednursingnews.com/2025/04/more-than-25-of-nursing-homes-slash-food-spending-below-10-a-day/>
- 102.** M3 (Making the Most of Mealtimes): адекватность меню и потребление (mMAR) — Канада. <https://www.jnursinghomeresearch.com/1592-food-services-in-long-term-care-homes-are-associated-with-residents-food-intake.html>
- 103.** Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н: статус на 2026 г.. <https://base.garant.ru/58070703/> (проверено: 23.07.2026)
- 104.** «Кейтеринг в организациях социального обслуживания» (отраслевое издание, 2022). https://www.profiz.ru/sec/4_2022/Kejtering/ (проверено: 23.07.2026)
- 105.** ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (проверено: 23.07.2026)
- 106.** Hospital Food Standards Panel. Standards for food and drink in NHS hospitals — DH, Великобритания, 2016. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a806e1eed915d74e33fa61a/Hospital_Food_Panel_May_2016.pdf
- 107.** Исследование «Если быть точным»: ПНИ России в цифрах — 466 интернатов (2024), 139 500 жителей, 74% недееспособных, 65% старше 45 лет (апрель 2026) (2026). <https://www.forbes.ru/forbeslife/558987-s-2022-po-2024-god-cislo-psihonevrologiceskih-internatov-v-rossii-snizilos-na-13>
- 108.** Великобритания: Accessible Information Standard — информация для пациентов с нарушениями предоставляется в доступных форматах (включая easy read: короткие фразы + изображения); Менсар — методические материалы — NHS England / Менсар, Великобритания. <https://www.mencap.org.uk/help-and-advice/health/accessible-information-standard>
- 109.** Narrative Review of Low-Intake Dehydration in Older Adults (обзор (2021); PMC8470893). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8470893/>
- 110.** Volkert D. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics (Clin Nutr, 2019, 38(1):10–47) (ESPEN (Европейское общество клинического питания и метаболизма); Clin Nutr). <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.029>
- 111.** Dehydration and Fluid Maintenance in the Long-Term Care Setting — клиническое руководство (PALTmed (Общество паллиативной медицины), 2024). <https://paltmed.org/sites/default/files/2024-10/Dehydration%20CPG%2008092024.pdf>
- 112.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (пост. ГГСВ РФ от 28.09.2020 № 28, зарег. в Минюсте 18.12.2020 № 61573). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/ (проверено: 23.07.2026)